

Comprender la ansiedad, las fobias y el estrés

Juan Rojo Moreno
(Coordinador)



PSICOLOGÍA PIRÁMIDE

Coordinador
Juan Rojo Moreno

Comprender la ansiedad, las fobias y el estrés

EDICIONES PIRÁMIDE

Índice

Prólogo

1. Casos clínicos

- 1.1. Primer caso clínico
- 1.2. Segundo caso clínico
- 1.3. Tercer caso clínico

2. Qué es la ansiedad y el estrés. La ansiedad como enfermedad que se «comprende» en la totalidad de la propia vida

- 2.1. La ansiedad
- 2.2. El estrés
 - 2.2.1. La *intensidad* de la vivencia
 - 2.2.2. El tiempo de duración de la vivencia
 - 2.2.3. La *edad* crítica del sujeto
 - 2.2.4. El *significado* que la vivencia tiene para él
- 2.3. La ansiedad como enfermedad que se «comprende» en la totalidad de la propia vida

3. Los sucesos de nuestra vida que pueden influir en la aparición de la ansiedad

- 3.1. Factores disposicionales
 - 3.1.1. La herencia
 - 3.1.2. Temperamento y carácter
 - 3.1.3. La edad y el sexo
 - 3.1.3.1. Edades más frecuentes de la primera aparición
 - 3.1.3.2. Edades de cambio, vulnerabilidad o metamorfosis
- 3.2. Factores de sensibilización biográfica
 - 3.2.1. Privación de comunicación adecuada
 - 3.2.1.1. El hijo mal deseado
 - 3.2.1.2. El exceso de castigos
 - 3.2.1.3. El aislamiento social de la familia
 - 3.2.2. Aprendizajes anómalos
 - 3.2.2.1. Hiperprotección
 - 3.2.2.2. Preferencias
 - 3.2.2.3. Responsabilidad precoz
 - 3.2.2.4. Falta de gratificación
 - 3.2.3. Frustraciones
 - 3.2.4. Conflictos

3.3. Factores desencadenantes

4. La neurosis de ansiedad y el trastorno de ansiedad

4.1. La neurosis de ansiedad

4.2. Trastorno de ansiedad

4.3. La enfermedad ansiosa endógena: la timopatía ansiosa

5. Fobias, obsesiones, compulsiones

5.1. Las fobias simples

5.2. Agorafobia

5.3. Fobia social (ansiedad social)

5.4. Síndrome obsesivo-compulsivo (Trastorno obsesivo-compulsivo, TOC)

6. Trastorno por estrés traumático (TEPT)

7. Ansiedad y depresión

7.1. Cuando la enfermedad es realmente ansiosa y deriva con el tiempo hacia una depresión

7.2. Cuando hay una enfermedad ansiosa y síntomas depresiformes, pero no una depresión real

7.3. Cuando ocurre que tenemos un síndrome ansioso-depresivo

8. La ansiedad y el estrés en la sociedad actual. Ansiedad y trabajo

9. La ansiedad desde el punto de vista de la psicología: modelos, evaluación y tratamiento

9.1. Introducción

9.2. Activación o arousal

9.2.1. Mecanismos neurofisiológicos de la activación

9.2.2. Ansiedad rasgo y ansiedad estado

9.3. Estrés

9.4. Evaluación de la ansiedad

9.5. tratamientos psicológicos para el control de la ansiedad

9.5.1. Principales técnicas para el control de la ansiedad

9.5.1.1. La relajación

9.5.1.2. La biorretroalimentación

9.5.1.3. Las técnicas de afrontamiento

9.5.1.4. La reestructuración cognitiva

9.5.1.5. Programas basados en el condicionamiento clásico

9.5.1.6. La terapia cognitivo-conductual

10. Conceptos fundamentales del tratamiento de la enfermedad ansiosa. tratamiento psicofarmacoterápico

11. La psicobiografía: valor higiénico y patológico. valoración de acontecimientos de las edades preescolares

11.1. Prefacio o prólogo a este capítulo

11.2. Introducción

11.3. Sobre la historia del individuo, que es su vida

11.4. Etapas y curso del bios

11.5. Variedades de «formas» del bios

11.6. Los sucesos y acontecimientos en las edades preescolares

11.6.1. En el primer año de vida

11.6.2. Edad preescolar: la etapa del aprendizaje

11.6.2.1. El juego

11.7. Aprendizaje preescolar y estructura social

11.8. ¿Es válido todo lo anteriormente dicho como influencia positiva (higiénica) o negativa (patológica)?

11.9. Epílogo

12. ¿Desaparecerá la enfermedad ansiosa y el estrés? La psiquiatría irredenta. Antropología biogenética

Bibliografía

Créditos

*A mi padre y maestro, Miguel Rojo Sierra.
A mi madre, María Luisa Moreno Ortega.*

*Ambos configuraron la primera estructura
de mi sentido vital*

PRÓLOGO

«Ya sea por la ansiedad y el estrés o por la pena y tragedia que rezuma el mundo, lo cierto es que cuando veo las noticias de la televisión o leo los periódicos siempre me viene a mi mente lo mismo: ¡qué desastre! Sólo la creatividad del ser humano nos dará luz para la esperanza de que éste sea capaz de crear una nueva concepción del mundo distinta a la que hoy impera.»

Como señala J. Krishnamurti, en su obra *El arte de vivir*, ha de darse una revolución si queremos salir de la serie infinita de ansiedades, conflictos y frustraciones en la que nos hallamos atrapados; pero esta revolución ha de comenzar, no con teorías e ideas que acaban siendo inútiles, sino con una transformación radical de la misma mente.

Es importante que tengamos en cuenta que la ansiedad y el estrés no es sólo una enfermedad de nuestra época como si estuviese originada por las circunstancias externas, por la vida acelerada o por la falta de estabilidad social, familiar o laboral. El problema quizá se encuentre en que el hombre moderno se ha estancado frente al mundo, de tal forma que vivencia día a día que no lo domina y se siente desbordado por los avances de la ciencia y de la sociedad, y al mismo tiempo que usa estos avances apenas entiende qué sentido tiene toda esta maraña de cosas en su vida. Pero el problema, realmente, no está en el mundo, el problema está en el propio hombre. Como dice P. Meseguer¹, hay una crisis de «hombreidad», al mundo le duele el hombre. Y le duele por culpa del mismo hombre, como bien señala Gabriel Marcel en su obra *Los hombres contra lo humano*. Nunca se ha hecho más por el «hombre parcial» y nunca se ha pecado tanto contra el «hombre total» como en esta época técnica que tanto nos halaga y al mismo tiempo nos atrofia.

Pero tengamos en cuenta que esto que estamos hablando no es sólo una cuestión «psicológica», sino que la biología y la genética se dirigen en la dirección en la que cada persona orienta su concepción del mundo y por lo tanto su sentido de la vida. Dice Igor Caruso que el sentido de la vida aparece cuando hay una jerarquía de valores estables². Y en los tiempos tan acelerados que vivimos con constantes cambios de los valores, siendo que muchas cosas que hace 15 años eran «normales» hoy se valoran como innecesarias, caducas, o sin importancia, y aparecen nuevas concepciones del mundo que cambian y cambian de generación en generación, e incluso entre grupos de personas de la misma generación, ¿quién tiene una jerarquía de valores estables? Desde luego es posible alcanzar esta estabilidad de valores en la vida de cada persona, pero haciendo un gran esfuerzo madurativo.

Este libro sobre ansiedad, estrés y fobias «en lenguaje para todos» intenta no sólo

informar sobre estas enfermedades, sino también que pueda cada lector, en un lenguaje comprensible, entender cómo es el mundo del paciente que padece estas enfermedades y asimismo poder tomar posturas o actitudes ante estas situaciones. Es tan importante el carácter formativo de este libro como el informativo. Al igual que en un libro precedente³ éste está habilitado para que pueda ser fácilmente leíble no sólo por psiquiatras, psicólogos, médicos o cualquier profesional de la salud, sino que cualquier persona que esté interesada por la enfermedad psíquica encontrará que con los distintos ejemplos y aclaraciones, sin mucha dificultad, se acercará a entender este padecimiento que todos creemos de alguna manera sufrir (la ansiedad y el estrés), pero que no a todos nos afecta como enfermedad.

Una de las cosas que más sorprende a muchos pacientes es que son incomprendidos en su enfermedad: «Todos tenemos ansiedad, todos tenemos estrés, lo que padeces son manías», le dicen familiares, amigos y conocidos, generalmente bien intencionados. Pero tener una enfermedad no es tener «manías» o simplemente «ansiedad», es algo más: es estar enfermo en una manera de vivenciar el mundo, es vivir un infierno sintiéndose desbordado por síntomas que le impiden desplegarse con normalidad en circunstancias habituales, como puede ser pasar por un puente, o simplemente salir a la calle o ir a un restaurante o a un centro comercial. Decirles a los pacientes «no tienes nada», ya que la analítica es normal y las radiografías o la TAC son normales, no es válido en estas enfermedades que no se reflejan en esas pruebas. Parafraseando a Rof Carballo podemos decir que todos los días, en todas las consultas del mundo, una realidad humana, la del enfermo como individuo singular, pretende muchas veces en vano hacerse ver. Siempre, cuando una persona está afectada de manera significativa en su vivir cotidiano «tiene algo», tiene una enfermedad más o menos grave, aunque, por desgracia, aún tengamos que oír eso de «yo no creo en la depresión, yo no creo en la ansiedad, es cuestión de voluntad».

El profesor López Ibor Sn. habló de la psiquiatría irredenta⁴ haciendo referencia a «aquellos a los que un especialista consideraría como enfermos, pero que no acuden a él, sino a otros médicos, o a otras personas o simplemente viven y mueren con su enfermedad».

Y muy a menudo éste es el problema: muchos pacientes no acuden a los profesionales de la salud porque piensan que sus síntomas no son suficientemente importantes o simplemente son consecuencia «natural» de las circunstancias, aunque tengan una calidad de vida poco óptima. Quizá debamos aprender que lo importante no es tratar el síntoma, sino tratar al ser humano enfermo, que es el que padece unos síntomas, una enfermedad.

Para terminar quiero agradecer la aportación que la profesora María Luisa García-Merita ha hecho a este libro escribiendo el capítulo sobre la ansiedad desde el punto de vista psicológico, y a María Adela Rojo y Amparo Betés por la corrección del manuscrito aportando ideas para que fuera más fácilmente entendible. Y, cómo no, agradecer el incondicional apoyo de las personas que comparten mi «mundo» vital y movilizan constantemente mi cosmovisión, Carlota, mis hijos Miguel y Carlota y mi «hermana» Sol.

NOTAS

[1](#) Pedro Meseguer: prólogo a la edición española de Igor Caruso (ver siguiente referencia). Nos referimos a «hombreidad» en el sentido de «hombre» como *ánthrōpos* (griego), al *homo* (latín), término que significa «humano» y por lo tanto abarca a los dos sexos, tanto masculino como femenino.

[2](#) Caruso, I. A. (1958). *Análisis psíquico y síntesis existencial*. 2.^a edición española. Barcelona: Editorial Herder.

[3](#) *La enfermedad depresiva. Conocer y entender la depresión en lenguaje para todos*. Editorial Albatros, 2008.

[4](#) López Ibor, J. J. Citado por López Ibor Aliño, J. J., en *La psiquiatría de hoy*. Toray, 1975.

1. CASOS CLÍNICOS

«Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías;
breve y eficaz por medio de ejemplos.»

LUCIO ANNEO SÉNECA (4 a.C.-65 d.C.), filósofo latino.

1.1. PRIMER CASO CLÍNICO

M. R. V. es un varón de 25 años, de carácter extravertido y muy nervioso «de siempre», como la madre («no paraba», dicen los padres). Tiene una hermana menor, de 20 años. La madre ha sido muy padecedora y ha realizado durante la infancia una hiperprotección ansiosa sobre él, «siempre estaba controlándome en todo». La escolaridad ha sido normal, con muy buenos resultados escolares, siendo muy responsable. Su relación social durante la primera infancia fue también buena y era «líder» entre sus amigos. En la adolescencia (13-15 años) apenas sale con los amigos, ya que se dedicó fundamentalmente a estudiar (realizando una identificación de su autovalor con los rendimientos escolares). Con 16 años padece su primera crisis existencial al fallecer su padre de cáncer, perdiendo ese curso escolar, que tuvo que repetir. Él era el «preferido» del padre, pues éste era reservado y poco comunicativo y él, al ser de carácter extravertido, se comunicaba bien con el progenitor, a diferencia de su hermana menor, que era reservada y poco habladora.

Con 18 años padece su segunda crisis existencial al sufrir una enfermedad con adenitis (ganglios) «al igual que su padre», pensando que tenía, asimismo, un cáncer, por lo que fue ingresado durante un mes en el hospital para ser estudiado, descubriéndose que los ganglios eran debidos a una infección vírica (citomegalovirus); «hasta que me dieron el diagnóstico creía que me moría», comentaba. Pasó ese mes en el hospital muy ansioso, inquieto, con insomnio y miedo a morir. Por esta razón perdió de nuevo un curso de sus estudios.

Aunque repite curso, ese nuevo año estudió menos, «pasaba las horas hablando con los amigos y trasnochando», y un día, cerca de los exámenes, jugando a fútbol, padece una crisis aguda de ansiedad, que la expresa así: miedo intenso, tenía la sensación de que me iba a morir, palpitaciones, como si el corazón se saliera, creía que era un infarto, sensación de hormigueo en las manos (parestesias), «notaba que me ahogaba y algo me subía a la cabeza», sensación de inestabilidad, «como si flotara», «como si no pisara seguro». Fue a urgencias del hospital pensando que padecía un infarto, y allí, tras descartarle una patología cardíaca, le dieron un tranquilizante, con lo que le desapareció la sintomatología. Desde entonces y durante aproximadamente un año se le repiten las crisis 3-4 veces a la semana. Luego, con las diversas modificaciones del tratamiento, disminuye la frecuencia de las crisis, pero no llegan a desaparecer hasta hace dos años. Desde hace dos años hasta ahora siempre

sale a la calle acompañado de su hermana o algún familiar y, aunque no ha vuelto a padecer crisis agudas de ansiedad, sí que sufre, casi constantemente, ansiedad que expresa como tensión interna, sensación de opresión en el pecho y sensación de falta de aire, dolor en el costado izquierdo, sudor en la cara y palpitaciones. Esto lo padece aun estando en casa, y si sale a la calle la sintomatología se hace más intensa. Por las noches, aunque concilia bien el sueño, no obstante, se despierta una o dos veces sobresaltado, costándole dormirse de nuevo.

Aunque dice no estar mal de ánimo, los días que está más nervioso se encuentra menos animado y más triste. Está muy caviloso por el tiempo de duración de su enfermedad y la inutilidad que ésta le origina.

Comentario

Este paciente padece un trastorno de ansiedad o neurosis de ansiedad (ya veremos más adelante qué diferencia hay entre estos dos diagnósticos), que se ha hecho ya crónico, durándole varios años y habiéndole originado un grado de incapacidad muy importante. Para comprender cómo aparecen las primeras crisis agudas de ansiedad es necesario conocer la importancia de su responsabilización en los estudios, de tal manera que su autoconcepto, su autovalía o autoestima se identifica en la infancia — y sobre todo en la adolescencia— con el estudiar y tener buenos resultados. Sin el conocimiento de la biografía del paciente, de su vida, sería imposible entender la importancia que tienen en él las crisis existenciales⁵ que sufrió. Solamente cuando padece dos crisis existenciales es cuando disminuye su rendimiento y cuando se disipa de sus estudios, apareciéndole ya las crisis agudas de ansiedad y poniéndose en marcha la enfermedad ansiosa. Aunque haya alteraciones de ánimo en relación con la evolución de su sintomatología ansiosa, no es suficiente para hablar de depresión.

En definitiva, fijémonos cómo se junta un temperamento previo de su personalidad «de siempre nervioso» + una hiperprotección ansiosa de la madre + una hiperresponsabilización en los estudios, y cómo, tras las crisis existenciales, al disiparse en los rendimientos y en su responsabilidad, aparece la enfermedad.

1.2. SEGUNDO CASO CLÍNICO

C. M. V. es una mujer de 47 años, casada, trabaja en un banco. En vacaciones, volviendo de viaje con su marido y sus hijos, conduciendo su marido, tienen un accidente frontal con otro coche, «pensé que nos íbamos a matar». Luego, tras el golpe, oyó al marido decir que había que salir del coche y pensó: «no se ha clavado el volante». Aun estando en el coche vio a su hijo mayor fuera ya del mismo, pero al girar la cabeza no puede ver al hijo menor. Esto último le originó mucha angustia pensando que habría salido despedido durante el choque y estaría muerto. Entonces sale del coche llorando y gritando «¿dónde está?». Al momento pudo ver al hijo vivo.

Durante los próximos días, exceptuando las molestias físicas menores, en el

ámbito psicológico se recuperó muy bien, estando ese mes muy hiperactiva con todo el papeleo, y centrada en la rehabilitación y atención de la recuperación de los demás miembros de la familia. Sólo presentaba, desde el día del accidente, insomnio entrecortado, con algunos despertares a mitad de noche más frecuentes de lo normal en ella, pero sin angustia en esos despertares, y volviendo prontamente a coger el sueño.

Pasado un mes y medio tras el accidente, estando ya todos los familiares recuperados físicamente, nota que cuando «todo está perfecto y todos recuperados», ella empieza a padecer labilidad afectiva (facilidad para el lloro) un gran cansancio, insomnio mucho más intenso —tanto de inducción como despertares muy frecuentes— con muchas pesadillas en las que ve, o bien al coche azul que se abalanza sobre ellos, o se ve en el coche y que al girar la cabeza no veía al hijo dentro del mismo en el momento del accidente; o ve a su hijo en el suelo tumbado y muerto. Estas pesadillas la despiertan sobresaltada a mitad de noche con gran angustia, sudoración y palpitaciones. También se encuentra irritable y se siente en sus actividades «más ralentizada».

Durante el día nota que le molestan mucho los ruidos, dolor de cabeza, sensación de «prisa interior» y de falta de aire y, a veces, una sensación de nudo en la garganta. Su estado le preocupa mucho, por lo que está triste, pensando constantemente en que no se encuentra bien y no paran de venirle a la cabeza las imágenes que tiene por la noche en las pesadillas.

Se le pautó tratamiento con un ansiolítico y trimeprimina (que es un antidepresivo que regula muy bien el sueño por la noche) y en dos meses desapareció completamente la sintomatología que padecía.

En el estudio biográfico no aparecen datos significativos. Es hija mayor, tiene una hermana con la que mantiene buenas relaciones al igual que con sus padres, la escolaridad fue normal y tanto en la primera infancia como en la adolescencia no hubo eventos especialmente a distinguir.

La armonización fue buena en la adolescencia y luego se adaptó muy bien en los estudios de licenciatura que realizó. Entró a trabajar en el banco nada más terminar la licenciatura y se casó a los dos años. En el matrimonio no se detectaron, al realizar el estudio biográfico, circunstancias clínicamente significativas e igualmente realizó con normalidad la crianza de los hijos.

Hasta que ocurre el accidente de tráfico, por tanto, no se encontró ninguna alteración psicológica, psicopatológica o enfermedad psíquica previa.

Comentario

Llamará la atención al lector que al principio, tras el accidente, no padece sintomatología psiquiátrica alguna, sino que es después, pasado un mes y medio, habiéndose ocupado ella, con gran actividad, de los otros miembros de la familia, cuando presenta los síntomas que serán de tipo ansioso. Esto ya lo veremos más

adelante, corresponde a lo que actualmente se denomina trastorno por estrés postraumático. Pero lo más importante es que la paciente «ha mantenido el tipo», el esfuerzo, mientras los otros familiares se recuperaban, y «cuando todo está perfecto y todos recuperados» es cuando su sistema nervioso «ya puede enfermar». Como las agujetas, tras el esfuerzo, ahora puede manifestarse en ella el desbordamiento afectivo que ha estado sufriendo. Esto corresponde a una «situación de descarga» (Glauser) o «enfermedad de descarga», descrita por Schulte, y que en resumen viene a decir: el sistema nervioso aguanta mientras la tensión le exige que esté sano, ya sea cuidando a un familiar, dirigiendo una empresa en crisis, etc., y cuando «por fin todo el estrés acaba», entonces se manifiesta la enfermedad⁶.

1.3. TERCER CASO CLÍNICO

J. R. M, tiene 38 años y es el hijo menor. Su hermano mayor tiene 42 años. Está casado y no tiene hijos. Tanto el padre como la madre son introvertidos y su «preferencia» ha recaído sobre el hermano mayor, al ser éste de carácter extravertido y se comunicaba mejor con ellos, mientras que él ha sido más bien reservado (introvertido) y con un temperamento de genio fuerte, ordenado, detallista, perfeccionista y meticuloso. Durante su infancia y adolescencia no hubo acontecimientos relevantes, siendo la escolaridad y sociabilidad normal y trabajando en la empresa familiar desde los 16 años. Cuando tiene 33 años la empresa quiebra y tiene que ir al paro originándole esto gran inseguridad, más en cuanto que al ser muy perfeccionista y programador de las cosas, una situación así, inesperada, le originaba gran angustia.

Cuando tiene 34 años (un año después y aún encontrándose en el paro) empieza a encontrarse muy agobiado «por la suciedad». Tras ir al servicio para defecar se siente sucio, aunque se limpie múltiples veces. Si va de paseo, está constantemente atento a no pisar heces de perro y aunque no las pise, no puede dejar de pensar una y otra vez, repetidamente, ¿y si las he pisado y no me he dado cuenta? No puede, por esto, ir tranquilo por la calle, y si ve «algo sospechoso» en el suelo, aunque esté lejos, ha de acercarse para comprobar si son o no heces de perro. Si conduce el coche, como en la carretera se pueden ver animales muertos, tiene miedo a que pueda pasar, sin darse cuenta, sobre un animal muerto y luego cuando baje él del coche «toque con la pierna la rueda del automóvil». En casa se lava constantemente las manos (más de 20 veces al día), pues piensa que ha podido tocar algo que hubiese estado en contacto antes con alguna persona o alguna cosa sucia.

Por todo esto no puede dejar de pensar constantemente en la suciedad, sin parar (esto se denomina mentismo obsesivo), y apenas puede dormir (insomnio), padeciendo gran tristeza y tendencia al llanto. Ha perdido la ilusión por todo (este síntoma se denomina anhedonia), y su disposición es a pasarse todo el día en la cama (inhibición). Nota muy a menudo ansiedad, que expresa como una opresión en el pecho.

Comentario

Este paciente padece un síndrome obsesivo. Las obsesiones son pensamientos, ideas, que el paciente sabe que son absurdas; él sabe perfectamente que no ha pisado heces, o que no tiene las manos sucias, pero al mismo tiempo que «lo sabe», no puede evitarlas, y se repiten una y otra vez, como un disco rayado. En nuestro caso, la vivencia de suciedad «se le impone», aunque pueda considerarla absurda. Quien ha padecido estos trastornos obsesivos sabe lo angustioso que es perder el control sobre nuestros pensamientos y vivencias, hasta el punto de que éstas nos martiricen todo el día de forma continua, mortificándonos en extremo, sin parar, aun sabiendo que son absurdas. Por esto, los pacientes se angustian mucho y al final dudan de todo. Nuestro paciente realiza actos de repetición de lavado de las manos; esto se denomina compulsión. Diríamos en definitiva que padece un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

* * *

Hemos expuesto tres casos clínicos diferentes en los que la ansiedad puede presentarse. Es distinta la manifestación clínica que padece cada uno de los pacientes, pero algo tienen en común: se quiebra el ritmo vital, infiltrándose con autonomía propia la inseguridad⁷. Entonces, esta inseguridad no será algo que esté en el mundo (eso ya lo asumimos en nuestra vida cotidiana) y que desde el mundo nos invada con mayor o menor intensidad; no, ahora *la inseguridad está encarnada en nuestra historia personal*, ha penetrado asentándose en nuestra historicidad íntima y desde allí colorea también todo el mundo circundante.

NOTAS

⁵ K. Jaspers (1960) considera que las situaciones límites individuales son: lucha, muerte, sufrimiento y culpa. Ante la muerte decimos que se sufre una crisis existencial, ya que desaparecen todos los valores externos y se encuentra el sujeto en su pureza, puesto en relación exclusiva consigo mismo. Por esto, dice en su *Psicopatología general*, son situaciones insuperables, en las que despierta a la existencia (es decir, al ser puro).

¿Cómo puede el hombre reaccionar cuando adquiere conciencia de la muerte como situación límite? Con respecto a la muerte (en nuestro caso la vivencia del paciente de la muerte de su padre), dice Jaspers, más allá de la existencia momentánea no se ve nada, la existencia misma aparece caótica. El intelecto llega a perder todo sentido para el examen de la inmortalidad, pues el intelecto se queda petrificado en lo limitable y, por ello, en lo finito. La reacción inmediata es puramente negativa: a la vista de la situación límite son destruidos todos los contenidos de fe, pero no entra nada nuevo en su lugar.

⁶ J. J. López Ibor, en su libro *Las neurosis como enfermedades de ánimo*, cita a W. Schulte y dice: «La ocupación y la preocupación, la primera por su exigencia de realidad y la segunda por su tensión propulsiva, encubren el fondo estático detenido y el tono silente de la vitalidad agotada».

⁷ M. Rojo Sierra y M. L. García-Merita, en el libro *Psicología y psicopatología de la captación del tiempo y del espacio*, ya señalan cómo al ritmo le define precisamente «la repetición» a lo largo del tiempo. Cuando existe ansiedad-angustia patológica hay una ruptura del ritmo (una desincronosis) de los ritmos tensión-relajación (D. Barcia, 1982).

2. QUÉ ES LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS. LA ANSIEDAD COMO ENFERMEDAD QUE SE «COMPRENDE» EN LA TOTALIDAD DE LA PROPIA VIDA

«Apresúrate lentamente.»

SUETONIO (75-150 d.C.), historiador latino.

2.1. LA ANSIEDAD

Cuando nos preguntan si las enfermedades psíquicas han aumentado desde hace 100 años, tenemos que decir que evidentemente sí, no sólo porque hay muchas más personas en este mundo, sino porque la frecuencia de las mismas es mayor. Pero este aumento de frecuencias se ha realizado fundamentalmente, en el mundo civilizado, a costa de las enfermedades de ansiedad y de los síndromes depresivos.

Tengamos en cuenta que en la antigüedad, las gentes creían saber quiénes eran y qué se esperaba de ellas y, comenta Goodwin, aunque asustadas a menudo, se encontraban con mucha menor frecuencia sufriendo estados de ansiedad.

¿Pero a qué puede deberse este cambio tan importante en los últimos 100 años? Quizá parte importante de la respuesta esté en el cambio tan constante y rapidísimo que el hombre ha vivido en esta centuria. En este sentido dice Rojo Sierra, cuando habla de «la vida de hoy y los trastornos psíquicos»: nuestro mundo que ha estado tan empeñado en crear un hábitat confortable y feliz para los hombres, de hecho ha originado un mundo hostil, que enajena, cansa e incluso mata. ¿Cómo ha sido posible esto? La causa de este seísmo histórico por el que transcurrimos es porque estamos en gravísima crisis. La palabra crisis procede, etimológicamente, de la griega *krino*, que significa cambiar. Y efectivamente desde poco antes de la mitad del siglo XX, cara al XXI, desde entonces, nunca ha sido, en efecto, más legítimo el sentimiento de que estamos viviendo un cambio sin precedentes. Y, fundamentalmente, este cambio afecta tanto a cada uno de nosotros porque han cambiado radicalmente ciertas peculiaridades del pasado que eran consideradas firmes y casi inamovibles:

1. El culto a la razón, era en la forma de que «sólo es verdad» lo que toco y lo que veo.
2. La cerrazón de las regiones sociogeográficas: unas fronteras rígidas separaban a los países.
3. La ética (los valores) eran parecidos en todo Occidente, y se consideraban firmes y claramente estables.
4. La familia era monocéfala, o patriarcal, o matriarcal. Era la célula social.

5. La predicibilidad del futuro: el joven en aquella época podía saber con bastante acierto lo que iba a ser de mayor, tanto acerca de su profesión como de su estatus.

Pues bien, sigue comentando Rojo Sierra, estas características tan bien establecidas del pasado, todas se han quebrado, e insiste —en otro artículo en 1975— en que por esto «el hombre de hoy va errando y vagando por cuarenta mil caminos, buscando infructuosamente algo que nunca encuentra [...] el hombre está perdido por fuera y por dentro. Cuando el hombre actual mira al mundo, éste le parece absurdo; cuando se mira a sí mismo, se siente vacío, impotente, incomunicado, despersonalizado y perplejo».

En esta misma dirección, Erich Fromm (1956) comenta: hoy nos encontramos con personas que obran y sienten como si fueran autómatas, que se sienten a sí mismas totalmente como consideran que se las considera; cuya sonrisa artificial ha reemplazado a la verdadera sonrisa; cuya charla insignificante ha sustituido al lenguaje comunicativo⁸.

Esto va a originar una situación de inseguridad, estructural, de fondo, abono fecundo para los síndromes ansiosos.

Podemos entender, de esta manera, cómo en la revisión que hace Merikangas entre 1951 y 1982 encontró en Europa una tasa de prevalencia⁹ de la ansiedad entre el 0,5 y el 5,4%. En 1979, el National Survey of Psychoterapeutic Drug Use (cit. M. Bernardo) tiene en cuenta todos los tipos de ansiedad y encuentra una tasa de prevalencia anual de 9,9%. Y en 1982, el estudio de Zurich (Angst, 1982) encuentra, asimismo teniendo en cuenta todos los tipos de ansiedad, una tasa de prevalencia del 8,4%. En esta misma línea, en España, Vázquez Barquero (1987) encuentra una tasa de prevalencia del 11,18%. Es decir, de cada 100 personas de la población más de 11 padecen enfermedad ansiosa que es clínicamente detectable, pues estamos hablando de una enfermedad (aunque se incluyan casos leves, moderados y graves).

En resumen, podemos ver cómo el número de pacientes ansiosos van aumentando con los años; y además cuando se han diferenciado según sexo, son más abundantes en mujeres que en varones.

Este número tan elevado de personas que en nuestra sociedad padecen alteraciones ansiosas hace que sea muy frecuente que tengamos que tratar, día a día, esta enfermedad y lo que es aún peor: la realidad existente del elevado número de pacientes que «funcionan» en la sociedad sin ser tratados, ni por el médico de cabecera ni por el psiquiatra, con una calidad de vida no muy buena, pero, claro está, se asume por muchos que «esta sociedad es así» y que la ansiedad, el nerviosismo, y el estrés es algo «natural de nuestra forma de vida», lo cual es un gravísimo error.

Veamos a continuación qué es lo que denominamos *ansiedad*.

La palabra ansiedad proviene del latín *anxietas/atis* y hace referencia fundamentalmente a que nos encontramos inquietos, «agitados» o nerviosos. Muchas veces se confunde ansiedad con la palabra angustia (que proviene del término latino

angustus), pero angustia hace referencia más que nada a «angostura, opresión, estrechamiento». Así, cuando una persona se encuentra que nota síntomas de angustia, suele señalarlos como «opresión en el pecho o sensación de falta de aire». Una persona sana que por un problema de la vida diga encontrarse angustiada, ya está refiriéndose a esa opresión y zozobra interna que le oprime, y clásicamente ya se hizo esta diferencia, pues Eduard Brissaud, en 1890, admitía que la ansiedad se manifestaba con una sensación de inseguridad, pero la angustia se expresaba como sensación de sofoco (véase tabla 2.1).

No obstante, cada vez más se utiliza en la clínica habitual psiquiátrica y psicológica el concepto de «ansiedad» incluyendo en él también los síntomas de angustia.

Pero es necesario diferenciar claramente lo que es ansiedad «normal» y ansiedad «patológica». Tanto es así que ya desde que el término ansiedad se empieza a utilizar en el lenguaje médico a principios del siglo XVII, se estableció una diferencia entre las «reacciones normales» de las personas ante fracasos sentimentales, económicos o familiares, y *la repercusión excesiva* que acontecimientos semejantes originaban en otras personas. Esta «repercusión excesiva» era la ansiedad.

Podemos, por lo tanto, definir la ansiedad como un estado del organismo en el que éste se sitúa en alerta, por la vivencia de una amenaza de su integridad física o psicológica, con la finalidad de obtener un suplemento de energía para poder huir o luchar.

TABLA 2.1
Diferentes formas de definir la ansiedad

1. Siglo XVII ò Se empieza a utilizar «ansiedad» como término médico.
2. Robert Burton (1694) ò Alteraciones originadas por lo que llamó «temor».
3. William Cullen (1769) ò Crea el término neurosis.
4. Warburg (1799) ò Utiliza el término obsesión en su sentido actual; luego se difundió bastante este concepto por Luys (1883) y Fairet (1889)¹⁰.
5. O. Domrich. Principios siglo XIX ò Escribe sobre las crisis de ansiedad.
6. Thackrah (1831) ò Aparece el término ansiedad de mente¹¹.
7. Esquirol (1838) ò Describe las obsesiones y compulsiones.
8. Beard (1868) ò Utiliza por primera vez el término neurastenia.
9. Benedikt (1870) ò Describe un cuadro agorafóbico que denominó «mareo en lugares públicos» (Platzschwindel).
10. Westphal (1871) ò Describe tres casos de agorafobia.
11. DaCosta (1871) ò Corazón irritable o síndrome de DaCosta.
12. Dagonet (1876) ò Habla de la *hypemanie* ansiosa.
13. Legrand du Salle (1875) ò Habla de «locura de la duda con delirio de tocar» en relación a lo que hoy llamaríamos síndrome obsesivo-compulsivo.
14. H. Oppenheim (1884) ò Neurosis traumática.
15. E. Brissaud (1890) ò Diferencia ansiedad de angustia.

16. Sigmund Freud (1895) ò Neurosis de ansiedad.
17. J. Donath (1896) ò Introduce el término anancasmo del griego *ananke*, necesidad, fatalidad, obsesión.
18. Honigman (1907) ò Neurosis de guerra.
19. W. Stekel (1908) ò Parapatía ansiosa y parapatía obsesiva.
20. Sigmund Freud (1909) ò Introduce el término neurosis obsesiva.
21. P. Janet (1909) ò Introduce el término fobia de las situaciones sociales.
22. Paul Dubois (1909) ò Crea el término psiconeurosis.
23. F Skinner (1904-1990) ò Ansiedad-respuesta a una situación temida.
24. Walter Cannon (1911) ò Introduce el término estrés, en biología.
25. Hans Selye (1936) ò Considerado el descubridor del estrés, describe el síndrome general de adaptación (SGA) y lo asocia a sufrimiento.
26. A. Vallejo Nájera (1944) ò Neurosis psicótímic (predominan los síntomas somáticos).
27. J. J. López Ibor (1950) ò Timopatía ansiosa.
28. Lifton y Olson (1976) ò Síndrome del superviviente.
29. DSM-III (1980) ò Surge el término trastorno de ansiedad generalizada y trastorno por estrés postraumático (clasificación APA).
30. Peter Tyrer (1985) ò Síndrome neurótico general.
31. CIE-9 (1992) ò Estado de ansiedad (clasificación OMS).

Imaginemos que repentinamente nos persigue un toro o un león: nuestro cerebro va a poner en marcha mecanismos de alerta para que podamos escapar y notaremos temor, nos encontraremos tensos e inseguros (éste será el componente psicológico de la ansiedad); al mismo tiempo aparecerá sudoración profusa, sequedad de boca, palpitaciones... (éste es el componente fisiológico de la ansiedad); y buscaremos como locos un árbol donde subirnos, o un lugar donde escondernos; nuestra concentración y atención aumentará mucho en busca de estos lugares de salvación y si conocemos el lugar, nuestra memoria se activará para llevarnos a ese lugar que sabemos nos puede salvar (éste es el componente cognitivo de la ansiedad). Cuando el toro se ha ido o han cazado al león, poco a poco irán desapareciendo estos cambios psicológicos, fisiológicos y cognitivos y volveremos a la normalidad. Y lógicamente no iremos al psiquiatra, pues consideraremos que ha sido una respuesta «normal» ante una situación de peligro.

Por lo tanto, la ansiedad normal:

- Es un dispositivo que todos disponemos genéticamente como posibilidad de reacción y adaptación.
- Es adaptativa.
- Es deseable para conseguir una acción eficaz. Como hemos visto, cierto nivel de ansiedad mejora los rendimientos (igualmente ocurre ante un examen: cierto nivel de tensión y alerta nos mejora el resultado).

El problema aparece cuando ese mismo mecanismo que produce estos cambios de

alerta (por el toro, el león o por un accidente que sufrimos, aunque no nos pase nada) se pone en marcha sin que haya un peligro real. Entonces, el mecanismo no es anormal, es el mismo que ocurre cuando hay un peligro concreto, pero aparece de forma inadecuada, ya sea cuando estamos paseando, o en un restaurante, o simplemente en la calle, y en ese momento empezamos a notar esos síntomas: palpitaciones, sudoración, opresión torácica, deseo de orinar, y como no sabemos a qué es debido, si los síntomas son muy intensos, aparece pronto la vivencia de miedo indeterminado e incluso miedo a que nos de un infarto o a que nos pase algo. Ahora ya estamos hablando de la ansiedad patológica, que podemos resumir diciendo:

- Presenta una inadecuación entre el estímulo y la respuesta de nuestro organismo.
- No es adaptativa, no sirve como señal de alarma.
- Origina un gasto energético antieconómico, al no ser útil.
- Interfiere en los rendimientos: por ejemplo, en los rendimientos psicomotores, y el paciente no se siente capaz de conducir, o en los rendimientos psicosociales y el paciente no es capaz de hablar en público o ir a centros comerciales o a restaurantes..., interfiere en las decisiones, y a nivel fisiológico, en el campo del apetito alimentario y en el sexual.

En la tabla 2.2 mostramos los síntomas más frecuentes asociados a los estados de ansiedad.

TABLA 2.2
Síntomas más frecuentes ansiosos

1. Inquietud o excitación nerviosa, desasosiego. Tensión muscular, nucalgia, cefalea tensional que suele aumentar a medida que pasa el día, sensación de incapacidad de relajarse (se manifiesta a menudo en pequeños movimientos de las manos, piernas, tics, muecas).
2. Dificultad para concentrarse.
3. Dolores erráticos (cambian de lugar, por lo que suelen haber sido motivo de múltiples análisis y pruebas diversas médicas). Parestesias (sensación de hormigueos o como corrientes).
4. Sensación de opresión torácica o falta de aire, o sensación de opresión en abdomen o como un nudo en el estómago. A veces sensación de no poder tragar, como si tuviesen un nudo en el esófago. Vómitos, diarreas, eructos, meteorismo.
5. Palpitaciones, taquicardia, hipertensión, temblores.
6. Oleadas de calor o «como algo que sube» desde el abdomen o por todo el cuerpo. Sudoración, polaquiuria (tener que ir muy a menudo a orinar), o tenesmo (sensación frecuente de tener que ir a defecar).
7. Anorexia y muchas otras veces aumento del apetito (bulimia), sequedad de boca.

8. Insomnio. Irritabilidad e hiperestesia a ruidos (molestan mucho más los ruidos) sobre todo si hay insomnio. También a veces hiperestesia a luces (molesta la luz).
9. Vivencia de miedo. Temores difusos. Miedo a volverse «loco», a perder el control.
10. Sensación de mareo, sobre todo en la calle, en sitios donde hay bullicio, almacenes, centros comerciales. Se vivencia como una inestabilidad, como si «no pisasen seguro» el suelo al andar. Mucho peor si van solos, menos o puede que inexistente si van acompañados, también desaparece cuando van en coche.
11. Ansiedad anticipatoria, antes de ir a lugares donde «saben» que se van a encontrar peor. Conductas de evitación de esos lugares.
12. Preocupaciones hipocondríacas.
13. Preocuparse mucho por los acontecimientos cotidianos.

Y por todo esto la OMS (9.^a revisión) definió la ansiedad patológica como las «combinaciones variadas de manifestaciones físicas y mentales de ansiedad no atribuible a peligro real, que se presentan ya sea como crisis o bien como un estado persistente. La ansiedad es generalmente difusa y puede llegar al pánico», y Hofling, asimismo, define la ansiedad como «una emoción análoga al miedo pero que no es referible a ningún peligro externo».

¡Sí, cierto!, la ansiedad puede llegar al pánico, puesto que invadiéndonos «no nos permite escapar de ella ni por distracción, ni por los ruidos, ni cuando trabajamos, hacemos deporte o jugamos, ni de día ni de noche».

Vayamos a donde vayamos, la ansiedad es una fiel acompañante patológica.

Por esto escribió Sören Kierkegaard¹²:

«Ningún gran inquisidor tiene a su disposición formas tan terribles como la ansiedad.

Ningún espía sabe cómo atacar más diestramente al hombre del que sospecha, escogiendo su momento más débil, ni sabe cómo tender una trampa en la que se verá atrapado, como sabe hacerlo la ansiedad.

Ningún juez intuitivo sabe cómo interrogar y examinar al acusado como sabe hacerlo la ansiedad, que nunca le deja escapar, ni por distracción ni por ruido, ni en el trabajo ni en el tiempo libre, ni de día ni de noche».

Veamos ahora el estrés.

2.2. EL ESTRÉS

«A los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde.»

SÉNECA, LUCIUS ANNAEUS (4 a.C.-65 d.C.), filósofo latino.

Muchos pacientes que son muy trabajadores se preocupan de si debido al trabajo que realizan van a enfermar psíquicamente o van a tener de nuevo una depresión o una enfermedad ansiosa como la que han padecido. Yo les insisto: no hay problema en trabajar mucho y llegar a casa cansados, ¡pero no estresados! Hay una gran diferencia entre estar cansado y estar estresado. Si uno está cansado y duerme bien, no habrá, en principio, un mayor riesgo de enfermedad, pero si está estresado, el riesgo aumentará considerablemente al ser, ahora, mucho más vulnerable a la enfermedad psíquica.

Veamos, pues, qué es el estrés.

Hay mucha dificultad para definir el estrés, ya que tiene en el uso común distintos significados.

Dicen J. C. Mingote y F. Pérez que el término «estrés» es tres cosas a la vez: unas veces se considera que es el estímulo estresante (como puede ser una sobrecarga de trabajo, o una falta de sueño); otras, una respuesta al estrés (como puede ser la elevación de la tensión arterial), y por último, a veces, lo que se considera es una relación estresante (como pueden ser conflictos interpersonales, mala comunicación, etc.)¹³.

Para otras personas es sinónimo de sobresalto o equivale a malestar, y para la mayoría se entiende como tensión o sobrecarga no controlada (y por esto también se habla de *distress*, que hace referencia a injuria y aflicción, es decir, a un estrés nocivo).

También se ha relacionado el estrés con el modo de vida actual, con nuestras características de la civilización moderna. Así, comenta J. Guimón cómo se tiende a considerar que son la hostilidad de la sociedad y el «estilo de vida insano» de las ciudades las causas de los trastornos psíquicos. El origen de estas creencias, sigue este autor, tomó forma en el siglo XVIII, constituyendo la que ha sido denominada por Srole (1980) «doctrina mental de paraíso perdido». Pero ahora el hombre se siente cansado, sin tiempo ni sosiego, sencillamente, dice M. Yela: el hombre no puede más.

Y en el mismo sentido, K. Jaspers (1960) señala cómo la mayoría de los hombres están frente al mundo técnico sometidos y sin comprenderlo. Este mundo se convierte en un lastre, y finalmente adquiere para los hombres vida propia.

Lo que tenemos que tener claro es que el estrés no es una enfermedad como puede ser la ansiedad¹⁴, sino que va a ser fundamentalmente una reacción.

El término estrés se empleó inicialmente en metalurgia para referirse a la fuerza externa que deforma la estructura de un metal, que luego puede, bien volver a su forma anterior, o quedar deformado, o romperse.

En el campo biológico, Walter Cannon, en 1911, ya lo utilizó para designar a todo estímulo nocivo capaz de perturbar la homeostasis¹⁵ el equilibrio del organismo. Entendió al estrés como perturbador de la armonía interna (y por lo tanto como sobrecarga) y que pondría en marcha mecanismos autorreguladores para recuperar el equilibrio.

Hans Selye, en 1936, en la revista *Nature*, publica el concepto de estrés, y en 1954, en la primera edición española de su libro sobre el estrés, ya lo relaciona con dos palabras muy importantes: con sufrimiento y con capacidad de adaptación (síndrome general de adaptación)¹⁶. Para Selye, lo importante no eran los agentes productores del estrés, que podían ser muy variados, sino la repercusión en el organismo y la capacidad de éste para adaptarse.

Considerado como el «descubridor del estrés», especifica:

1. Cualquier sufrimiento general produce un síndrome...
2. Este síndrome conduce a la adaptación.
3. La adaptación puede originar la enfermedad.

La adaptación puede originar la enfermedad, ya que hay tres fases adaptativas:

- a) La reacción de alarma, en la cual todavía no se ha adquirido la adaptación.
- b) El período de resistencia (se adquiere la adaptación).
- c) El período de agotamiento, en el que se pierde la adaptación y aparecen síntomas como alteraciones del sueño, cansancio, dolores vagos, mareos... (véase tabla 2.3).

Cambell y Singer publicaron en 1983 un magnífico libro titulado *Estrés, drogas y salud*, en el que recopilaban interesantes trabajos en relación con el estrés, y aportaron tres características importantes:

1. Los neurotransmisores adrenalina y noradrenalina y el cortisol (glucocorticoide segregado por la corteza suprarrenal) están muy relacionados con el estrés.
2. Las situaciones de estrés originan un «coste fisiológico».
3. La vivencia de control o no control de la situación se relaciona de forma importante con el estrés.

Así, en un estudio de Frankenhauser, cuando las personas que tenían que realizar un trabajo o una tarea eran sometidos a un ruido de fondo de 76-78 decibelios, se producía un aumento de la secreción de adrenalina, noradrenalina, cortisol y una aceleración del ritmo cardíaco. Pero si a algunos de ellos se les decía que no se preocuparan del rendimiento, no se producía este aumento a pesar del ruido. Es decir, el tener que realizar el trabajo con unos objetivos marcados y con ruido (situación no controlada) producía una angustia y en definitiva un estrés medible en la liberación de esas sustancias, y esto no ocurría si no tenían que cumplir con las exigencias impuestas o si podían regular el nivel de ruido (situación controlada).

TABLA 2.3

Repercusión en el organismo del estrés (Puede haber repercusión en prácticamente todos los órganos y sistemas del cuerpo, por lo que sólo señalamos algunos de ellos)

- Aparato circulatorio ò Influye en la aparición del infarto de miocardio. Taquicardia, hipertensión.
- Aparato digestivo ò Diarreas, estreñimiento, bulimia, hipoglucemia, nauseas, vómitos, gastritis, úlcera péptica, colon irritable, sequedad de boca, malas digestiones, dispepsia.
- Síntomas generales ò Adelgazamiento, temblores, linfocitosis de guerra, hiperestesia a ruidos, irritabilidad, disminución de la capacidad de concentración y de la capacidad creativa, lapsos de memoria, dificultad para recordar nombres, aumento de los episodios alérgicos, insomnio, aumentan las infecciones. Las personas que cuidan a un familiar enfermo de Alzheimer tienen más infecciones y un sistema inmunitario más debilitado.
- Piel ò Sudoración, alergias, caída del cabello, la curación de heridas es más lenta, eczema.
- Sexual y ginecología ò Disminución de la libido, de la erección en el varón, bloqueo de la eyaculación, anorgasmia, eyaculación precoz, amenorrea y dismenorrea. Las mujeres tratadas de cáncer de mama que tenían apoyo social, presentaban mayor actividad inmunitaria y vivían el doble de años, que las que no tenían apoyo social o familiar.
- Sistema muscular ò Cansancio, cefalea, sensación de opresión en el pecho, pinchazos precordiales, dolor de mandíbulas.
- Drogas ò Aumento del consumo de alcohol, tabaco y consumo de drogas «ilegales».

Por otra parte, se determinó el «coste fisiológico» (es decir, un «precio» de esfuerzo orgánico) midiendo la secreción de estas sustancias (adrenalina, noradrenalina, cortisol) y midiendo al mismo tiempo la presión sanguínea y el ritmo cardíaco.

El coste fisiológico era superior en los trabajadores de la línea de montaje de una fábrica respecto a los de mantenimiento, que, en general, se mostraban más satisfechos con su labor.

El trabajo por turnos, las horas extraordinarias y los viajes de ida y vuelta al trabajo en medio de grandes aglomeraciones originaban un mayor coste fisiológico. El no poder controlar la situación generaba más estrés en los viajes diarios que la longitud del trayecto o la duración del viaje. La secreción de cortisol aumentaba intensamente en las situaciones de indefensión y vivencias de falta de control.

Igualmente ocurría con el hecho de trabajar contra reloj (por desgracia tan frecuente en nuestros días). Los niveles de adrenalina aumentaban cuatro veces y los de noradrenalina dos veces en los trabajadores que realizaban su labor a destajo¹⁷ o contra reloj, frente a los que hacían el mismo esfuerzo físico (medido según el consumo de oxígeno) pero sin ese «estrés de ritmo».

Por último, Cambell y Singer también señalan en relación con los trabajos por turnos, cómo el trabajador que los realiza se encuentra en un período importante de desfase de sus ritmos corporales (más aún si esos turnos cambian muy

frecuentemente). Cuando el estrés del trabajador por turnos se suma a la automatización, el coste fisiológico aumenta aún más. El incremento crónico de los costes fisiológicos producirá efectos nocivos en la calidad de vida y en la salud.

Por esto, decíamos al principio de este apartado que el estrés, en sí, no es una enfermedad concreta como puede ser la ansiedad, sino que es una reacción a la situación vivida que, por distintos motivos, rompe el equilibrio vital, y cuando el organismo no consigue volver a recuperar su normalidad entonces no es capaz de autorregularse, y en ese momento aparecerán las manifestaciones de lo que llamamos estrés, ya sea agotamiento, una depresión, un trastorno de ansiedad, o bien disfunciones sexuales, o problemas cardiovasculares o gastrointestinales. Por esto podemos decir que la patología del estrés es una patología de la vivencia situacional.

Ciertamente, mucho se ha escrito, y se sigue escribiendo, sobre las alteraciones biológicas (hormonales, inmunitarias...) que originan el estrés, pero la ansiedad, la cólera, la depresión y hasta el placer intenso pueden suscitar respuestas adrenocorticales semejantes a las originadas por cualquier perturbación emocional generalizada y, como indica R. Grinker, los efectos emocionales y fisiológicos resultantes del estrés son específicos de cada individuo.

Por lo tanto, lo importante es cómo se adapta una persona, y por esto ya se preguntaba Selye: ¿por qué «las enfermedades de adaptación» son tan polimorfas si todas ellas son debidas al estrés? Y ¿por qué la exposición a un mismo «estresor» produce sólo enfermedades a ciertos individuos?

Para intentar responder a esto último, tenemos que tener en cuenta una palabra importante que se repite en las diferentes definiciones del estrés: ésta es «situación». Es decir, la necesidad de valorar la situación individual que vive o vivencia cada persona que va a padecer de manifestaciones del estrés, y por lo tanto el significado que esa situación tiene para esa persona.

Situación

Toda vida se realiza en un mundo circundante, dice K. Jaspers (1913). Este mundo cercano es, pues, la situación que vivimos. En la situación que vivimos, sigue este autor (1932), cobran valor otros sujetos y sus intereses. La situación no es sólo una realidad natural, sino más bien una realidad *referida a un sentido*.

Por lo tanto, el mundo que nos rodea en cada momento, o lo que es lo mismo, las situaciones en las que nos encontramos van a tener siempre un significado especial para nosotros, un sentido, y por eso serán agradables, desagradables o estresantes¹⁸.

En el espacio cercano —vivido—, las situaciones (laborales, familiares, sociales, etc.) serán estresantes en cuanto que sean vivenciadas así por el sujeto. Las situaciones pertenecen, por lo tanto, a nuestro mundo vital, es decir, a nuestra manera de entender la vida y el mundo que nos rodea.

Kurt Lewin nos aportó un modelo que nos puede ayudar a comprender este concepto de espacio vital. Lewin¹⁹ creó un sistema psicológico que se denominó

psicología topológica. Utiliza los siguientes conceptos:

— Concepto de «campo»

Para Lewin, el campo psicológico es un espacio que incluye a todos los hechos reales con tal de que tengan efectos sobre el individuo, tanto si son conscientes para él como si son inconscientes. Influirá la personalidad, el ambiente y sus relaciones recíprocas.

Así por ejemplo, si tenemos un trabajo determinado, esto es, para Lewin un campo psicológico, puesto que lo importante es nuestra *vivencia* en él. El hecho de tener este trabajo determinado nos crea la vivencia de estar a gusto o a disgusto, pensar que nos queremos quedar allí o no, tener experiencias desagradables en el mismo, o agradables, ventajas por localización geográfica, economía, etc. Si nos queremos cambiar a otro trabajo, este nuevo será otro campo psicológico, pues la vivencia que tenemos de él también será, incluso antes de realizarlo, buena, mala, positiva, negativa, ventajoso o no económicamente, lejano o cercano de casa, etc.

— Concepto de «barrera»

Es el límite de cada campo. Las barreras pueden ser rígidas o permeables. Cuanto más rígida es una barrera, más «fuerza» psíquica habrá que hacer para poder pasarla y así entrar en otro campo. Por el contrario, una barrera permeable indica que es fácilmente penetrable. Así por ejemplo, imaginemos el campo psicológico que es el hogar (agradable, tranquilo, familiar, etc.) y tenemos que pasar a otro campo psicológico como es el trabajo. Si está cerca de casa y podemos ir andando, la barrera de campo «hogar» es bastante permeable, al contrario que si tenemos que ir en automóvil durante una hora de viaje. Pero imaginemos que un día tenemos que ir al mismo trabajo con un fuerte dolor en la pierna cuando andamos, entonces puede ser la barrera más rígida que en el caso de que tengamos que ir en automóvil.

— Concepto de «valencia»

La atracción o repulsión con que está cargado un campo se denomina valencia. Puede ser, por lo tanto, positiva o negativa. Siguiendo con el ejemplo anterior, si en el lugar de trabajo hay buen ambiente laboral y somos bien considerados, este campo psicológico «trabajo» estará cargado de valencias positivas, pero si allí tenemos mucho estrés y mal ambiente laboral, el campo «trabajo» estará cargado de valencias negativas.

Cuando queremos pasar de un campo a otro se produce una «tensión». Si la tensión hace que pasemos de ese campo al otro, se origina, dice Lewin, una locomoción.

Con estos conceptos de situación de Jaspers y de campo psicológico-topológico de Lewin tenemos una ayuda para entender el significado de «estrés percibido o vivenciado», ya que lo importante no es lo que «objetivamente» ocurre, sino qué

sentido tiene la situación para nosotros y cómo está cargada esta situación (o campo) de valencias (valores positivos o negativos).

Si en la situación que vivimos predominan las cargas de valencias como negativas se va a producir angustia, y si tenemos que pasar o ir constantemente a situaciones angustiosas, o vivir en campos psicológicos angustiantes, el gasto fisiológico será elevado por el esfuerzo psíquico persistente y, como dicen Campbell y Singer, el estrés es esfuerzo asociado a angustia.

* * *

Bien, ya sabemos qué es la ansiedad (patológica) y qué es el estrés; pero esto no es lo más importante; lo más relevante es que volvamos a la pregunta principal: ¿por qué un acontecimiento determinado, en un momento dado de nuestra vida, nos desencadena una enfermedad ansiosa?

Muchas veces los pacientes nos comentan con cierta perplejidad cómo en su vida han tenido acontecimientos importantes, como han podido ser fallecimientos de familiares de forma inesperada, o problemas económicos graves, o enfermedades importantes que les originaban mucha incertidumbre, y sin embargo, no les apareció un trastorno ansioso, pero... ahora, comentan, otro acontecimiento que consideran «lógicamente» de menor importancia les ha desencadenado una enfermedad ansiosa. ¿Por qué?, se preguntan.

Ya en 1950, Rollo May publicó un libro titulado *The Meaning of Anxiety (El significado de la ansiedad)*, y ya entonces introduce una palabra muy importante: «significado». Lo que ahora nos interesa es por qué ha tenido tanto significado, tanto impacto, una vivencia determinada en el sujeto hasta descompensarlo de su salud y originarle una enfermedad ansiosa.

Se ha intentado comprender esto mediante los denominados «acontecimientos vitales». El estudio más conocido es el de Holmes y Rahe, que en 1967 diseñaron una escala para valorar, mediante una puntuación el impacto de diferentes acontecimientos (*Stressful life events*). Hablaron de «unidades de cambio vital» y le dieron la máxima puntuación a la muerte del cónyuge (100 puntos), en segundo lugar el divorcio (73 puntos), siguieron con separación matrimonial (65 puntos), encarcelamiento (63 puntos), y así sucesivamente hasta un total de 43 acontecimientos vitales (véase tabla 2.4).

TABLA 2.4

Inventario de acontecimientos vitales estresantes de Holmes y Rahe (Schedule of Recent Experiences-SRE- 1967)

	PUNTUACIÓN (VALOR PROMEDIO ASIGNADO)
1. Muerte de la pareja	100

2. Divorcio	73
3. Separación conyugal	65
4. Condena a prisión	63
5. Muerte de un familiar cercano	63
6. Enfermedad o lesión personal	53
7. Matrimonio	50
8. Pérdida de empleo	47
9. Reconciliación con la pareja	45
10. Jubilación	45
11. Problemas de salud de un familiar próximo	44
12. Embarazo	40
13. Problemas sexuales	39
14. Aumento de la unidad familiar (nacimiento, adopción, etc.)	39
15. Readaptación en cuestión de negocios	39
16. Cambios en la situación financiera (ganar o perder más)	38
17. Muerte de un amigo íntimo	37
18. Cambio del tipo de trabajo	36
19. Cambio en la frecuencia de las discusiones de la pareja	35
20. Contrato de una hipoteca costosa	31
21. Vencimiento de una hipoteca o crédito	30
22. Cambio de responsabilidades en el trabajo	29
23. Independización de un hijo	29
24. Problemas con la familia política	29
25. Triunfo personal sobresaliente	28
26. Comienzo o final del trabajo de la pareja	26
27. Comienzo o final del colegio de los hijos	26
28. Cambio de las condiciones de vida	25
29. Cambio en las costumbres propias (vestuario, amigos, etc.)	24

30. Problemas con el superior laboral	23
31. Cambio importante en las condiciones o el horario de trabajo	20
32. Cambio de casa o residencia	20
33. Cambio del colegio de los niños	20
34. Cambio en el tipo y/o actividad en el tiempo libre	19
35. Cambio en la práctica religiosa	19
36. Cambio importante en la actividad social	19
37. Hipoteca o préstamo no muy elevado (coche, TV, etc.)	17
38. Cambio importante en los hábitos del sueño	16
39. Cambio importante en los familiares que viven juntos	15
40. Cambio importante en los hábitos dietéticos	15
41. Vacaciones	13
42. Navidad	12
43. Violación menor de la ley	11

En España, González de Rivera, J. L. y Morera, A. (1983), hicieron una adaptación, ampliando el número de acontecimientos hasta 61 y diferenciando por ejemplo entre embarazo deseado y no deseado, aborto provocado y no deseado, o introduciendo otros acontecimientos como relación sexual al margen del matrimonio, dificultades en la educación de los hijos o reformas en casa.

En todos los casos se entiende que son situaciones de adaptación, y en el caso de la muerte del cónyuge, que tiene la máxima puntuación, es debido a que por lo común sigue a ésta un cambio en el estado financiero, una revisión de hábitos personales, readaptaciones íntimas y de las relaciones sociales, etc.

Puede llamar la atención que en los últimos lugares se encuentren también las vacaciones (13 puntos) y las Navidades (12 puntos), pero de nuevo ha de entenderse que son situaciones de cambio de la dinámica regular de la vida que también suponen esfuerzos adaptativos, muchas veces porque los hijos están en casa en vez de en el colegio, otras veces por las obligaciones sociales de esos períodos, o por estar más tiempo las parejas juntas que durante el resto del año en que están ambos trabajando. De todas formas, independientemente de que se considere un acontecimiento positivo o negativo, siempre será estresante por la necesidad de adaptación situativa. Y por esto mismo le otorgan 50 puntos al matrimonio (aunque se realice con toda la dicha, amor y deseo del mundo) y 45 a la reconciliación conyugal.

Por ejemplo, «cambiar de casa», aunque se realice con todo el mejor deseo y placer, va a suponer: inestabilidad mientras se busca la nueva vivienda, carga complementaria de trabajo cuando se realiza el traslado, adaptarse a la nueva zona y vecindario, reorganizar luego la casa, etc.

Si en el período del último año se juntaban diversos acontecimientos y la suma de la puntuación era de 300 puntos o superior, el riesgo de enfermedad psiquiátrica o de infarto de miocardio, úlceras pépticas o infecciones era muy elevado (más de un 80% de probabilidad). Entre 200 y 299 puntos el riesgo es moderado (50%), y entre 150 y 199 aún habría un 33% de riesgo de enfermedad.

También se ha intentado medir la vulnerabilidad al estrés, valorando síntomas y conductas del estrés general. Es el caso del «Índice de reactividad al estrés» (IRE), de González de Rivera. Cuantifica la respuesta individual al estrés como un rasgo de la persona que es estable a lo largo del tiempo; es decir, como una forma de reaccionar del propio sujeto, ante el estrés, en cierto modo ya unida a su personalidad (tabla 2.5). El autor considera que una puntuación superior a 9-10 ya indicaría un probable trastorno de estrés.

Pero si bien, tanto la evaluación de los acontecimientos vitales como la determinación de la reactividad al estrés, nos permiten valorar el impacto de las circunstancias estresantes (en el primer caso) o medir la forma habitual de respuesta ante los factores externos estresógenos (con el segundo cuestionario), no obstante, sigue sin responderse a la pregunta ¿por qué ese acontecimiento ahora tiene un impacto tan intenso, llegando incluso a originar patología, y sin embargo anteriormente el mismo o uno parecido en otro momento de mi vida no me afectó tanto?

TABLA 2.5
Índice de reactividad al estrés
J. L. González de Rivera, 1990

El estrés es una respuesta automática del organismo ante situaciones que exigen mayor esfuerzo de lo ordinario, o en las que puede suceder algo peligroso, nocivo o desagradable. Cada persona tiene una serie de reacciones características ante el estrés, y algunas de las más frecuentes se enumeran en la lista que sigue.

Por favor marque las respuestas que le parecen más próximas a su forma habitual de reaccionar en situaciones de estrés o tensión nerviosa.

1. Inquietud, incapacidad de relajarse y estar tranquilo.
2. Pérdida de apetito.
3. Desentenderse del problema y pensar en otra cosa.
4. Ganas de suspirar, opresión en el pecho, sensación de ahogo.
5. Palpitaciones, taquicardia.
6. entimientos de depresión y tristeza.
7. Mayor necesidad de comer, aumento del apetito.
8. Temblores, tics o clambres musculares.
9. Aumento de actividad.
10. Náuseas, mareos, inestabilidad.

11. Esfuerzo por razonar y mantener la calma.
12. Hormigueo o adormecimiento en las manos, en la cara, etc.
13. Molestias digestivas, dolor abdominal, etc.
14. Dolores de cabeza.
15. Entusiasmo, mayor energía o disfrutar con la situación.
16. Disminución de la actividad.
17. Pérdida del apetito sexual o dificultades sexuales.
18. Tendencia a echar la culpa a alguien o a algo.
19. Somnolencia o mayor necesidad de dormir.
20. Aprensión, sensación de estar poniéndose enfermo.
21. Agotamiento o excesiva fatiga.
22. Urinación frecuente.
23. Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.
24. Sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad.
25. Diarrea.
26. Beber, fumar o tomar algo (chicle, pastillas, etc.).
27. Necesidad de estar solo sin que nadie le moleste.
28. Aumento del apetito sexual.
29. Ansiedad, mayor predisposición a miedos, temores, etc.
30. Tendencia a comprobar repetidamente si todo está en orden.
31. Mayor dificultad en dormir.
32. Necesidad de estar acompañado y ser aconsejado.

Puntuando con 1 punto cada respuesta que marquemos, a partir de 9-10 puntos nos indicaría un nivel de estrés, mayor cuanto más alta sea la puntuación. En la página web del autor del test (<http://www.psicoter.es/tests/test-de-estres>) se puede hacer una evaluación mediante este test, del nivel de estrés, de una manera más completa.

Tenemos que entender la importancia real en nuestra vida de lo que O. Schwartz denominó fuerza eficaz de una vivencia.

Este autor, en su libro *Psicogénesis y psicoterapia de los síntomas corporales*, se dio cuenta de la influencia que sobre el organismo podían tener los factores emocionales. Habló del concepto «fuerza eficaz». Las vivencias que desencadenan enfermedades tienen «fuerza eficaz»²⁰.

La «fuerza eficaz» de una vivencia nos va a mostrar su capacidad para desencadenar una enfermedad psíquica.

Esta fuerza se hallará en función de varios factores:

1. La *intensidad* de la vivencia.
2. El *tiempo* de duración de la vivencia.
3. La *edad* crítica del sujeto
4. El *significado* que la vivencia tiene para él.

2.2.1. La *intensidad* de la vivencia

Todo lo que el hombre vivencia, lo que hace, deja huella y altera su constitución lentamente, dice K. Jaspers (1975).

Pero cuanto más intensa sea una vivencia, mayor será su repercusión. Hay vivencias que de por sí son muy intensas, como son las relacionadas con la muerte, con catástrofes, con la familia o con personas cercanas afectivamente. Por esto, Karl Jaspers, en su libro *Filosofía*, llama «situaciones límite» a las que conllevan tanta carga afectiva, y dice: «Ante las situaciones límite no reaccionamos mediante planes y cálculos para superarlas, sino por una actividad completamente distinta, llegando a ser la posible “existencia” que hay en nosotros». Estas situaciones, considera Jaspers, son insuperables por la lógica, nos van a inundar de sentimientos y nos van a llevar a planteamientos sobre lo más profundo de cada uno (existencia). Considera que las experiencias intensas de realidades vividas unidas a la muerte, el sufrimiento, la lucha y la culpa son muy facilitadoras de situaciones límite.

2.2.2. El *tiempo* de duración de la vivencia

El tiempo puede hacer que una vivencia poco intensa pero duradera llegue a ser eficaz. Por esto, la tensión diaria que ya origina repercusión en la persona puede con el tiempo desbordar la capacidad psíquica y producir un trastorno psiquiátrico, lo más frecuente ansioso o depresivo. Cuando analizamos lo que ocurre en sujetos estresados, encontramos que no es que sufran unas vivencias muy graves día a día, por ejemplo de índole laboral o familiar, sino que éstas se repiten constantemente hasta que llega un momento en el que se desencadena la enfermedad.

2.2.3. La *edad* crítica del sujeto

El ser humano no se desarrolla de forma uniforme y sin grandes variaciones. Todo lo contrario, aunque a lo largo de nuestra vida siempre estamos expuestos a continuos cambios y adaptaciones, no obstante hay una serie de etapas que son especialmente importantes, pues «en ellas se producen importantes cambios», muchas veces sólo de origen psíquico y en otros casos también físicos.

La primera etapa, que describió Conrad, se produce entre los 6-8 años y se denomina primera metamorfosis. Igual que un gusano de seda cuando cambia realiza

una metamorfosis y se transforma en mariposa, siguiendo con este símil, la idea es que en estas primeras edades, entre los 6-8 años, el niño «ya deja de ser un niño pequeño», cambia muy rápidamente, quizá en uno o dos años ya es un «niño adulto» que razona mucho más, pero muchísimo más, que uno o dos años antes. Antiguamente se decía que «ya ha adquirido conocimiento» para indicar este cambio en estas edades, en las que ya se les podía dar más responsabilidades, que eran entendidas y asumidas por los niños —mientras que sólo uno o dos años antes era inconcebible—.

La segunda metamorfosis es quizá la más conocida. Aparece entre los 13-16 años y se corresponde con la adolescencia²¹, ese período en el que se producen abrumadores y rápidos cambios en los jóvenes en muchos niveles; en el físico, con la pubertad, cambio de voz y aparición de los caracteres sexuales secundarios, pero también se producen muchos cambios desde el campo psicológico. Deja de ser un «niño adulto» para «sentirse adulto». Aparece la rebeldía propia de la adolescencia y toda la transición hacia el período de madurez, que realmente le hará adulto, con la toma de responsabilidades y autonomía para responder a ellas.

La tercera metamorfosis de Conrad aparece entre los 35 y 50 años, y es el período de «balance existencial».

Entramos en crisis, en este período de edad, pero es una crisis muy especial, y por eso se ha denominado de balance existencial. Te planteas, «ya no soy un joven o una joven de 26 años, pero tampoco soy mayor», «ya estoy más o menos establecido en mi vida, trabajo, etc.», pero ya ha pasado la juventud. Y ahora vienen las preguntas: ¿Y qué he hecho de mi vida? ¿Ha valido la pena lo que he realizado? ¿No tiene sentido lo que he hecho? ¿No era eso lo que quería? ¿No ha valido la pena?

Evidentemente, muchas veces acontecimientos que ocurren en estas etapas de la vida pueden tener mayor impacto vivencial, mayor fuerza eficaz. Somos psíquicamente más vulnerables en esos momentos; al igual que cuando cambiamos de casa es más fácil que se rompa alguna cosa, pues todo está en movimiento, en estas etapas de metamorfosis nuestros cimientos existenciales están menos sólidos, nuestra experiencia pasada, nuestra vida que ya ha transcurrido, no tiene la misma consistencia que hasta ese momento tenía y por eso somos más vulnerables.

2.2.4. El significado que la vivencia tiene para él

Vamos a entender como «significado» a «la relación de una parte con el todo». Cualquier acontecimiento ocurrido no tiene significado o sentido alguno si no se relaciona con una totalidad que le sirve de referencia. Cuando digo que para mí significa mucho o tiene mucho significado una cosa, por ejemplo, tener un apartamento en la playa para veranear, eso quiere decir que para esa persona el «apartamento» lo relaciona con algo importante en relación con *toda su vida*. Puede ser que lo considere algo necesario por estatus social, o por calidad de vida o porque siempre veraneó en la montaña... Sea lo que fuere, cuando decimos que esto es muy significativo o que tiene mucho significado, estamos relacionándolo con muchas

características emotivas, recuerdos, necesidades, o aprendizajes que hemos realizado en la vida.

Igualmente ocurre con las vivencias y su *fuerza eficaz*. Si, como decíamos, la situación o el acontecimiento que tiene mucho «significado» para nosotros lo estamos relacionando con aspectos importantes de nuestra vida, recuerdos o situaciones pasadas, entonces podemos comprender la enfermedad que padeció una paciente, por el impacto (fuerza eficaz) que le originó el que su marido sufriera un infarto. El infarto del marido tuvo un especial significado para ella (relación de la parte con el todo) no sólo por la preocupación por la patología del cónyuge, de la cual se recuperaba bien, sino porque en la familia de ella habían fallecido varias personas por dolencias cardíacas. Por lo tanto, en este caso el infarto del marido se relacionaba con toda la vida futura que podría tener ella, con inseguridades, con vivencias pasadas dolorosas, etc., por lo que tuvo una fuerza eficaz especialmente intensa, desencadenándole la enfermedad psiquiátrica.

Todos estos factores hemos de tenerlos en cuenta a la hora de entender por qué y cómo aparece una enfermedad ansiosa en un paciente; como dice Oswald Schwarz, «el valor eficiente de una vivencia se halla condicionado:

1. Por la vivencia misma,
2. Por el pretérito relacionado con ella,
3. Por la constitución.
4. Por factores de vulnerabilidad y exógenos.

Y especialmente insiste en la importancia que el pasado tiene en la fuerza eficaz de la vivencia cuando dice «en toda vivencia psíquica se hallan representados procesos pretéritos [...] en toda vivencia psíquica pervive el pasado determinando el valor eficiente de una nueva vivencia. O expresándolo en otros términos: factores energéticos psíquicos del pasado son transferidos a toda nueva vivencia [...] la totalidad del pasado presta su halo a la nueva vivencia que emerge ahora».

En definitiva, para Schwarz, la totalidad del pasado actúa en el presente, y es decisivo para la fuerza eficaz de una vivencia todo el pasado que se halla enlazado a la misma.

Así pues, la fuerza eficaz de cualquier vivencia concreta dependerá de la historia vital (psicobiografía) del individuo, de lo que le ha ocurrido y vivenciado en su vida anterior.

Como señala Rojo Sierra (1961), el que una vivencia produzca una enfermedad no ocurre de forma inespecífica, sino individualizada, personalizada. En cada caso es totalmente diferente la fuerza con que puede contar una vivencia. De esta manera podemos entender cómo la vivencia, el acontecimiento que ha ocurrido y que le ha desencadenado la enfermedad ansiosa, si bien podría no ser por sí misma patógena, sí que lo ha sido «en esa persona», debido a que por las circunstancias de su vida, o por sus vivencias anteriores, ha tenido un «significado» especial.

En definitiva, es necesario conocer la totalidad de la vida del paciente (su psicobiografía) para comprender por qué tal o cual acontecimiento ha tenido esa

fuerza eficaz. Si no realizamos esta «comprensión» de la vida del paciente, es decir, un conocimiento biográfico que nos muestre el significado, las relaciones de las vivencias ansiógenas actuales con el todo pretérito, si no conocemos este significado de sus vivencias, no diagnosticaremos personas enfermas, sino sólo síntomas que padece alguien que tenemos delante, que está enfermo, del que sabremos su nombre, pero no sabremos *quién* es ese enfermo, ni qué enfermedad padece *él*. ¡Cierto, le haremos un diagnóstico de trastorno de ansiedad!, identificaremos los síntomas y le daremos tratamiento, la mayoría de las veces con psicofármacos. ¡Y si a continuación viene otro paciente con una enfermedad ansiosa parecida, probablemente le indiquemos el mismo diagnóstico, pues tiene los mismos síntomas, y también le daremos el mismo tratamiento o uno muy parecido!

Así estaremos tratando «esquemas humanos», y no a verdaderos seres humanos sufrientes que padecen una enfermedad única en ellos, pues el significado de la misma está enraizado en lo más profundo de su propia vida.

Por esto, ya decía J. J. López Ibor (1966):

- Contentarse con conocer los cuadros clínicos y tratar de clasificar los enfermos con un único propósito de describir y clasificar su enfermedad, es renunciar a la comprensión vital de cada caso.
- La experiencia clínica consiste en la *singularización en la comprensión del enfermo*.
- Ésta es la psiquiatría que no está en los libros... ésta es la psiquiatría que está en la médula de los verdaderos psiquiatras.

2.3. LA ANSIEDAD COMO ENFERMEDAD QUE SE «COMPRENDE» EN LA TOTALIDAD DE LA PROPIA VIDA

«El pasado tiene sus códigos y costumbres.»

SÓCRATES (470-399 a.C.), filósofo griego.

En base a lo referido anteriormente, lógicamente, ya podemos entender que sin conocer la vida de la persona enferma que tenemos delante, sin realizar el estudio de su pasado (psicobiografía), no vamos a poder comprender la enfermedad particular de ese enfermo, y lo que es más importante, el sentido que en él tiene *su* enfermedad. Si sólo estudiamos los síntomas y nada más, desindividualizamos al paciente, no conocemos su singularidad. El valor peculiar del hombre está en el *individuo histórico* que es insustituible, dice Jaspers en su libro *La fe filosófica*.

Pues bien, si hablamos de historia personal del individuo, para entender el sentido de su enfermedad, es necesario nombrar al que inició esta importante concepción. Éste fue Wilhelm Dilthey²².

Dilthey fue un explorador de la vida psíquica que entendió la necesidad de conocer el sentido de las vivencias que tenemos en cada momento en base a nuestro

pasado y a lo que hemos vivido anteriormente, y por eso concibe que la realidad de la vida psíquica actual consiste en esa mezcla inquietante del pasado con el presente.

Comprender una enfermedad, un trastorno, es descubrir las conexiones de sentido que tiene lo actual en relación con la vida psíquica pasada. Y evidentemente, en nuestra vida psíquica pasada influye el momento histórico en que nos hemos encontrado. Por ello, cuando realizamos el estudio de la vida del paciente también hay que entender qué significado tuvo para él, en aquel momento de la historia, el acontecimiento que entonces le ocurrió. Puede ocurrir que cuando estudiamos a un paciente y su vida, sucesos a los que ahora no le daríamos la menor importancia, en otro momento de la historia (por ejemplo hace 40 años) fuesen muy importantes y de gran repercusión para él, por el contexto cultural. Es importante detectar «experiencias clave» de la vida del paciente, decía Von Weizsäcker.

Por esto, dice Dilthey, «toda concepción del mundo está condicionada históricamente. Qué es el hombre sólo se lo dice su historia. La melodía de nuestra vida psíquica está condicionada por las voces del pasado que la acompañan. El hombre no es, sin lo que ha sido, lleva consigo su pasado. Gracias a la historia de cada hombre se es alguien insustituible e intransferible». Y por todo esto cada individuo «tiene su mundo respectivo, y para conocer el sentido de un hecho hay que conocerlo dentro de una vida donde se experimenta».

Como indica Rojo Sierra (1978), a lo largo del estudio psicobiográfico podemos comparar un hecho actual con los sucedidos y vividos por el individuo en otros tiempos... y así podemos enlazar y relacionar las vivencias entre sí y descubrir cómo se encajan unas con otras y, enlazándose sucesivamente, se recomponen ordenadamente a modo de eslabones de una cadena; es el «todo vivido». Así pues, gracias al estudio de la biografía se revela la relación que tiene cualquier vivencia determinada con la totalidad, y por lo tanto se hace patente que cada vida tiene sentido propio.

Por lo tanto, el psiquiatra ante un paciente con ansiedad tiene que hacer una comprensión del sentido y significado de las vivencias del paciente. Así podrá explicarle por qué le ha aparecido su enfermedad ansiosa y cómo es esta enfermedad. El paciente puede realizar entonces una comprensión de sí mismo, una autognosis²³. Si la vida psíquica no se comprende, ninguna psicología será posible, se trataría de un simple caos, insiste Dilthey.

Con el estudio psicobiográfico nos acercamos directamente a la autognosis. Mediante la autobiografía se llega a captar el sentido del pasado. Las cosas que tienen importantes conexiones, grandes significados, son preferentemente recordadas y jamás o difícilmente se olvidan. A través del estudio psicobiográfico es como se hace patente que «cada vida psíquica tiene su sentido propio».

¿Y cómo considera Dilthey que podemos hacer esta comprensión de nuestra vida psíquica?

Evidentemente, para él lo fundamental es descubrir lo que denominó la categoría del significado.

El significado, como ya indicamos anteriormente, es el modo especial de relación

que dentro de la vida psíquica guardan las partes con el todo. Consiste por lo tanto en conocer la influencia que tienen los acontecimientos pasados en el presente. Así por ejemplo, comprenderemos por qué suspender un examen le ha producido a un estudiante una crisis aguda de ansiedad teniendo que acudir a urgencias, cuando conocemos qué significado tenía ese examen para él en concreto (relación de la importancia del resultado del examen con la totalidad de su vida pasada = descubrir el significado). Por esto dice Dilthey que el sentido de la vida resulta de conocer el significado de las vivencias.

Veamos un ejemplo de la comprensión de la enfermedad en un paciente que padece una enfermedad ansiosa.

C. R. V. es una joven soltera de 24 años. Su temperamento lo define como «nerviosa de siempre», tozuda, genio fuerte e introvertida.

Es hija única. El padre, también de genio fuerte, es padecedor, y la madre es definida como tranquila y cariñosa. Ella vive con los padres y los abuelos maternos. Cuando se casaron sus padres la madre no fue admitida por los suegros, que «querían otra cosa para su hijo».

La familia de la paciente estaba muy bien estructurada, y por esta circunstancia tanto los padres como los abuelos maternos, que vivían con ella, se apoyaban mucho y estaban muy bien cohesionados y de acuerdo en que la familia fundamental eran ellos cinco.

La abuela materna es definida como ansiosa: «me ha mimado siempre», «siempre estaba encima de mí, no me dejaba hacer nada». El abuelo materno, aunque no tanto como la abuela, también era padecedor.

En conjunto, ambos abuelos realizan una hiperprotección ansiosa sobre la paciente.

C. R. V., desde los 4 años de edad padecía constantemente bronquitis —«cada quince días tenía bronquitis», dice la abuela—, y la madre era la que estaba continuamente cuidándola. Estas bronquitis de repetición le duraron con mucha frecuencia hasta los 8 años de edad.

Luego, ya el resto de la infancia fue normal, y la escolaridad y sociabilidad asimismo normales, sin acontecimientos relevantes.

Cuando tiene 14 años acaba la escolaridad y se queda en casa cosiendo, bordando y ayudando en las faenas domésticas. Sale con amigas los fines de semana, pero en su *escala de valores se encuentra en primer lugar «la familia»*, pues siempre se ha sentido muy armónica en casa con los padres y abuelos.

Cuando ella tiene 19 años, el abuelo materno, tras una breve enfermedad de cuatro días, muere en casa. A ella le impactó mucho: «vi cómo era la vida», «no era nada».

Poco después se rompe la relación que tenía con su novio, pues él la engañaba con otras mujeres.

Empezó a padecer síntomas ansiosos que se manifestaban con palpitaciones, «no podía estar sola», flojedad de piernas, sensación de mareo a modo de inestabilidad mayor en los centros comerciales o si iba sola por la calle, pero menos si iba

acompañada, y no los padecía en casa ni cuando iba en coche.

Aun con esta sintomatología, conoce a otro chico y se ennovian. Ella se enamora mucho de su nueva pareja, pero no es admitida por la familia de él. Los padres de él le dicen que quieren algo «mejor» para su hijo.

Tras dos años de noviazgo piensan casarse, pero la familia de él no apoya en absoluto este matrimonio y hacen múltiples intentos para convencerle a él de que no se case.

Definitivamente deciden casarse y quieren ir a vivir a un piso que está situado encima de donde viven los padres de ella, pero no tienen economía, ellos solos, para hacer la reforma y amueblar el piso, si no es con la ayuda de los padres de él, que al pedírsela se niegan.

En estas circunstancias aumenta mucho la sintomatología, con mucha ansiedad, sensación de tensión interna, opresión abdominal, como un nudo en el estómago, sensación de falta de aire, más palpitaciones, sudoración de manos, cefalea, insomnio y le aumenta más la sensación de mareo al salir a la calle.

Comentario

La comprensión, dice Jaspers (1913), radica en el descubrimiento de la verdadera conexión de motivos que se hace *real* en el paciente. La comprensión es un modo de ordenar los fenómenos psíquicos sucesivos transcurridos en el tiempo, dando un sentido al dinamismo de la vida.

Esto es como si hiciéramos un camino de conexiones y relaciones desde el «yo-presente» hasta el más lejano «yo-pasado», valorando en todo momento la importancia lógica y afectiva de cada situación del presente y sus conexiones con las situaciones pasadas que nos han influido. Cada situación presente y pasada tendrá su valor específico en cada persona²⁴.

En nuestro caso, es muy importante el hecho de ser hija única y vivir con los padres y abuelos, en una estructura muy cohesionada, más en cuanto que su madre fue rechazada, no admitida, por la familia del padre.

Aquí tenemos una «situación» en el pasado, cargada muy intensamente de un fuerte «valor» afectivo. La vivencia «familia unida-matrimonio unido» adquiere un valor positivo y los padres de la rama paterna adquieren un valor negativo, «destructor del símbolo familiar». Cuando muere el abuelo materno aparece una situación límite, es decir, un impacto existencial ante la muerte. La vivencia de destrucción del núcleo familiar le origina tal vulnerabilidad que la ruptura de la relación con el novio (de nuevo una vivencia de quiebra de proyecto familiar) ya hace que se manifieste claramente la sintomatología ansiosa patológica y comience la enfermedad.

Las situaciones se van encadenando unas tras otras con un gran significado, dejando su marca vital que tiene sentido con la totalidad de la persona. La ansiedad que le aparece se comprende perfectamente por el significado (relación de cada

situación con el todo de la persona).

De nuevo aparece un proyecto familiar con el nuevo novio, que es posible de ser integrado en el núcleo principal (padres y abuela de ella), pero otra vez más se revive la angustia de la posibilidad de destrucción del proyecto nuevo matrimonial, por los esfuerzos de los suegros para evitar el matrimonio, no ayudando nada e incluso deseando que no pudieran vivir juntos en el mismo espacio vital que los padres y abuela de ella, y no tuvieran piso.

Se mantiene de fondo una revivencia del rechazo hacia la paciente por parte de los padres de él, al igual que ocurrió con la madre de la paciente.

La fuerza eficaz de las vivencias, y su impacto efectivo capaz de originar enfermedad es comprensible cuando entendemos el significado de las *situaciones-vivencias* que se han concatenado desde el pasado hasta la actualidad en la vida psíquica de la paciente.

Y por esto mismo E. Fromm considera fundamental el examen de la «situación humana» para definir la salud o enfermedad mental.

* * *

El tratamiento, por consiguiente, no sólo será psicofarmacológico, sino que además, una vez que ya se ha realizado el estudio psicobiográfico-situacional, le explicamos al paciente con palabras que pueda comprender, sin tecnicismos, su enfermedad y los factores biográficos importantes, ya de la infancia, o posteriores de la adolescencia o adultez, que le han sensibilizado o desencadenado su enfermedad ansiosa. Es importante que el paciente «entienda» su enfermedad y el impacto que han tenido esos factores para conformar su estado actual.

Queremos que el paciente comprenda su enfermedad ansiosa y buscaremos que pueda de algún modo «objetivar» su vida²⁵.

«Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro», decía Confucio 500 años antes de Cristo, y en este sentido quisiera terminar este apartado, dejando bien claro que mediante la comprensión psicobiográfica del paciente ansioso no sólo vamos a conocer *su* enfermedad, no sólo vamos a tratar *su* enfermedad, sino que además vamos a favorecer en él una *autognosis*, un entenderse él mismo en su enfermedad ansiosa en la totalidad de su vida, y de esta manera el médico psiquiatra ya no será un especialista que se dedica exclusivamente a curar enfermos (que ya es una excelsa dedicación), sino que además, siendo eubiata²⁶, ejerce su labor psiquiátrica también «enseñando a vivir»; y ésta es la psiquiatría que debe estar en la médula de los verdaderos psiquiatras, como indicaba López Ibor.

NOTAS

⁸ Fijémonos que siguen vigente en la actualidad factores generadores de ansiedad que ya eran claramente planteados por autores en los años cincuenta e incluso antes. El mundo civilizado ha avanzado mucho en la técnica y en las posibilidades de utilización de aparatos para nuestro mejor vivir, ¿pero ha mejorado la maduración psíquica del hombre o de la sociedad? Dice Fromm: si la edad contemporánea ha sido llamada con razón la época de la ansiedad, se debe primordialmente a la falta de sentimiento del «yo». En la medida en

que «yo soy como usted me desea», yo no soy: estoy angustiado, dependo de la aprobación de los demás, procuro constantemente agradar.

[9](#) La «tasa» es un coeficiente que expresa la relación entre la cantidad y la frecuencia de un fenómeno o un grupo de fenómenos. La mayoría de los estudios muestran una tasa de prevalencia, es decir, el número de casos presentes en la población en un tiempo dado.

[10](#) Datos aportados por J. Vallejo (2006).

[11](#) Thackrah adscribió vulnerabilidad a la necesidad especial de los médicos de estudiar e investigar y (lo peor de todo) a las guardias nocturnas (cit. M. H. Stone).

[12](#) Kierkegaard «descubre» la ansiedad en 1844 en un opúsculo titulado *The Concept of Dread* (cit. Goodwin).

[13](#) Fijémonos en la dificultad de definir lo que es el estrés, pues en su propio intento de definición se utiliza asimismo la palabra estrés (por ejemplo, al decir que es estrés es una respuesta al estrés...).

[14](#) En lo sucesivo, cuando me refiera a «ansiedad», quiero siempre decir que es «ansiedad patológica».

[15](#) Homeostasis (del griego *homeo*, que significa «similar», y *estasis*, en griego *στάσις*, «posición», «estabilidad») La homeostasis es la característica de un sistema, especialmente en un organismo vivo, que regula su ambiente interno para mantener una condición estable y constante. El concepto fue creado por Claude Bernard, considerado a menudo como el padre de la fisiología, y publicado en 1865. Tradicionalmente se ha aplicado en biología, pero dado el hecho de que no sólo lo biológico es capaz de cumplir con esta definición, otras ciencias y técnicas han adoptado también este término (wikipedia.org).

[16](#) Es curioso cómo Selye utiliza la palabra adaptación, y en su propia biografía tuvo que adaptarse de una forma importante. Él era austrohúngaro educado en Praga en idioma alemán, y también estudió en Roma. Trabajaba en la Universidad de Montreal de habla francesa y escribía en inglés (sin dominarlo perfectamente).

[17](#) La frase trabajar «a destajo» proviene de Alexei Stajanov, minero ucraniano que batió récords de extracción de carbón (el 31 de agosto de 1935 logró, en ese día, recolectar 102 toneladas de carbón superando por 14 veces los estándares de recolección) y al que Stalin puso de ejemplo de héroe del trabajo comunista.

[18](#) El mundo no es simplemente un mundo de cosas, sino el mundo en el que se vive; tiene, pues, un carácter vital y circunstancial definido por el individuo para quien es mundo (comentario de Julián Marías a la frase de Dilthey: «Así crea la vida desde cada individuo su propio mundo»).

[19](#) He simplificado y adaptado los conceptos de la psicología topológica de Lewin del libro *Fundamentos doctrinales para una psicología médica*, M. Rojo Sierra.

[20](#) A la fuerza de una vivencia, Schwarz lo denomina «valor eficiente» (*Wirkungswert*). Es la fuerza impulsora y modificante que tiene la vivencia. Rojo Sierra lo interpreta como «fuerza eficaz», centrando este concepto en la fuerza de la vivencia para desencadenar enfermedades psíquicas.

[21](#) La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como «[...] un estado de espíritu y un nivel de desarrollo psicosocial, en el que domina la imaginación, el gusto por la aventura y la necesidad de revisar las normas establecidas con el fin de reafirmar su personalidad [...]». Distingue entre una adolescencia temprana desde los 10-14 años y una adolescencia tardía de 15 a 19 años.

[22](#) Aunque anteriormente San Agustín, en las *Confesiones*, se dedicó a tener en cuenta el contenido y el sentido de las vivencias.

[23](#) El término «autognosis» fue aportado por Ortega y Gasset para referirse a esta concepción de Dilthey de «conocerse a sí mismo».

[24](#) Dilthey habla de la categoría del valor. Llama valor a la captación afectiva del momento de la vida (positivo/negativo, grato/molesto, aceptable/rechazable...). El valor propio de la persona es la captación afectiva que hacemos de la totalidad de nuestra vida psíquica: «cuando la vida se convierte en objeto de sí misma», esto es el valor propio de la persona.

[25](#) Como señala L. Martín-Santos, Jaspers añade a la comprensión de Dilthey que el enfermo puede comprender sus vivencias como morbosas (insanas o enfermas). Es la comprensión racional.

[26](#) Eubiatra. Término utilizado por Emilio Mira y López (1945). M. Rojo Sierra, en *Psicopatología de la sociedad* (1962), remarca en relación con este concepto la idea de que la labor del psiquiatra no es sólo curar enfermos, sino también «enseñar a vivir».

3. LOS SUCECOS DE NUESTRA VIDA QUE PUEDEN INFLUIR EN LA APARICIÓN DE LA ANSIEDAD²⁷

«Cada cual es como Dios le ha hecho, pero llega a ser como él mismo se hace.»

MIGUEL SERVET (1511-1553), médico y reformista español.

Por lo que hemos podido ver hasta ahora, en psiquiatría no va a ser válido el buscar una causa en la infancia, en la adolescencia, o en un período concreto anterior al que aparece la enfermedad ansiosa, ya que un hecho concreto no va a determinar obligatoriamente una enfermedad concreta. Es decir, si ha habido, por ejemplo, un accidente en un familiar cercano, esto puede no originar ninguna enfermedad, o bien puede tener mucha fuerza eficaz y originar una enfermedad ansiosa, pero también puede desencadenar una depresión u otro trastorno psíquico.

Para que algo sea la «causa» de la enfermedad tienen que ocurrir tres características:

1. Que sea unívoca: es decir, un suceso A origina un suceso B (por ejemplo, accidente de familiar ò enfermedad ansiosa).
2. Que sea necesaria: es decir, sólo se producirá el suceso B si antes se ha dado el A (sólo se producirá la enfermedad ansiosa si antes ha ocurrido el accidente del familiar).
3. Que sea suficiente: bastará que se produzca A para que se produzca B.

Cuando se dieran las tres circunstancias diríamos que A es la causa de B.

Es cierto que a veces tendemos a considerar, equivocadamente, que un acontecimiento reciente ha sido «la causa» de que padezcamos un trastorno de ansiedad, pues observamos que, por ejemplo, «fue dejarle el novio y empezó toda la ansiedad», pero tengamos bien claro que si fuera la causa, a todas las personas que les deja el novio tendrían una enfermedad ansiosa, y esto ya sabemos que no es así.

En psiquiatría, en la enfermedad ansiosa, como hemos podido ver en el apartado anterior, pueden existir muchas circunstancias que hayan influido en la enfermedad pero ninguna es la determinante. Incluso cuando decimos que un acontecimiento ha sido el desencadenante, tenemos que valorar la vida, la psicobiografía, para comprender por qué ha tenido esa fuerza eficaz.

Por esto tenemos siempre que conocer los hechos anteriores y sus conexiones reales con la enfermedad ansiosa actual.

Todo ese conjunto de acontecimientos, combinados en esa persona concreta,

cuando originan una enfermedad se denomina campo etiopatogénico, ya que:

- Campo = Conjunto de acontecimientos interrelacionados entre sí.
- Etiopatogénico = Han originado una enfermedad.

Siguiendo a Rojo Sierra, vamos a considerar dentro de un campo etiopatogénico tres apartados:

1. Factores de disposición: son factores de índole biológica, que pueden cambiar la vulnerabilidad del cerebro y en determinado momento favorecer la enfermedad ansiosa. Aquí también incluiremos los rasgos temperamentales.
2. Factores de sensibilización psicobiográfica: son todas las influencias del ambiente, familia, infancia, que han actuado a lo largo de nuestra vida.

Se distinguen dentro de este apartado:

- a) Privación de una comunicación adecuada.
- b) Aprendizajes anómalos.
- c) Frustraciones.
- d) Conflictos.

3. Factores desencadenantes: son los que van a actuar como percutores, los que van a tener la suficiente fuerza eficaz para originar en un momento dado la enfermedad ansiosa.

Vamos a considerar ahora cada uno de estos apartados, de una manera más detallada.

3.1. FACTORES DISPOSICIONALES

3.1.1. La herencia

La enfermedad ansiosa no se hereda de padres a hijos como se heredan otras características físicas, como pueden ser la calvicie, rasgos faciales o el color de los ojos.

Existen unas leyes muy conocidas en relación con la herencia, que son las denominadas leyes de Mendel, y que no van a ser válidas para la enfermedad psiquiátrica.

Gregor Mendel, considerado padre de la genética, fue un monje austriaco que nació en 1822. Entre 1856 y 1863 realizó experimentos con hibridación de plantas. Demostró, en resumen, que hay caracteres genéticos que se heredan. Así, si unimos una rosa blanca y una rosa roja, la primera generación aportará, por ejemplo, cuatro rosas todas de color «rosa». Pero si uníamos luego una rosa «rosa» con otra rosa «rosa», aparecería una rosa blanca (25%), una rosa roja (25%) y dos rosas «rosas»

(50%). Por lo tanto, en las generaciones siguientes se heredaban caracteres de los padres de forma directa.

Así es lo que ocurre (más o menos) cuando entendemos que «mi padre es calvo y yo también soy calvo», o cuando decimos que hemos heredado «los ojos azules de mi madre...», etc.

Otro autor, Galton (finales del siglo XIX), optó por realizar una curva de probabilidad de riesgo de enfermar.

Esta curva se basa en los trastornos psíquicos de los familiares del sujeto, y a partir de conocer la frecuencia de estas enfermedades en los familiares se calcula una probabilidad de enfermar, de un individuo, tomando como comparación la población general.

Predisposición
endógena
(herencia)

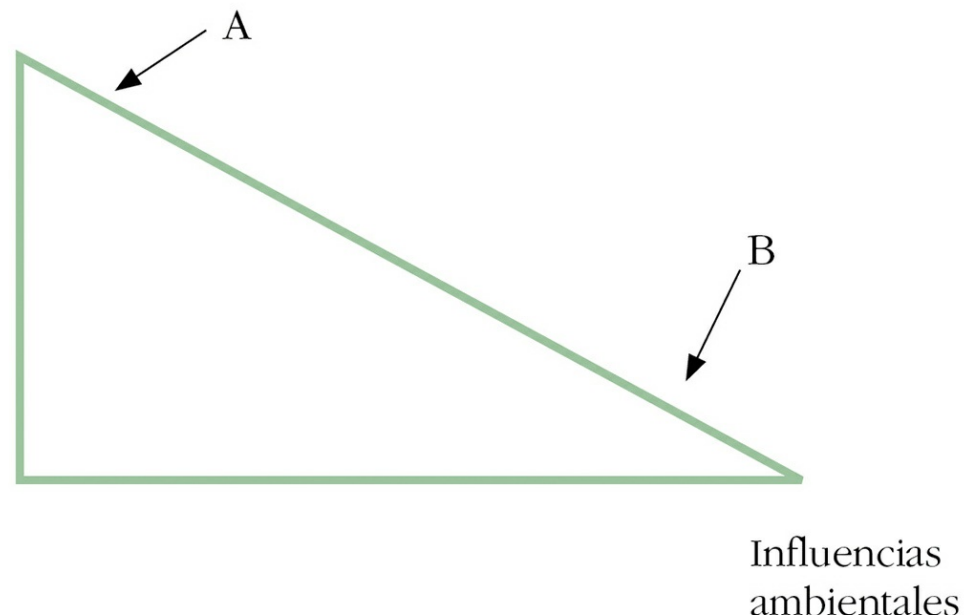


Figura 3.1. *Luxemburger: herencia-ambiente.* ([Descargar](#) o [imprimir](#))

En un extremo del triángulo estaría aquello originado sólo por el ambiente y en el otro extremo sólo lo endógeno y la herencia. Pero siempre ha de haber una combinación de ambas cosas. En el punto B supongamos una depresión «reactiva», que se relaciona claramente con un factor importante externo, pero ha de haber una mínima disposición a padecer depresiones. Otras personas con factores de fuerte impacto emocional padecen cuadros de ansiedad o alteraciones digestivas o no les aparece una enfermedad. En el otro extremo, en el punto A, las depresiones endógenas o la timopatía ansiosa en las que la disposición está clara, supongamos un 90% de disposición. Pero aún no conocemos un factor 100% de herencia o disposición a los cuadros endógenos que sea independiente de otros factores de la propia biografía o historia individual.

La primera ley de Galton se llama de la herencia proporcional. Viene a decir que cuanto más lejano esté el antepasado nuestro que padeció enfermedad ansiosa, menos probabilidades tendremos de padecer esa alteración.

La segunda y tercera ley de Galton (ley de la regresión de la probabilidades de enfermar y ley del mejoramiento o purificación) indican que cuanto más generaciones pasen, menor es la probabilidad de contraer la enfermedad, y que por lo tanto la prole tiende a normalizarse en el tiempo.

No obstante, en la realidad no se cumplen siempre estos criterios, ya que es necesario que el diagnóstico de trastorno de ansiedad sea correcto. Muchas veces la gente prefiere decir que ha tenido ansiedad o depresión en vez de otras enfermedades psíquicas de mayor rechazo o incomprensión social, y por lo tanto tenemos el problema que al hacer estos estudios las familias han de ser sinceras. También existe el problema de que en muchas familias sin antecedentes familiares aparecen enfermedades psíquicas.

Luxemburger, a principios del siglo xx, estableció una relación herencia-ambiente. Fundamentalmente viene a decir que el resultado final va a ser la relación de estos dos factores: herencia y ambiente (y así seguimos esencialmente hoy en día). Habrá muchos casos en los que la herencia tendrá más importancia como factor de predisposición para padecer una enfermedad, pero no lo va a ser todo, el ambiente podrá influir para que se ponga en marcha esa herencia y se manifieste la enfermedad; la herencia no sería en este caso «destino», sino, como mucho, «destino amenazante», dice este autor. En otros casos, lo que predomina es la influencia del ambiente, y la herencia tiene un impacto menor (véase figura 3.1).

Con todas estas concepciones, la realidad es que seguimos estudiando la frecuencia de aparición de la enfermedad en los familiares de un paciente ansioso respecto a la población general o en relación con familiares de sujetos sanos (esto se denomina estudio genético conductual familiar), y encontramos que el trastorno generalmente es familiar, es decir, hay mayor número de familiares afectados si uno de los miembros padece ansiedad que si no hay ningún miembro. Esto no quiere decir que la etiología sea sólo genética, pues los miembros de la familia también comparten factores ambientales.

En general, la posibilidad de herencia genética de la ansiedad oscila entre el 20 y el 30% (revisión de Eley y Gregory, 2004).

En la revisión que realiza J. M. Hettema encuentra que el riesgo de padecer crisis de angustia los familiares de primer grado de un paciente es del 10%, mientras que era sólo del 2,1% cuando considerábamos el riesgo de los familiares de un sujeto sano (sujeto control). Igualmente, en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, el riesgo de padecer esta enfermedad los familiares de primer grado de un paciente es del 9%, mientras que el riesgo para los parientes de un sujeto sano (controles) es del 2%.

Por otra parte se han realizado investigaciones sobre gemelos. Estudiando a los gemelos monocigóticos (también llamados univitelinos), es decir, los que son idénticos genéticamente, se les han comparado con los gemelos dicigóticos (o bivitelinos, los llamados mellizos), que comparten la mitad de sus genes. Como los gemelos monocigóticos son genéticamente idénticos, si resulta que entre ellos la concordancia de padecer la enfermedad ansiosa es significativamente mayor que la

concordancia que tienen los dicigóticos (que no son genéticamente iguales, sólo la mitad), esto quiere decir que los genes están interviniendo decisivamente en la transmisión del trastorno ansioso.

En la investigación VATSPSUD²⁸ se estudiaron 6.000 gemelos de parejas de varones y de mujeres, y se observó que para el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) las obsesiones y compulsiones tenían, respectivamente, una heredabilidad del 33 y del 26%.

Para el trastorno de angustia hay un 30-40% de riesgo genético, y el resto 60-70% depende del ambiente.

En relación con el trastorno de ansiedad generalizada, VATSPSUD aportó una heredabilidad moderada (15-30%). Otro estudio VET (Vietnam Era Twin) observó una heredabilidad entre gemelos del 38%.

Y cuando se hizo un estudio teniendo en cuenta ambos estudios (VATSPSUD y VET) (meta-análisis) ya se concluyó que la genética activa en el trastorno por ansiedad generalizada tenía una influencia del 31,6%.

El ambiente está influyendo de manera decisiva y por eso se habla de correlación genes-entorno y correlación genes-ambiente.

Esto es de vital importancia porque todos los miembros de la familia comparten tanto los genes como el ambiente, y si, por ejemplo, un niño ha heredado una tendencia hacia un rasgo temperamental o de carácter concreto que pueda influir en la ansiedad posteriormente, hay que tener en cuenta que el comportamiento del niño originará ciertas reacciones en los demás miembros de la familia, y esto influirá en el ambiente que tendrán en casa toda la familia.

¿Y este cambio en el ambiente favorecerá más o menos a la expresión del gen heredado para que luego se manifieste la ansiedad?

Es decir:

Ambiente familiar ò Nace el niño y crece en ese ambiente ò El niño tiene un gen (temperamento heredado) ò Influye en el ambiente modificándolo ò Puede este ambiente modificado facilitar la expresión del gen (carácter) haciendo que aparezca con más facilidad la ansiedad en la adolescencia.

Por esto dice T. C. Eley: «Esta asombrosa gama de variables en el entorno familiar, sobre las que existe una influencia genética significativa, indica que la complejidad del origen del ambiente familiar es mucho mayor de lo que se consideraba en el pasado».

Y si ya entramos en los estudios de genética molecular, la realidad de los resultados es que no hay nada claro y, como concluye J. M. Hettema, «los estudios de genética molecular de los trastornos de ansiedad todavía se encuentran en las etapas iniciales»²⁹. En resumidas cuentas, seguimos como dijo Luxemburger pensando que en la enfermedad ansiosa parece ser que hay cierta influencia de la herencia, pero también en igual medida influencia del ambiente y de los sucesos que han ocurrido durante la infancia y en su vida.

TABLA 3.1
Diferentes trabajos y revisiones sobre la enfermedad ansiosa muestran la inconsistencia de los estudios genéticos en esta enfermedad

TAG- Noyes (1987)	El 19,5% de los parientes de primer grado padecían el trastorno, frente al 3,5% de las familias de sujetos sanos.
TAG- Brouette (2004)	En el trastorno por ansiedad generalizada los estudios gemelares han arrojado estudios contradictorios.
TAG-Saiz Ruiz (2005)	Los resultados acerca de la determinación genética son discordantes.
TAG- Spiegel (2003)	En la actualidad se cree que los factores genéticos desempeñan un papel modesto en la etiología del trastorno por ansiedad generalizada.
TOC- Rauch (2004)	En el trastorno obsesivo-compulsivo, los estudios de ligamiento y de asociación alélica han arrojado poca luz.
TOC- Andrews (1990)	No encuentra diferencia de concordancia entre gemelos monocigóticos y dicigóticos.
TOC- Alsobrook (2001)	Los estudios de gemelos y familiares genéticos proporcionan un cierto apoyo a la hipótesis de que los factores genéticos desempeñan algún papel en la manifestación del TOC. Sin embargo, estos datos son en cierto modo controvertidos, ya que en algunos estudios no existe evidencia de una forma específica de herencia del TOC.
FOS- Tancer (2004)	La fobia social parece el resultado de interacciones complejas entre la vulnerabilidad genética, el ambiente familiar, el temperamento y las vivencias personales
FOS- Kendler (2002)	En los varones influye especialmente la carga genética, mientras que en las mujeres importaban más los factores ambientales y familiares.
TA- Ayuso (2005)	Prevalencia vida de familiares afectos oscila entre 7,9-17,3%, mientras que la prevalencia vida en familiares de controles varía entre 0,8-8%.
TA- Ballenger (2003)	Los datos disponibles acerca de estudios familiares y de gemelos sugieren que el trastorno de pánico contiene un 40%-50% de influencia genética y un 50-60% de influencia ambiental.
AGO- Díez (2000)	Los datos de los trabajos que revisan evidencian que la alta prevalencia familiar de trastornos ansiosos se debe sobre todo al trastorno por angustia y a la agorafobia, pero no así al trastorno por ansiedad generalizada ni a otros trastornos fóbicos.
AGO- Schlatter (2005)	Posee un componente genético distinto al de los trastornos de angustia

TAG = trastorno ansiedad generalizada. TOC = trastorno obsesivo-compulsivo. FOS = fobia social. TA = trastorno por angustia o pánico. AGO = agorafobia

Otro problema añadido es que hay muchos tipos de enfermedades de ansiedad,

desde el llamado trastorno por ansiedad generalizado, fobia social, agorafobia, trastorno por angustia, síndrome obsesivo-compulsivo... y cada uno de ellos tiene una influencia de la herencia diferente, pero también genética cruzada entre ellos y asimismo factores ambientales diferentes que influirán para que se desencadene el trastorno.

En la tabla 3.1 resumo algunas conclusiones dispares a la que han llegado diversos autores. Como se puede ver en la misma, está claro que no hay una herencia (genética) decisiva para padecer la enfermedad ansiosa, y por esto Spielgel señala que en la actualidad se cree que los factores genéticos desempeñan un papel modesto en la etiología de la ansiedad generalizada; y en la fobia social, Tancer indica cómo aparece ésta fundamentalmente en relación con interacciones complejas entre la vulnerabilidad genética, el ambiente familiar, el temperamento y las vivencias personales.

Podemos pensar que esto es así porque en la ansiedad más que en otras enfermedades, debido a la vivencia de inseguridad vital que lleva en sí, la personalidad que se ha formado a través de la vida se ha podido ver influenciada en sus cimientos a la hora de adquirir mayores o menores mecanismos psicológicos de defensa ante esas adversidades situacionales. Es decir, con otras palabras, nuestra personalidad se va formando desde la infancia hasta la vejez, y durante ella siempre estamos reforzándola con vivencias que nos dan «seguridad en nuestra vida» o inseguridad vital. Por esto comentábamos antes la importancia del «comprender» la vida del paciente, para así entender el significado que cada vivencia había tenido para producir la enfermedad. Y por todo esto, quizá la genética tenga una influencia menor.

Por lo tanto, si tenemos un familiar cercano que ha sido diagnosticado de trastorno de ansiedad, en principio, podemos estar tranquilos, pues no tenemos por qué «heredar» esa enfermedad y padecerla como él, excepto que sea nuestro gemelo monocigótico, pues entonces sí deberíamos preocuparnos algo (al coincidir completamente la genética y muchos factores ambientales, familiares, educacionales... si hemos sido criados en la misma familia). Igualmente, si nosotros padecemos una enfermedad ansiosa, nuestros hijos no tienen por qué heredarla; los elementos ambientales, culturales y educacionales seguro que son diferentes a los que nosotros hemos vivido.

Pero ¿qué ocurre si nuestro hijo o nosotros mismos tenemos un temperamento o carácter especialmente nervioso?, ¿tendremos facilidad para que ese temperamento pase, en algún momento, a ser una enfermedad ansiosa?

3.1.2. Temperamento y carácter

El temperamento se hereda. Todos podemos detectar en nuestros hijos o en nuestros hermanos unos «rasgos» temperamentales desde pequeños. Unos son más tranquilos, otros más nerviosos, otros más abiertos y extravertidos o, por el contrario, tímidos o reservados. Hay muchos rasgos temperamentales que sabemos son propios

de cada sujeto, y detectables en el primer año o segundo de la vida y lógicamente a lo largo de la infancia.

Pero el carácter es lo que surge de la interrelación del temperamento con el ambiente. Si bien los rasgos de temperamento los descubrimos permaneciendo en el fondo de la personalidad y se mantienen, no obstante, la persona puede evolucionar y modificarse según como el ambiente, la sociedad, la familia, los amigos, el colegio... van influyendo en él. El conjunto que aparece ya no es sólo originado por el ambiente, ni sólo por los rasgos de temperamento que aparecieron. Ese nuevo producto de la interrelación de las dos cosas es el carácter.

Muchas veces, encontramos a personas que nos dicen que son «de siempre» nerviosas. Unas, porque notan en su vida normal que son muy activas, que no pueden estar quietas (se denominan hipermotóricas); otras, aunque físicamente son más tranquilas, no obstante «no pueden estar sin hacer nada» y expresan frases como «no hacer nada es perder el tiempo»; en otros casos son personas que se agobian mucho si no está todo perfecto, y son detallistas, ordenadas, meticulosas, que «limpian sobre limpio», que les molesta cualquier cambio en su casa, pues «todo tiene que estar en su sitio. Por último hay también personas que están acostumbradas a ser muy sufridoras, padecedoras, sensibles, todo les afecta mucho y notan con frecuencia síntomas físicos de ansiedad —no muy intensos—, como sudoración, palpitaciones e intranquilidad, pero se han acostumbrado a ellos.

Veamos a continuación cómo pueden influir estos temperamentos o caracteres en cuanto a la capacidad de que aparezca una enfermedad ansiosa.

— Ser «hiperactivo emocional secundario de Heymans» (los que siempre han de tener «ocupado el tiempo»)

Con el apelativo de «hiperactivos emocionales secundarios» no nos referimos a los que ahora se denominan niños hiperkinéticos y que ya fueron descritos desde hace muchos años por Schultz como hipermotóricos.

Vamos a hablar de otro tipo de hiperactividad.

Heymans no se refería a esta hipermotricidad (la de los niños hiperkinéticos) que podemos decir que es «primaria» (primaria en el sentido de que es constitucional, con apenas nada de influencia del ambiente), sino que se refería a aquellas personas que han de ser muy activas «porque si no hacen algo, es como perder el tiempo», siempre han de estar ocupadas. Es más bien ya un factor de carácter, con clara influencia del ambiente, o de la evolución durante su infancia o adolescencia. Por esto llamó a este carácter hiperactivo «secundario emocional», ya que es su tendencia emocional, su deseo interno, que le es confortable, el hacer siempre algo, «no parar». Este carácter hiperactivo emocional secundario de Heymans, no se hereda, sino que se aprende, se incorpora como carácter a lo largo de la infancia o adolescencia fundamentalmente.

K. Jaspers (1967) decía del «hombre activo»: a su alrededor nada puede estar ocioso; lo que ha de valer tiene que actuar y tiene que servir... para el activo siempre hay movimiento... el hombre activo elige entre posibilidades, para él sólo existe un «o esto o lo otro»... y se origina de una forma totalmente espontánea e involuntaria

un autodominio típico y una autodisciplina condicionada por el fin.

Estas personas «tan activas», de las que podemos decir «siempre han de estar ocupadas haciendo algo», pueden tener riesgo de padecer una enfermedad ansiosa cuando por una circunstancia externa, como tener que dejar de trabajar por ir al paro o jubilarse, o por una enfermedad física que les impida realizar esa actividad que necesitan para encontrarse a gusto consigo mismas, no pueden cumplir con su motivación existencial de «ser activos». Entonces aumentan mucho sus pensamientos, sin parar de cavilar, con constantes rumiaciones (se denomina mentismo a este no parar de pensar). Se sienten inútiles por no poder ocupar el tiempo, y aumenta entonces su estado de ansiedad, con mayor vulnerabilidad a la enfermedad ansiosa.

— Ser perfeccionista, enequético (Mauz)

Hoy en día se habla también de «temperamento o carácter obsesivo», aunque personalmente no me gusta este término, pues se acerca demasiado a considerar a una persona, por los médicos, como si fuera un enfermo con un trastorno obsesivo, o, por el contrario, a llamar por la población general «obsesiva y maniática» a muchas personas que son muy perfeccionistas.

Mauz era discípulo de otro psiquiatra, E. Kretschmer, y ya detectó la importancia de este temperamento, detallista, perfeccionista, ordenado. «Si me mueven algo de la casa, me molesta», «todo está ordenado hasta el mínimo detalle», «limpio sobre limpio», dicen muchos de nuestros pacientes. Consideraba a estas personas muy tenaces, laboriosas, y denominó a este temperamento enequético (y viscoso, aunque este último término no se siguió usando, pues hoy viscoso se asocia más a pegajoso, adherente, adhesivo; pero sí que tenía su razón de ser, en el sentido de que estas personas se adhieren mucho a los pequeños detalles).

H. Tellenbach dice de estas personas que «no pueden pasar detalles por alto», «todo ha de estar en orden», y remarca cómo por este afán por un orden minucioso, al mismo tiempo se exigen mucho a sí mismo. Incluso ya esbozó un cuestionario para evaluar este temperamento en el que incluía:

- Ser meticuloso, ahorrativo, enérgico, decidido.
- Ser programador de las actividades con tiempo, muy atado al deber.
- Estar satisfecho con las normas, disciplinado.
- Gran fuerza de voluntad, buenos hábitos de trabajo.
- Cuando he dejado algo por hacer me afecta mucho y pienso en ello hasta que lo cumplo.

En un caso nuestro, ama de casa, que padecía mucha ansiedad durante todo el día, el problema fundamental era que no podía dejar de hacer cada día las faenas de casa con tanta minuciosidad y limpieza que «no le daba tiempo» a terminar sus labores, y por esto se pasaba todo el día angustiada, intranquila, con palpitaciones y dolores musculares, por el sentimiento de falta de tiempo. En realidad, esta paciente, de

aproximadamente 55 años, vivía sola con el marido, al tener los hijos independizados, y las obligaciones de la casa no eran muy abundantes, «pero no puedo dejar de hacer todo minuciosamente», decía.

El orden les da seguridad. Con el orden y el perfeccionismo «todo está en su sitio». Este enquetismo o perfeccionismo obsesivo les da la seguridad que compensa una gran inseguridad interior. Si se rompe por algún motivo las posibilidades de realizar su carácter, entonces la inseguridad interna brotará sin control, aumentando mucho el riesgo de enfermedad ansiosa.

Podríamos decir con L. Binswanger (1881-1911) que las personas con este temperamento suelen ser deterministas, es decir, se sienten perfectamente cuando todo va según lo programado, pero les afecta mucho lo inesperado. El ser determinista es ser programador, determinar de antemano lo que pueda ocurrir, pero si lo esperado no ocurre, si hay imprevistos, esto les afecta mucho, quizá demasiado. Un acontecimiento importante, imprevisto, les afecta significativamente de forma sustancial, les hace tener que pensar mucho, les origina gran inseguridad y fácilmente les quita el sueño; entonces ya estamos abriendo puertas para una vulnerabilidad a padecer un cuadro ansioso.

Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta cuando valoramos cómo ha empezado un cuadro ansioso, si el temperamento perfeccionista, detallista, enquetico ha influido en la aparición del mismo y más aún si el paciente además es también de carácter determinista.

Esto es importante, porque no sólo nos bastará con tratar con psicofármacos la ansiedad y que ésta desaparezca, sino que igual de importante será que el paciente conozca sus riesgos de vulnerabilidad y quizá, en algunos casos, mediante tratamiento psicoterápico podamos, si bien no cambiar el carácter, mejorar ciertos mecanismos psíquicos que le permitan al paciente ser menos afectable por el mismo, limar algo esas tendencias temperamentales o que tengan menos acción en su vida diaria. Una mesa cuadrada puede que siempre sea cuadrada, pero las esquinas podemos limarlas para que no sean demasiado agudas. Igualmente, el tratamiento combinado psicofarmacológico y psicoterápico puede ayudar a estos pacientes a que el impacto en su vida diaria del carácter perfeccionista y determinista sea más suave, menos intenso, y así conseguir que disminuya la vulnerabilidad a la enfermedad.

— Ser nervioso, tener «de siempre» síntomas somáticos de ansiedad

Veamos, a continuación, diez síntomas ansiosos extraídos de diversas escalas de ansiedad:

1. Estoy ansioso/a la mayoría de los días.
2. Encuentro dificultad para relajarme.
3. Tengo malestar por mi ansiedad.
4. Me preocupo excesivamente.
5. Me siento alterado.
6. Noto frecuentemente taquicardia o palpitaciones, o dolores en el pecho.

7. Noto con frecuencia sensación de peso en el pecho o sensación de opresión torácica, suspiros o sensación de falta de aire.
8. Con frecuencia sufro de ardores, diarrea, estreñimiento, o distensión abdominal, o sensación de estómago vacío o náuseas o meteorismo (gases).
9. Noto con cierta frecuencia sudoración excesiva, frialdad de manos, dolores de cabeza por estar tenso, sequedad de boca.
10. Fobias. Ansiedad en situaciones específicas como en el autobús, supermercado, multitudes, estar solo.

Muy a menudo nos encontramos en la clínica diaria personas que nos dicen que son «de siempre» muy nerviosas, y ese nerviosismo consiste en que les afecta todo, tienen palpitaciones, o sudores de manos, intranquilidad y siempre están tensas... Estas personas, posiblemente tengan casi continuamente 8 o más de los síntomas descritos anteriormente, aunque no de intensidad tan elevada que les haya llevado a acudir a un tratamiento psiquiátrico, ya que consideran que han podido seguir haciendo su vida normalmente, aun padeciéndolos. Muchas de estas personas no llevan tratamiento, otras, algún medicamento «suave» dado por el médico de cabecera (o peor si lo toman por prescripción propia o por prescripción de la vecina) y tienen una calidad de vida que «siempre» han considerado «aceptable», a pesar de los síntomas. Esta manera de ser de su temperamento la llevan con resignación, pues ya se han «acostumbrado» a esa «mala» o «aceptable» calidad de vida.

Cuando por distintas circunstancias de la vida (problemas familiares, laborales, etc.) esa sintomatología que tenían tan habitual ahora se ha exacerbado y ya padecen un trastorno ansioso, acuden a visita por especialista. Ahora han de ser tratadas psiquiátricamente para que vuelvan a recuperarse. ¡Y lo más curioso! Si bien muchas de ellas cuando se han recuperado vuelven a encontrarse «como antes», con la sintomatología leve que tenían de «toda la vida», en otros muchos casos al recuperarse se encuentran —dicen ellos— ¡mejor que nunca!, pues les ha desaparecido incluso la sintomatología que sufrían desde siempre. En estos casos, muy aliviados por tener ahora una mejor calidad de vida que la que habían tenido nunca, es necesario plantearles que tendrán que tomar medicación de por vida si quieren mantener ese nuevo estado de normalidad sin síntomas, sin volver a padecer siquiera «los de siempre». Por mi experiencia, en estos casos, algunos pacientes deseosos de mantener esta nueva calidad de vida admiten de buen grado el tratamiento psicofarmacológico, pero en otras ocasiones quisieran encontrar otros métodos, sin medicación, que les mantuvieran completamente asintomáticos de forma continua durante toda la vida. Se puede intentar mediante técnicas de relajación de tipo sofrológico³⁰ o de Jacobson, o mediante yoga conseguir un control sobre la sintomatología más corporal o somática, que les permitiese suprimir la medicación. Tengo que decir sinceramente que pocos lo consiguen, y la mayoría de los que lo intentan tienen que volver a tomar medicación psiquiátrica para mantener esa nueva vivencia de calidad de vida mejor que la que habían tenido «de siempre». Mas dejemos abiertas las puertas de la esperanza para cada caso individual que quiera

intentarlo por el camino del control psicogenético.

TABLA 3.2
Escala de detección del trastorno de ansiedad generalizada de Carroll y Davison ([Descargar o imprimir](#))

Instrucciones: Estas cuestiones son para preguntarle sobre cosas que puede haber sentido la mayoría de los días en los últimos 6 meses.

SÍ ☐ NO ☐	1. La mayoría de los días me siento nervioso/a.
SÍ ☐ NO ☐	2. La mayoría de los días me preocupo por muchas cosas.
SÍ ☐ NO ☐	3. La mayoría de los días no puedo parar de preocuparme.
SÍ ☐ NO ☐	4. La mayoría de los días me resulta difícil controlar mis preocupaciones.
SÍ ☐ NO ☐	5. Me siento inquieto/a, intranquilo/a o con los nervios de punta.
SÍ ☐ NO ☐	6. Me siento cansado/a fácilmente.
SÍ ☐ NO ☐	7. Tengo problemas para concentrarme.
SÍ ☐ NO ☐	8. Me enfado o irrito fácilmente.
SÍ ☐ NO ☐	9. Mis músculos están tensos y agarrotados.
SÍ ☐ NO ☐	10. Tengo problemas de sueño.
SÍ ☐ NO ☐	11. Las cosas que he señalado anteriormente ¿afectaron a su vida diaria (en el hogar, en el trabajo, o en su tiempo libre) o le causaron mucho malestar?
SÍ ☐ NO ☐	12. Las cosas que he señalado anteriormente ¿fueron suficientemente molestas como para que pensara en buscar ayuda para ellas?

Puntuar 1 punto por cada respuesta «Sí». Puntuación para personas sanas menor de 4 puntos.

(Extraído de Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica, 4.ª edición. M. P. García Portilla, M. T. Bascarán, P. A. Saiz, M. Bousoño, J. Bobes, y de Propiedades psicométricas de la versión española de la escala de detección del trastorno de ansiedad generalizada según DSM-IV de Carroll y Davison. J. Bobes, C. Gacía Calvo, R. Prieto, M. García García, F. Rico Villademorros. Ver bibliografía.)

Pero aunque dejamos abiertas las puertas a esa esperanza de que la persona quiera «por sus medios psicológicos» controlar su sintomatología ansiosa, no obstante no podemos dejar de informar al paciente de los graves riesgos que hay si se mantienen estos niveles «bajos» de ansiedad. En una revisión sobre las «Fases iniciales de las enfermedades mentales: Trastornos de ansiedad», editada por J. L. Vázquez-Barquero y A. Herrán Gómez, muestran cómo en repetidos estudios esta ansiedad prodrómica^{[31](#)}, es decir, estos síntomas «de bajo nivel» que se dan antes de padecer

una verdadera enfermedad ansiosa, aparecen no sólo meses, sino años antes del inicio del trastorno. Simplemente el que la persona se autoperciba como «ser nerviosa» ya predice en más del 60% que esa persona padecerá en un año una enfermedad ansiosa (otra cosa, por desgracia, es que muchos de ellos cuando ya tienen el trastorno ansioso no van al especialista, como han demostrado Issakidis y Andrews).

Los adolescentes que presentaban también estos síntomas prodrómicos o de bajo nivel tenían un riesgo mucho más alto de presentar enfermedad ansiosa en la edad adulta.

Por supuesto, si se realiza un tratamiento de esta ansiedad de bajo nivel, el riesgo de tener posteriormente depresión mayor es mucho menor que en los casos que no se haya tratado. Y terminan estos autores insistiendo, lógicamente, en la importancia de intervenir sobre estas fases tempranas de síntomas, debido a la alta morbilidad y repercusiones en términos de discapacidad, sufrimientos psicológicos y costes económicos. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos la enfermedad ansiosa es responsable del 32% del gasto económico generado por las enfermedades mentales, muy por encima de otros trastornos como la esquizofrenia (21% del gasto) o los trastornos depresivos (22% del gasto).

En la tabla 3.2 se puede ver la escala de detección del trastorno de ansiedad generalizada de Carroll y Davison. Las personas sanas responden menos de cuatro «sí» de las 12 preguntas.

3.1.3. La edad y el sexo

¿Hay edades en que se padece más ansiedad?

Ciertamente se puede padecer una enfermedad ansiosa, ya sea como trastorno de ansiedad, fobia, trastorno obsesivo compulsivo, etc., en cualquier momento de la vida, pero tenemos que tener en cuenta dos aspectos:

1. En qué edad es más frecuente que aparezca por primera vez.
2. Las edades de cambio, vulnerabilidad o metamorfosis.

3.1.3.1. *Edades más frecuentes de la primera aparición*

El trastorno por ansiedad social o fobia social suele aparecer en torno a los 14-16 años, siendo muy raro que aparezca a partir de los 27 años, y no aparecen claras diferencias a favor de padecerlo más las mujeres (al contrario que ocurre con la fobia simple y la agorafobia, que sí es más frecuente en mujeres).

En el caso del trastorno obsesivo compulsivo suele iniciarse en la adolescencia o al inicio de la edad adulta (entre los 15 y los 20 años), y afecta con igual frecuencia a varones y a mujeres, aunque en niños se ha descrito un predominio importante en varones.

En el caso del trastorno por ansiedad generalizada es más frecuente en mujeres

(60-70%) que en varones (30-40%). La edad de comienzo es variable aunque suelen acudir al médico entre los 20 y 30 años.

Por último, en el caso de las crisis de angustia o trastorno de angustia, es claramente más frecuente en la mujer (el doble que en el sexo masculino), y el comienzo de la enfermedad es alrededor de los 30 años.

Pero no olvidemos, como comentábamos en el apartado anterior, la importancia del tiempo que los pacientes pueden padecer síntomas de baja o mediana intensidad hasta que se les diagnostica la enfermedad.

3.1.3.2. Edades de cambio, vulnerabilidad o metamorfosis

Ya señalamos anteriormente las edades de metamorfosis de Conrad, etapas de cambios importantes en la globalidad de la persona. Recordémoslos brevemente:

- Entre los 6-8 años, el niño «ya deja de ser un niño pequeño», cambia muy rápidamente, quizá en uno o dos años, y ya es un «niño adulto»; es, pues, la primera metamorfosis.
- A los 13-16 años, la segunda metamorfosis o cambio importante global, de la adolescencia.
- Y entre los 35- 45 años la tercera metamorfosis o de balance existencial.

¿En cuál de estos períodos es más frecuente que aparezca la enfermedad ansiosa?

Evidentemente, la segunda metamorfosis, entre los 13-16 años, va a ser un período de importante crisis y necesidad de adaptación coincidiendo con la adolescencia. Nuevas maneras de concebir el mundo, sintiéndose el joven ya adulto, con ideas y creencias que puede contrastar con otros jóvenes-adultos de su edad, al mismo tiempo aparecen frecuentemente desacuerdos importantes con los padres o tutores, disconformidad con estructuras sociales y búsqueda de nuevas vivencias en un deslumbrante mundo que ahora se les abre.

En esta etapa suelen aparecer más trastornos adaptativos, trastornos de ansiedad, o simplemente crisis de adolescencia, con fricciones entre su ser-en-el-mundo³² y la concepción del mundo que tienen las personas cercanas y que ejercen «poder» o ascendencia sobre él. Muchas de las enfermedades ansiosas tienen su aparición en este período de metamorfosis.

¿Y entre los 35-45 años, en la tercera metamorfosis o de balance existencial?

Pueden aparecer alteraciones ansiosas, o mejor dicho angustiosas³³, y en otras ocasiones importantes trastornos ansiosos o depresivos «adaptativos», pero de hondo calado.

En estas edades el paciente se pregunta por el sentido de la vida que ha realizado hasta el momento y si el esfuerzo realizado ha valido la pena. La edad en este caso es un factor de predisposición, y cuando se hace el balance existencial, normalmente, además de poderse recurrir a psicofármacos para aliviar los síntomas clínicos que sufre el paciente, como pueden ser insomnio, desánimo, ansiedad, mentismo

(rumiaciones constantes acerca de qué hacer, qué futuro plantearse, etc.), además, decía, es fundamental un tratamiento psicopedagógico. Me refiero con psicopedagógico en el sentido de que al paciente no le vale sólo que se supriman los síntomas clínicos, sino que su sentido existencial, su sentido en los proyectos de futuro ahora desaparece completamente o bien adquiere un pseudoproyecto cargado de puro automatismo: «puedo seguir trabajando, cumpliendo, haciendo lo que hacía hasta ahora, pero YA no me es suficiente», y por esto ha de configurar un nuevo sentido existencial. La enfermedad ansiosa, cuando aparece debido a esta quiebra del sentido existencial, será una enfermedad de su proyecto vital y por lo tanto la relación médico paciente, y también desde la psicología clínica cuando es necesario aplicar ésta³⁴, obliga a un tratamiento ontológico, es decir, un tratamiento que conmueva la raíz del ser-paciente, puesto que ha de tomar decisiones puras, decisiones nuevas y vitales, para desde «dentro», desde su verdad interior crear nuevos caminos y proyectos de futuro. Ha de realizar un nuevo proyecto de su ser-en-el mundo; una renovación de su proyecto de individuación.

Es muy curioso, que en ocasiones cuando se plantea esta situación de balance existencial, muchos pacientes, tras sufrir el desierto y la oscuridad del sentido vital, renacen con mucha más fuerza, con mucha mayor capacidad de relativización de la vida y con nuevos valores y modelos aplicables, tanto a su trabajo, a la familia, como a sus amistades. La concepción del mundo ha cambiado, pues ellos mismos han cambiado en sus proyectos desde su más profunda interioridad, superando así la angustia y el desánimo que les producía una etapa vital ya acabada.

Pero en otras ocasiones gana la batalla la angustia que les origina el posible cambio; al final deciden que «arriesgarse» a cambiar desde la profundidad es algo que no les conviene o que les angustia mucho más que el desespero que tienen en la disconformidad de su vida anterior. Y entonces resuelven la situación prefiriendo seguir como antes: estarán disconformes con su proyecto actual y lo considerarán insatisfactorio, incluso vacío, pero al igual que un dolor muy fuerte puede hacer desaparecer otro más débil, en este caso, la fuerte inseguridad que les produce el cambio o el riesgo del cambio hace que parezca débil o imperceptible y en todo caso aceptable la actual angustia de su existencia inauténtica, de tal manera que prefieren seguir manteniendo esta inautenticidad así vivida³⁵.

Como ya señalaba Rojo Sierra (1961), el paciente se acomoda a su existir (neurótico), aunque «conozca» la falsedad de este existir, y carece de incentivo para «cambiar».

En todo caso seamos realistas: no es malo ni bueno, ni mejor o peor, si el paciente decide adentrarse en el camino del cambio interior para configurar una nueva estructura existencial o decide permanecer en la actual estructura que tanto le angustia. Lo importante es que sea consciente de que ha de tomar una decisión. Cuando así ocurre, ¡ES LA DECISIÓN! que ha tomado esta persona. Y al tomar una resolución, desaparece la angustia y por lo tanto siempre hay que considerarla positiva (la decisión), pues es válida y resolutiva para esa persona en particular.

Aclararé este punto de «la decisión» con un caso clínico.

Una paciente nuestra, 39 años de edad, acudió a visita clínica con fuertes síntomas ansiosos e insomnio. No podía apenas conciliar el sueño debido a que constantemente estaba pensando en su situación, con la que estaba disconforme. Casada y con dos hijos, vivía en un chalé, bien acomodada y con un buen nivel económico. Ella no trabajaba fuera de casa y tenía ayuda doméstica. El marido, definido por la paciente como «un antiguo, del siglo pasado», no la dejaba conducir, pues decía que las mujeres no conducían bien, y la dejaba salir poco de casa con las amigas, pues quería que cumpliera bien su labor de «ama de casa». Por supuesto, no admitía el marido que trabajara ella fuera de casa. Disconforme con esta situación, pues se sentía «sin libertad» y, comentaba, «estar oprimida» por las ideas desfasadas del marido, consideraba que si bien hasta ahora había estado conforme con la buena situación socioeconómica que disfrutaba, ahora, a sus 39 años, realmente su vida no tenía mucho sentido y le angustiaba mucho permanecer así año tras año en el futuro. Le dimos medicación para controlar la ansiedad y el insomnio y fue remitida a psicóloga para tratamiento psicoterápico. Una vez desaparecida la ansiedad, y tras varias sesiones de psicoterapia, acude a una visita comentando que ya se encuentra perfectamente, pues tras valorar con la psicóloga y un abogado las ventajas y desventajas de divorciarse «ha decidido» ya con toda claridad y certeza que prefiere seguir disfrutando de las circunstancias socioeconómicas que su marido le dispensa, aunque «tenga que aguantar sus ideas trasnochadas», a separarse y tener que disminuir su nivel económico, buscar trabajo y aumentar su responsabilidad.

En este caso, ¡la decisión! de aceptar su situación es de importancia suprema para entender que la desaparición de la sintomatología ansiosa e insomnio está unida a una actitud interna de su renovado proyecto vital, aunque éste sea seguir con la situación que tenía, pero ahora tras la decisión propia de «seguir así»³⁶.

Por último hemos de referirnos a una 4.^a etapa de metamorfosis, que si bien no la definió Conrad, no obstante hoy en día, con el aumento de la longevidad, aparece frecuentemente como nueva situación de crisis existencial. Va a ser la etapa de la edad que podríamos denominar postraria y disidente³⁷ o también llamada edad senil, involutiva o edad «avanzada». La anterior etapa era considerada como de «balance existencial»; ahora esta será vivida como «crisis existencial».

No debería ser así, pues el hecho que en los países civilizados se consiga tan altas edades de longevidad debería ser considerado un fabuloso éxito. Como señala F. Notestein, «Visto en su conjunto, el problema del envejecimiento no es un problema en absoluto. Es solamente la forma pesimista de considerar un gran triunfo de la civilización».

Pero nada más lejos de la realidad, cuando nos centramos en las vivencias de las personas que se encuentran en estas edades. Lo que vivencian las personas en estas edades postrarias es que pronto se les va a considerar, como señala V. Conde, «ancianos vulnerables, frágiles, cada vez más solitarios, con elevado riesgo de dependencia, consumidores de recursos en vez de bienestares, cada vez con mayores demandas sociosanitarias».

Como indica R. Rey Ardid, esta «edad crítica» debe considerarse como la

«antesala» de la vejez. La involución marca la transición entre la plenitud de la edad madura y la decadencia de la senectud. Por ser esta situación intermedia, surgen conflictos vitales que con frecuencia desembocan en trastornos psíquicos. Tanto es así —continúa Rey Ardid— que puede decirse que la involución es la época en la que con mayor facilidad se presentan alteraciones psíquicas ansiosas, neuróticas.

No puede señalarse con exactitud una edad de comienzo. Pongamos de referencia entre los 60-70 años, en que la persona empieza a vivenciar su propio proceso de envejecimiento que exige una nueva actitud ante la vida, pues ya no está en la «madurez» que gozó hasta ese momento, sintiéndose más incomprendido por las personas jóvenes, sin las mismas capacidades que «hasta entonces», pero muchas veces queriendo aún mantener y resistiéndose a perder su sentimiento de «aún soy joven».

Como no hay una edad determinada, lo que tenemos realmente es una situación vivencial de involución. En este sentido, Rojo Sierra, en sus *Lecciones de psiquiatría* (tomo IV), hizo un importante análisis de «la vejez como situación de decadencia». Resumo a continuación algunos conceptos que muy acertadamente exponía.

Lo importante es el concepto «situación». Es decir, entender que en la senectud vivimos una «situación» especial³⁸.

La situación en la senectud no es la misma, ni parecida a etapas anteriores de la vida de la persona. Antes se ha vivido un cenit, una época de sentirse con su máximo poder, y pocos años antes —sin sentirse «mayor»— sí que se sentía la persona con experiencia y conocimientos ya reflexionados y bien asentados.

Ahora, a partir de una edad, ya no se siente con esa fuerza de antes, ya ha pasado el máximo apogeo, su realidad es más reducida. «Las situaciones de decadencia tienden, en virtud de la nostalgia, a vivirse como amputación de algo de nosotros», dice Rojo Sierra.

¿Nostalgia de qué? Evidentemente, del apogeo y de la fuerza que antes se tenía y el control evidente del mundo que te rodea.

Son conocidas las crisis que han sufrido personas de prestigio social, cultural, laboral y profesional, cuando por su situación de decadencia o por tener que jubilarse no han podido mantener ese alto nivel con el que se identificaban, no han podido ya controlar las variables del mundo cambiante, muchas veces profesional, que ahora les cuesta asimilar.

Porque si el mundo no cambiase para el hombre en senectud, si la velocidad vertiginosa de cambio que existe hoy en día, y que supone un esfuerzo constante para adaptarnos a nuevos conceptos familiares, sociales y laborales que en pocos años mutan y mutan, digo, si no existiera esta velocidad de cambio tan vertiginosa, entonces la experiencia del hombre en la tercera o cuarta edad sería muy útil para los más jóvenes y para las familias o para las empresas.

Pero esta transformación tan tremenda y veloz, de la estructura general de la sociedad, hace que la persona en la senectud, que ya se encuentra psicobiológicamente con más dificultades de adaptación y de asimilación de los cambios, se encuentre «sin comprender del todo» a las nuevas generaciones, a los

nuevos conceptos sociales o familiares y en ese sentido se encuentra cada vez más aislado.

Y el aislamiento origina angustia.

Pero aún otro factor puede aumentar más la angustia que en estas edades se va a padecer de forma primaria, simplemente por la dificultad de adaptación. Este factor es el paradigma laboral. Esto es, considerar por la sociedad que el trabajo es el máximo, o uno de primeros valores fundamentales que dan autoestima y sentido a la persona en el ámbito social. Trabajar, producir, ser muy competitivo, valoraliza al ser humano con tal intensidad en nuestra sociedad, que el jubilarse, el dejar de ser productivo, le hace sentirse a la persona «mayor» como socialmente «negativa», una rémora o un peso para la sociedad. Y más aún si constantemente nos recuerdan, en los medios de difusión y políticos, como negativo, el gasto sanitario y pensionario... que originan las personas «de edad».

Por esto, muchas personas tienen miedo a ser consideradas ya «viejos» y cuando están en las edades preseniles intentan simular su edad, bien intentando rendimientos que ya no están a su alcance, volviendo a intentar realizar actividades más «juveniles», usando lenguaje «de jóvenes» o recurriendo a atuendos que les den «aspecto juvenil».

En esta etapa, que Volcher ha denominado «edad de las pérdidas», se pueden desencadenar trastornos psíquicos por circunstancias como el abandono, separación matrimonial propia y también separaciones de los hijos. En ocasiones, un divorcio o ruptura matrimonial de un hijo o una hija le origina un gran impacto emocional y le desencadena una enfermedad ansiosa. Cualquier nueva fisura «de la familia» puede aumentar su vivencia de aislamiento, y de angustia, hasta el punto de desencadenarle un estado ansioso, ya que en estas edades hay una menor adaptabilidad a los cambios, hay una tendencia a la rutina, no sólo fisiológica, sino también afectiva. Los cambios que le movilicen estados afectivos de incertidumbre le van a originar fuerte ansiedad.

3.2. FACTORES DE SENSIBILIZACIÓN BIOGRÁFICA

Son todas las influencias del ambiente, familia, infancia, que han actuado a lo largo de nuestra vida.

Se distinguen dentro de este apartado, siguiendo a Gregory³⁹:

- a) Privación de una comunicación adecuada.
- b) Aprendizajes anómalos.
- c) Frustraciones.
- d) Conflictos.

Pero ante todo consideremos lo que ya mencionamos anteriormente: nuestra biografía⁴⁰, nuestro pasado, está repleto de circunstancias especiales que nos han sucedido, y muchas veces durante la infancia hemos podido padecer situaciones de aislamiento, traslados de domicilio por motivo de trabajo de nuestros padres, o

frustraciones importantes ante expectativas que considerábamos fundamentales para nosotros. Todas estas circunstancias pueden ser factores sensibilizantes, pero siempre tenemos que tener en cuenta —y esto ha de quedar muy claro— que ninguno de estos acontecimientos va a ser la «causa» de una enfermedad ansiosa. Por esto estamos hablando de un campo-etiotopatogénico-situacional.

Aunque esto ya lo señalé al principio de este capítulo, no obstante es importante remarcarlo, ya que cuando hablamos de factores sensibilizantes, ha habido una fácil tendencia a achacar como causa de todos los males psíquicos futuros a un acontecimiento importante que ha ocurrido, bien en la infancia, bien en un momento importante de la vida.

Por supuesto que no se puede, ni mucho menos, minusvalorar la importancia de los acontecimientos o situaciones fuertemente cargados de emotividad negativa, o que han supuesto una marca de indudable valor en nuestra biografía, pero huyamos de considerar que estas situaciones o acontecimientos son la «causa» de la enfermedad ansiosa o de otros trastornos psíquicos que pueden aparecer más adelante. Haber vivido una infancia con penuria económica, o en una situación en la que uno de los padres era alcohólico, o haber vivenciado la separación de los padres cuando éramos niños, evidentemente que puede marcar especialmente nuestro carácter; pero no todos los que han vivido estas situaciones tienen enfermedad ansiosa de adultos, ni enfermedades psíquicas; en cada caso habrá que valorar el «peso», el significado que estas situaciones —junto a otras dentro de un campo de fuerzas, de influencias múltiples— han tenido como desestabilizadoras de nuestra salud.

3.2.1. Privación de comunicación adecuada

El ser humano es un ser no sólo gregario, es decir, que necesita del contacto social, sino que desde el inicio de su infancia, también va a necesitar de un buen contacto afectivo y relacional con su más cercana intrasociedad, la familia. Si no se produce esa comunicación afectiva adecuada, se desarrollará en su cerebro un aprendizaje anómalo, que puede ser en ocasiones importante valorar como factor sensibilizante en los cuadros ansiosos.

Así, ya algunos autores como Liddell y Bauvelt trabajaron con mamíferos (corderos, cabritos) y aves, respectivamente. Hicieron dos grupos de animales: uno estaba expuesto a los contactos con la madre y el otro no (aunque separados de la madre se procuraba que tuvieran las mismas condiciones de habitabilidad y alimentación, en este caso de forma artificial). Se pudo observar que los animales separados de sus madres tenían un desarrollo biológico inferior y tenían disminuidas las defensas, enfermando con facilidad.

Otros autores, como Galton y Cattell, observaron que las ratas a las que nadie tocaba ni acariciaba, frente a las que sí eran acariciadas por el personal de laboratorio, aprendían con mayor dificultad.

Por su parte, F. S. Seiz hizo tres grupos de gatitos:

- Al primero los separó de su madre a las dos semanas del nacimiento.
- Al segundo los separó a las seis semanas del nacimiento
- Al tercero, a las doce semanas.

En conjunto, observó que los del primer grupo eran los más suspicaces y miedosos, jamás compartían el alimento, si se les acercaba otro gato bufaban y arañaban, e incluso, si podían, robaban alimento a otros gatos. Este primer grupo tardaba más en aprender.

El segundo grupo de gatitos (separados a las seis semanas) tenía un comportamiento intermedio.

El tercer grupo (separado a las doce semanas) era el más confiado y amistoso, compartían la comida, cuando competían apenas bufaban y prácticamente nunca arañaban. Éste era el grupo que aprendía más rápidamente.

Experiencias similares se han realizado, con resultados parecidos en primates, sustituyendo a la madre por muñecos o por armazones de alambres con forma de chimpancé o gorila. También había en estos casos consecuencias en el aprendizaje, en la sociabilidad y en su desarrollo.

En seres humanos, R. Spitz estudió las condiciones de vida de niños en orfanatos, comprobando que los aspectos técnicos estaban bien cuidados, el personal muy bien preparado, pero muchos de los niños tenían posteriormente dificultades en el aprendizaje e incluso morían prematuramente. Pero bastaba con que recibieran visitas de su madre o que fueran objeto de maternaje por otra mujer, para que su vida posterior fuera mucho más optimista y normal. Igualmente, los hijos de mujeres en prisión que tenían familiares que los acogieran, si eran mantenidos con ellas un tiempo, aunque hubiera deficientes condiciones técnicas, también sobrevivían más y aprendían mejor que los niños criados en el ambiente perfectamente «aséptico» del orfanato.

Vemos, pues, cómo el contacto afectivo y táctil es fundamental para el desarrollo normal del ser humano, y tendremos que preguntarnos si en la primera infancia estamos dando suficientemente ese tipo de con-tacto afectivo a nuestros infantes, en una sociedad cada vez más tecnificada. No olvidemos que la misma palabra con-tacto indica una transitividad, es decir, es un «tacto»-«con». Y ese «con» significa estrechísima interrelación con otra persona; en eso no pueden sustituirnos ni los ordenadores ni los diversos juegos de *play* o las horas que pasan los niños ante la televisión.

A nivel puramente de la entrevista psiquiátrica, vamos a valorar especialmente tres circunstancias que pueden suponer una comunicación inadecuada en la infancia, sin olvidarnos nunca de que si aparece uno de estos factores, tendrá siempre un valor estocástico (influencia en el estudio del campo situacional) pero no causal.

1. El hijo mal deseado.
2. El exceso de castigo.
3. El aislamiento social de la familia.

3.2.1.1. *El hijo mal deseado*

Aunque en la entrevista psiquiátrica, en ocasiones, sí que nos expresan que el hijo no fue deseado, no obstante puede ocurrir que esto no lo aclare o que lo minimice la madre, en cuanto a las consecuencias que tuvo para la crianza del hijo.

Debemos sospechar la posibilidad de un hijo no deseado en los casos de:

- a) Madre soltera.
- b) Hijo de viuda/o precoz. La muerte prematura del padre o de la madre puede dejar a uno de los cónyuges en una situación social o económica difícil y vivenciar la «carga» del hijo, como una coartación a su libertad de movimientos, o de la realización de posibilidades laborales o de otro tipo.
- c) Si es la madre la que ha muerto en el parto, el padre puede actuar introyectando el pensamiento o la vivencia que ésta no habría muerto, de no ser por el nacimiento del niño.
- d) Si hay desavenencia o crisis prolongada matrimonial y el hijo se parece a uno de los padres, puede entonces el otro cónyuge proyectar la angustia, el enfado y a veces incluso el odio que tiene, en el hijo.

3.2.1.2. *El exceso de castigos*

Este aspecto ha sido excesivamente sobrevalorado. Es cierto que hace ya bastantes años, en la educación que se recibía hasta los años de la década del sesenta (para poner un límite temporal aproximado), la estructura social era más rígida. Las personas que ahora pueden tener 50 o más años han conocido u oído cómo cuando eran niños no se podía hablar en la mesa al comer, y cómo los castigos «con la correa» o «la bofetada» podían ser en muchas ocasiones frecuentes en muchas familias, considerándose esto, hasta cierto punto, normal dentro de la rigidez educativa.

Se valoró bastante que en familias en las que había un exceso de castigos el niño podía desarrollar una personalidad, en ocasiones muy insegura o, en otras ocasiones, una personalidad muy rígida (para evitar tener equivocaciones y no ser castigado). Estos factores tenían que ser tenidos en cuenta a la hora de apreciar elementos de sensibilización o predisposición de la infancia para el padecimiento de enfermedades psíquicas cuando fueran mayores.

Pero si bien es cierto que durante la primera mitad del siglo XX la estructura social y familiar era bastante rígida, ahora estamos en el polo contrario. Como un péndulo que balancea, desde un extremo se ha pasado al contrario. Y quizá «por el miedo a que se frustre» el niño, y también porque las familias tienen muchos menos hijos que antes, es mayor la tendencia a mimarlos y a «darles todo lo que quieran». Esto es más frecuentemente aún si el hijo es único (las familias monofiliales son bastantes numerosas hoy en día).

La realidad es que hoy, con mucha frecuencia, debido a una generalización de

consentimientos, a una falta de normas educativas en las familias que se han situado en el otro extremo del péndulo, esto está originando problemas de adaptación en adolescentes que han desarrollado una personalidad muchas veces poco organizada, otras veces muy impulsiva y en otras ocasiones sólo deseosa de tener cosas, y cuando ya las tienen tener otras muchas más. Cuántas veces nos vienen padres a pedirnos consejos porque «ahora» el hijo les es completamente inmanejable, ahora el joven dice que ni quiere estudiar ni trabajar ni ir al colegio. Claro que ese «ahora» es cuando su hijo ya tiene 13-14 años. Los sociólogos hablan de la «generación ni-ni»: «ni» quieren estudiar, «ni» quieren trabajar. Pero el problema de normas ya viene de muchos años antes⁴¹ (nos encontramos, a veces, que nos piden consejo los padres porque ya con 6-8 años su hijo les es «inmanejable, incontrolable»).

Está claro que es absurdo considerar como adecuados los castigos físicos que se realizaban antaño en la educación infantil, con un grado e intensidad hoy en día inaceptables. ¿Pero no a los castigos? ¿Cómo instruir a los jóvenes durante la infancia en la necesidad de cumplir normas, y obligaciones? ¿Sólo hablando con ellos «como amigos», aunque el niño tenga 5 años?

Evidentemente, el exceso de castigo va a impedir un desarrollo armónico de la personalidad, pero los castigos tienen un papel que cumplir cuando son correctamente administrados en la educación infantil; no los demonizamos.

Otra cosa que indudablemente es importante diferenciar va a ser el maltrato (malos tratos) durante la infancia. Esto deja unas secuelas, no sólo durante la misma infancia (es el gravísimo problema de los niños maltratados), sino también en la formación de la personalidad, que posteriormente puede tener repercusiones importantes como factor sensibilizante de muchas patologías psíquicas.

3.2.1.3. El aislamiento social de la familia

La familia es un microsistema incluido en un sistema social más amplio.

Han sido clásicamente conocidos, como factores a tener en cuenta dentro de este apartado:

- I. Cambios frecuentes de residencia durante la infancia no dando tiempo a establecer unas relaciones sociales suficientes con los compañeros de clase o del barrio, dificultándose así la habilidad social en el niño al tener que renovar frecuentemente los amigos, creándole inseguridad y en muchas ocasiones retraimiento.
- II. Residencia en lugares apartados, en despoblados, masías... porque apenas si tenían contacto con otros niños de su edad. Esta situación, no obstante, hoy en día es muy rara.

Pero no nos olvidemos que puede ocurrir también otro tipo de aislamiento. Es el aislamiento intrafamiliar. Es muy frecuente que ambos padres trabajen y entonces apenas se establezca comunicación con el hijo. Los ratos que el hijo está más tiempo

en casa los padres muchas veces no están; y en otras ocasiones, cuando los padres llegan de trabajar, cansados y agotados, les cuesta o apenas realizan comunicación efectiva con el hijo. Digo «efectiva» porque los padres dirán que quieren mucho a los hijos, que los aman... pero el problema que aquí nos planteamos no es el de si quieren o no a sus hijos, que por supuesto presumimos que sí. El problema es que aun estando los padres cansados, el poco rato que tienen para descansar, ¿lo dedican a los hijos? ¿Para preguntarles por el colegio, por los amigos, por lo que están aprendiendo...?

El afecto que tienen por los hijos ha de ser también efectivo. No basta con tener afectividad con los hijos; el aislamiento del hijo se rompe cuando éste siente que se interesan por sus notas (no sólo si han sido buenas o malas, sino que en el caso de que sean malas o regulares, interesándose por los motivos de ellas, y si es necesario hacer alguna cosa, ayudarle en algo, para mejorar el rendimiento escolar, que asimismo le ayudaría a mejorar su autoestima), sus amigos, lo que él ha hecho en el colegio, y cuáles son sus problemas. Los problemas de los hijos han de detectarlos los padres.

Valga en general este aserto: es mejor pocas horas de contacto con el hijo, pero «*con una afectividad efectiva*», de manera que a él le llegue la atención y el «cuido» de los padres por él, que dedicar al hijo muchas horas de supuesta afectividad, pero no siendo esa afectividad efectiva: «estoy toda la tarde con mi hijo, lo recojo del colegio, luego él se mete en su habitación a jugar con la *play* o ve la televisión y yo hago cosas de casa».

Muchos padres y profesores escolares se quejan de que a los niños de hoy no les gusta leer, y tenemos que admitir que la información pasiva que pueden recibir a nivel audiovisual, juegos, televisión con múltiples canales, etc., les es, quizá, más atractiva y cómoda que el esfuerzo de estar concentrados en una lectura de un libro. Pero tengamos en cuenta que no sólo con la lectura aumenta mucho más la riqueza del lenguaje, aprenden más palabras y cometen menos faltas de ortografía, sino que además la lectura facilita una comunicación con los padres sobre el tema de lo que leen, sugerencias que les origina la lectura o ilustraciones, cosas que no comprenden, etc., pudiendo los padres compartir mejor la evolución del aprendizaje y los conocimientos que el niño va aprendiendo. Los niños pueden comentar con los padres sobre lo que han leído, ¿pero pueden fácilmente comentarles la trama de unos dibujos animados o unas series o programas que tienen mayor contenido visual que lingüístico? Y más en cuanto que el niño integra la película a la vida ordinaria mezclando frecuentemente fantasía y realidad, o imitando a sus ídolos de ficción, en su mundo real.

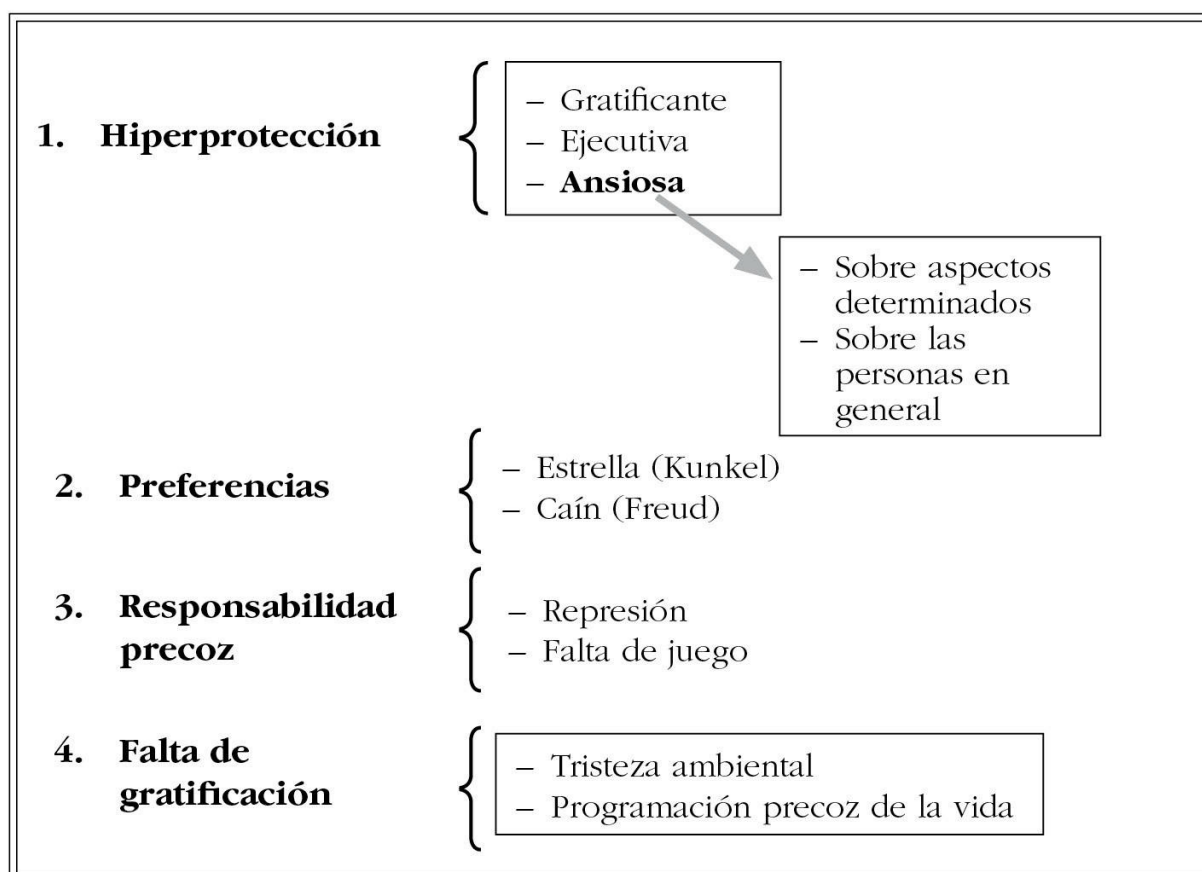
Difícil lucha la que tenemos los padres de hoy para que nuestros hijos aprendan con gusto a leer; enfrente no es que tengamos la *play* o la televisión, sino que tenemos «el poderoso mundo audiovisual».

Cuando P. Ridruejo habla de las agencias de sociabilización, señala cómo la familia es la primera fuente de socialización que influye en el niño y además la que accede de manera más directa. La implicación del niño con su familia es máxima y, por lo tanto, la acción sociabilizadora será global y completa. La escuela será la

segunda agencia importante de socialización, utilizando figuras de autoridad personal, conocimientos y reglas generales y especiales de comportamiento. La escuela, como la sombra al cuerpo, ha de ser un magnífico complemento efectivo de la directriz educativa familiar.

Pero si en la familia no se establecen claramente valores positivos de educación⁴², y lo importante para los padres es que en el colegio sólo se les dé a los alumnos la suficiente instrucción porque la educación es cuestión de ellos, tenemos entonces un gran problema. Por desgracia, frecuentemente lo más que se le exige al colegio, señalaba ya Rojo Sierra (1961), es que enseñe al niño a guardar la compostura social, es decir, que la conducta del niño se revista de un barniz de estética social, pero se olvida la educación psíquica del niño, la educación profunda del individuo por la que aprenderá a valorarse a sí mismo con dignidad y a tratar a los demás dignamente. Y peor aún si además le quitamos autoridad al maestro, no ya sólo sobre enseñanza, sino fundamentalmente sobre la educación.

TABLA 3.3
Esquema de aprendizajes anómalos ([Descargar o imprimir](#))



FUENTE: Extraído de M. Rojo Sierra. Lecciones de psiquiatría, tomo I. Ed. Promolibro, 1984.

3.2.2. Aprendizajes anómalos

Vamos a considerar una serie de aprendizajes anómalos que pueden influir de una

manera importante en la forma de enfrentarnos a los problemas de la vida en la adultez. Durante la infancia no sólo adquirimos conocimientos, sino que situaciones especiales de nuestra familia pueden hacernos adquirir una escala de valores y de «importancias», que en el caso de que el aprendizaje sea anómalo, también van a influir de manera decisiva en la formación de la personalidad.

En la tabla 3.3 se puede ver el esquema.

3.2.2.1. *Hiperprotección*

Tenemos una tendencia innata a proteger a nuestros hijos, lo cual es normal. El problema aparece cuando a la palabra «protección» le estamos preponiendo el superlativo «hiper», que, proviniendo del griego, significa «exceso»; en definitiva, estamos hablando de una exagerada protección.

— Hiperprotección gratificante

Este tipo de hiperprotección es hoy en día una de las más frecuentes. No sólo «le damos todo a los niños», o casi todo lo que piden, sino que incluso muchas veces se lo damos antes de que lo pidan, simplemente porque tal juego, juguete, ropa de vestir o cualquiera de los miles de complementos y cosas existentes para los niños la tiene un amigo, un compañero de colegio u otro niño cercano a la familia.

El aprendizaje cerebral y motivacional del niño va haciéndose según la pauta «consigo las cosas sin esfuerzo».

Esto, si bien antes era frecuente cuando los hijos eran cuidados por los abuelos, clásicamente considerados como «consentidores» y «mimadores», ahora se ha extendido a muchos padres. Más aún, en una sociedad en la que muy frecuentemente ambos padres trabajan, y en vez de plantearse realmente la calidad del contacto que realizan y el tiempo que están con los hijos, buscan, quizá inconscientemente, una compensación de su falta de tiempo en esa dádiva, en esa donación, de «cosas» con las que el niño —esperan los padres— se pueda sentir feliz.

La realidad es que el niño no aprende el camino del esfuerzo para obtener las gratificaciones, y cada vez le serán más insuficientes estas gratificaciones dadas, y necesitará nuevas cosas que apenas si le ilusionarán por poco tiempo. El niño se hará cada vez más exigente y los trastornos de comportamiento pronto aparecerán.

Cada vez más oímos a padres que se quejan de que a sus hijos de 8 a 13 años (aún puede aumentar más el problema un poco más adelante, en plena adolescencia) «nada les satisface». Igualmente, es cada vez más frecuente la situación del niño que con 13-15 años dice que ya no quiere estudiar más, que no quiere ir al colegio, ni trabajar «ni nada», ante el desespero de los padres, que perplejos no saben qué hacer, ni cómo actuar. Los padres no tienen antecedentes ni experiencia en su generación de circunstancias similares. Otras veces, estos niños ya adolescentes «se deprimen o padecen ansiedad», pues no encuentran alicientes, ni comprenden el sentido del esfuerzo: esperan ante un esfuerzo concreto una recompensa rápida y suficiente⁴³.

— Hiperprotección ejecutiva

En este caso, los padres le hacen todo al hijo, le matriculan, le atan los zapatos, etc. Este «ya lo hago yo» de los padres impide el correcto aprendizaje de muchas acciones y obligaciones en las que puede equivocarse el niño, pero, al mismo tiempo, también aprender del error que cometiera. Se harán muy dependientes.

Nuestra autoestima, nuestra vivencia de autovalor, se va desarrollando a medida que van sucediendo éxitos en nuestras acciones y fracasos, errores y consecuentes frustraciones. De esta manera, con un equilibrio del impacto vivencial de nuestros éxitos y fracasos, nuestro autoconcepto y sentimiento de valía suele desarrollarse con los años de una manera nivelada y estable. Evidentemente, una hiperprotección ejecutiva creará un sentimiento de minusvalía importante y una necesidad de buscar personas que dirijan y tomen las decisiones importantes por el sujeto, haciéndose anómalo en la edad adulta el comportamiento y/o el conjunto de sus relaciones sociales, de las que será muy dependiente.

— Hiperprotección ansiosa

La hiperprotección ansiosa es también muy frecuente. Todos conocemos esas madres «padecedoras» que están siempre controlando al hijo. Muchas veces, de una forma equivocada se puede pensar que este «ser padecedor» se hereda sobre todo de madres a hijas: «soy muy padecedora, como mi madre», nos dicen muchas pacientes. La realidad es que estamos en el contexto de un aprendizaje, no de una herencia. Si la madre es muy padecedora, haciendo una hiperprotección ansiosa sobre los hijos, les origina una inseguridad vital. El niño (más frecuentemente la niña, por la identificación de rol con la madre) vivencia de una manera inconsciente desde pequeño que «algo malo» ha de tener, «alguna indefensión importante ha de sufrir», pues la madre está siempre controlando lo que hace, padeciendo por la hora a la que llega, temiendo que le haya pasado algo, o abrigándolo excesivamente para que no enferme. Por este aprendizaje, de mayor serán también padecedoras al proyectar de nuevo, ellas también, esta inseguridad en las personas cercanas de su familia.

Por lo tanto, la hiperprotección ansiosa puede recaer:

a) Sobre la salud:

En este caso, el padecimiento es fundamentalmente de forma constante a que enferme, a que se resfríe, a que su salud empeore, siendo múltiples los motivos que puede encontrar: ese constante «quítate de la corriente», «abrigate», «no comas helados», etc., originará esa inseguridad corporal, un sentimiento de fragilidad de su salud y por lo tanto la tendencia a padecer trastornos ansioso hipocondríacos.

b) Sobre el mundo:

Una constate atención y cuidado excesivo acerca del mundo, «la gente es mala, te pueden hacer daño, te pueden pervertir». El niño aprenderá a ser muy desconfiado y por lo tanto susceptible, tendiendo, bien a retraerse o a hacerse su personalidad con

propensión paranoica.

3.2.2.2. *Preferencias*

En ocasiones nos encontramos con una preferencia de uno o ambos padres hacia alguno de los hijos.

Un individuo cualquiera puede:

- Ser preferido por uno de los padres.
- No haber sido el preferido.
- Haber sido marginado.

Hay que tener en cuenta que cuando utilizamos la palabra «preferencia» lo hacemos en un sentido muy concreto. Muchas veces es cierto que al preguntarle esto al paciente, nos responde claramente que él u otro hermano era el preferido del padre o de la madre, «el ojo derecho», pero otras veces ante la palabra preferencia no detectan realmente el sentido con que lo estamos preguntando. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor.

Ciertamente queremos a los cinco dedos de la mano por igual. Nadie quiere más al dedo índice que al pulgar. Aunque cada uno es diferente. No obstante, si tuviéramos que decidir, uno a uno, con qué dedo nos tenemos que quedar, distintos valores, ideas, funcionalidades, pasarían por nuestra mente para hacer una gradación y poner uno primero, otro segundo, hasta el quinto, sin que ni mucho menos se pudiera suponer que el quinto dedo elegido fuera así porque lo consideramos sin valor o porque no le tenemos «amor corporal».

Pues algo parecido ocurre con los hijos (entiéndase que el anterior sólo es un ejemplo comparativo). Partamos del principio que si en una familia hay 2 o 5 hijos, a todos se les quiere igual. Los padres no van a decir que su amor por uno de los hijos es mayor o menor que el que tienen por otro. Por lo tanto, cuando hablamos de preferencias hacia los hijos, el primer concepto claro que tenemos que tener es que no estamos hablando de «amores» hacia los hijos.

Estamos hablando más bien de circunstancias y elementos personales de padres e hijos que hacen que un padre o una madre se «lleven mejor», «se sientan más cercanos», «sintonicen más» con un hijo que con otro.

Si un padre es muy reservado, poco hablador e introvertido, y el hijo mayor varón es como el padre también poco comunicativo, y la hermana segunda es muy abierta, extravertida, alegre y expresiva, es más fácil que el padre se comunique mejor con la hija, simplemente por la complementariedad temperamental. El padre puede sentirse más cómodo con la hija que le da conversación y alegría, y notarse en la dinámica familiar que ésta «es la preferida del padre».

Otras veces el hijo mayor es el preferido del padre, al ser hijo mayor y ser considerado en la estructura familiar un valor de especial importancia el lugar que se ocupa en la fratría, sobre todo en referencia con los hijos mayores.

Otras veces, la hija mayor, que luego tiene uno o dos varones hermanos menores, tiene más afinidad con la madre, al ser ellas las dos únicas personas del sexo femenino, y se establece una preferencia de la madre por la niña.../..., y así podríamos valorar casi infinitas posibilidades que en cada caso pueden aparecer, teniendo en cuenta las dinámicas familiares y muchas veces el lugar que ocupa en la fratría el hijo o la hija.

En relación con la importancia e influencia que tiene el lugar que ocupaba el niño en la fratría en la formación del carácter, Alfred Adler (discípulo, al principio, de Sigmund Freud) estudió detenidamente este aspecto:

— El hijo único

Es el primer hijo y sobre él van a recaer todas las preferencias y las proyecciones de los padres, acerca de lo que quisieran haber sido o haber mejorado, o bien darle todo lo que ellos no tuvieron. Los padres tenderán a dirigirlo y a programarlo. El hijo único tendrá riesgo de ser neurótico (es decir, muy inseguro y con muchos conflictos internos) al sentirse programado, y a su vez, cuando ya sea mayor, tenerse que enfrentar a esa programación y control de los padres, con la que puede no estar de acuerdo, queriendo internamente tener su propia programación y proyecto vital.

Hoy en día, que vemos muy frecuentemente hijos únicos, éstos tienen un riesgo aún mayor, ya que en las sociedades modernas, en estos casos, hay un gran peligro de una hiperprotección gratificante y de darles todo lo que quieran, pues «como sólo tenemos un hijo»..., y al mismo tiempo una hiperprotección ansiosa por miedo a que le pase algo «al ser el único hijo».

Será, por lo tanto, en conjunto, complicada su estabilidad psíquica en la adolescencia y adultez si los padres no son conscientes de estos riesgos de preferencias e hiperprotecciones.

Es riesgo de los hijos únicos, como diría Kunkel, «ser estrella».

El niño se encuentra en el centro de la casa y todo el mundo está muy contento con él. Al final todo le es permitido y encuentra normal ser el primero en todo. Esa realidad de «ser el primero en todo» la tiene en su ambiente familiar que le lleva a la cumbre, por su gracia, habilidades, belleza, etc. Pero cuando vaya a la escuela, allí dejará de ser «estrella», pues no será el centro de los profesores ni de otros compañeros, y se producirá una caída de estrellato.

Por esto es muy recomendable que los hijos únicos empiecen la escolaridad y sociabilidad lo antes posible, en el período preescolar, para ya hacer el contacto en la escuela infantil con otros niños pequeños de su edad.

Si queremos evitar la neurosis en los hijos únicos, tenemos que conseguir para ellos, lo que denomina Adler la «comunidad social íntima». Con este término está haciendo referencia a la sociabilización de los impulsos. Adler es el primer psicoanalista que a principios del siglo xx ya dio un consejo pedagógico, para la salud psíquica. Considera que en los primeros 5 años es cuando el niño tiene que aprender los cimientos fundamentales de su personalidad social. El niño, hasta los 5 años va a intentar mostrar su «poder», mandar según sus impulsos; en definitiva,

hacer lo que le apetezca según los impulsos le vengan. Más todavía si es hijo único y sólo se mueve en el ambiente familiar, por cuanto que los padres le van a consentir muchos de esos impulsos, saltos en las camas, en los sillones, incluso bocados y otras «gracias», dentro de la familia. Si el niño pronto va al colegio infantil, entonces se verá obligado a sociabilizar esos impulsos de poder y, si lo hace, si interioriza la sociabilidad necesaria y aprende a hacer sociales sus impulsos, según Adler, se forma esa «comunidad social íntima» y el riesgo de la neurosis estará en camino de desaparecer.

— El hijo mayor (primer lugar en la fratría)

En principio está en la misma situación que el hijo único. Hasta que nace el segundo hermano. Entonces va a ser destronado por el segundo hermano. Ahora todas las atenciones recaen en el nuevo hijo, él ya no es el centro de la casa, el centro es el bebé y durante los primeros años todos los conocidos y familiares preguntarán a menudo por el nuevo vástago, olvidándose muchas veces de él. Se sentirá destronado.

Se irá planteando de una manera inconsciente, en los siguientes años, si ha de seguir con la programación de los padres, o buscar algo distinto. Ése será su conflicto fundamental.

— El segundo hijo (segundo lugar en la fratría)

El segundo hijo ya se encuentra con el hermano mayor antes que él. Considerará que todas las prebendas y beneficios los tiene el hermano mayor. Al hermano mayor ya le dan algo de dinero para ir a comprar, aunque sean caramelos, pero a él no: «Es muy pequeño, no vaya a perderlo, que lleve el dinero el mayor».

Desde su punto de vista, el mayor es quien posee todos los privilegios.

Por lo tanto, la postura psicológica del segundo hijo será la de ser competitivo. Intentará destronar realmente al hermano mayor. Si el hermano mayor no es muy responsable, él sí lo será; si el hermano mayor no es bueno en los estudios, él sí lo será. En definitiva, será competitivo, y querrá tener el rol de hermano mayor.

— El último hijo

En este caso, su aprendizaje psicológico va ser ya más variado, según la separación entre los hermanos y él.

Si es un último hijo, con bastantes años de diferencia entre él y los que le preceden, será entonces el mimando de la casa; los hermanos son mayores y él es ahora el juguete de todos, el bebé con el que todos los hermanos pueden jugar y mimar. Su postura psicológica será como si fuera hijo único.

Si son varios hermanos, tres o más, y hay pocos años de diferencia, todos mandarán sobre él y se sentirá marginado.

En este caso, cuando el niño tiene la vivencia de marginación, Freud dice que padece el complejo de Caín.

También puede darse este complejo de Caín en niños que ya van al colegio, y que por su temperamento muy reservado, introvertido, tímido (se denomina temperamento esquizotímico) apenas se relacionan con otros amigos, estando aislados. Entonces se encuentran en una situación de «dispatía», es decir, fuera de sitio, «fuera de ambiente», «como gallina en corral ajeno», no sintonizan con los demás compañeros, se sienten ajenos a los demás, inseguros. Tienen grave riesgo de enfermar de mayores, si no compensan su déficit de sociabilidad, pues introyectan sus vivencias en demasía y también sus impulsos agresivos, guardándoselo todo para ellos, creándoles una gran tensión interna, aunque aparentemente parezca «que van a la suya» o que son apacibles aislados.

El mismo Adler también opina —en su línea psicopedagógica— cómo el mejor medio de prevenir los desequilibrios de la personalidad consiste en evitar que los niños pasen el tiempo ocultos o separados en los rincones: «El niño que rehúye jugar, es neurótico o está en camino de serlo».

3.2.2.3. Responsabilidad precoz

Clásicamente, la responsabilidad precoz en la infancia la encontrábamos cuando la familia pasaba por situaciones económicas difíciles y el niño tenía que trabajar desde joven. A los 8-10 años (a veces incluso antes), y siempre antes de la adolescencia, ya se incorporaba de una forma u otra al ámbito de «obligación laboral», viviendo esta situación con un especial deber y necesidad para el bien o ayuda de la familia.

En generaciones anteriores no era raro encontrar personas que tenían que realizar cuidados de animales en el campo o en casa, trabajos agrícolas, recolecciones o empezar apenas a los 14-15 años a buscar un trabajo, de cuyo rendimiento económico en gran parte iba a necesitar la familia.

Hoy en día, en países desarrollados esto prácticamente no ocurre (exceptuando casos marginales). La escolaridad obligatoria y la mejora de las condiciones de vida y del nivel económico básico, así como las ayudas del Estado-social a las familias con dificultades, han disminuido (o hecho desaparecer) lo que era antes una práctica bastante frecuente.

Pero otras formas están apareciendo. Si tenemos en cuenta que la palabra «responsabilidad» procede de «esponsalis» que quiere decir «ligado» (de ahí el nombre de esposa/o), «que obliga a algo», las formas de obligación precoz o de presión que pueden hacer que niños actualmente en edad escolar se sientan excesivamente hiperresponsables aparecen por ejemplo ante situaciones de exigencia en notas y estudios. Esto ha dado lugar en ocasiones a alteraciones psíquicas, reactivas a obtener «un notable» cuando anteriormente los resultados eran «siempre» de sobresaliente. Niños con estos rendimientos tan excelentes pueden hacer una reducción existencial de su vivencia de autovalía en relación con las magníficas notas, y además la familia suele sentirse orgullosa de esos buenos rendimientos que pueden utilizar como prototipo de la imagen «buena» de su hijo ante los demás amigos y relaciones sociales. Tener un rendimiento «regular» o «malo» es vivido con

un intenso sentimiento de fracaso existencial, con gran angustia y vivencia de pérdida de valor ante la familia y las relaciones sociales propias, y muchas veces incluso con el miedo de pérdida de valor ante las relaciones sociales de los padres.

Pero también puede darse el caso contrario. En una paciente nuestra, con magníficos rendimientos «todos sobresalientes», los padres habían organizado desde que ella era pequeña un conjunto de actividades complementarias, propias de un ejecutivo «con agenda completa». Tras las clases, hacía piano, judo, otros días tocaba en una banda de música y otros días ballet, teniendo muy buenos rendimiento también en todas estas actividades. Esto funcionó hasta los 14 años, en que la joven se empezó a sentir internamente tan presionada por toda esta actividad complementaria que asombró a los padres, diciendo que «quería dejar de estudiar y dejar el colegio», además, por supuesto, de todas las demás actividades.

Por lo tanto, la hiperresponsabilidad precoz puede originar de adulto personas con muy poca «elasticidad psíquica», poniendo excesiva carga de compromiso en todo lo que hacen, y estando más vulnerables a acontecimientos que puedan hacer que las cosas le salgan mal (proyectos laborales, económicos, familiares...), pues también se sienten responsables del fracaso ocurrido. Aumenta entonces el riesgo de enfermedad psíquica. Y también puede ocurrir que, por un efecto pendular, se vayan al otro extremo, y decidan no querer tener responsabilidades de adulto, o rechazando muchas de éstas, entrando en un peligroso proceso de alteración del carácter y adaptabilidad (caracteropatía).

3.2.2.4. *Falta de gratificación*

Ante determinadas circunstancias el niño aprende que la vida carece de aspectos gratificantes (esta posibilidad está significativamente relacionada con la responsabilidad precoz). En este caso, la vida pierde incentivo para el sujeto.

Esta falta de gratificación aparece fundamentalmente en:

1. Tristeza ambiental

En este caso ocurre en el entorno alguna desgracia que oscurece el panorama vital. Por ejemplo, un niño cuyo padre murió y su madre y abuela no le dejaban salir de casa, ni jugar a nada, por la inmensa tristeza que había en el ambiente desde que el padre falleció. Sólo oía lamentos, y a los 6 años hizo un intento de suicidio.

En otro caso, un joven adolescente vivía solo con dos tías mayores. El joven apenas se relacionaba con amigos fuera del horario escolar. En casa —comentaba—, las tías estaban siempre sentadas en unas mecedoras desde las cuales podían ver por la ventana la calle. La casa era oscura, pues tenían muy cerradas las ventanas, y las tías se pasaban todo el rato quejándose de esta manera: una decía «¡Ay, Dios mío!», y la otra respondía «¡Qué se le va a hacer!».

2. Programación precoz

Un adulto es frecuente que tenga una visión gris (o por lo menos complicada) del mundo. La programación precoz aparece cuando ese adulto transmite esa visión al niño. Esta actitud es nefasta, no porque no corresponda a la realidad, sino porque puede bloquear la fantasía del niño al no estar preparado para comprender esa perspectiva adulta del mundo.

3.2.3. Frustraciones

Alfred Adler enfatizó mucho el problema de las frustraciones. Considera Adler que el ser humano desde que nace se va a encontrar con una situación de minusvalía o inferioridad. Durante los primeros años de su vida va a depender de los adultos para todo, incluso para su propia supervivencia. A diferencia de los felinos que pronto adquieren agilidad para evitar los peligros; las aves, capacidad para volar, y en general en el reino animal, que en poco tiempo se adquiere autonomía de supervivencia, en el caso del ser humano no es así.

Por esto, Adler habla de que existe en el ser humano, por el mero hecho de serlo, un sentimiento primario de minusvalía o inferioridad⁴⁴. Este sentimiento de minusvalía o inferioridad tendría que compensarse a lo largo de la infancia mediante lo que denomina el «afán de poder».

En definitiva, el niño buscando dominar su entorno, la familia, los amigos, etc., intentaría compensar ese sentimiento de minusvalía que tendría desde pequeño. Si consigue un equilibrio entre sus acciones de dominio y minusvalía de manera que se supere el sentimiento de inferioridad, entonces el sujeto evitaría la neurosis y sería psíquicamente normal.

Debemos considerar las contrariedades como un ejercicio, decía Lucio Anneo Séneca (2 a.C.-65 d.C.). Y ciertamente, si se compensan las frustraciones con éxitos, entonces nos dirigimos a la normalidad. Pero si el niño padece alguna característica que aumente su sentimiento de inferioridad, como puede ser un defecto físico, tendrá que buscar formas de hipercompensación de su sentimiento de minusvalía. Así por ejemplo, si un niño varón es muy poco hábil en los deportes en el colegio, puede que lo compense con muy buenos rendimientos escolares, o en otro caso un niño bajo de estatura se puede hacer muy impulsivo (de ahí viene el dicho «pequeño pero matón»). Todos estos mecanismos pueden compensarle de forma adecuada y se establece — como ya indicó Adler— una «comunidad social íntima» al ser los impulsos ya sociabilizados. Pero puede en algunos casos derivar a estilos disociales, haciéndose el niño un tirano, hostil, agresivo o humillante de otros niños.

La frustración, por lo tanto, va a ser algo con lo que vamos a vivir, queramos o no, durante nuestra vida. Podemos intentar definirla como el estado psíquico en que queda una persona cuando intenta realizar un acto psíquico, un deseo o un proyecto y no lo puede conseguir.

Es importante remarcar, como indica Ortega-Monasterio, que la experiencia ha de

ser vivida como displacentera.

Esto es debido a que en el campo de las frustraciones humanas la repercusión del acto psíquico, deseo o proyecto que pretendemos, va a estar muy mediatizado por la motivación o la meta puesta por el propio sujeto. No es lo mismo presentarse a una primera oposición esperando sacar una plaza, que ir motivado sólo como «prueba» para ver cómo es el examen o sabiendo que tiene pocas posibilidades de obtener esa plaza. En el primer caso puede originar gran insatisfacción no obtener la plaza y ser la experiencia muy displacentera (considerándose una frustración de las expectativas), en el segundo caso incluso se vivencia como positiva la experiencia aunque no se pueda conseguir la plaza.

Las frustraciones, pues, son normales en la vida. No todo lo conseguimos, deseos, proyectos, ilusiones, etc. Lo importante no es «no tener frustraciones», sino que el balance entre frustraciones y éxitos sea el adecuado. Nuestra vivencia de autovalía, nuestro autoconcepto, el valor que nos damos a nosotros mismos, va a depender de ese equilibrio.

Por lo tanto, tengamos muy en cuenta que no es malo tener frustraciones, sino que lo inadecuado será que haya un exceso de frustraciones frente a los éxitos, pues entonces disminuye mucho la autoestima.

Vemos, pues, que siempre rondamos la idea del equilibrio. Si bien un exceso de frustraciones sin compensaciones originará problemas comportamentales y a la larga psíquicos, no obstante se ha exagerado mucho en nuestros tiempos con la idea de que a los niños no hay que frustrarles, pues esto sería aumentar sus posibilidades de anomalía psíquica. Esto es absurdo; los niños han de tener frustraciones como un proceso normal de la formación de su carácter. No se les puede dar todos los juguetes que quieran para que no se frustren, ni comprarles un perro «para que no se frustre», y así una tras otra cosa.

Tanto es así, que en el caso contrario en que un niño viviera una infancia sin frustraciones, en el que todo fueran éxitos, y todo lo consiguiera, al no haber aprendido a superar frustración alguna, cuando llegara a edades de adolescencia o postadolescencia, cuando empezaran a presentarse las primeras frustraciones, se sentiría una persona desgraciada por no conseguir lo que quiere o desea, con grave riesgo de enfermedad psíquica y de inadaptación con su entorno (ya vimos la importancia negativa que tenía la hiperprotección gratificante y ejecutiva). En este sentido, Alonso Fernández resume lo que considera una opción educativa idónea: «el tipo de educación complaciente e impregnada de afecto que, cuando llega el caso, contradice alguno de los inoportunos deseos e impulsos del niño, con un oportuno “no”, es, en mi opinión, el mejor sistema para enseñar al niño a tolerar las frustraciones». Yo añadiría algo: ese «no» puede ser bastante frecuente, si es necesario, sin que por ello la educación deje de estar impregnada de afecto. Al final lo que buscamos es que el niño vaya adquiriendo madurez, y la madurez es la capacidad de superar las frustraciones, no la capacidad de no tenerlas.

3.2.4. Conflictos

Los conflictos nos pueden generar una «ansiedad» normal. Es imposible no tener conflictos, pues por el mero hecho de tener que elegir entre dos o más alternativas ya tenemos un conflicto; y esto es constante en nuestro desarrollo vital cotidiano. Como decía la escritora estadounidense Lin Yutang (1895-1976), «los conflictos existen siempre; no tratéis sólo de evitarlos, sino de entenderlos». El problema aparece cuando el conflicto nos genera una tensión tan elevada que nos desborda, entrando ya en un estado de ansiedad patológico.

Rojó Sierra (1984) esquematiza los conflictos de la siguiente manera:

— *Conflicto de atracción-atracción*

$$A (+) \longleftarrow / \longrightarrow B (+)$$

Tenemos, en este caso, que elegir entre una situación o un hecho A, que nos es agradable y lo consideramos en nuestra valoración como positivo, y frente a esta situación tenemos otra B, también considerada positiva y deseable. Lo importante para que sea conflicto es que nos veamos obligados a la elección. Decidarnos por una de las situaciones exige eliminar la otra.

Por ejemplo, puede ocurrir cuando en el caso de una separación un hijo ha de elegir entre el padre o la madre, siendo obligada esa elección (por las circunstancias especiales que aparezcan) y para ese niño, tanto la figura materna como la paterna sean ambas positivas y deseables. Puede aparecer, ante la exigencia de la elección, una crisis de ansiedad o trastornos comportamentales, expresión de la angustia que le supone esa elección que no es capaz de afrontar.

— *Conflicto de evitación-evitación*

$$A (-) \longleftarrow / \longrightarrow B (-)$$

En este caso, las dos posibilidades son indeseables o entendidas por la persona como negativas y ha de elegir forzosamente entre una de ellas («estoy entre la espada y la pared» es una expresión frecuente para indicar una persona que se encuentra en esta situación).

En un caso clínico de Rojó Sierra, el conflicto apareció en una joven cuyo ambiente familiar estaba constituido por su padre alcohólico que molestaba a la madre, que a su vez era poco comunicativa y expresiva y a la que descubrió en una ocasión teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Ante esta perspectiva pidió y consiguió una beca para un internado, en donde se encontró con un profesorado frío y que la sometía a una disciplina muy rígida y la castigaba por el mínimo fallo. El conflicto apareció porque los dos campos le repelían, el familiar y el del internado.

— *Conflicto de atracción-evitación*

Sujeto ha de elegir A (+ y -)

Por lo tanto, el esquema es:

Sujeto $\longrightarrow$ A (+ y -)

El mismo objeto agrada y desagrada al mismo tiempo, produciéndose mucha tensión, ansiedad y muchas veces un sentimiento de perplejidad.

Esto ocurrió en un caso en que un joven se hizo jefe de un grupo juvenil excursionista, sintiéndose con gran aumento de su autoestima por haber alcanzado ese estatus de «jefe» del grupo. En una excursión se hizo un ensayo de escalada y se le planteó el conflicto. Por un lado tenía que subir para no perder el liderazgo (con el que se había identificado en buena parte su autoestima), y por otra parte no podía subir, pues tenía pánico a las alturas. A consecuencia de esto le aparecieron vómitos y desmayos.

Este conflicto aparece muy frecuentemente en la vida cotidiana, en la adolescencia, cuando el joven empieza a salir más de casa y coincide que la madre es muy padecedora. Ante el hecho de salir por las noches se plantea el conflicto. Muchas veces el mensaje que le llega al joven es el siguiente:

1. Es bueno que salgas con tus amigos, ya eres mayor y no debes quedarte en casa (mensaje +).
2. Pero al mismo tiempo el joven recibe un mensaje negativo (-) ante el mismo hecho de salir por la noche los fines de semana, cuando la madre se queda esperándole despierta a que vuelva, «sufriendo» por si le pasa algo⁴⁵. El joven que cuando llega a casa ve a la madre que ha padecido tanto, que ha estado esperándole hasta bien avanzada la noche y que en muchos casos incluso le ha mandado varios mensajes de móvil a lo largo de la noche para saber ¿cuándo vuelves?, ¿todo va bien?, ¿vas a tardar mucho en volver?, etc., está recibiendo un mensaje claro contrario a su salida
3. Estos mensajes son computados por su inconsciente (y muchas veces también conscientemente) como: «salir es bueno, porque estoy en la edad de hacerlo y es bueno para mi desarrollo tener amigos y salir con ellos, también por la noche, pues es cuando salen habitualmente los jóvenes de ahora» (+) --- y --- (-); al mismo tiempo: «salir es malo, pues hago sufrir mucho a mi madre que se queda sin dormir toda la noche, padeciendo por mí».

Esta última situación familiar origina muchas veces ansiedad neurótica y otras veces enfrentamientos entre el joven y los padres si el adolescente radicaliza su postura y resuelve su conflicto, bien no haciendo el más mínimo caso a la madre y a sus padecimientos, o bien cuando se origina, por estos motivos, una situación de constante altercado y enfrentamiento en casa por estas circunstancias.

— *Conflicto de doble atracción-evitación*

A (±) $\longleftrightarrow$ B (±)

Se produce cuando las dos posibilidades o situaciones, o circunstancias a elegir, son ambivalentes; es decir, cada una de ellas es (+) y (–) a la vez.

En un caso nuestro, una persona tenía un sueldo bajo para sus aspiraciones económicas y de deseos de confortabilidad y proyectos para él y su familia (–). No obstante, este sueldo funcional era muy estable (+).

Le hicieron una oferta de traslado a otra ciudad en donde le ofrecen un sueldo muy elevado, con posibilidad de ascender económicamente más aún en años sucesivos (+), pero el contrato era renovable cada 5 años, perdiendo la seguridad que tenía con su plaza funcional previa (–).

Padeció fuertes síntomas ansiosos, insomnio, anorexia, y ya aparecían síntomas depresivos y de agotamiento, con irritabilidad (por el insomnio) cuando acudió a nuestra clínica y empezó el tratamiento.

* * *

Será fundamental, pues, reconocer y dar la importancia necesaria en cada uno de nosotros a los conflictos que tenemos, pues, como dice Elrod, «El paciente aprende que el conflicto está siendo amaestrado cuando el conflicto es reconocido como maestro».

3.3. FACTORES DESENCADENANTES

Son los que van a actuar como percutores, los que van a tener la suficiente fuerza eficaz para originar en un momento dado la enfermedad ansiosa.

Por supuesto, en base a lo visto anteriormente, cualquier frustración, conflicto o situación vivida puede actuar como factor psicógeno desencadenante de una enfermedad ansiosa si éste tiene un especial significado dentro de su biohistoria y/o una fuerza eficaz intensa capaz de quebrar el estado de salud.

Pero también he querido referir una serie de factores productores de ansiedad en relación con enfermedades médicas, muy didácticamente extraídas por S. A. Epstein y D. Hicks.

1. Incertidumbre acerca de los diagnósticos médicos. Las exploraciones sistemáticas pueden producir ansiedad. Una persona con antecedentes familiares de cáncer de mama puede sentirse especialmente ansiosa durante el período previo a una mamografía sistemática. También puede influir esto en el personal laboral encargado de las mamografías: una paciente nuestra padeció fuerte ansiedad, pues era la encargada de informar, por teléfono, a las mujeres que se habían hecho una mamografía, que tenían que repetírsela «pues no estaba bien del todo». La angustia que le transmitían constantemente estas mujeres tuvo un fuerte impacto vivencial, originándole un trastorno ansioso.

Frases médicas como «probablemente no será nada, pero vamos a repetirle la prueba» o «no está bien, pero no tiene demasiada importancia, dentro de unos meses

volvemos a repetirlo», pueden ser provocadoras de ansiedad por la incertidumbre que originan.

2. Ansiedad por el impacto de la enfermedad en la identidad y en el sustento. Esto aparece cuando piensan que la enfermedad médica va a afectar significativamente en su capacidad para trabajar, en la realización de sus funciones domésticas o en las posibilidades de mantener los ingresos económicos.

3. Ansiedad ante los desconocidos y ante la soledad en el hospital. No es infrecuente la aparición de ansiedad en pacientes graves que han de confiar su vida a nuevos médicos que acaban de conocer en visitas o en urgencias. Igualmente, para muchos pacientes es difícil tolerar el hecho de estar solos en el hospital.

Por otra parte, hay una serie de factores físicos o bioquímicos que pueden originar ansiedad. Aunque son muchos los estados médicos y las sustancias relacionadas con la ansiedad, especialmente he de subrayar:

- Prolapso de la válvula cardíaca mitral (consiste en un prolapso de una de las valvas de la válvula). Algunos autores han encontrado entre un 6-18% de la población con algún tipo de prolapso de la válvula mitral, siendo esto completamente asintomático. Pero en ocasiones origina sintomatología parecida a la ansiosa, como puede ser palpitaciones, taquicardia, mareo, vértigo, fatiga, dolor torácico, y otras veces, aunque aún hay polémica, crisis agudas de ansiedad (crisis de angustia o de pánico).
- Hipertiroidismo. Muy importante de descartar cuando tenemos cuadros crónicos de ansiedad y asimismo cuando aparecen crisis agudas de ansiedad. Se ha señalado cómo en ocasiones el que tengan las palmas de las manos calientes y secas (no frías y húmedas) y que la fatiga acompañe al deseo de estar activo, puede diferenciar algo al hipertiroidismo de la ansiedad pura.
- Feocromocitoma. Es un tumor suprarrenal que libera mucha noradrenalina y adrenalina originando hipertensión y síntomas semejantes a los ansiosos (temblor, oleadas de calor, sudoración, sequedad de boca cefalea...). Es poco frecuente (aproximadamente un 0,1% de las personas con hipertensión). En un caso nuestro, pensamos en esta posibilidad, que luego se confirmó, porque padecía estos síntomas de una manera muy entrecortada, una vez cada 2-3 días, con hipertensión y sin relacionarse con ningún factor psicológico, estando el resto del tiempo completamente asintomático.
- Hipoglucemia.
- Porfiria aguda intermitente. Es un trastorno de transmisión genética, más frecuente en mujeres y que aparece alrededor de los 30 años. Origina episodios de dolor abdominal, hormigueo en los miembros y ansiedad.
- Sustancias estimulantes. Cocaína, éxtasis, anfetaminas, marihuana, LSD. Y hay que estar especialmente atentos con los tratamientos con corticoides, que si bien muchas veces son imprescindibles para una patología orgánica (alérgica, pulmonar, intestinal...), no obstante frecuentemente nos desencadena estados ansiosos o nos descompensa a pacientes ya asintomáticos de su ansiedad. ¿Y la

cafeína? Evidentemente es un excitante, y a partir de 200-300 mg al día de cafeína pueden producirse síntomas ansiosos. Lógicamente, en las personas más sensibles a la cafeína, con mucha menos dosis se les desencadena ansiedad. Por supuesto, no pueden tomar cafeína los pacientes que se encuentran en tratamiento por un trastorno de ansiedad o sufren enfermedad ansiosa, aunque no se estén tratando.

Los contenidos de cafeína de bebidas habituales los expongo a continuación:

Contenido de cafeína	Cafeína (mg)
Coca Cola regular (360 cc)	46
Coca Cola light (360 cc)	38
Pepsi Cola regular (360 cc)	46
Pepsi Cola light (360 cc)	38
Café exprés (180 cc)	103
Café instantáneo (1 cuch. té)	57
Café descafeinado (1 cuch. té)	2
Té (250 cc)	30-36
Chocolate (1 oz)	5-35

NOTAS

[27](#) Fundamentado esencialmente en el libro *Lecciones de psiquiatría*, tomo I. M. Rojo Sierra.

[28](#) Virginia Adult Twin Study of Psychiatric and Substance Abuse Disorders.

[29](#) Aunque investigaciones apuntan a una posible implicación del gen de la COMT y el gen de la IMAO-A.

[30](#) Sofronia = serenidad.

[31](#) Con el término pródromos se hace referencia las manifestaciones ansiosas que se dan de manera temprana antes de la aparición de un episodio claro del trastorno ansioso (Vázquez-Barquero, 2005).

[32](#) Ser-en-el mundo es igual a existencia. Esto significa *ex* = fuera, y *sistere* = colocar. Es decir, cómo aparecemos, nos manifestamos en el mundo en relación con los demás.

[33](#) Como ya hemos indicado anteriormente, la palabra angustia proviene de *angustus*, que significa angosto, estrecho. La angustia, más que la ansiedad, es vivida como una opresión interior, una angostura y agobio que desde el interior paraliza.

[34](#) En muchos de estos pacientes, además del tratamiento psiquiátrico, también se prescribe un tratamiento psicológico con psicólogo.

[35](#) Erich Fromm desarrolla magistralmente la dificultad que aparece cuando hay que elegir entre la seguridad y la libertad (autenticidad) en su obra *El miedo a la libertad*. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1974.

[36](#) Dice Mónica Cavallé que una vida orientada prioritariamente hacia los bienes utilitarios se asfixia esencialmente, aunque existencialmente parezca floreciente y envidiable. Como nuestra paciente no volvió posteriormente a consulta, una vez que tuvo clara su decisión y se encontraba bien, no sabemos si esa decisión le sirvió para enriquecer su mundo interior, o sólo le ocultó el vacío interior que padecía en esa etapa de crisis o metamorfosis de su vida.

[37](#) Postrario/ria lo derivo de *postrarius*, que significa «último de una serie» o «dícese de la parte más retirada»; disidencia proviene de *dissidere* = mutuamente separado. Algo que caracteriza a esta edad es ser la

última de la serie de edades, y que en ella las personas de esta 3.^a y 4.^a edad no sólo se encuentran separados de las otras generaciones, sino que además entre sí también se aíslan y progresivamente limitan sus contactos y proyectos comunes.

[38](#) Recoge el concepto «situación» de K. Jaspers, subrayando que toda situación supone vivenciar una realidad con sentido.

[39](#) Estos apartados los desarrolla más ampliamente Rojo Sierra en sus *Lecciones de psiquiatría*, tomo I.

[40](#) Biografía significa bios = vida, grafía = escritura. Es decir, lo pasado de nuestra vida, lo que podríamos escribir de nuestra vida. Se usa normalmente para referirnos a nuestros acontecimientos pasados.

[41](#) Hacia los años ochenta nos visitó el profesor Urban, catedrático de Psiquiatría en Leipzig, y cuando le pregunté cuál era el mayor problema que tendría la juventud de entonces, me respondió que «la anomia» (falta de normas); pensé que habría exagerado un poco, pero ahora con el tiempo he de darle la razón, como uno de los principales problemas educativos «desde la familia».

[42](#) Es clásica la división de la pedagogía en «enseñanza», que se ocupa de la instrucción del niño en los conocimientos que debe saber, y «educación», que se interesa por la formación de la persona del niño y sus relaciones con el ambiente social

[43](#) En España, la escolaridad obligatoria hasta los 16 años (en anteriores planes educativos era hasta los 14 años) ha planteado un grave problema de niños, ya adolescentes, que en los dos últimos años (14-16), sintiéndose con la elevada vitalidad propia de su edad, y el convencimiento, ya, de sus primeras decisiones, no quieren ni tienen el mínimo interés en realizar estos dos últimos años de estudios. Esto está originando un grave problema de comportamiento escolar y en la familia, desmotivaciones y alteraciones de ánimo. No realizan esfuerzos, no tienen interés en realizarlos, y no comprenden las gratificaciones, a medio o largo plazo, que les proporcionaría el esfuerzo escolar, pues su situación la consideran intensamente forzada y sin proyecto existencial.

[44](#) Este concepto luego derivó, popularizándose, por influencia de otro autor, Branchfield, al término de «complejo» de inferioridad.

[45](#) Más grave es aún el problema si la madre no es sólo padecedora, sino una hiperprotectora ansiosa.

4. LA NEUROSIS DE ANSIEDAD Y EL TRASTORNO DE ANSIEDAD⁴⁶

«Al aceptar la neurosis, el ego ha realizado un mal negocio.»

SIGMUND FREUD.

4.1. LA NEUROSIS DE ANSIEDAD

Lo que hemos conocido en el capítulo anterior nos va a servir de gran utilidad para entender qué estamos diciendo cuando diagnosticamos a un paciente de neurosis de ansiedad.

El problema fundamental es que el diagnóstico hay que hacerlo individualizado y, por lo tanto, no nos va a bastar con saber que un paciente tiene síntomas de ansiedad, sino que lo más importante será conocer cómo aparece la ansiedad en esa persona en concreto y si los acontecimientos de la vida (factores sensibilizantes) son fundamentales para entender cómo se desencadenó la enfermedad y por qué un acontecimiento actual tiene un especial significado y fuerza eficaz. Si el desencadenante de la enfermedad se puede relacionar con su biografía, entendiendo que ha tenido esa fuerza eficaz por su significado biográfico (relación de la parte con el todo), entonces podemos hablar de neurosis de ansiedad, y por esto, R. Sarró considera a las neurosis como reacciones biográficas patológicas.

Es decir, estamos señalando que el paciente padece una enfermedad con sintomatología claramente ansiosa y que esa sintomatología se ha desencadenado por algún acontecimiento que le ha ocurrido⁴⁷. Pero lo importante es que ese acontecimiento ha tenido una fuerza eficaz especialmente grande, ya que el paciente se encontraba sensibilizado anteriormente, en su vida o en su infancia, al mismo.

Esto presupone que hay una sensibilización del sujeto a determinados hechos o vivencias, y en un momento de la vida un acontecimiento actual «semejante» al que le ocurrió desencadena la enfermedad⁴⁸. Por esto dice López Ibor (1966): «Cada hombre tiene su fórmula personal de convertirse en neurótico». Y en 1979: «No se tiene una neurosis, sino que se hace un neurótico».

Pongamos un ejemplo sencillo.

Una persona ha pasado penuria económica en la infancia. Luego, durante su juventud, empieza a trabajar y poco a poco crea varias empresas que le aportan muy buenos beneficios, y ya vive tranquilo sin problemas económicos. Mas un día le dicen sus asesores que una de sus empresas (sólo una de las 8 o 9 que tiene) ha tenido ese mes números «rojos», y le explican que no ha de preocuparse, pues es algo coyuntural y que en breve se solucionará, y además las otras empresas de su

propiedad van viento en popa.

El paciente empieza a padecer mentismo (es decir, pensamientos continuos que no puede evitar) acerca de si se arruinará, y en poco tiempo padece insomnio por este «sin parar de pensar» en la ruina, y la angustia va apareciendo junto con síntomas ansiosos, palpitaciones, diarreas, sensación de falta de aire, etc. Sabe lógicamente que no debería preocuparse del problema económico de la empresa que ha dado el balance negativo, pero no puede dejar de estar tenso, con dolores de cabeza, inquietud y otros muchos más síntomas ansiosos junto a los anteriormente descritos.

Podemos entender, en este caso, que por la sensibilización previa de la infancia se identifica el valor «pasar penuria económica = números rojos». Y por esta sensibilización, el que aparezcan esos números rojos en su empresa tuvo un significado (relación de la parte con la totalidad) angustioso y cargado de gran fuerza eficaz, capaz de originarle la enfermedad ansiosa, es decir, una neurosis de ansiedad.

Por esto, desde K. Schneider, a las neurosis se las llamó *reacciones vivenciales anormales*.

Este autor dice que una reacción vivencial normal es una respuesta motivada y con sentido ante una vivencia. Pero en las reacciones vivenciales anormales (neurosis) hay ante ellas un impacto en el individuo de extremada violencia e inadecuación frente al estímulo que las provocó.

Las neurosis son, por lo tanto, trastornos de la elaboración o del impacto vivencial.

Y entonces el paciente queda prendado de la vivencia pretérita y de su conexión con la actual. Como la mujer de Lot, que quedó mirando al pasado y así petrificada en estatua de sal, el paciente neurótico queda agarrado por el pretérito. El futuro ahora pierde flexibilidad, el paciente no avanza en la vida y el pasado está actualizándose constantemente en su vivir cotidiano. El futuro ahora está arrastrado cada día por el angustioso pasado. Por esto, cuando tratamos a pacientes neuróticos la salud la recupera no sólo cuando la sintomatología desaparece, sino cuando consiguen dejar el pasado «atrás»; no hay que olvidarlo —el pasado no hay que olvidarlo, es parte de nuestro acervo histórico personal—, pero sí dejarlo donde debe estar: en nuestra historia pretérita, no actualizándose y presentizándose en nuestro vivir diario. Metafóricamente digamos: «Dios puso los ojos delante para que miremos al futuro, no en la nuca para que miremos para atrás».

Veamos otro ejemplo⁴⁹.

Una enferma viene a consulta porque de noche sufre crisis de ansiedad y desasosiego, sintiendo tanta inquietud como si fuera a morir. Estas crisis pronto las sufre también de día, y a consecuencia de ello no puede atender a su madre enferma, que ha venido a vivir con ella. He aquí una curiosa coincidencia: estas molestias le aparecen desde que su madre está con ella. Es importante conocer que la enferma tiene cuatro hijos y no tiene servicio. El estudio de su biografía nos descubre que la madre de la paciente, cuando ésta tenía 4 años de edad, cuidaba a la abuela que era cardíaca y tenía frecuentes ataques. Era tanto el cuidado que tenía que prestarle que no podía dormir y languidecía día a día. La paciente, a pesar de ser tan pequeña, llegó a preocuparse tanto por su madre que acabó por instaurarse en ella una tremenda

agresividad hacia la abuela, hasta desear que se muriera; a la par tenía cada vez más resentimiento hacia la madre porque la inculpaba de preocuparse más de la abuela que de ella. La madre posiblemente se dio cuenta de estos sentimientos de la niña, pues un día la llamó aparte y le dijo que si no cuidaba de la abuela sería una *mala hija*, y que una mala hija siempre es *mala madre*. Entonces se creó en nuestra paciente un conflicto doble de aversión, ya que si su madre no cuidaba a la abuela al ser mala hija, la calificaba como «mala madre» (–), y si la cuidaba dando su vida y dejándola huérfana, no sería una buena madre tampoco (–). Por lo tanto, la vivencia de la relación hija-madre no fue elaborada en su niñez.

Ahora, en la situación actual, siendo ya adulta, desde que la madre se fue a vivir con ella se reproduce una misma situación: si la paciente cuida a su madre, se inculpa de no poder cuidar a sus 4 hijos como debiera, faltando a su deber de madre, y si no cuida a la madre enferma, al ser mala hija, demostraría también ser madre mala. La neurosis de ansiedad, con sus crisis de angustia, es el resultado de este viejo conflicto no elaborado y ahora repetido.

* * *

El término neurosis, que fue introducido por el médico y químico escocés William Cullen en 1769⁵⁰, ha evolucionado mucho desde entonces hasta la actualidad, pues se llegaron a incluir en esta enfermedad trastornos orgánicos como la enfermedad de Huntington, la astasia-abasia, la parálisis agitante, y hasta el tétanos y la rabia. En el siglo xx ya claramente se admite su génesis por un conflicto intrapsíquico y se le da especial importancia a la personalidad para valorar cómo se elaboran las vivencias. Así, Jaspers (1913) define lo neurótico, como desviaciones psíquicas cuyas bases se asientan en situaciones y conflictos. Igualmente, S. Freud (1929) considera que la angustia neurótica aparece cuando los estímulos que alcanzan el aparato psíquico son demasiado grandes para que puedan ser absorbidos, incorporados.

Lo neurótico en sus tres acepciones (Baca, E. y cols., 2002): 1) como resultado de un trauma; 2) como resultado de lo biográfico, y 3) como patología de lo personal, supone que es necesario el estudio profundo de la vida del paciente, siendo insuficiente la mera descripción de la sintomatología clínica.

En 1985, P. Tyrer define el síndrome neurótico general, que permite detectar y tratar a pacientes muy mal delimitados por las nuevas clasificaciones actuales CIE-10 y DSM-IV. Aunque éstas hayan apartado el nombre neurosis de sus códigos, no obstante, señala Sims (1983): la vida ordinaria y las consultas médicas están plagadas de individuos infelices que viven abrumados por problemas nimios, sufren con frecuencia ansiedad y desmoralización, y su vida está llena de pequeños o grandes temores, rarezas o extravagancias, que amargan su existencia y la de los que le rodean.

¿Pero cómo ponernos de acuerdo todos los psiquiatras para valorar los acontecimientos de la vida?

Dado que hay muchas teorías para explicar «la importancia» de ciertos

acontecimientos de la infancia, ¿cómo hacer estudios estadísticos e investigaciones sobre la población de enfermos neuróticos si hay tantas teorías? Como señala López Ibor (1979), «las neurosis son enfermedades tan personales que resulta muy difícil la apreciación estadística»

4.2. TRASTORNO DE ANSIEDAD

La dificultad de poder tener criterios iguales para todos los psiquiatras y sobre todo cuando se realizan investigaciones sobre pacientes con enfermedades psíquicas hizo que aparecieran los RDC, es decir, el manual de criterios de investigación (Research Diagnostic Criteria, 1975). A partir de ese momento, y desde él, evolucionaron las diferentes versiones de DSM (manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales), elaborados por la Asociación Americana de Psiquiatría, y los diferentes CIE (clasificación estadística internacional de enfermedades y otros problemas de salud) elaborados por la Organización Mundial de la Salud.

Lo importante, como indican J. Giner Ubago y cols. (2002), es que por la necesidad de obtener un consenso lo más amplio posible, sin tener en cuenta teorías, es por lo que el término neurosis desapareció de estas clasificaciones (de la DSM) o quedó como un simple referente histórico en segundo plano (en el caso de la CIE). Desaparece también el término «enfermedad» y aparece el término «trastorno» (ese horrible e indiferenciado «palabro» psiquiátrico, comenta V. Conde, 2005). Los pacientes pasan de tener una enfermedad mental a tener un trastorno mental.

Ya en el primer borrador del DSM-III (1977) se estableció eliminar términos y conceptos que no implicasen definiciones operativas, por lo que tanto los conceptos de neurosis como los de psicosis, neurastenia e hipocondría fueron eliminados. Igualmente se decidió que las definiciones deberían tener criterios de inclusión y de exclusión.

A continuación vemos *los criterios de la CIE-10* para incluir a un paciente como que padece un trastorno de ansiedad generalizada (código F41.1).

La característica esencial de este trastorno es una ansiedad generalizada y persistente, que no está limitada y ni siquiera predomina en ninguna circunstancia ambiental en particular (es decir, se trata de una «angustia libre flotante»). Como en el caso de otros trastornos de ansiedad, los síntomas predominantes son muy variables, pero lo más frecuente son quejas de sentirse constantemente nervioso, con temblores, tensión muscular, sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos y molestias epigástricas. A menudo se ponen de manifiesto temores a que uno mismo o un familiar vaya a caer enfermo o a tener un accidente, junto con otras preocupaciones y presentimientos muy diversos. Este trastorno es más frecuente en mujeres y está a menudo relacionado con estrés ambiental crónico. Su curso es variable, pero tiende a ser fluctuante y crónico.

Pautas para el diagnóstico

A. El afectado debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante varias semanas seguidas. Notable ansiedad, preocupación y sentimientos de aprensión (justificados o no) en relación con acontecimientos y problemas de la vida cotidiana.

B. Por lo menos 4 de los 22 síntomas listados abajo deben estar presentes, y al menos uno debe ser del grupo de síntomas autonómicos.

- Síntomas autonómicos: palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado, sudoración, temblores o sacudidas de los miembros, sequedad de boca (no debida a la medicación o deshidratación).
- Síntomas torácicos y abdominales: dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor o malestar en el pecho, náuseas o malestar abdominal.
- Síntomas relacionados con el estado mental: sensación de mareo, inestabilidad o desvanecimiento, sensación de que los objetos son irreales (desrealización), o de sentirse lejos de la situación o «fuera» de ella (despersonalización), sensación de perder el control, «volverse loco» o de muerte inminente, miedo a morir.
- Síntomas generales: sofocos o escalofríos, sensación de entumecimiento u hormigueo.
- Síntomas de tensión: tensión muscular o dolores y parestesias, inquietud y dificultad para relajarse, sentimiento de estar «al límite» bajo presión o de tensión mental, sensación de nudo en la garganta o dificultad para tragar.
- Otros síntomas no específicos: respuesta de alarma exagerada a pequeñas sorpresas o sobresaltos, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco debido a la preocupación o ansiedad, irritabilidad persistente, dificultad para conciliar el sueño debido a las preocupaciones.

En los niños suelen ser llamativas la necesidad constante de seguridad y las quejas somáticas recurrentes. La presencia transitoria (durante pocos días seguidos) de otros síntomas, en particular de depresión, no descarta un diagnóstico principal de trastorno de ansiedad generalizada, pero no deben satisfacerse las pautas de episodio depresivo (F32.-), trastorno de ansiedad fóbica (F40.-), trastorno de pánico (F41.0) o trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-).

Incluye: Estado de ansiedad. Neurosis de ansiedad. Reacción de ansiedad.
Excluye: Neurastenia (F48.0).

En la tabla 4.1 vemos los criterios según el DSM-IV-TR.

TABLA 4.1

Criterios según el DSM-IV-TR para el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada (incluye el trastorno por ansiedad excesiva infantil) ([Descargar](#) o [imprimir](#))

A. Ansiedad y preocupación excesivas (expectación aprensiva) sobre una amplia gama de acontecimientos o

actividades (como el rendimiento laboral o escolar), que se prolongan más de 6 meses.

B. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación.

C. La ansiedad y preocupación se asocian a tres (o más) de los síntomas siguientes (algunos de los cuales han existido más de 6 meses). Nota: en los niños sólo se requiere uno de estos síntomas.

(1) Inquietud o impaciencia.

(2) Fatigabilidad fácil.

(3) Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco.

(4) Irritabilidad.

(5) Tensión muscular.

(6) Alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el sueño, o sensación al despertarse de sueño no reparador).

D. Los síntomas de ansiedad no se refieren a la posibilidad de padecer una crisis de angustia (como en el trastorno de angustia) o a pasarlo mal en público (como en la fobia social), o a contraer una enfermedad (como en el trastorno obsesivo-compulsivo), o a engordar (como en la anorexia nerviosa) o a padecer una enfermedad grave (como en la hipocondría).

E. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

F. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (ej., drogas, fármacos) o a una enfermedad médica (ej., hipertiroidismo) y no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno del estado de ánimo (ej., depresión), de un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo.

Así pues, sin tener en cuenta la biografía del paciente, independientemente de cuáles puedan ser los motivos, la situación o las circunstancias personales, si se cumplen esos criterios, se puede diagnosticar a una persona como padecedora de un trastorno de ansiedad.

Veamos un ejemplo clínico.

C. V. G. tiene 40 años de edad y padece desde hace 4 años dolor de nuca (nucalgia) y dolor de cabeza en la mitad izquierda (cefalea hemicraneal), gran inquietud interna, se siente casi siempre tensa y con sensación de prisa interior («todo lo hago acelerada», comenta) y nota como si tuviera un pellizco o peso en el estómago y sensación de nudo en la garganta (nudo esofágico). Frecuentemente siente palpitaciones y que se le acelera el pulso. Se encuentra muy irritable y ante «la más mínima cosa» responde de mal humor. Suspira frecuentemente y nota un «peso» que le oprime el pecho, por lo que ha de respirar fuertemente al tener la sensación que no le entra «bien» el aire. Se encuentra muy cansada y el más mínimo ruido le molesta mucho (hiperestesia a ruidos) y la hace estar más irritable.

Los días que sufre más intensamente estas molestias se siente triste y con poca disposición para hacer las cosas de casa.

Evolución de la enfermedad

El cuadro clínico se inicia hace 4 años, tras un grave problema familiar. El marido se compromete en un negocio en el que tienen que aportar mucho dinero, teniendo que acudir a un crédito que se avala con los bienes de la familia. El negocio sale mal

y ante la presión de los acreedores ella ha de hablar con su padre para que les ayude. Como el padre y el marido se llevan muy mal, ella ha de mediar entre los dos para conseguir la ayuda económica. Tras múltiples discusiones, muy violentas con el padre, por fin consigue que les ayude y se resuelve el problema económico. Desde que tiene esas discusiones le aparece la sintomatología que no ha mejorado de manera significativa hasta la actualidad.

Estudio psicobiográfico

La paciente ha sido desde pequeña muy padecedora, trabajadora, ordenada, meticulosa y programadora del futuro. Es hija única.

El padre es definido por la paciente como avaro a pesar de tener bastante dinero. Trataba mal a la madre, con insultos frecuentes y amenazas casi diarias delante de la hija desde que ésta tenía sólo 4-5 años de edad. El padre se iba con otras mujeres cuando quería y apenas si le daba dinero a la madre. Posteriormente, el padre dejó de hablar, por completo, a la madre, y entonces para decirse mutuamente lo que querían o pensaban usaban como «mensajera» o mediadora a la hija.

La paciente, en su primera etapa escolar, hasta los 9 años de edad, cambió tres veces de colegio, por lo que en cada ocasión perdía las amigas que hubiera hecho. Ante esta circunstancia de soledad se encontraba muy unida a la madre.

A los 9 años entra en un colegio fijo pero de un nivel socioeconómico superior al suyo. El padre no le daba dinero, por lo que se sentía desplazada y apenas hace amigas. Cuando acaba la escolaridad con 18 años hace secretariado durante dos años, y cuando lo termina encuentra trabajo, pero el padre se niega tajantemente a que trabaje fuera de casa. Se la lleva a trabajar al comercio familiar en donde está 10 horas diarias, pero sin darle casi dinero a ella, por lo que no tiene apenas relaciones sociales ni amistades.

Con 21 años va a veranear con la madre a un balneario en donde conoce a un chico y se enamora. Con 24 años ya está dispuesta a casarse con su novio, que también es hijo único. El padre se niega tajantemente a este matrimonio. Con el apoyo de su madre, teniendo 26 años, consigue casarse aunque el padre los deja plantados en la iglesia. Se independizan tras casarse y se adapta bien a la vida matrimonial. Ha tenido dos hijos y ha llevado muy bien la crianza de éstos y la relación con el marido. Ha tenido constantemente problemas con el padre, ya que la madre «por aguantar al padre» tenía depresiones, de manera que la paciente la recogía durante unos meses hasta que mejoraba y luego volvía a casa del padre hasta que de nuevo la situación se hiciera insoportable.

Ésta ha sido la dinámica familiar hasta hace 4 años, en que aparecen los problemas económicos relatados al principio y comienza su enfermedad actual.

A) Factor disposicional: Temperamento meticuloso y ordenado.

B) Factores sensibilizantes:

1. { Hija única en familia conflictiva.
Enfrentamientos entre padre y madre: disputas y palizas.
Ella tenía que ser la mediadora. Pues se hablaban sólo a través de ella como mensajera entre ambos.
2. Cambios de colegio → desadaptación y soledad.
3. Colegio estable pero socioeconómicamente superior → marginación.
4. Se opone el padre a la boda, pero se casa con otro hijo único.

C) Desencadenante

El marido se compromete en un negocio en el que se endeuda de forma importante y tienen que ser ayudados por el padre de ella → VUELVE A REPRODUCIRSE LA SITUACIÓN DE HIJA ÚNICA MEDIADORA

SINTOMATOLOGÍA

Figura 4.1. Esquema etiopatogénico de una neurosis de ansiedad. ([Descargar](#) o [imprimir](#))

Comentario

Si entendemos que la historia vital (su vida, su psicobiografía) ha influido fundamentalmente en el origen, en el desencadenante, de su enfermedad ansiosa, entonces diagnosticaremos a la paciente de una neurosis de ansiedad.

En nuestro caso, podemos observar que cuando se desencadena el cuadro clínico se repite, en ese momento, en esa situación, una revivencia de circunstancias angustiosas que sufrió en la infancia. Por una parte, el problema económico es muy

importante durante su infancia y le ha sensibilizado, pues le ha dificultado relacionarse y desarrollar su potencial social y de amistades, y ahora, al fracasar el negocio del marido, se encuentra «como antes, cuando era niña», sin dinero.

Pero por otra parte, quizá es aún más importante el tener que hacer de nuevo de mediadora con su padre. Podemos «comprender» el inicio de la enfermedad ansiosa, teniendo en cuenta la sensibilización psicobiográfica y angustiosa que la paciente ha padecido realizando el papel de mediadora, primero durante la infancia con la madre y en la actualidad entre el marido y el padre, con fuertes discusiones. Entonces se desencadena la enfermedad.

Las dificultades económicas y el papel de mediadora han creado una situación (relación con el mundo) de tal nivel de angustia, por la sensibilización que tenía de la infancia, que ha tenido la suficiente fuerza eficaz como para descompensarla, originándole su enfermedad ansiosa, su neurosis de ansiedad (véase figura 4.1).

Luego, durante 4 años, ya sigue la enfermedad ansiosa su curso y por lo tanto el tratamiento consistirá en la administración de psicofármacos para que mejoren los síntomas, pero también hará falta un tratamiento psicoterápico para que resuelva sus conflictos vitales.

Ahora bien.

Si consideramos sólo la primera parte de la historia clínica, la que hace referencia a los síntomas y a la evolución de la enfermedad ¡y nada más!, y nos olvidamos del resto del estudio psicobiográfico, entonces podemos decir, *si cumple criterios DSM o CIE*, que padece un trastorno ansioso.

Veámoslo:

Según la CIE-10, la paciente tiene: 1) palpitaciones y se le acelera el pulso (síntoma autonómico); 2) inquietud interna, sensación de prisa interior; 3) se siente casi siempre tensa; 4) suspira frecuentemente, ha de respirar fuertemente al tener la sensación que no le entra «bien» el aire; 5) nota un «peso» que le oprime el pecho; 6) irritabilidad, el más mínimo ruido le molesta mucho y la pone más irritable.

Según el DSM-IV TR, la paciente tiene: 1) inquietud, 2) cansancio (fatigabilidad), 3) irritabilidad, 4) tensión muscular.

La duración de los síntomas es de más de 6 meses y le están originando un malestar clínicamente significativo.

Por lo tanto, sí se cumplen los criterios para trastorno por ansiedad generalizada.

¿Hay contradicción entre el diagnóstico de neurosis de ansiedad y el de trastorno de ansiedad?

Evidentemente no: si yo remito al paciente con una nota a su médico de cabecera o a otro profesional de la salud diciéndole que ha tenido un trastorno de ansiedad, está claro que he valorado estos últimos criterios para el diagnóstico (con su limitada información acerca de la persona-paciente) ¡y nada más!

Pero si la remito con el diagnóstico de neurosis de ansiedad, le estoy diciendo al compañero médico que nuestra común paciente padece una alteración ansiosa (enfermedad ansiosa) en la que, *además* de los síntomas, es importante lo que le ha

ocurrido, bien en la infancia, o en un período previo a la enfermedad, y que esto que le ha ocurrido en el pretérito la sensibilizó para que se desencadenara su enfermedad ansiosa.

Evidentemente, que no hay contradicción entre ambos diagnósticos, son compatibles; pero en resumidas cuentas, doy mucha más información sobre el paciente, sobre el ser humano enfermo, sobre *quién* padece la enfermedad, e individualizo mucho más *su* enfermedad, con el diagnóstico de neurosis de ansiedad que con el diagnóstico de trastorno de ansiedad. El concepto «neurosis de ansiedad» es clínicamente abarcante del concepto «trastorno de ansiedad».

Hay una tendencia, como señala E. Fromm (1956), en nuestra cultura a hacer referencias abstractas de las cosas y de las personas olvidándonos de nuestra singularidad, y la realidad concreta de las personas es sustituida por abstracciones. Y en este sentido, hablar de trastorno de ansiedad es una abstracción del enfermo, ya que «cumple criterios», pero no se define la singularidad de la enfermedad en «ese» ser humano.

Señala C. Gastó (2005) que «exceptuando unos pocos autores, principalmente europeos, actualmente casi nadie utiliza el término neurosis en ninguna línea de investigación o en la práctica clínica. A lo sumo, el término neurosis queda relegado a un papel introductorio en la historia general de los trastornos de ansiedad».

Estoy parcialmente de acuerdo con este autor. Evidentemente, muchos de los jóvenes psiquiatras, tan influenciados por los DSM y CIE, se han olvidado o no han aprendido a diagnosticar la enfermedad ansiosa tal como se hacía normalmente hace sólo 25 años. Ahora utilizan estos criterios operativos y quizá por desconocimiento, o por falta de tiempo, o por el efecto rápido de los tratamientos psicofarmacoterápicos en conseguir, al menos, mejoría (que no es lo mismo que remisión), tienen más fácil el camino para utilizar esos criterios. Pero, como dice Baca, E. (2002), «a día de hoy las neurosis podrían parafrasear al personaje de Zorrilla y decir aquello de: “los muertos que vos matáis gozan de buena salud”». Aún somos muchos psiquiatras los que queremos seguir tratando a los pacientes como enfermos únicos, individuos históricos insustituibles, los que queremos hacer una psiquiatría individualizada y que el paciente no sea sólo un número de síntomas que cumplen los criterios, sino una persona enferma de la que conoceremos lo más relevante de su vida para intentar curarle si es posible, mejorarle si lo anterior no puede ser, y en último caso, si no podemos ninguna de las dos cosas, al menos mediante la autognosis biográfica que el paciente hace de sí mismo y de su enfermedad intentaremos que se comprenda a sí mismo como persona enferma⁵¹.

Ciertamente, si yo padezco una neurosis de ansiedad, tendré una preferencia apodíctica⁵² a que me la diagnostiquen así, y no como trastorno de ansiedad porque «cumpló criterios» y luego me den un psicofármaco y ya está. ¡Sí!, prefiero ser un neurótico ansioso que simplemente «por defecto» un trastornado ansioso⁵³.

4.3. LA ENFERMEDAD ANSIOSA ENDÓGENA: LA TIMOPATÍA ANSIOSA

Pero a pesar de lo comentado anteriormente, ocurría una cosa muy curiosa. Había pacientes con enfermedad ansiosa que por mucho que se investigase en su psicobiografía, en los acontecimientos de su infancia o a lo largo de su vida, no se encontraba nada, en absoluto, que pudiese hacernos comprender por qué había empezado su ansiedad. Por más sesiones que se realizaran, por más que se investigara, el paciente refería que sin que hubiese ningún desencadenante, ningún acontecimiento, «de repente» le había aparecido la sintomatología ansiosa. Y no es que no se encontraran acontecimientos desencadenantes por falta de tiempo del psiquiatra ni por inexperiencia, es que simplemente la ansiedad había aparecido «sin más». Por esto decía López Ibor (1969): me refiero a aquellos cuadros clínicos en los que la ansiedad ocupa el primer plano de la sintomatología y, sin embargo, no es reactiva (neurosis de ansiedad). Existen, pues, unos enfermos en los que la ansiedad es autónoma y forma el núcleo de su enfermedad. «No es, pues, ilegítimo pensar que, aun en las “neurosis”, no todas pueden ser comprensibles (1979)».

Existiría, pues, una enfermedad ansiosa que aparecería de forma endógena (es decir, desde «dentro» del individuo) por una predisposición a ella, y no relacionada con acontecimiento alguno cercano o lejano de su vida. A esta enfermedad ansiosa endógena, López Ibor (1966) la denomina timopatía ansiosa, cuando comenta: mi experiencia me demostró que en muchos enfermos calificados de «neurosis de angustia» la angustia no era reactiva a una situación determinada, sino que la angustia venía de dentro; era, por así decirlo, endógena⁵⁴. Ocurría lo mismo que en la melancolía (depresión endógena)... al lado de la angustia reactiva («neurosis de angustia») existe otra angustia endógena. Estos últimos casos intenté agruparlos con el nombre de «timopatía ansiosa». Si la angustia es, en estos casos, endotímica, fisiógena, es natural renunciar al nombre de neurosis de angustia y —sigue este autor—, la angustia endotímica muchas veces es fásica, el sujeto sale indemne de la crisis, y a veces en un período de veinte o treinta años aún se pueden observar varias fases que no dejan huella⁵⁵.

Creo que este concepto ha sido muy acertado y al mismo tiempo muy poco utilizado. ¿Qué ocurre cuando a una persona que padece una enfermedad ansiosa fásica no le podemos explicar a qué se debe su alteración? Lo más fácil es decirle que tiene un «trastorno de ansiedad», pues cumple criterios, y ya está. Le medicamos y luego, según la evolución, decidiremos cómo se realiza el mantenimiento del tratamiento psicofarmacoterápico. Pero esto, creo, es poco riguroso. Si estudiamos a un paciente que ha padecido varios episodios ansiosos y que tiene tendencia a la repetición de su ansiedad sin que los relacione con factores externos o biográficos, el mismo paciente se va a encontrar perplejo ante esta repetición de su enfermedad si sólo se le dice que es un trastorno de ansiedad y nada más. Cuando le expliquemos, como hacemos con el depresivo endógeno, que esa enfermedad es una timopatía ansiosa, que es una tendencia que tiene a que le aparezca la enfermedad ansiosa y a repetirse, entonces se le abrirán varias puertas importantes al paciente: 1.º) entenderá su enfermedad, evitándose la angustia y perplejidad ante lo desconocido que se le repite fásicamente, y 2.º) admitirá un tratamiento preventivo para evitar nuevas

repeticiones de su timopatía ansiosa.

Y casi siempre —aunque sea incómodo, pero a la vez honesto— tendremos que explicarle al paciente que el tratamiento preventivo ha de ser continuado, para muchos años, o toda la vida, por la tendencia a la repetición, que es una tendencia constitucional y biológica.

Y esto es muy importante, porque cuanto más conoce el paciente sobre su enfermedad, mejor asume su futuro y su tratamiento y más fácilmente elabora una nueva filosofía sobre sí mismo admitiendo su vulnerabilidad. Como indica M. Cavallé, la aceptación activa es la fuente por excelencia de la transformación, del crecimiento y del cambio profundo. No somos responsables de lo que nos pasa, pero sí depende de nosotros cómo nos relacionemos con eso que nos pasa, de la actitud que tomemos ante nuestra experiencia.

NOTAS

[46](#) Analizar las diferentes teorías psicoanalíticas y no psicoanalíticas que intentan explicar el «origen» de la angustia neurótica escapa a los objetivos de este libro.

[47](#) Por esto, muchas veces se habla de reacción «psicógena» y no de reacción psicológica. La reacción psicógena ha de tener carácter patológico y origina la presentación de fenómenos anormales. Desde Birnbaum se denomina psicógeno a los efectos patológicos de las influencias psíquicas (*Lo psicógeno*, Rojo Sierra, 1962). Para los lectores más especializados he de indicar que otros autores hablan de psicogénesis, en sentido estricto, sólo cuando la vivencia psíquica origina una alteración patológica en el cuerpo (en el soma), es decir, origina síntomas somáticos.

[48](#) Esta semejanza puede ser a veces sólo simbólica.

[49](#) Extraído de Rojo Sierra. *Lecciones de psiquiatría*, tomo III.

[50](#) Curiosamente, el término neurosis, que proviene de la voz griega *neuron*, que significa «nervio» y hace referencia etimológicamente a una degeneración orgánica nerviosa, se utiliza para los casos de enfermedad por «causa psicológica», y al contrario, el término psicosis, que haciendo referencia etimológica a un origen «psíquico de la enfermedad», hoy en día se relaciona fundamentalmente con una «causa biológica u orgánica».

[51](#) En la XV Reunión de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas (2002) se puso de manifiesto que en las nuevas generaciones de médicos se pierde el perfil humanista. En una profesión integral, el profesional no debe atender enfermedades sino personas.

[52](#) Apodíctico, es definido por el Diccionario de la Lengua como cierto sin condiciones, es decir, pensamiento racional concluyente y cierto.

[53](#) ¿Es mejor uno u otro sistema de diagnóstico: neurosis o trastorno de ansiedad? Ninguno de los dos es absolutamente perfecto. Y el problema aparece si hacemos de la clasificación diagnóstica una doctrina psiquiátrica, de manera que los seguidores de este tipo de diagnóstico, como puede ser el de neurosis, absoluticen esta concepción frente a los seguidores de los criterios «operativos» (DSM, CIE) que absoluticen asimismo su concepción clasificatoria. Se forman entonces doctrinas distintas que reaccionan en discusiones estériles, pues no hacen sino señalarse mutuamente lo negativo de las doctrinas respectivas.

Como indica Rojo Sierra (1966), para que exista una verdadera psiquiatría es necesario que nos descomprometamos con las estructuras de conocimiento como algo absoluto. Sólo así se hará factible hallar lo positivo en las mismas, siendo de esa manera todas absolutamente aprovechables.

[54](#) La introducción de los conceptos «endógeno» y «exógeno» en psiquiatría se atribuye a Moebius (1892). Lo endógeno hace referencia a que la causa se halla dentro, en las disposiciones genéticas, en la biología.

[55](#) En la fase se padece una alteración, por ejemplo una depresión, o una timopatía ansiosa, y luego el paciente se recupera completamente. Este concepto aportado por Jaspers (*Psicopatología general*), lo define de la siguiente manera: Fases son alteraciones endógenas de la vida psíquica que duran desde semana a meses, hasta años, pero que luego vuelven a desaparecer, de manera que el estado anterior es restablecido.

5. FOBIAS, OBSESIONES, COMPULSIONES

«A cada día le bastan sus temores, y no hay por qué anticipar los de mañana.»

CHARLES PÉGUY (1873-1914), escritor francés.

La palabra fobia es de origen griego y significa miedo (o pánico)⁵⁶. Fobos fue un dios griego que era implorado para atemorizar a los enemigos y con este propósito se pintaba su fisonomía sobre máscaras y escudos. Por esto, Fobos o fobia significó miedo o pánico. En medicina se utilizó por primera vez en Grecia, por Celso, para referirse a la hidrofobia (miedo al agua), que era un síntoma propio de la rabia. La concepción de la fobia como temor absurdo a un objeto se produce en 1801, y en 1925 ya se define la fobia como «aversión apasionada contra algo».

La prevalencia de las fobias es del 10-14% de la población general.

- La fobia específica o simple, entre el 5 al 11% de la población, es la más frecuente.
- La agorafobia, 2,5 al 6% de la población es, generalmente, la más grave y la más consultada (el 50% de los que la padecen consultan al médico) y más frecuente en mujeres.
- La fobia social, 1,5% de la población, también es más frecuente en mujeres.

El DSM-IV clasifica las fobias específicas en cinco tipos:

1. Tipo animal: temor hacia animales e insectos.
2. Tipo ambiental: temor a situaciones relacionadas con la naturaleza y con los fenómenos atmosféricos (tormentas, rayos, relámpagos...).
3. Tipo sangre-inyecciones-daño: temor a la visión de heridas, de sangre o a recibir determinadas intervenciones médicas invasivas.
4. Tipo situacional: temor a situaciones específicas.
5. Otros tipos: temor a otros estímulos, como el vómito, adquirir enfermedades, etc.

Las fobias son, por lo tanto, miedos, pero que han de tener unas características:

- a) Es un miedo excesivo, intenso, persistente e irracional, ante una situación, objeto o actividad.
- b) El sujeto reconoce que ese miedo es excesivo e irrazonable.
- c) Aunque la persona se encuentra sin ansiedad normalmente en su vida cotidiana, no obstante le aparece una intensa ansiedad sólo de pensar que ha de exponerse ante el objeto o situación fóbica (es la ansiedad anticipatoria), y más aún si

realmente se expone, sufriendo entonces palidez, taquicardia, sudoración, mareo, palpitaciones, dificultad de respiración..., y necesidad urgente de alejarse del contacto con la situación u objeto fóbico. Así por ejemplo, si lo que padece es fobia a las serpientes, ratones, perros o gatos, sólo de pensar que va a ir a una casa donde se encuentren estos animales le puede originar gran angustia y ansiedad. Si ha de ir obligatoriamente, puede tener una crisis de ansiedad si contacta con esos animales, aunque sólo sea visualmente. Igualmente, si la fobia es a lugares cerrados o a comer en restaurantes, en este caso sólo de pensar que ha de ir de cena ya le aparecerá fuerte ansiedad y, muy posiblemente, si acude a la cena tendrá que abandonar el local por la angustia que sufra. La fobia no está relacionada con que la persona sea valiente o no: así, Napoleón Bonaparte padecía fobia a los gatos, presentando gran angustia, ansiedad y asco ante la presencia de los mismos. La respuesta angustiante y ansiosa es pues automática cuando la persona piensa que va a exponerse ante la situación fóbica, o cuando se expone.

- d) Por lo tanto existirá una conducta de evitación del estímulo o situación fóbica.
- e) Ha de repercutir de forma significativa en la vida personal, familiar, laboral o social del paciente.

Este último punto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de las fobias específicas o simples.

5.1. LAS FOBIAS SIMPLES

Las fobias simples suelen ser sólo a un estímulo u objeto que no tiene, en sí, carácter amenazador, pero originará ansiedad anticipatoria y conductas de evitación, aunque, lógicamente, el sujeto sepa que no hay nada que temer, como por ejemplo una fobia a perros. En un caso que tuvimos, la paciente padecía fobia a comprar una botella de butano y a que luego se abriese «sin querer» en casa y falleciesen todos los familiares. Por esto, la paciente cuando salía a la calle evitaba encontrarse con cualquier vehículo repartidor de butano, y si lo veía, se alejaba varias manzanas para estar segura de no haber cogido ninguna de las botellas.

Aunque son muy frecuentes, un gran número de los que las padecen no suelen acudir a consulta médica, excepto cuando interfieren de una manera significativa en la vida cotidiana. Claro está, no es lo mismo tener una fobia a los volcanes o cráteres (aniafobia) y vivir en España, que vivir en Japón, que tiene el 10% de los volcanes activos de todo el mundo.

Generalmente se inicia en la infancia, y frecuentemente (pero no siempre) se asocia a una experiencia traumática que se ha padecido personalmente o que ha visto.

TABLA 5.1
90 fobias
(Extraído de *Fobias y manías*, S. López Galán)

1. F. a las abejas. Apifobia, melisofobia.
2. F. a abrir los ojos. Optofobia.
3. F. al acto sexual. Ciprifobia, cipridofobia, coitofobia, erotofobia.
4. F. al polvo. Misofobia.
5. F. a lo agrio. Acerfobia, acerofobia.
6. F. a las alturas, Acrofobia.
7. F. a las cimas. Acrofobia.
8. F. al amanecer. Eosofobia.
9. F. a la asfixia. Pnigofobia.
10. F. a los bastones. Rabdofobia.
11. F. a la barba. Pogonofobia
12. F. a la basura. Ripofobia.
13. F. a los bosques. Hilefobia.
14. F. a caminar. Basiforia, estasisbasiforia.
15. F. a los coches en movimiento. Amaxofobia.
16. F. a comer. Fagofobia.
17. F. a cometer un error. Hamartofobia.
18. F. al contacto. Pselaofobia.
19. F. a la contaminación. Molismofobia.
20. F. a las corrientes de agua. Potamofobia.
21. F. a la gravedad terrestre. Barofobia.
22. F. a los cuerpos desnudos. Gimnofobia.
23. F. a la defecación dolorosa. Defecalgiesiofobia.
24. F. a la desgracia. Ateobia.
25. F. a los destellos de luz. Selaofobia.
26. F. a dios. Teofobia.
27. F. al embarazo. Maieusiofobia.
28. F. a las escaleras Climacofobia.
29. F. a los espacios llenos de gente. Coinonifobia.
30. F. a los espejos. Catoptrofobia, eisoptrofobia, espectrofobia.
31. F. a estar sucio. Automisofobia
32. F. a la fatiga. Copofobia, ponofobia.
33. F. al firmamento. Astrofobia, uranofobia.
34. F. a hablar en voz alta. Fonofobia.
35. F. a la infección. Molismofobia.
36. F. al infinito. Apeirofobia.
37. F. al invierno. Quimafobia.
38. F. a la libertad. Eleuteroofobia.
39. F. a los familiares. Singenesofobia.
40. F. a los gallos. Alectorofobia.
41. F. a las hormigas. Mirmecofobia.
42. F. a lavarse. Ablutofobia.
43. F. a los lugares desiertos. Eremofobia.
44. F. a la luna. Selenofobia.
45. F. a la lluvia torrencial. Ombrofobia.

46. F. al mar. Talasofobia.
47. F. al matrimonio. Gamofobia.
48. F. a las muñecas. Pediofobia.
49. F. a las montañas. Orofobia.
50. F. a la niebla. Homiclofobia, nebulafobia.
51. F. a la nieve. Quionofobia.
52. F. al número 13. Triscaidecafobia.
53. F. a las nubes. Nefofobia.
54. F. a los objetos religiosos o sagrados. Hierofobia.
55. F. a los objetos sucios. Hafefobia.
56. F. a oler mal. Autodisomofobia.
57. F. al oro. Crisofobia.
58. F. los paseos. Dromofobia.
59. F. al pecado. Hamartofobia.
60. F. al pene erecto. Itifalofobia.
61. F. a los pendientes. Clinofobia.
62. F. a los precipicios. Crenmofobias.
63. F. a la piel de los animales. Dorafobia.
64. F. a la pobreza. Peniafobia.
65. F. a quedarse calvo. Falacrofobia.
66. F. al rayo. Astropofobia.
67. F. al resplandor. Fotaugiafobia.
68. F. al ridículo. Catagelofobia.
69. F. a ser arañado. Amicofobia.
70. F. a ser enterrado vivo. Tafefobia, tafofobia.
71. F. a ser raspado. Amicofobia.
72. F. a sí mismo. Autofobia.
73. F. al sol. Heliofobia.
74. F. a la suciedad. Ripofobia.
75. F. a sudar excesivamente. Efidropfobia.
76. F. a tartamudear. Pselismofobia.
77. F. a tener un amante. Filofobia.
78. F. a tocar o ser tocado. Hafefobia.
79. F. a todo. Panfobia, pantofobia.
80. F. al trueno. Brontofobia, queraunofobia, tonitrofobia.
81. F. a las tormentas. Estrapefobia.
82. F. al vacío. Cenofobia, quenofobia.
83. F. a los vehículos. Amaxofobia, hamaxofobia.
84. F. a vestirse. Enduofobia.
85. F. a viajar por mar. Talasofobia.
86. F. a la vida. Biofobia.
87. F. al viento. Anemofobia, queimofobia.
88. F. a volver a casa. Nostofobia.
89. F. al vino. Enofobia.
90. F. a los zurdos. Sinistrofobia.

Hay tantas fobias como posibilidades en el mundo, pues se puede tener fobia simple a cualquier cosa, por lo que el número es altísimo: cancerofobia, hematofobia (sangre), tanatofobia (muerte), claustrofobia (lugares cerrados), geriofobia (puentes), belonofobia (agujas) efidrofobia (sudor), hipopotomonstrosesquidelaofobia (fobia a las palabras largas) e incluso fobiofobia (miedo al miedo); un paciente se angustiaba mucho cuando pasaba por su imaginación la idea de que estaba sobre un planeta girando por el universo, otro paciente cuando tenía la sensación de estar lanzado en el espacio porque «la Tierra va bogando»⁵⁷..., etc. (en la tabla 5.1 nombro 90 de estas fobias).

Las que son de tipo animal (animales, insectos) suelen iniciarse en la infancia, al igual que las ambientales (tormentas, precipicios...), pero las que hacen referencia a sangre o heridas o recibir inyecciones pueden ser algo más tardías. Este último grupo tiene la peculiaridad de que puede originar problemas importantes físicos, no por la fobia en sí, sino que por no acudir a hacerse los análisis o revisiones médicas pueden sufrir enfermedades que no se detectan por faltar a esas revisiones generales (diabetes, hipercolesterolemia, etc.). También es característico de este grupo de fobias a sangre, inyecciones y heridas, que ante el objeto fóbico (la sangre, la herida...), en vez de originar una crisis de ansiedad les origine un desmayo de tipo lipotímico, con palidez, mareo y caída al suelo. Cuando se padece fobia a tragar puede ocurrir que el paciente se alimente mal, tomando sólo alimentos fáciles de tragar, o falle en la toma del tratamiento médico al tener miedo a atragantarse cuando toma las pastillas.

¿Cuánto incapacita la fobia?

Esto es muy importante, pues mucha gente tiene miedos y evita las arañas, ratones, cucarachas, serpientes y muchos insectos inofensivos, mas esto no afecta de manera importante a su vida cotidiana. Pero no ocurre así en el ejemplo siguiente citado por D. W. Goodwin: «Una mujer con fobia a las arañas empezó a gritar cuando encontró una en casa, corrió a buscar a la vecina para que la sacara de allí, temblaba de miedo y necesitó que la vecina se quedara con ella durante dos horas antes de poder quedarse sola de nuevo; otra paciente con fobia a las arañas se encontró subida encima de la nevera de la cocina sin saber cómo había ido a parar ahí; el miedo engendrado por la araña había provocado un breve período de amnesia (relatado por Isaac Marks)». La capacidad de afectación de la fobia es, pues, muy importante. Una fobia a las alturas puede ser muy molesta e incapacitante si la persona es un albañil de la construcción.

La persona normalmente acude a pedir ayuda médica, en el caso de las fobias simples, fundamentalmente, cuando éstas le originan un impacto existencial efectivo.

Los miedos más conocidos y frecuentes son: las fobias a los animales, a las alturas y a las enfermedades.

Dentro de las fobias a los animales, muchos autores piensan que en el caso de las serpientes y los murciélagos son miedos innatos, es decir, que no son aprendidos. «No hay otra explicación posible para que un chimpancé adulto que ve por primera vez a una serpiente a veinte pasos de distancia se deje llevar por el pánico», señala D. W. Goodwin. Igualmente, señala este autor, como quizá más que el miedo al animal

concreto sea a los movimientos ondulantes del reptil.

El miedo a las alturas es en realidad un miedo a caerse o a resbalar por el borde. Más exactamente, señala Goodwin, es el temor a perder el soporte visual. Así, las personas que miran por la ventana no sienten temor si ésta está a la altura de su pecho. Un coche ofrece la misma protección. Sorprendentemente, sigue este autor, hay muchos pilotos de aviación que sienten temor a las alturas; muchos pilotos tienen un miedo horroroso a mirar desde un rascacielos, pero vuelan con total despreocupación a 40.000 pies de altura. De nuevo, no es la altura lo que importa, sino el «espacio visual». No hay mucho espacio visual en un avión, ni siquiera desde la cabina.

Debido a esto, es por lo que una persona con fobia a las alturas puede viajar en avión perfectamente sin ningún problema, pero ser incapaz de bajar andando las escaleras de la torre Eiffel al tener más abierto el espacio visual, o puede pasar perfectamente en coche por puentes muy altos, pero no cruzar uno más bajo a pie.

Los que padecen fobia a las enfermedades no son los mismos que los hipocondríacos. Los hipocondríacos van constantemente a los médicos por sentirse que están enfermos. En el caso de las fobias a las enfermedades ocurre exactamente lo contrario, se niegan a hacerse revisiones y análisis de sangre por miedo a que les encuentren alguna enfermedad. Las fobias a las enfermedades, a diferencia de las otras fobias específicas, no suelen aparecer en la infancia, sino a mitad de la vida.

La evolución de las fobias simples y el comportamiento de las personas fóbicas ha sido revisada por Goodwin, concluyendo:

1. Las fobias que aparecen antes de los 20 años tienden a mejorar y, eventualmente, a desaparecer. Cinco años después de su aparición, cerca de la mitad de los jóvenes fóbicos no presentan síntomas y casi todos han mejorado (están menos preocupados).

Las fobias que aparecen después de la adolescencia duran más. El 20% se ven perjudicados en su trabajo o en sus relaciones sociales por culpa de la fobia.

2. Las fobias simples, consideradas como grupo, presentan un pronóstico más favorable que otros trastornos fóbicos. Una excepción es la fobia a las enfermedades: el miedo a padecer un cáncer o un ataque cardíaco aparece a partir de los 40 años y presenta peor pronóstico. En estos casos no pueden evitar el objeto fóbico, pues no existe, no hay posibilidad de enfrentar al enfermo directamente con su objeto fóbico (por ejemplo al cáncer o al ataque cardíaco, ya que aún no lo han tenido). En general, las fobias simples que persisten durante la edad adulta difícilmente remitirán.
3. Los pacientes con fobias simples provienen de familias razonablemente estables y su familia e hijos son razonablemente normales⁵⁸.

5.2. AGORAFOBIA

La palabra agorafobia significa miedo a lugares abiertos. «Ágora» es una palabra griega que se refiere a plazas de mercados o lugares abiertos de reunión. Ya en 1870 Benedict describió el caso de un paciente que padecía «vértigo a las plazas». No obstante es en 1871 cuando el neurólogo alemán Westphal describe tres casos de pacientes que padecen ansiedad muy elevada al atravesar plazas, una calle vacía o lugares desiertos, y denominó a esta alteración agorafobia.

Si bien la agorafobia se puede definir como el miedo a andar solo y sin apoyo por un espacio abierto (H. J. Weitbrecht), no obstante, hoy en día el término se ha ampliado y no sólo se utiliza para ese miedo o fobia a lugares abiertos o plazas, sino también para:

- Lugares tumultuosos, mercados, centros comerciales, cuando hay mucha gente. Ya en 1794 se observa esto en las declaraciones de Mr. Purrier, cuando pidió que se le excusara de formar parte de un jurado porque «se mareaba en todos los lugares llenos de gente» (cit. Nemiah). Muchos pacientes sí que van a estos lugares en horas que saben que hay menos gente, como puede ser al mediodía. También en el caso de los transportes públicos los evitan o van en ellos cuando hay poca gente. Más de un paciente que hemos tenido se ha montado en el autobús en horas de poca afluencia, pero si ha coincidido que ha subido un número de pasajeros que considera agobiante, se baja en la siguiente parada aunque aún esté lejos de su destino.
- Lugares cerrados en donde consideren que no tienen una huida fácil, como son túneles, puentes o bien cines o teatros, y en estos casos buscan sentarse cerca de las salidas. La repercusión existencial puede ser grande, como le ocurría a un paciente nuestro taxista con gran agorafobia a los túneles, por lo que tenía gran dificultad para realizar adecuadamente su labor profesional.
- Miedos a quedarse solos y que se desmayen o tengan una crisis. Una paciente nuestra no sólo necesitaba que hubiese un familiar en casa cuando ella estaba, sino que necesitaba que la acompañasen cuando se duchaba o que alguien estuviera en la habitación contigua, pero sin dejar de hablarle.
- Estar lejos del hogar. Muchas veces consideran que una distancia afectiva «de seguridad» les permite moverse por el barrio cerca de su casa, pero no más. En casos graves no salen siquiera de su casa, en otros apenas pueden dar la vuelta a la manzana⁵⁹ o ir a lugares muy cercanos. Un paciente que tuvimos y que vivía en un pueblo podía moverse con total tranquilidad en coche o andando dentro del perímetro del pueblo, pero no alejarse más de dos kilómetros del mismo, por lo que no podía viajar ni ir a ninguna población cercana si no era acompañado.

El acompañante fóbico es la persona que va junto al paciente agorafóbico dándole seguridad. Un familiar o un amigo son las personas más frecuentemente utilizadas como acompañantes. Con ellos sí pueden ir a muchos lugares que sería imposible hacerlo sólo. Otras veces adquieren seguridad si llevan un bastón, o un carrito o un teléfono móvil. Una paciente nuestra salía con amigas, pero tenía que tener siempre a

dos o tres familiares localizados con el móvil, y además que ellos supieran que estaba saliendo para que lo tuvieran libre para recibir su llamada en caso necesario.

Muchas veces llevan ansiolíticos en el bolsillo «para estar seguros» de tener un tranquilizante en caso que padezcan una crisis angustiosa, pero pueden pasar temporadas largas sin usar ese recurso aunque lo siguen llevando porque les da seguridad.

Los agorafóbicos suelen restringir sus actividades y solicitar a familiares, amigos o vecinos que realicen las compras. En ocasiones pueden estar meses sin salir de casa, organizándose prácticamente todas sus necesidades mediante personas cercanas y haciendo pedidos por teléfono.

A menudo sólo salen cuando es de noche o con gafas de sol aunque esté nublado. La tendencia a la depresión o al consumo de alcohol es frecuente en esta enfermedad.

Por orden de frecuencia, lo que más les suele agobiar es alejarse de casa (90%), ir en transporte público (70%), ir a lugares concurridos, con mucha gente (60%), lugares cerrados (40%), lugares abiertos (30%). Pero también pueden salir poco por miedo a «montar un espectáculo» en la calle, o por miedo a que les ocurra «algo» y no tener asistencia rápida. Un 5% son incapaces de abandonar sus casas, permaneciendo cautivos en sus domicilios.

La vivencia de mareo agorafóbico⁶⁰ es muy frecuente y angustiante. El paciente refiere sensación de «no pisar seguro», como si flotase, «como cuando he bebido una copa»; otros lo expresan como ir sobre algodones, o andar sin consistencia o sobre rodillos o con las piernas flojas o como si pisasen blando. Tienen la sensación que se van a caer y que andan mal, aunque familiares y amigos les insistan que andan perfectamente y que no se nota en absoluto inconsistencia en su marcha. Este mareo agorafóbico o timopático es mayor si va por la calle la persona sola que si va acompañada, si hace colas o si entra en lugares bulliciosos, mercados o centros comerciales, disminuyendo de manera muy importante o desapareciendo al llegar a casa. No se padece cuando se va en coche, ya sea como acompañante o conduciendo él mismo (excepto en utopistas con mucho tráfico), pudiendo hacer muchísimos kilómetros perfectamente, para luego, nada más pararse y salir del coche volver a notar el mareo inestable.

Cómo empieza el paciente a padecer agorafobia también es importante, ya que en un porcentaje elevado de éstos (alrededor de un 75%) lo primero que sufren es una crisis aguda de angustia.

Las crisis agudas de angustia aparecen de forma bastante repentina, y por orden de frecuencia (J. C. Ballenger) el paciente sufre: palpitaciones, latidos violentos, taquicardia, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de falta de aire, sensación de ahogo, sensación de sofocación. Dolor o malestar torácico, náuseas, malestar abdominal, mareos, inestabilidad, desmayos, sensación de rareza o extrañeza ambiental (desrealización), o sentirse extraño él mismo (despersonalización), miedo a perder el control o a volverse loco, miedo de morir, hormigueos (parestias) y escalofríos u oleadas de calor.

La vivencia de morir es atroz, y bien se puede decir que estas crisis son

vivenciadas de modo terrorífico, por lo que el paciente tendrá la necesidad de huir, escapar, rápidamente del lugar en donde las padece⁶¹.

Tras esta crisis, si la sufre, por ejemplo, en un restaurante o en un centro comercial, a partir de ese momento empezará el paciente a hacer conductas de evitación de esos lugares. Como bien indica K. Jaspers (1975), la primera vivencia en cuanto tal es irrepetible y tiene una especial fuerza sobre la vida; una primera vivencia decisiva cambia completamente al hombre en su mundo. El problema y la gravedad de esta enfermedad está en que con el tiempo, o bien se repiten las crisis de angustia en otros lugares, o se va generalizando el miedo a que aparezcan cada vez en más sitios, restringiéndose el espacio vital y de los movimientos. Si además le aparece el mareo agorafóbico en la calle, transportes, plazas o mercados, etc., esto hace que tampoco puedan ir a estos lugares, transformándose lo que en principio fue una evitación a lugares concretos en una evitación generalizada agorafóbica.

En otras ocasiones la agorafobia no se acompaña de crisis agudas de ansiedad. Siempre me ha llamado la atención la existencia de numerosos casos en los que hemos podido observar cómo el mareo timopático y la agorafobia aparecen después de unos vértigos rotatorios⁶². Estos vértigos rotatorios, que no son de origen psíquico, sino normalmente del oído interno (laberíntico, vértigos de Ménière) o producidos por una alteración cervical (vértigo cervical), se vivencian como «que todo da vueltas», y el paciente bien en la cama o sentado, a menudo, con sólo girarse nota como si todo su alrededor se moviese y rodase. Son bastante invalidantes, pero suelen ceder muy bien con el tratamiento que el médico de cabecera les prescribe. El problema está en que los pacientes que, lógicamente, no tienen por qué saber medicina, llaman a estos vértigos «mareos» y, a menudo, una vez que les ha desaparecido el mareo «rotatorio» les aparece seguidamente el mareo de tipo agorafóbico a modo de inestabilidad, y siguen expresando a su médico que «aún siguen mareados», haciendo pensar que no acaban de curarse del todo de los mareos «rotatorios», y por esto el médico sigue tratándolos como si de ese tipo fuera. Así, nos hemos encontrado con pacientes que tras haberse curado de los vértigos rotatorios han seguido tomando meses y meses tratamiento para éstos y se les ha realizado múltiples pruebas físicas, sin que desaparezca completamente el «mareo», pues ya era de tipo agorafóbico. Tras las múltiples exploraciones es cuando, por fin, llegan al psiquiatra para que estudiemos el mareo «que no es causado orgánicamente»; y realmente es así, pues desde hace mucho tiempo que ya era timopático. Esto es importante, ya que cuando se curan con el tratamiento psiquiátrico, a menudo, tenemos que mantener un tiempo largo el tratamiento no sólo de mantenimiento para que no vuelva la agorafobia, sino también tratamiento preventivo para el vértigo rotatorio, pues si les aparece de nuevo éste, tienen elevada vulnerabilidad a que de nuevo, asimismo, les vuelva a aparecer, a continuación, otra vez, el mareo timopático y la agorafobia.

La agorafobia es la más incapacitante de todos los trastornos fóbicos y es de comienzo más tardío que las fobias específicas, apareciendo entre los 20 y 30 años y más frecuente en mujeres; para algunos autores, si ya se mantiene más de un año, la

enfermedad será, casi seguro, muy duradera, y si no se trata adecuadamente, se hará una dolencia crónica.

Para terminar este apartado, un caso clínico clásico, descrito por Janet a principios del siglo xx (cit. Nemiah), nos ilustra bien cómo se generaliza la enfermedad cuando no se realiza un tratamiento efectivo:

Tenía 25 años cuando empezó lo que él llama «problemas con los espacios». Se encontraba atravesando la plaza de la Concordia (debe notarse que lo hacía solo) cuando sintió una extraña sensación de amenaza. Su respiración se hizo rápida y sintió una especie de sofocación; su corazón empezó a latir violentamente y sus piernas empezaron a temblar como si estuvieran medio paralizadas. No podía ir ni adelante ni atrás y tuvo que realizar un tremendo esfuerzo, bañado en sudor, para alcanzar el otro lado de la plaza. Desde aquel momento sintió un gran disgusto por la plaza de la Concordia y decidió que no se arriesgaría a pasar por ella otra vez solo. Sin embargo, poco tiempo después, la misma sensación de ansiedad se le presentó en el puente de los Inválidos, y luego, en una calle que, aunque era estrecha, parecía larga y muy inclinada... su enfermedad continuaba aumentando. La ansiedad que experimentaba siempre que se atrevía a traspasar un lugar que fuera abierto era tan intensa que se le hizo imposible controlarla, y ya no fue capaz de atravesar más plazas. Doce años más tarde, tras acompañar a una jovencita a su casa, mientras lo hacía todo fue bien, pero cuando la hubo acompañado fue incapaz de regresar sólo a casa. Cinco horas más tarde, al notar su mujer que aunque oscurecía y estaba lloviendo no había vuelto a casa, ésta empezó a alarmarse y salió en su busca. Lo encontró mojado y temblando en un rincón de la plaza de los Inválidos, que había sido completamente incapaz de atravesar. Después de esta desagradable experiencia ya no se le permitió salir solo, que era exactamente lo que él quería, puesto que de esta manera podía controlar sus ataques. En la actualidad, su mujer tiene que acompañarle a cualquier sitio, incluso cuando tiene que ir al lavabo.

5.3. FOBIA SOCIAL (ANSIEDAD SOCIAL)⁶³

A nivel popular la fobia o ansiedad social se ha confundido con otras muchas cosas. Hay personas que son introvertidas y, por lo tanto, su lado fuerte no son las reuniones sociales o tener que hablar en público, más aún si también son tímidas. Algunas personas son tan introvertidas y tienen tan pocas relaciones sociales que Kretschmer las denominó esquizotímicas (que es un tipo de temperamento, no una enfermedad como la esquizofrenia). Estas personas esquizotímicas apenas si tienen uno o dos amigos como mucho, o ninguno, cumplen bien en su trabajo, suelen ser muy poco habladoras y aparte de la relación imprescindible en el trabajo, no tienen, apenas, otra relación social, ni en fines de semana, ni en vacaciones, etc. Por otra parte, las personas con agorafobia, como hemos visto en el apartado anterior, pueden rehuir el contacto social.

Pero si bien en todos estos caso el contacto social está muy menoscabado o

incluso prácticamente abolido, en la fobia social el problema es diferente. El paciente con fobia social puede ir a lugares abiertos, puede hablar con normalidad con otras personas, pero... si ha de presentarse en una situación que suponga interacción social, entonces le aparece una fuerte ansiedad, se bloquea o padece una vivencia de pánico y necesidad de huir del lugar. En la fobia social —a diferencia del temor normal que muchas personas pueden tener a hablar en público o a presentarse a situaciones en las que serán evaluados por los demás—, la ansiedad llega a ser incapacitante. Estas situaciones pueden ser hablar, comer, escribir... *en público*. La fobia social es un miedo a ser observado en situaciones concretas, miedo a ser puesto en ridículo, miedo a actuar, a perder el control y, fundamentalmente, a que los demás realicen una valoración negativa sobre él, a sentirse humillado, avergonzado, y a que sus síntomas ansiosos (rubor, temblores, sequedad de boca...) sean percibidos por los demás. Suele comenzar en la adolescencia o juventud, que es cuando hay más interacción social, y adquiere mayor intensidad alrededor de los 30 años. Un paciente nuestro hacía la vida completamente normal, excepto que le aparecía fuerte ansiedad si tenía que ir a comer a bodas, bautizos, comuniones o la cena anual que organizaba la empresa para todos los trabajadores. Esto último le estaba originando problemas importantes, pues ya llevaba varios años poniendo excusas en el trabajo para no acudir a esa cena anual. Aparecía, entonces, un miedo a ser juzgado por los demás, miedo a que hicieran juicios negativos o comentarios desfavorables o humillantes, o a no controlar la situación. Fuera de estas circunstancias, su vida era completamente normal.

Frecuentemente, el paciente fóbico social tarda en acudir al médico, pues considera que es un problema de timidez.

La clínica más habitual que puede aparecer en la fobia social cuando se expone obligatoriamente a estas situaciones es: ruboración (lo más frecuente), acaloramiento, temblores, palpitaciones, sequedad de boca, sudoración, tensión muscular, sensación de vacío en estómago, sensación de falta de aire, tartamudez, sensación de frío o calor, cefalea, diarrea, necesidad imperiosa de micción, miedo a vomitar en público, somatodisforia (es decir, malestar general corporal) y muchos pensamientos negativos del tipo «qué pensarán de mí», teniendo a menudo, por la ansiedad y angustia, que abandonar la reunión o el local.

En casos graves pueden complicar de forma importante la vida profesional, como puede ser en periodistas y profesores que han de exponerse ante gente o estudiantes.

TABLA 5.2

	PORCENTAJE
1. Hablar en público	30,2
2. Hablar delante de un grupo pequeño	15,2
3. Hablar con otros	13,7
4. Usar un baño público	6,6

5. Escribir cuando alguien mira	6,4
6. Comer o beber en público	2,7
7. Cualquier miedo social	38,6

Prevalencia-vida de miedos sociales en el National Comorbidity Survey. Extraído de Jiménez Treviño L. y cols. (Epidemiología del trastorno social). En J. Bobes, M. P. González, P. A. Saiz y M. Bousoño. *Abordaje actual del trastorno por ansiedad social*. Masson, 2000.

No suelen tener una personalidad característica⁶⁴ y esto los diferencia de personas esquizotímicas con delirio sensitivo de autorreferencia. Esto último es importante, ya que muchas personas esquizotímicas, es decir, tan introvertidas que apenas si tienen amigos o casi ninguna relación social, padecen a menudo autorreferencias, es decir, notan que la gente les mira o murmura de ellas, pero no padecen ninguna otra sintomatología psicótica o delirante. Hemos encontrado muchos pacientes con delirio significativo autorreferente que realizaban su trabajo perfectamente, aunque apenas se comunicaban con sus compañeros de oficina o almacén..., pero cumplían muy bien. Notaban diariamente esta vivencia de que le miraban o murmuraban de ellos, a veces sólo en el trabajo, otras veces también con la gente desconocida de la calle. Cuando salen del trabajo, directamente van a casa. Al encontrarse incómodos, por las autorreferencias, en cualquier situación social, han dejado de salir, excepto para trabajar, y no tienen ya amistades. En su domicilio se encuentran bien, a gusto y relajados. Evidentemente, estas personas rehúyen toda actividad social, y si se ven con la obligación de acudir a bodas, cenas o comuniones, o al tener que acudir a centros comerciales, pueden padecer intensa ansiedad por las autorreferencias y frecuentemente tener que abandonar lo más pronto posible el lugar de reunión. Pero como decíamos, no ocurre esto con la fobia social; en ésta el miedo al juicio que sobre el paciente realicen los demás es lo que les quita espontaneidad y por esto les aparece la intensa ansiedad.

Las fobias sociales más frecuentes son a hablar en público (miedo excesivo) —que puede hacer que padres que la padecen no vayan a reuniones de la asociación de madres y padres escolares, o a otras reuniones «por si les hacen hablar»—, miedo a comer en público, pues le observan cómo come o bebe; miedo a escribir cuando hay gente delante, o a leer. También son frecuentes las fobias a utilizar los lavabos públicos y a acudir a entrevistas o a fiestas (véase tabla 5.2). En general, los estudios muestran una prevalencia⁶⁵ de esta enfermedad en la población entre el 7 y el 14%.

Existen personas que padecen ansiedad social secundaria a alteraciones médicas, como puede ser por la obesidad, el tartamudeo, o en personas mayores si tienen temblor en las manos o por el uso de prótesis dentales inadecuadas.

En un estudio de Beidel y Turner con pacientes de ansiedad social, las situaciones que más les originan ansiedad eran: dar una conferencia (99%), una charla informal (88%), fiestas (76%), mantener una conversación (64%), iniciar una conversación (60%), comer o beber en público (39%), escribir en público (31%) y utilizar un lavabo público (8%). Otro autor (S. Manuzza) encuentra que para el 60% la situación más temida es el tener que relacionarse con la autoridad y para el 27% tener que

preguntar una dirección⁶⁶.

Finalmente, refirámonos a dos aspectos relevantes como son el consumo de drogas y la timidez. Hay que prestar especial atención al hecho de que estos pacientes en un porcentaje elevado (entre el 20-40%) abusan del alcohol, y es importante, si generalizamos, que estemos atentos a los adolescentes que por problemas de timidez, o por tener un temperamento introvertido o esquizotímico, o una fobia social, realizan un consumo abusivo de alcohol o de cannabis (cuando no de otras sustancias tóxicas), para «compensar» su temperamento o el problema de su ansiedad social, convirtiéndose en poco tiempo en toxicómanos, o teniendo graves problemas escolares, familiares y sociales por el consumo abusivo de estas sustancias. Fijémonos que sólo el 25% de los pacientes que padecen fobia social reciben tratamiento, y la mayoría de las veces el diagnóstico se hace ya cuando acuden por consumo de alcohol o por padecer otras enfermedades psiquiátricas, bien ansiosas o depresivas.

En relación con la timidez, en la revisión sobre la ansiedad social de inicio en la infancia y adolescencia que realizan C. Ballesteros y V. Conde, señalan cómo la timidez ha sido a veces desvalorizada al considerarse una característica frecuente en la infancia. Afecta a un 2% de la población, y cuando se les pregunta a los niños si se consideran tímidos, cerca de un 40% responden afirmativamente; cuando se les pregunta a los padres, éstos encuentran tímidos aproximadamente a un 30% de sus hijos.

La timidez comparte con la fobia social muchos de los síntomas (rubor, temblor, palpitaciones, sudoración...) y asimismo el temor a valoraciones y evaluaciones negativas, y aunque este temor es menor en los tímidos que en la fobia social, no obstante, también interfiere en los rendimientos. En ambos casos existen comportamientos de evitación ante situaciones sociales. La disminución del tono de voz en las respuestas con abatimiento de la mirada es también una conducta observada en ambos ante situaciones ansiógenas. Evidentemente, siguen explicando estos autores, el funcionamiento habitual está más afectado en la fobia social y generalmente la timidez tiene un comienzo más precoz que la fobia social. Hay pues un indiscutible solapamiento entre la timidez y la fobia social y muchas veces los padres no perciben de forma adecuada el malestar que tienen los hijos ante situaciones sociales. Es muy importante que prestemos atención cuando el niño presenta síntomas físicos en situaciones de interacción social, así como cuando el joven rechaza ir a la escuela o tiene dificultades en las relaciones con los compañeros. Es muy importante valorar que si bien cierto grado de ansiedad social es una vivencia común en gran número de adolescentes como fenómeno propio de esta etapa evolutiva, no obstante, no nos olvidemos de evaluarla de modo y manera minuciosa para distinguirla de una ansiedad o fobia social clínica.

Remarcamos tanto la necesidad de diagnosticar este problema pues las personas que padecen fobia social no sólo tienen peor calidad de vida y por su alteración muchas de ellas no se casan, sino que además, como señala J. Ross, presentan menor rendimiento académico, limitaciones vocacionales (dificultad para el trabajo,

subempleo, bloqueo en los ascensos laborales), empeoramiento social (menor interacción social, dificultad para establecer y mantener amigos), mayor dependencia económica, realizan un mayor número de exámenes médicos, usan el alcohol como automedicación, padecen más depresión, agorafobia, ideación suicida e intentos suicidas.

Y una vez más tenemos que preguntarnos: ¿Cuándo nuestra sociedad llevará al más alto rango la necesidad de valorar el estado afectivo de nuestros jóvenes, en vez de estar tan preocupada por los rendimientos o porque se diviertan? ¿Cuándo los valores humanos, y cómo no entre ellos el equilibrio del ser-intimo con lo social, el equilibrio socioemocional, van a ser materia troncal de nuestro proceso educativo y social?⁶⁷.

¿Por qué una persona tímida tiene problemas en la adolescencia? ¿Sólo por la dificultad de relacionarse? ¡No! Evidentemente que no: tiene problemas porque en la adolescencia los valores que más frecuentemente predominan son los de tener bello físico y tener capacidad para atraer a los/as jóvenes del sexo opuesto, y cuanto más capacidad, más «valor» tiene esa persona y más se eleva en la pirámide de admiración de sus compañeros. Y si además tiene el joven una economía buena, más valor aún. ¿Y los valores humanos? Éstos no entran, a menudo, en el cortejo adolescente sino como en una segunda ecuación, una vez que la primera ya ha pasado el filtro. Evidentemente, en una sociedad madura, en la que el valor humano sea el primero de la relación adolescente, y no el coche, la moto o el físico que se posee, entonces las personas tímidas y con ansiedad social realizarían con normalidad las relaciones interpersonales desde su sociotimia, es decir, desde su capacidad íntima para lo social.

Cada persona, como señala E. Neuman, es original, no un anónimo estandarizado. Cuando en la infancia y adolescencia nuestros jóvenes tengan incorporados la ética social que supone entender al otro como «social y emocionalmente original» posiblemente esta enfermedad desaparecerá.

5.4. SÍNDROME OBSESIVO-COMPULSIVO⁶⁸ (TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO, TOC)

«La peor decisión es la indecisión.»

BENJAMIN FRANKLIN (1706-1790),
filósofo, físico y político estadounidense.

A un enfermo le atormenta, desde hace 6 meses, la idea de tener las manos contaminadas por larvas de gusanos cadáveres. Esta idea le asaltó repentinamente, un día que le saludó en la calle un amigo y éste le dijo que venía del cementerio. Desde ese momento está tan desasosegado que ha de lavarse infinidad de veces las manos todos los días y a pesar de ello no queda tranquilo. No puede evitar pensar que cualquier persona u objeto pueden estar contaminados por estas larvas. Aunque sabe,

racionalmente, que todo esto es absurdo, que las larvas de gusanos de cadáveres no son contaminantes, no puede evitar pensar en ello. Últimamente la situación se ha agravado de tal manera que se encuentra recluso en casa, para así no infectar a nadie y que tampoco le infecten a él. Por este aislamiento ha dejado de acudir al trabajo y se culpa constantemente, tanto por tener estos pensamientos como por dejar la actividad laboral.

Otra paciente se encuentra muy agobiada, pues constantemente le viene la idea de que delante de la gente puede levantarse la falda en la calle. Sabe que es absurdo, y en ningún caso lo ha realizado, pero teme continuamente que, repentinamente, le venga el impulso y no pueda impedirlo.

En otro caso, la angustia obsesiva se presenta en el miedo a que al ir por la calle o en cualquier transporte público alguien le origine una lesión en la cara sin que él se dé cuenta; llega a casa muy agobiado y ansioso, teniendo que mirarse rápidamente la cara en el espejo para comprobar minuciosamente, y durante largo rato, que no ha llegado al domicilio con alguna lesión facial.

Por último, en otro caso nuestro, un paciente con consolidadas ideas religiosas se angustia sobremanera cada vez que va a misa, pues entonces le vienen al pensamiento ideas soeces y sexuales en relación con el cura, con los santos y con Jesucristo; por esto ha de realizar continuos rezos durante mucho tiempo, por el sentimiento de culpa y angustia que le origina tener esos pensamientos sexuales que no desea. Incluso en varias ocasiones ha tenido también, en casa, vivencia de culpabilidad, pues le vienen pensamientos sexuales en relación con su madre y hermanas, viviendo esto con gran angustia. Sabe que son ideas absurdas, pero no puede evitarlas.

Los términos que se han utilizado para definir esta patología son:

- Obsesión, palabra procedente de *obsidere*, que significa asediar (proviene de, señala V. Conde, originariamente del ámbito militar), y también, desde 1737, «idea fija».
- Compulsión, palabra que proviene de *compellere*, *compulsum*, que significa «acción de obligar» (es un término del latín jurídico que hacía referencia a forzar a alguien a declarar, a comunicarse).
- Anancasis, palabra procedente de *ananke*, significa necesidad, algo que domina sin fundamento.

Es decir, lo que principalmente aparece en estos pacientes son unas percepciones, pensamientos, imágenes, impulsos, representaciones o recuerdos repetitivos que le asedian una y otra vez de forma fija (son las ideas obsesivas u obsesiones), y muchas veces, asimismo, tienen la necesidad de repetir acciones, lavados de manos, o movimientos, que no son útiles por sí mismos, pero viéndose obligados y necesitados de hacerlo (compulsiones). Las obsesiones son vivenciadas como negativas o desagradables, interfieren el funcionamiento normal (social, laboral, lúdico, etc.) del sujeto y éste se encuentra en una constante lucha contra ellas.

El carácter primario de la obsesión es su extrañeza y su falta de sentido; aparecen fenómenos psíquicos extraños pero pertenecientes al yo, perturbadores, y ante los

cuales el yo se comporta como espectador angustiado (López Ibor, 1979).

Por su parte, en la compulsión, el reino de la repetición automática es su naturaleza. Como indican J. Menchón y J. Vallejo, son conductas o actos mentales repetitivos que aparecen en respuesta a las obsesiones. Estas conductas o actos mentales que se realizan repetidamente constituyen rituales que no son placenteros ni útiles en sí mismos, pero que para el paciente tienen la función de prevenir hechos objetivamente improbables. Mientras que las obsesiones generan ansiedad, las compulsiones se realizan para intentar aliviar esta ansiedad, aunque el alivio es muy transitorio y sólo de forma inmediata. En principio, las compulsiones no aparecerían si no hay obsesiones, ya que el fenómeno nuclear (el principal) es la obsesión, pero excepcionalmente puede observarse.

La persona sabe que las ideas o pensamientos obsesivos son absurdos, pero al mismo tiempo no puede evitar pensar en ellos, dominan al control de su yo y le angustian mucho, repitiéndose constantemente y creándole un sustancial sentimiento de duda. Pero por otra parte, la repetición de actos, conductas o movimientos (compulsiones) consigue al final de ellos que se sienta con una sensación subjetiva de tranquilidad cuando «por fin» han conseguido terminar la repetición. Sólo aproximadamente un 25% de los pacientes padecen obsesiones sin tener compulsiones.

La angustia, la duda y la repetición son tres características fundamentales del síndrome obsesivo-compulsivo. Esto supone que el paciente se encuentra constantemente disconforme con muchas de las actividades que realiza:

1. Bien por una sensación de impureza, vivenciando angustiosamente que puede ser infiltrado por otras formas de vida, contaminado, temiendo a los contagios. Un paciente nuestro que vivía recluso en su casa tenía todo el domicilio perfectamente ordenado, para poder moverse por el mismo «sin tocar ningún mueble ni objeto», por miedo a contagiarse de «suciedad». Si tocaba algo su cuerpo, tenía que realizar repetidos lavados de esa parte hasta que se encontrase tranquilo de haberse desinfectado y limpio. El temor a la contaminación y los rituales de limpieza son unos de los síntomas más frecuentes.

2. También puede aparecer una vivencia de imposición, como ocurría con nuestro paciente, que hemos comentado, que se angustiaba con los pensamientos que le aparecían en su mente, contra su voluntad, obscenos en relación con las figuras religiosas y con sus familiares.

3. Asimismo, puede padecer esta disconformidad en relación con la imperfección. Muchas veces han de repetir las cosas porque necesitan que todo esté en simetría y ordenado, y otras veces porque no están seguros de hacerlas perfectamente, y repiten una y otra vez hasta que al cabo de numerosas repeticiones ya les aparece esa seguridad. La duda se encarna a menudo en esta inseguridad por lo perfecto: un paciente nuestro llegaba muy a menudo tarde al trabajo, pues antes de ir al almacén tenía que cargar su camioneta, nada más levantarse, de cajas repletas de material para el trabajo. Pero una vez que había acabado de cargar el vehículo le aparecía la duda

¿habré puesto todas las cajas?, por lo que tenía que sacarlas de nuevo, contándolas, y luego volver a meterlas contándolas otra vez, para estar seguro de que ponía todas. Esta labor la realizaba 3-4 veces antes de salir para el trabajo, por lo que aunque se levantaba muy temprano para «tener tiempo», no obstante frecuentemente llegaba tarde por esa repetición.

Cuán a menudo vemos pacientes que han de comprobar 7-8 veces o más que han cerrado bien la puerta, o el gas, el agua, o la luz de la entrada de su casa, antes de poder sentirse desangustiadados ante esa eventualidad.

Estos pacientes no se deciden a finalizar. Es significativo que el vocablo «decidir», etimológicamente procede del latín *decidere*, que quiere decir acabar, resolver. En la decisión normal hay una lucha entre motivos o factores entre los que tenemos que elegir, y una vez resuelta esa lucha aparece la resolución. Esto no puede hacerlo el obsesivo que cuando termina una acción la vivencia «inacabada». Por esto un paciente puede tras ponerse varias veces un calcetín sentirse seguro de que ya está bien puesto, o bien puede, como en el caso de un enfermo de O. Bumke, tener que reflexionar durante horas antes de decidir si se ponía primero el calcetín izquierdo o el derecho. Como señala López Ibor (1966), no es que el obsesivo no sea capaz de terminar, sino que no puede terminar como los seres normales. No puede dejar ningún resquicio ni posibilidad abiertos, ninguna fuente de error, por mínima que sea. En la vida normal, el yo decide sobre todos los hechos que constituye su existencia diaria, y en los enfermos la angustia se mueve en el plano intelectual de forma tan meticulosa que les impide terminar la acción; la angustia les impide decidir⁶⁹.

4. Igualmente, la disconformidad íntima puede aparecer en relación con la propia espontaneidad. No están conformes con su forma natural de ser, su forma de hablar, moverse, comer, etc.

Las manifestaciones clínicas del síndrome obsesivo-compulsivo aparecen en prácticamente todas las áreas de la persona:

- En la percepción puede surgir como «inseguridad perceptiva»; un paciente tenía que mirar largos ratos al cerrojo de su puerta para poder estar seguro de que estaba echado; abría ambos ojos cuanto podía para verlo mejor, lo iluminaba con una linterna... pero no acababa de estar conforme de «haberlo visto bien del todo».
- En la memoria puede presentarse a modo de una tonadilla o melodía que ha oído y que se repite constantemente como un disco rayado, sin poder pararlo, o, por ejemplo, otro paciente se encontraba continuamente angustiado, ya que tenía que recordar todo cuanto había oído, visto o leído en días pasados, no pudiendo parar de buscar recuerdos.
- Hay pacientes obsesivos que constantemente están haciendo pensamientos reflexivos que aunque saben que son absurdos, no obstante no pueden evitarlos: ¿por qué me llamo Juan?, se preguntaba angustiosamente un enfermo; ¿por qué al domingo le sucede el lunes y no el sábado? La idea obsesiva reflexiva de otro paciente nuestro era que su novia besó a un novio antiguo que tuvo:

¿disfrutó con el beso?, se martilleaba él, y a su novia, cientos de veces diariamente.

- El miedo a impulsos incoercibles también tiene relevancia en muchos pacientes obsesivos: ¿y si de pronto tengo el impulso de tirarme por el balcón?, sufría una paciente, por lo que tenía todos los balcones de su casa cerrados y ni siquiera se atrevía a acercarse a ellos a más de dos metros. ¿Y si de pronto doy un volantazo y me estrello con el coche?, padecía otro paciente que dejó de conducir por la angustia que esto le ocasionaba. A veces, miedo a no controlar un impulso agresivo contra un ser querido. En ocasiones aparecen impulsos de evitación (denominadas por O. Bumke fobias funcionales), como el paciente que evitaba subir a transportes públicos por miedo a contagiarse de una enfermedad infecciosa por las otras personas que allí viajasen.

¿Y las personas con escrúpulos?

Una persona sana normalmente se siente libre en las percepciones, pensamientos o representaciones que tiene, así como en la angustia que sufre por los recuerdos a los que se entrega. Cuando hablamos, en el lenguaje popular, de escrúpulos, podemos entender su sentido si nos fijamos que es un diminutivo del vocablo latino *scrupus*, que significa guijarro, aludiendo a la piedrecita que se introduce a veces en la sandalia del caminante y con ello la sensación de extrañeza y molestia que produce al andar por la vida.

Es decir, va a ser una molestia, pero no una enfermedad. Señala López Ibor (1966) cómo una persona es tanto más enferma cuanto menos libre se halla frente a los escrúpulos; si el sujeto logra mantener su proyecto vital —por lo tanto, su libertad—, a pesar de la fisura escrupulosa, no será enfermo, a diferencia de si la fisura se expande por una buena parte de su proyecto vital. La duda del escrupuloso, que no es enfermo, será quizá una duda intelectual, pero la personalidad actúa como un todo único capaz de decidir y tomar una posición; en cambio, en el obsesivo la decisión es imposible, encontrándose ambivalente por la angustia.

¿Cuál es la causa de la enfermedad obsesiva?

Por una parte, como indica Seva (1979), es una enfermedad en la que hay una gran influencia de factores endógenos; esto quiere decir que hay una importante predisposición a tener la enfermedad; se podría presuponer que en parte son factores genéticos [en los gemelos monocigóticos hay una concordancia de aproximadamente el 60% y en los dizigóticos (mellizos) alrededor del 30%], pero la genética no ha dado aún resultados concluyentes.

Por otra parte, hay muchos «tipos» de obsesivos. A. Seva y Rojo Sierra (1964 y 1965) encontraron 5 grupos clínicos diferentes:

1. Desarrollos obsesivos	10%
2. Obsesivos epileptófilos	54%
3. Obsesivos esquizófilos	12%
4. Obsesivos depresófilos	17%
	7%

5. Neurosis obsesivas puras

En el grupo de desarrollos obsesivos, los lavados rituales de manos aparecen en el 90% de estos enfermos, y con igual porcentaje el miedo de contagiarse de cosas o personas. En el grupo de enfermos obsesivos epileptófilos, el carácter explosivo aparecía en el 77% de los casos. En el grupo de enfermos obsesivos esquizófilos, aparecía con una frecuencia del 66% el síntoma de «temor a las imposiciones exteriores», como era el caso de nuestro enfermo, que tenía miedo a que en la iglesia le dominaran palabras soeces sobre el cura, Jesucristo o los santos. En el grupo de los enfermos obsesivos depresófilos, en un 53% de los casos habían tenido en su vida oscilaciones anímicas depresivas y/o maníacas.

Como vemos, pues, hay muchos «tipos» de enfermos obsesivo-compulsivos, y por esto es muy difícil encontrar una «causa» común.

Más aún si tenemos en cuenta que los tratamientos también consiguen mejorías desde muchas perspectivas:

- Desde la psicofarmacoterapia, mediante los avances en los estudios sobre los neurotransmisores (la serotonina fundamentalmente, y la dopamina). La medicación que aumenta los niveles de serotonina es claramente eficaz en esta enfermedad. No obstante, aunque parece bastante clara la relación del neurotransmisor serotonina con el TOC, no se puede decir que sea su alteración la «causa» (patogenia) de la enfermedad.
- Desde las teorías psicoanalistas. Freud fue el primero que acuñó el término neurosis obsesiva y consideró que la enfermedad se originaba por impulsos inconscientes agresivos o sexuales (libido).
- Desde las teorías del aprendizaje (infancia muy rígida...).
- Desde las teorías de la conducta. Estas teorías, si bien no explican satisfactoriamente el origen de las obsesiones, sí que son muy útiles para explicar los rituales y el mantenimiento de las conductas obsesivas. Las terapias de conducta de exposición *in vivo* (exposición gradual a las situaciones temidas), junto al tratamiento psicofarmacológico, son muy eficaces para conseguir una remisión completa de los síntomas.

La prevalencia del trastorno obsesivo-compulsivo en la población general es aproximadamente del 2%, siendo igual para ambos sexos, aunque durante la adolescencia los varones pueden tener una frecuencia algo mayor de padecer esta enfermedad. Suele aparecer alrededor de los 20 años.

Surge la enfermedad, muchas veces, tras acontecimientos estresantes, como pueden ser fallecimientos, embarazo, enfermedades propias, problemas laborales, parto, etc., pero muy a menudo los pacientes se avergüenzan y esconden sus síntomas, por lo que pueden tardar de 3 a 7 años en acudir para ser tratados médicamente.

Es importantísimo que detectemos lo más pronto posible a estos pacientes, que tardan en pedir ayuda profesional, pues hasta el 5-10% se pueden hacer crónicos con

síntomas persistentes graves y, evidentemente, el tratamiento precoz es un factor que mejora el pronóstico.

Podemos decir, en general, que la mayoría de los pacientes van a responder bien al tratamiento, aunque éste va a ser para muy largo plazo, si no para toda la vida⁷⁰.

En la revisión que hicieron Goodwin y cols. se comprobó que el curso del TOC podía ser: 1) fásico, con períodos de remisión completa, pero tendente a volver a aparecer; 2) episódico con remisión incompleta, pero que permite un funcionamiento social normal, y 3) crónico y sin remisión. Como indican Rasmussen y cols., se ha demostrado que los períodos claros de remisión (sin síntomas) sin medicación son poco frecuentes. En algunos casos muy graves y resistentes a las distintas alternativas terapéuticas, señala Vallejo Ruiloba (2000): «No podemos omitir el papel que la psicocirugía (cerebral) ocupa en el tratamiento [...] en el momento actual la capsulotomía bilateral anterior y la cingulotomía son las dos técnicas más acreditadas con resultados que se sitúan alrededor del 50% de éxitos. En vista de estos resultados cualquier otra consideración que se aparte de las razones científicas y alegue otras de tipo ético está fuera de lugar si pensamos que para algunos enfermos la psicocirugía es la última posibilidad de alcanzar una existencia digna».

Por esto podemos preguntarnos: ¿Qué hacer con los llamados «nuevos crónicos»? es decir, con aquellos pacientes que con los tratamientos modernos, principalmente psicofarmacológicos, no mejoran y que aun tomando altas dosis de uno o varios medicamentos siguen padeciendo gravemente su enfermedad. ¿Esperar a que en un futuro se encuentre la solución y mientras tanto «la ciencia lamenta» no poder ayudarles más? Pienso, como Kalinowsky y otros autores, que también se han atrevido a sugerirlo, que habría que revisar la efectividad en estos pacientes de algunos «tratamientos antiguos» que hoy en día ya han sido desechados por la comunidad científica médica. Por ejemplo, en algunos pacientes obsesivos-compulsivos graves. En 1954, Rojo Sierra publicó la curación de esta enfermedad con la administración controlada vía subcutánea de derivados del troptano (solución al 10% de cocaína) sin producirles dependencia a esta sustancia, y en 1959 y 1965 publicó cómo un grupo de ellos (epileptófilos y esquizófilos) respondían satisfactoriamente al tratamiento con LSD-25 (choque psicodisléptico). En aquellos años, estas sustancias no estaban prohibidas para su uso médico. Ni mucho menos debería atreverme a sugerir que usemos cocaína o ácido lisérgico para tratar, actualmente, a los TOC, pero no debemos desechar absolutamente antiguas estrategias para rescatar a estos «nuevos crónicos» de su tirana enfermedad⁷¹.

NOTAS

⁵⁶ Del griego *phobéomai* = yo temo, y éste de *phóbos*, temor, huida.

⁵⁷ Citados estos dos últimos casos por López Ibor (*Las neurosis como enfermedades de ánimo*).

⁵⁸ Aunque no se han encontrado de forma concluyente bases genéticas de las fobias específicas, no obstante se avanza en este camino, y en un estudio de la Universidad de Yale de 2003, J. Gelenter y cols. asocian un gen del cromosoma 14 con la posibilidad de ser vulnerable a esta enfermedad.

[59](#) En un caso nuestro, comercial, que llevaba dos años sin salir de casa, conseguimos, tras ocho meses de tratamiento bífrente (es decir, un psiquiatra se encargaba del tratamiento médico psiquiátrico y una psicóloga se encargaba del tratamiento psicoterapéutico), que el paciente pudiera salir solo, sin acompañante, a dar la vuelta a la manzana de su casa una vez al día, ¡y nada más! Lo llamativo es que la abogada del paciente pidió una incapacidad laboral absoluta para todo tipo de trabajo y en el juicio que se celebró se la denegaron, diciendo que la incapacidad únicamente le correspondía para «su trabajo habitual». Yo me pregunto: ¿qué trabajo puede realizar una persona que sólo puede salir a dar una vuelta a la manzana de su casa y haciéndolo con esfuerzo? Por desgracia siguen siendo, a menudo, muy incomprensidos estos pacientes graves simplemente porque no sale su enfermedad en una radiografía o en una TAC.

[60](#) También denominado por López Ibor vértigo timopático (*La angustia vital*, 1950).

[61](#) También son denominadas estas crisis de angustia ataques de pánico. El dios griego Pan, dios de los pastores y rebaños, espantaba de manera súbita a ovejas y a los hombres.

[62](#) El vértigo es una sensación de desplazamiento de los objetos externos en relación al cuerpo; en los casos intensos se convierte en sensación de rotación (vértigo propiamente dicho). Pueden ocasionar la caída del enfermo si no se apoya o se echa a tiempo. Hay innumerables causas de vértigo, infecciosas, tumorales, intoxicaciones, hipoglucemias, lesiones oculares, alteraciones del oído, vértigo cervical, etc. (*Manual de diagnóstico etiológico*, G. Marañón).

[63](#) En 1909, Janet introduce el término fobia de las situaciones sociales, describiendo a pacientes que temían hablar en público, tocar el piano o escribir mientras eran observados.

[64](#) J. Giner y cols. (1998) encuentran en estos pacientes una especial susceptibilidad a la crítica, temor al rechazo, dificultad para la autoafirmación, baja autoestima y sentimientos de inferioridad.

[65](#) Como ya indicamos, en epidemiología se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado en un momento dado.

[66](#) En los países asiáticos, lo que en Occidente se denomina fobia o ansiedad social, allí se denomina TKS = *taijin-kyofusho*, y a diferencia de la fobia social (occidental), en la que el paciente tiene miedo a ser humillado, avergonzado o ridiculizado, el TKS consiste en un temor a ofender a los demás, al ponerles en una situación embarazosa o incómoda por el problema personal del paciente (ruborizarse delante de los otros, emitir un olor corporal desagradable o exponer una parte repugnante de su cuerpo). Como señala Chang (1997), el TKS es un patrón cultural de la ansiedad porque refleja la naturaleza «orientada al prójimo» de sociedades de Asia, de la misma manera que la fobia social refleja la naturaleza «egocéntrica» de las sociedades occidentales.

[67](#) Rojo Sierra (*Psicopatología de la sociedad*) señala cómo el individuo tiene dos formas de relacionarse con los demás: una intelectualizada; otra afectiva, tímica o también llamada pática. La sociotimia es el modo íntimo que cada persona vivencia, en su ser, lo social. Y mediante esta vivencia se expresa su afectividad social íntima en el mundo que nos rodea, con las otras personas.

[68](#) Este apartado se ha basado estructuralmente siguiendo a M. Rojo Sierra, *Lecciones de psiquiatría*, tomo III.

[69](#) Los llamados «endentecidos primarios», descritos por Rachmann en 1974, constituyen este subgrupo de pacientes que emplean una enorme cantidad de tiempo en la realización de tareas cotidianas (lavarse, vestirse, comer...), no tanto porque deban comprobar sus actos, sino porque se ven obligados a llevarlos a cabo siguiendo una pauta de conducta rígida, que si se interrumpe, conlleva la necesidad de reiniciar de nuevo la acción completa (cit. Vallejo Ruiloba y cols., 2005).

[70](#) En el folleto elaborado por la Obsessive-Compulsive Foundation para ayudar e informar a las personas que sufren un TOC, en la pregunta ¿tienen los pacientes con TOC que tomar medicación antiobsesiva toda su vida?, la respuesta es... parece que más de la mitad (probablemente más) necesitan tomar la medicación durante muchos años, tal vez toda la vida.

De forma parecida, la guía aportada para estos pacientes por el Obsessive-Compulsive Information Center de la Dean Foundation for Health, Research and Education, ante la pregunta ¿qué sucede al suspender los medicamentos anti-obsesivo-compulsivos?, responde: Por desgracia, la mayoría de los pacientes experimentan una recaída hasta el nivel previo de síntomas, cuando suspenden la medicación. Los hay que conservan la mejoría al menos durante un cierto tiempo. Muchos pacientes pueden mantener casi toda la mejoría obtenida con dosis algo menores que las que fueron necesarias para conseguir el alivio inicial de los síntomas.

[71](#) En un trabajo de Moreno y Wiegand et al. del año 2006, publicado en la prestigiosa revista internacional J.

Clin Psychiatry, estos investigadores de las universidades de Arizona y Texas, trataron enfermos obsesivos-compulsivos mediante la droga psicodisléptica psilocibina, encontrando en estos pacientes graves una importante mejoría de sus síntomas tras la administración de la droga, sin producirles significativos efectos secundarios. Como señala J. C. Ballenger en el *Year Book Psychiatry and Applied Mental Health* de 2008, tratar de ayudar a estos pacientes TOC graves es muy frustrante, pues fracasan todos los tratamientos, y es muy importante este estudio, que encuentra beneficio en estos pacientes en los que la medicación es inefectiva. También, señala Ballenger, se está estudiando el tratamiento del trastorno por estrés postraumático mediante la droga éxtasis.

6. TRASTORNO POR ESTRÉS TRAUMÁTICO (TEPT)

«La tempestad puede derrumbar incluso el árbol más fuerte.»

Por supuesto que cualquier vivencia importante puede afectarnos y sernos «traumática» hasta el punto, en algunos casos, de originarnos una enfermedad ansiosa. No puedo dejar de insistir en que si un acontecimiento o un suceso importante nos afecta más o menos, esto dependerá de diversas variables como pueden ser la historia del propio individuo y el proyecto de su vida. Por lo tanto, la fuerza eficaz de las vivencias será siempre completamente individual, hasta el punto de que —como señala Rojo Sierra (1962)— «en el mismo individuo el impacto vivencial es muy variable según las circunstancias en que se encuentre envuelto y el momento histórico en que se halle [...] por lo que la actividad patógena de lo psíquico no se ejerce inespecíficamente sino personalmente».

Pero se ha querido hacer hincapié en una alteración en la que la persona normal, sana, sin ninguna característica especial de riesgo, quedaba fundamentalmente marcada por un acontecimiento inesperado, estresante en extremo, violento, de excepcional intensidad e impacto, y que a partir de éste, claramente identificado, se ha originado la enfermedad. Como ejemplo histórico, Pinel describe cómo el filósofo Pascal, tras un accidente de automóvil en el que estuvo a punto de perecer al precipitarse al Sena, cambió su carácter, se hizo más aprensivo, escrupuloso, retraído y sufrió el resto de sus días pesadillas en las que se veía caer por un precipicio. Estamos hablando, por lo tanto, de acontecimientos como pueden ser atentados terroristas, desastres ferroviarios, de avión, guerras, bombardeos, violaciones, abusos sexuales, presenciar muertes, accidentes con lesiones, víctimas de torturas, grandes quemados, agresiones con violencia, etc. Y lo interesante de este diagnóstico es que aunque se han estudiado múltiples factores de personalidad y de la historia familiar, historia de traumas pasados, apoyos vitales, etc., lo novedoso es que muchas personas sin vulnerabilidad especial, sanas, ante el acontecimiento existencialmente traumático padecen esta enfermedad de larga duración.

Aunque ya anteriormente se habían descrito por numerosos autores trastornos psíquicos relacionados con acontecimientos traumáticos, y por esto se habló de neurosis traumática, neurosis de guerra⁷², trauma de la explosión del obús, etc., no obstante la vuelta de los soldados de Vietnam supuso comprobar que gran número de estos veteranos, independientemente de sus condiciones psíquicas previas, padecían tras la vuelta a Estados Unidos cuadros psiquiátricos de evolución crónica. Por esto surgió este concepto nuevo fundamental que subyace en el trastorno por estrés

postraumático, y es, como indica E. Baca (2002), que esta enfermedad «es prácticamente el único trastorno psiquiátrico definido por su causa [...] etiológicamente en las nosologías actuales»; es decir, se le supone prácticamente un origen causal, y que si no se hubiera producido el grave trauma la persona seguiría completamente sana⁷³.

Según el manual diagnóstico DSM-IV, el suceso ha de ser amenazante para su integridad física o la de los demás, y además la persona responde con un terror, una desesperanza o un horror intensos. Es muy importante que el individuo haya percibido el suceso como amenazante para su vida, o le origine una fuerte indefensión, bien sea física, psíquica o incluso valorativa existencial. Le afectará en áreas significativas de la vida, como pueden ser la familiar, social o laboral.

En la mayoría de los casos el trastorno ansioso aparecerá inmediatamente después del suceso traumatizante, pero hay un porcentaje, alrededor del 10%, que puede presentar la sintomatología de forma «retardada» pasados más de 6 meses después del acontecimiento.

El 25% de la población afectada por una catástrofe mantendrá una conducta «eficiente» durante el período postraumático inmediato; otro 25% mostrará respuestas claramente anormales e inadecuadas de uno u otro tipo. Como indica Melick, la experiencia muestra que al menos el 15% de la población afectada sufrirá una alteración mental tan intensa que precisará tratamiento.

Los síntomas más significativos se relacionan con el recuerdo continuado del acontecimiento o recurrencia intrusiva de recuerdos (*flashbacks*) que originan malestar, como pueden ser imágenes o pensamientos sobre el suceso. Sueños recurrentes y angustiosos sobre el acontecimiento y afectación de la vida normal, presentando frecuentemente insomnio, irritabilidad, dificultad de concentración y facilidad para sobresaltarse. Asimismo, aparece un desinterés hacia actividades significativas o «embotamiento emocional». Hay tendencia a evitar aspectos o situaciones que le recuerden el suceso y a menudo le aparecen síntomas ansiosos físicos si se exponen a situaciones o símbolos que le recuerdan el acontecimiento.

Se asocia frecuentemente con el llamado síndrome del superviviente; éste consiste en fuertes sentimientos de culpa por haber sobrevivido (o por no haber podido salvar a otros), cuando tantos murieron, o por las cosas que tuvo que hacer para poder sobrevivir, por lo que busca constante y angustiosamente una comprensión cognoscitiva (lógica) del desastre.

La evolución es buena en un 50% de los casos a lo largo del primer año, pero más de un 25% de los que han padecido trastorno por estrés postraumático no se recuperan completamente durante muchos años, siendo su evolución, por lo tanto, crónica. Según R. O. Pasnau, son muy importantes para valorar este trastorno dos factores:

1. El factor de la percepción de la mediación humana. En un extremo se sitúan los sucesos en los que la mediación humana es muy pequeña o inexistente: huracanes, terremotos, etc. Se consideran normalmente desastres naturales⁷⁴ y

aluden normalmente a una adversa ordenación cósmica o al destino. En el otro extremo se sitúan los sucesos que derivan de una malevolencia humana: terrorismo, violación, violencia física, tortura, etc. Cuanto mayor sea el grado de intervención, culpa o fallo humano para que se produzca la catástrofe, más se favorecerá la enfermedad postraumática.

2. El aislamiento social constituye un factor importante. Si el individuo tiene apoyos en sus relaciones interpersonales, y de los familiares y amigos, así como de diferentes personas de confianza, sacerdotes, médicos y otras que supongan un apoyo a su situación y proyecto vital, entonces su vulnerabilidad disminuirá tremendamente.

Es importante, como señala A. Ehlers, que tengamos en cuenta que al ser la evitación uno de los principales síntomas de esta enfermedad puede el paciente tardar mucho tiempo en buscar ayuda, y además al tener dificultades para hablar sobre la experiencia traumática pueden ser inconstantes en las visitas al médico. Igualmente, ya que pueden encontrar muy doloroso y tener dificultad para ocuparse de las consecuencias del acontecimiento traumático, tales como los procedimientos legales y el tratamiento continuado de sus lesiones físicas, es por lo que muchas veces se mantienen sin solucionar estos factores estresantes relacionados con el trauma, lo que dificulta su recuperación completa.

Pero tenemos que preguntarnos, obligatoriamente, por qué el acontecimiento traumático no sólo produce un gran impacto vivencial, sino que además hace que la persona quiebre psíquicamente de tal manera que luego no puede recobrar su funcionamiento psicofisiológico normal.

Hemos de diferenciar entre lo que se ha denominado *reacción psicológica*, que no supone patología —por ejemplo, ante un problema o un duelo normal por el fallecimiento de una persona cercana—, y *reacción psicogénica*, que supone, ya, que se ha originado, como consecuencia de la vivencia, una patología y por lo tanto fenómenos psicofísicos anormales.

Desde Birbaum se denominan «psicógenos» a los efectos patológicos de las influencias psíquicas.

En el caso del trastorno por estrés postraumático, ciertamente se produce una repercusión exagerada y patológica del fenómeno psíquico directo vivenciado, y podemos decir, siguiendo a Bumke, Lange y K. Schneider, que este trastorno es una «reacción psicógena», pues consideraron la enfermedad como una consecuencia *cuantitativa* del factor estresante.

Como señala Rojo Sierra (1962), la vivencia y su emoción es una reacción fisiológica de finalidad vital que puede rebasar la resistencia habitual y agotar al sistema nervioso por su intensidad. Es necesario, sigue este autor, no desvalorizar a lo psicógeno como un simple agente productor de alteraciones más o menos aparatosas.

El impacto de la vivencia puede ser tan impactante que, como señala Bonhoeffer, la reacción psicógena se explicará biológicamente por los trastornos de las funciones anímicas y corpóreas del organismo.

Pero seguimos preguntándonos ¿qué ha hecho que el acontecimiento tenga esa virulencia hasta el punto, psicogénico, de originar una enfermedad, en muchos casos irre recuperable?

Consideremos en primer lugar los datos aportados por una revisión que realiza Pau Pérez-Sales (2009). Señala cómo la epidemiología muestra que no todos los hechos traumáticos tienen un impacto similar. Mientras que se estima que entre un 5-10% de las personas desarrollan secuelas a un accidente de tráfico que ha tenido riesgo para su vida (vivencia de un mundo impredecible e inseguro), en el caso de abuso sexual con violencia física el porcentaje se eleva al 35-50% (vivencia de desconfianza en el ser humano en general) y hasta el 50-65% si el abuso sexual con violencia física se produce por un familiar o amigo cercano.

¿Qué se está rompiendo en el *intus*, en el interior de la persona?

La respuesta puede que esté en la desestructuración ético-afectiva que produce el trauma como vivencia límite, ante la cual se siente el sujeto totalmente impotente para poder actuar. Como ya señalamos anteriormente, Karl Jaspers llamó «situaciones límite» a estas situaciones que conllevan tanta carga afectiva, y dice: «ante las situaciones límite no reaccionamos mediante planes y cálculos para superarlas, sino por una actividad completamente distinta, llegando a ser la posible “existencia” que hay en nosotros. Hay vivencias que de por sí son muy intensas, como son las relacionadas con la muerte, con catástrofes, con la familia o con personas cercanas afectivamente. Por esto, estas situaciones límite son insuperables por la lógica, nos van a inundar de sentimientos y nos van a llevar a planteamientos sobre lo más profundo de cada uno (existencia). Estas situaciones límite como tales son insoportables para la vida [...]; en la vivencia límite parece encontrarse siempre el acaso absoluto, la muerte, la culpa [...] el sernos arrebatado lo más querido, la aniquilación, ante la propia impotencia».

La impotencia aparece ante la vivencia catastrófica, ante la humillación de la violación o del secuestro; esta impotencia es fundamental para entender el impacto vivencial, pues ante esta vivencia límite la afectividad queda desnuda del componente director «lógico», por la *impotencia* que el suceso origina. La vivencia límite del acontecimiento traumatizante tiene capacidad para fracturar la *concepción del mundo* del paciente; ahora ya esta concepción del mundo está desmembrada, y centrada prácticamente sólo en la vivencia traumática que adquiere un valor absoluto. Adquiere valor absoluto esta vivencia de impotencia, pues ahora el paciente ha creado su nueva concepción del mundo; un mundo finito, concreto, parado, en el que la capacidad lógica y su capacidad de resolución cognoscitiva ya no pueden liderar al movimiento. «El hombre en tanto que lo mueven fuerzas de concepciones del mundo jamás puede quedarse parado en lo finito concreto [...] las concepciones del mundo auténticas están íntimamente unidas con la vida total del individuo», señala Jaspers (1960). Pero ahora el paciente, con esta enfermedad, no se mueve con concepciones de mundo; ha quedado fijado, paralizado, con una sola concepción que lo atrapa en la vivencia traumatizante y lo paraliza, sólo girando de modo finito alrededor de lo sucedido.

Explicándolo con otras palabras:

Toda vivencia emocional que tenemos, al mismo tiempo que la vivenciamos se proyecta en nuestra vida futura, en nuestro sentido de la vida, en nuestra concepción del mundo futuro con una directriz lógico-racional. Así por ejemplo, fallece un familiar y nos afecta mucho, pero, al mismo tiempo, aunque vivenciamos el dolor del fallecimiento, «sabemos» que tenemos que seguir con nuestro día a día; nuestro proyecto vital ha de continuar. Pero cuando se produce una vivencia trágica que rompe la conexión lógica y racional, que derrumba el sentido que tenemos de nuestro proyecto, entonces la vivencia violenta queda sola, queda desnuda y con capacidad destructora del equilibrio afectivo global de la persona⁷⁵.

Por otra parte, a veces, más que una vivencia brusca traumática lo que tenemos es una situación grave a la que hemos de adaptarnos —o, como indica K. Kolle, una situación de *iniquidad de destino*—, y entonces curiosamente no aparece este trastorno. Así ocurre con las observaciones de Kral (un psiquiatra judío que estuvo internado en la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Theresienstadt y tuvo allí a su cuidado a 140.000 compañeros de infortunio), y que pudo comprobar que si bien casi todos los compañeros tenían que vencer al principio un «shock inicial» que desaparecía sin tratamiento en 1-2 semanas de aclimatación, no obstante las reacciones de pánico o intentos de suicidio eran raras, y lo más sorprendente era el hecho de que ciertas neurosis que padecían algunos presos antes de su internamiento desaparecieron en el curso de él y no volvieron a presentarse en ningún caso mientras duró la reclusión. También «las enfermedades en las que predomina el factor psicogénico como úlcera gástrica o asma eran de extrema rareza».

En condiciones parecidas, señala D. S. Charney, cómo los estudios realizados en niños que se han criado en situaciones de guerras, violencia familiar, pobreza y desastres naturales, presentan, en estos infantes, un patrón de adaptación satisfactorio; muestran un buen funcionamiento intelectual, una autorregulación eficaz de emociones y la capacidad de convertir la impotencia traumática en competencia adquirida y un estilo de afrontamiento activo a la hora de enfrentarse al estrés. Es decir, han sido capaces de desarrollar un adiestramiento cognoscitivo y «lógico» del impacto emocional destructivo. En ellos aún se mantiene, a pesar de las vivencias traumáticas, lo que Ann Mastern ha denominado la «magia habitual» de la capacidad de adaptación.

Diríamos que en estos casos se mantiene la directriz lógico-racional que mantiene coherente la situación vivenciada, con la vida total del individuo, con su concepción del mundo⁷⁶.

Algo parecido puede ocurrir en el caso del denominado síndrome de Estocolmo⁷⁷. Éste aparece en personas que son objeto de un secuestro y durante el cautiverio hacen una identificación con el secuestrador, disculpándolo y entendiendo sus motivos; aunque no significa que no vayan a tener esta enfermedad postraumática, en muchos de estos casos no aparece y en otros es menos intensa, pues «comprenden» las razones y conducta del secuestrador. Un caso muy famoso fue el de Patricia Hearst,

también conocida como Patty Hearst, nieta del influyente y poderoso editor William Randolph Hearst, que fue secuestrada el 4 de febrero de 1974 de su apartamento en California por un pequeño grupo de izquierda denominado Ejército Simbionés de Liberación (Symbionese Liberation Army —SLA—). Peticiones exageradas por el grupo dieron como resultado la donación por parte de la familia Hearst de comida por un valor de 6 millones de dólares para los pobres, a continuación de lo cual no hubo noticias de Patricia. Poco después, el 5 de abril de 1974, fue fotografiada con un rifle de asalto durante el atraco a una de las sucursales del banco Hibernia. Más tarde se supo que había cambiado su nombre por el de *Tania* y se había comprometido con las ideas del Ejército Simbionés de Liberación. Se dictó una orden judicial de captura y en septiembre de 1975 fue arrestada en el apartamento de otro de los militantes. Mientras tanto la policía había atacado y prendido fuego a otro de los apartamentos del grupo, en el que murieron la mayoría de los miembros.

Como vemos, de nuevo es como si por esa «comprensión lógica» de las razones del secuestrador, el trauma emotivo fuese conducido por una directriz ética-cognoscitiva, evitando así el estallido afectivo impotente, desestructurante y paralizador de la fluidez de la concepción del mundo futuro.

NOTAS

[72](#) Los alemanes negaron la neurosis de guerra durante la Primera Guerra Mundial, y el que presentara algún síntoma debía ser fusilado, por lo que no se detectaron casos de esta enfermedad en el ejército alemán. En la Segunda Guerra Mundial, el general Patton prefería el término «agotamiento de combate», pues mantenía que la neurosis era un «problema de voluntad». Pensaba que la neurosis debía castigarse con la pena de muerte, punto de vista en el que los rusos fueron pioneros, con un éxito notable. Eisenhower no compartía esta opinión (cit. D. W. Goodwin).

[73](#) Y debido a esta concepción causal es por lo que este diagnóstico nos lo encontramos frecuentemente en procesos judiciales para dirimir quién ha de pagar, económicamente, las consecuencias de la enfermedad que puede durar años e incluso toda la vida.

[74](#) El término castellano *desastre* y su equivalente inglés *disaster*, derivan del latín (*dis* + *aster* = hado o estrella) y etimológicamente significan «mala estrella» o «mala suerte»).

[75](#) Se llama carga alostática (McEwen y Stellar) al trabajo, al esfuerzo que hace el cuerpo, el cerebro, cuando se está adaptando a un desafío fisiológico o psicológico, e indica que ya el organismo se encuentra en estado acumulado de desregulación. Podemos entonces decir que en el organismo, tras una vivencia límite, en el caso de la enfermedad postraumática, la carga alostática, la desregulación, la incapacidad de adaptación psicobiológica, es producto de la imposibilidad de incorporación del hecho emocional traumático a su proyecto cognitivo vital.

[76](#) Aunque en algunos casos los hechos traumáticos asociados a horror extremo duradero en el tiempo, como sería, por ejemplo, la violencia política prolongada, pueden originar una transformación persistente de la personalidad. Se habla entonces de Desnos (Disorder of Stress not Otherwise Specified) o TEPT-complejo (P. Pérez-Sales, 2009).

[77](#) Debe su nombre a un hecho curioso sucedido en la ciudad de Estocolmo (Suecia). En 1973 se produjo un robo en el banco Kreditbanken de la mencionada ciudad sueca. Los delincuentes debieron mantener como rehenes a los ocupantes de la institución durante seis días. Al entregarse los captores, las cámaras periodísticas recogieron el momento en que una de las víctimas besaba a uno de los captores. Y, además, los secuestrados defendieron a los delincuentes y se negaron a colaborar en el proceso legal posterior.

7. ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

«Una palabra bien elegida puede economizar no sólo cien palabras sino cien pensamientos.»

HENRI POINCARÉ (1854-1912), matemático francés.

La ansiedad y la depresión se unen muy a menudo, hasta el punto que no es raro encontrar pacientes que han sido diagnosticados de «ansiedad» y cuando hacemos un estudio clínico más exhaustivo nos encontramos que aunque padezcan síntomas ansiosos, realmente el cuadro predominante es el depresivo; puede ocurrir igualmente en sentido inverso para pacientes que han sido diagnosticados de «depresión» y no encontramos esa enfermedad de base, sino una enfermedad ansiosa.

Por todo esto vamos a considerar tres aspectos de esta relación entre ansiedad y depresión:

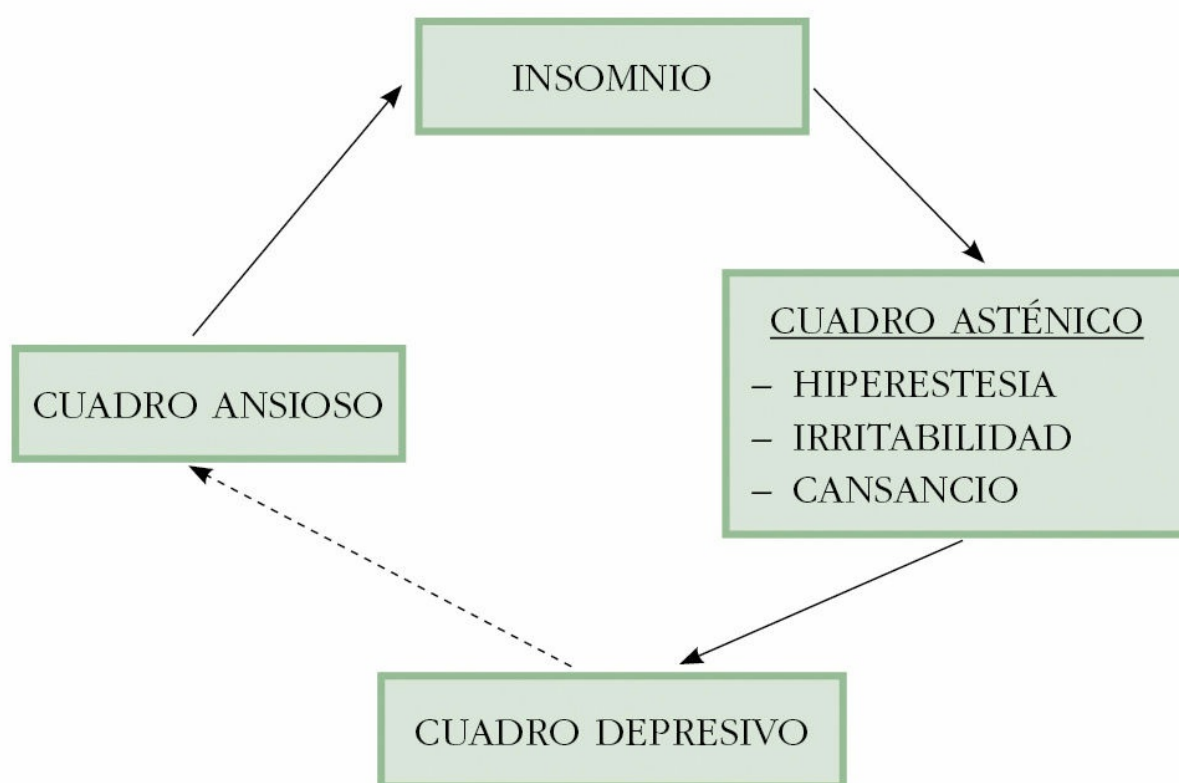
1. Cuando la enfermedad es realmente ansiosa y deriva con el tiempo hacia una depresión.
2. Cuando hay una enfermedad ansiosa que tiene además síntomas depresivos, pero no hay una depresión real. O, al contrario, cuando hay una enfermedad fundamentalmente depresiva que se acompaña de síntomas ansiosos.
3. Cuando ocurre que tenemos, ciertamente, a la vez un síndrome ansioso-depresivo, siendo válidos simultáneamente los dos diagnósticos. Dentro de este apartado tendremos en cuenta:
 - a) El trastorno mixto ansioso-depresivo.
 - b) La depresión ansiosa.

TABLA 7.1
Diez síntomas de la depresión

1. *Tristeza*. Normalmente expresada como desánimo, ganas de llorar.
2. *Anhedonia*. Significa pérdida de la capacidad de disfrute de las cosas. Pérdida de ilusión.
3. *Inhibición*. Disminución o pérdida de la disposición a realizar actividades. No es lo mismo que cansancio. En la inhibición el hecho de iniciar la actividad, aunque sea pequeña, se hace muy difícil o imposible.
4. *Astenia*. Significa cansancio. También se puede usar el término Adinamia.
5. *Anorexia*. Disminución o pérdida del apetito. Muchos pacientes depresivos comen «porque hay que comer», pero sin ese «apetecer» comer.
6. *Insomnio*. Puede ser insomnio de «inducción» (le cuesta conciliar el sueño),

«entrecortado» (está bien la inducción al sueño, pero luego se despierta muchas veces), o sueño «acortado» (insomnio de tercera fase) cuando duerme unas pocas horas, pero ya no vuelve a conciliar el sueño de nuevo.

7. *Mentismo (rumiaciones)*. Pensar constantemente sin parar sobre su estado, o sobre su futuro incierto o cosas del pasado que ahora se revela todo de forma negativa.
8. *Falta de proyecto de futuro*. El paciente depresivo vivencia el futuro «parado», sin futuro, habiendo desaparecido su proyecto vital.
9. *Hipobiotonía*. Muchas veces como mejor expresa el paciente depresivo su estado es como «falta de vitalidad».
10. *Dispatía* Vivencia de sentirse «fuera de lugar». No sintoniza con el ambiente, aunque sea agradable y/o familiar.



Tanto la ansiedad, como el insomnio, o un cuadro asténico, pueden desencadenar un cuadro depresivo.

Figura 7.1. CAAD (cuadro asténico-ansioso-depresivo) ([Descargar](#) o [imprimir](#))

7.1. CUANDO LA ENFERMEDAD ES REALMENTE ANSIOSA Y DERIVA CON EL TIEMPO HACIA UNA DEPRESIÓN

En muchas ocasiones, en un paciente que padece una enfermedad ansiosa, si ésta dura mucho tiempo, nos podemos encontrar, sobre todo si aparece insomnio, con que van apareciendo síntomas de agotamiento psíquico (astenia). Estos síntomas son, fundamentalmente, que molestan todos los ruidos (hiperestesia a ruidos), cefalea e

irritabilidad por mínimas cosas (paratimias irritables). Esta irritabilidad llama mucho la atención, pues aparece con demasiada frecuencia una reacción de mal genio, muchas veces explosiva, y los familiares —que si bien pueden comprender que se encuentre el paciente enfermo y ansioso— señalan como «todo le molesta, los ruidos del vecino, el televisor, etc.», y además, dicen, está «muy insoportable», por esa irascibilidad. A menudo, poco tiempo después ya aparecen los síntomas típicos de la depresión: inhibición, anhedonia, insomnio, anorexia... (véase tabla 7.1).

Coincidimos, por lo tanto, con la indicación que ya hizo F. Gersh en 1979, en el sentido de que algunos depresivos presentan un estado ansioso inicial que gradualmente evoluciona hacia una depresión grave.

Podríamos decir, sencillamente, que el estado de ansiedad e insomnio ha agotado al paciente haciéndole claudicar en un cuadro depresivo. Hemos hablado del cuadro ansioso-asténico-depresivo (CAAD) para referir cómo con frecuencia de una enfermedad ansiosa se pasa, al poco tiempo, a la depresiva. Dependiendo en qué momento de la evolución diagnostiquemos al paciente, lo haremos como ansiedad o como depresión. En la figura 7.1 vemos el esquema de este CAAD.

A continuación exponemos un caso clínico:

SVG es una mujer de 30 años y es de carácter tímido, introvertido y con genio fuerte. Es la hija menor. El padre es definido como «de carácter débil» y la madre como «de genio muy fuerte, dominante y posesiva, era la que mandaba en casa». De la hermana mayor dice «ha sido siempre como la madre». Durante la infancia, en la escolaridad, tiene muy buenos rendimientos pero muy mala sociabilización, «no tenía amigas, sólo compañeras» y además la madre no la dejaba salir a jugar con «las amigas» los fines de semana. Con 13 años (segunda metamorfosis de Conrad) se encontraba «acomplejada», ya que no salía «y mi hermana sí». Además tenía sobrepeso y «mi hermana me lo hacía notar, diciéndome que estaba gorda y a nadie le iba a gustar así, que mejor no saliese». Además, como era muy sensible, el padre también se metía con ella y desde pequeña le hacían gracia sus agobios: «como me impresionaba ver un pajarito muerto me traía pajaritos muertos; como me asustan los insectos, a lo más mínimo me tiraba insectos». Con 16 años tiene una primera amiga y con la influencia de ésta consigue salir más. Empieza a estudiar psicología y durante esa época sale con la amiga y una pandilla de amigos, relacionándose más. La amiga seguía siendo el vínculo fundamental en su relación con la pandilla. Cuando tiene 25 años ya empezó a trabajar. Cuando tiene 27 años se casa la amiga y ella vuelve a replegarse en su casa y aunque mantiene el trabajo apenas realiza relación social. Entonces le aparece la sintomatología ansiosa, encontrándose con fuerte sensación de tensión interna, temblor interno, palpitaciones, sensación de nudo en la garganta, opresión en el pecho, sensación de faltarle el aire «como si no se llenaran bien los pulmones», opresión o peso a nivel del estómago y dolores abdominales. Va al médico que le da tratamiento y mejora la sintomatología, permitiéndole seguir trabajando, pero aún se mantiene la ansiedad, aunque en menor grado, y se va instaurando un insomnio tanto de inducción (costándole más de una hora conciliar el

sueño) como entrecortado (despertándose a menudo por la noche). A los 6 meses de empezar el tratamiento psicofarmacológico ya nota también un dolor de cabeza que refiere como si tuviera «un casco» (cefalea en casco), todos los ruidos le molestan mucho (hiperestesia a ruidos) y está muy irritable, fundamentalmente en casa con los familiares, pero también en ocasiones no puede contener la irascibilidad en el trabajo (paratimias irritables). Cuando lleva tres meses con esta sintomatología ya claramente se puede identificar un cuadro depresivo, con tristeza y ganas de llorar, ideas de muerte, ha de dejar de trabajar, pasándose la mañana tumbada en el sofá y sin ilusión por nada, con gran dificultad de concentración: «Intento leer algo y no me entero de lo que he leído».

Comentario

Curiosamente en esta paciente, dada la falta de sociabilidad durante la infancia y la poca compensación que realiza durante la adolescencia, podríamos esperar que tuviera un riesgo mayor a descompensarse en otro tipo de enfermedad, como, por ejemplo, pudiera haber sido una esquizofrenia, pero no ha sido así. El aislamiento social y la boda de la amiga, vínculo de su sociabilidad que se rompe al casarse ésta, le desencadena una enfermedad ansiosa. Si el diagnóstico de la enfermedad lo hacemos en los primeros 8-9 meses, ciertamente, diagnosticaríamos un trastorno ansioso o una neurosis de ansiedad, pero unos meses después la sintomatología depresiva es tan evidente que el diagnóstico que ha de prevalecer es el de depresión.

* * *

Es más fácil que pacientes que padecen una enfermedad ansiosa puedan presentar en su evolución una depresión, que al contrario. En este sentido, R. E. Kendell estudió a 2.000 pacientes, detectando que en un 24% de los casos diagnosticados de ansiedad con el tiempo padecían también depresión, pero sólo en un 2% de los pacientes diagnosticados de depresión pasado tiempo se cambiaba el diagnóstico a ansiedad.

7.2. CUANDO HAY UNA ENFERMEDAD ANSIOSA Y SÍNTOMAS DEPRESIFORMES, PERO NO UNA DEPRESIÓN REAL

Realmente, uno de los problemas más frecuentes que tiene el médico de cabecera y otros compañeros médicos no especializados en psiquiatría es diferenciar entre el diagnóstico de depresión y el de ansiedad. A menudo los pacientes vienen diagnosticados de depresión y cuando hacemos un estudio más tranquilo y detallado⁷⁸ nos encontramos que la enfermedad fundamental es un síndrome ansioso aunque tenga síntomas «depresivos»; y al contrario, igualmente, pueden venir los pacientes diagnosticados de «ansiedad» cuando la sintomatología predominante es la

depresiva, aunque tenga también el paciente síntomas ansiosos. No digo ya cuando ante el dilema ansiedad o depresión, el paciente es diagnosticado de «síndrome ansioso-depresivo» para así no equivocarse en ninguna de las dos vertientes diagnósticas.

Tengamos claro que si la sintomatología depresiva es evidente, prevalecerá el diagnóstico de depresión sobre el de ansiedad, y por esto, aunque no lo podemos tomar como una norma absoluta, no obstante tengamos en cuenta que cuando el paciente padece inhibición, anhedonia y pérdida de proyecto del futuro, de manera evidente y continua, el diagnóstico que debemos pensar es el de depresión. Es decir, si a un paciente se le hace muy costoso hacer el trabajo diario, o no puede hacerlo, o se pasa gran parte del día en el sofá o en la cama o «hace lo mínimo» y con gran esfuerzo (inhibición) y al mismo tiempo ha perdido la capacidad de disfrute de las cosas que antes le ilusionaban (anhedonia), pensemos en la depresión. Pero en el caso, por ejemplo, de un paciente con síntomas ansiosos, que nos diga que se pasa todo el día en la cama, o que no puede realizar su actividad normal, pero que el fin de semana sale con familiares o amigos y lo pasa muy bien, o que cuando queda con un amigo durante la semana no le cuesta ir y lo pasa con buen disfrute, evidentemente no padecerá una enfermedad depresiva. La depresión es una enfermedad que no va a diferenciar entre sábados, domingos, y los otros días semanales. En este caso puede tratarse de un trastorno ansioso que le afecta bastante y le origina secundariamente una imposibilidad para hacer las actividades, y puede encontrarse triste..., y con síntomas «depresivos» pero no será una enfermedad depresiva; también puede tratarse de una enfermedad diferente a la ansiedad, evidentemente, como sería, por ejemplo, un trastorno de la personalidad con clínica ansiosa.

Por esto, muchos pacientes que padecen importantes síntomas de ansiedad expresan desánimo y alteraciones de su humor, pero no tendrán claramente síntomas importantes y mantenidos como los descritos de anhedonia, inhibición y pérdida de proyecto de futuro. Los estudios aportan un amplio espectro de entre el 25 y el 70% de los pacientes ansiosos que presentarán «síntomas» depresivos a lo largo de la evolución de su enfermedad. Y en la otra vertiente, entre el 75 y el 95% de los pacientes depresivos tienen síntomas ansiosos.

Los estudios en gemelos sugieren una independencia genética sustancial entre trastorno depresivo mayor y la mayoría de los trastornos de ansiedad (Kendler, 1995). Muy a menudo, las investigaciones internacionales han avalado la separación de estos cuadros como enfermedades diferentes. Como bien concluyen los estudios de Roth y cols. (1982), el análisis estadístico de los principales datos clínicos y de las escalas (cuestionarios y test) demuestran que los pacientes ansiosos y depresivos están claramente separados⁷⁹.

7.3. CUANDO OCURRE QUE TENEMOS UN SÍNDROME ANSIOSO-DEPRESIVO

a) El trastorno mixto ansioso-depresivo

El trastorno mixto ansioso-depresivo se ha incluido dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud Cie-10 (1992) como «otros trastornos de ansiedad», que tienen una intensidad clínica menos potente, por lo que se denominan «subumbrales» o subsindrómicos. Es decir, se van a caracterizar por malestar junto con otros síntomas de tipo depresivos y ansiosos, como dificultad de concentración, insomnio, fatiga, irritabilidad, preocupaciones, labilidad para el llanto, anticipación de lo peor, baja autoestima o pesimismo, pero que, como señala la Cie-10, son «síntomas ansiosos y depresivos de intensidad o número limitado sin predominio claro de unos o de otros [...] que no cumplen criterios de trastorno de ansiedad o depresivo». Son, pues, síntomas leves que se nutren de ambas alteraciones. Como bien señala L. Caballero, la clasificación americana DSM-IV lo incluyó cautelarmente en el grupo de trastornos cuya validez requiere más investigación; es decir, que son muy heterogéneos y no están nada claros.

Algunos de los focos de confusión, según J. Vallejo y R. Bataller, de muchas investigaciones que tratan sobre el binomio ansiedad-depresión son:

- Distinta significación de los conceptos de ansiedad y depresión, según culturas y grupos.
- Ansiedad y depresión son emociones complejas.
- Diferencias de los criterios diagnósticos empleados.
- Escaso control de variables como procedencia de los pacientes, sexo, momento evolutivo de la enfermedad, antecedentes familiares.
- No control de la personalidad, acontecimientos y soporte social.

Por lo tanto, seremos poco proclives en general a utilizar este diagnóstico, si no es imprescindible.

No obstante, no debemos minusvalorar este trastorno, fundamentalmente en atención primaria, ya que se asocia con una importante alteración social, un deterioro significativo de la actividad global e implica un mayor riesgo de padecer trastornos más graves, especialmente enfermedad ansiosa o depresiva.

En la revisión sobre este trastorno que realizan R. P. Cameron y A. F. Schatzberg señalan cómo muchos autores han documentado que este trastorno mixto origina un mayor uso de los servicios sanitarios y de morbilidad asociada (uso de medicamentos, alteración de la salud física y emocional, absentismo laboral). La mayoría de los estudios se han realizado, bien en centros de atención primaria, o estudiando a la población general. En un estudio (Zinarg, 1994) sobre 666 pacientes de atención primaria se encontró que un 11,7% tendrían este trastorno. En esta misma dirección hay otros muchos estudios. En uno de ellos, realizado por Stein y cols. en 1995 con 501 pacientes de atención primaria que negaban sufrir trastornos psiquiátricos en ese momento o recibir tratamiento psiquiátrico, se encontró que el 12,8% de los pacientes entrevistados satisfacían los criterios de este trastorno mixto, y se detectó en ellos una importante discapacidad global.

Basándose en distintos estudios señalan Cameron y Schatzberg como ventajas de

que exista este diagnóstico:

1. El trastorno mixto ansioso-depresivo se ve en el marco de atención primaria sobre todo porque los pacientes ansiosos y deprimidos tienden a pedir ayuda por sus síntomas somáticos al médico. El reconocimiento de este grupo de pacientes puede permitir al médico saber quiénes precisan intervención y reducir el uso excesivo o insuficiente de los servicios sanitarios.
2. El trastorno mixto ansioso-depresivo podría representar una fase prodrómica (es decir, previa) o residual de un trastorno más grave, de modo que el reconocimiento de este grupo de riesgo facilitaría la adopción de medidas de prevención secundaria.

Aunque también refieren estos autores algunos inconvenientes, como que fuera un cajón de sastre que desincentivara un diagnóstico más cuidadoso. Esto obstaculizaría, en última instancia, la investigación y disminuiría el reconocimiento de la depresión mayor y de otros diagnósticos que requieren una intervención inmediata decidida y específica. Otros autores argumentan, en esencia, que habría que poner más énfasis en la separación entre los pacientes ansiosos y deprimidos que en su agrupación dentro de una misma categoría.

La discusión y polémica se mantiene en relación con este diagnóstico, aunque quizá aún resiste bien en las clasificaciones actuales, pues «aunque la información sobre la distribución por sexos, la edad de inicio, la cronicidad, la evolución y el tratamiento escasea o falta [...] no obstante brinda en principio la oportunidad para caracterizar a un grupo con malestar y deterioro que, en este momento, no recibe la atención adecuada» (Cameron y Schatzberg).

b) La depresión ansiosa

El conjunto ansiedad-depresión, no sólo como unión de síntomas (por ejemplo tengo una enfermedad depresiva y también síntomas de ansiedad; o al contrario, tengo una enfermedad ansiosa y asimismo síntomas depresiógenos), sino como dos diagnósticos ciertos, a la vez, en el mismo paciente, es poco habitual aunque en las personas de la tercera edad es más frecuente, y como señala F. Alonso Fernández (1979), en estos casos «el enfermo solloza, se mesa los cabellos pasea continuamente, quizá se autoagrede y sus “ayes” son incesantes».

En general, no nos gusta que se utilice este diagnóstico de «depresión ansiosa», al igual que comentábamos con el síndrome mixto ansioso-depresivo, como *cul de sac* (fondo de saco) que excusa no saber bien diagnosticar ninguna de ambas patologías. El que haya riesgo de un uso inadecuado no quiere decir que no exista esta patología en la que la intensidad de la sintomatología depresiva es tal que no podemos evitar el diagnóstico de depresión y al mismo tiempo la intensidad y gravedad de la sintomatología ansiosa, incluso con crisis agudas de ansiedad, es así mismo tan intensa que es inevitable unir el diagnóstico de ansiedad. Por esto se habló de depresión ansiosa en estos casos, poco frecuentes, pero muy llamativos e impactantes

cuando aparecen.

Como señala H. Weitbrecht, en estos pacientes muy deprimidos aparece una laboriosidad angustiosa, inquieta. Los enfermos no se pueden estar quietos un momento, van sin cesar de un lado a otro, de la silla a la puerta, de la cama a la ventana y cuando agotados se sientan un rato oscilan inquietos a un lado y a otro. Muchas veces se deshilachan los vestidos, se arrancan los cabellos y se quejan sin cesar. Se habla en estos casos, sigue Weitbrecht, de depresión agitada, en ellos hay una perplejidad angustiosa. El paciente no está quieto un momento y el poder descargarse a través de la motilidad le alivia la angustia. En el período involutivo, las tentativas de suicidio de enfermos de estas edades, con depresiones agitadas, se caracterizan a menudo por una forma impactante. El método de elección muchas veces no es la pastilla, sino el cuchillo, la soga, el atropello por una locomotora, etc.

K. Leonhard habló de psicosis angustiosas, y en un caso describe cómo la paciente estaba siempre intranquila, incapaz por esta intranquilidad de dedicarse a una ocupación ordenada; las quejas sobre los mismos motivos persistían inagotablemente. La paciente se quedaba toda una noche sentada encima de un montón de leña gritando continuamente «matadme, matadme». Una conversación con la enferma resultaba imposible, porque repetía sus reproches constantemente en vez de contestar y cortaba las preguntas con la frase «ahora es demasiado tarde».

Veamos un caso clínico:

L. S. V. es una mujer de 62 años. Su carácter ha sido siempre muy activo, de genio fuerte, ordenado, meticulado, muy responsable y cumplidor. Es la hija menor, teniendo una hermana cinco años mayor que ella. Se casó con 28 años, tiene tres hijos y ha llevado bien, sin problemas, la casa y las obligaciones de crianza de los hijos. Siempre ha sido muy activa trabajando en casas limpiando y también trabajando en su casa en confección. El cuadro clínico aparece a partir de que una vecina de su finca le expone que quería comprarle un piso que ella tenía deshabitado y le ofrece una cantidad aceptable de dinero; ella le dice que es posible que se lo venda pero que se lo va a comentar a sus hijos. Éstos deciden no vender el piso, pues no necesitan, ni ellos ni los padres, ese dinero. A partir de ese momento empieza a agobiarse pensando constantemente, sin parar, que no habría cumplido bien con la vecina al haberle dado esperanzas (mentismo), apareciendo insomnio intenso, sin apenas dormir por las noches, y apenas transcurridos quince días ya no es capaz de realizar la faena de casa, se encuentra muy triste y se pasa casi todo el día tumbada en el sofá (inhibición) mordiéndose las manos, o paseando por la casa sin parar (inquietud acatísica), y diciendo que tiene temblor y un peso en el pecho y falta el aire y que algo le «corre por la cabeza y los pelos»; en el estómago nota una sensación de peso que denomina «aleteo». Apenas habla (mutismo, hipofemia), o sólo repite con mucha frecuencia «ay, me he portado mal» (perseverancia temática), con muchos sentimientos de culpa. Un día que predominó mucho la inquietud y el constantemente estar diciendo ese ¡ay, me he portado mal! la llevaron a urgencias, en donde le dieron un tranquilizante. No ve la televisión y nada le hace disfrutar (anhedonia) y ha

perdido el apetito (anorexia). Piensa que no tienen dinero para pagar la contribución ni el agua, y apaga la estufa, pues está segura de que no tienen dinero para pagar el butano o la luz (delirio de ruina). También tiene miedo a que la vecina les «haga algo» a sus hijos o a algún familiar, por no haberle vendido el piso (delirio de perjuicio). Pasado un mes y medio de encontrarse así se autolesionó el brazo pegándose contra un mueble y se lesionó la muñeca; ha intentado suicidarse ahorcándose con el cordel del cabestrillo de la puerta. No sale a la calle por miedo a encontrarse con la vecina.

Comentario

En este caso, el cuadro clínico depresivo es evidente, padeciendo síntomas muy importantes como inhibición, anhedonia, insomnio, anorexia, delirio de ruina y de perjuicio, ideas e intento de suicidio, ideas de culpa... y asimismo, la ansiedad es tan intensa que incluso, debido a la misma, ha tenido que acudir en una ocasión a urgencias; dentro de los síntomas ansiosos, ese ¡ay, me he portado mal!, y la inquietud acatísica, sin parar de moverse, junto a la ansiedad somatizada en estómago y en tórax con sensación de falta de aire... es en conjunto tan elevada que tenemos que unir los dos diagnósticos y decir que es una depresión ansiosa o angustiosa.

Otro caso clínico muy ilustrativo, es el presentado por J. J. López Ibor⁸⁰:

A. G. S., 28 años, casada, sin hijos y sin antecedentes patológicos previos. Diez meses antes de consultar a visita había fallecido su padre y ella se preocupó por la suerte de su madre y hermanos. Cuatro meses después de fallecer el padre empieza a notar «espasmos en estómago que me impedían comer, unidos a una gran nerviosidad». Siente desmayo sin llegar a desmayarse nunca; gran frialdad de pies y manos, entrándole después un estado de nerviosidad y como un estremecimiento generalizado. A veces todo este estado nervioso acaba en una diarrea. Al principio, estos estados le asaltaban cada quince días. Luego han sido más frecuentes hasta llegar a ser casi diarios. Actualmente vive en continuo pánico a que le repitan esos estados, por lo que tiene que estar continuamente acompañada. Ha estado sin comer algunos días por el mismo pánico. Adelgazamiento. El pánico es indefinible, es miedo a que le dé algo o perder la cabeza. Se siente triste sin saber por qué; todo lo ve oscuro, tiene continuas ganas de llorar. Habla poco, está retraída. Reconoce que no tiene, en el momento actual, motivos para su tristeza. Ésta le viene no sabe de qué. En casa no puede estar, ha de estar siempre fuera, pero acompañada. Cansancio y sueño, pero se mete en la cama y no duerme. Palpitaciones, se inquieta por nada, da muchas vueltas a las cosas, se siente enormemente pesimista, todo lo ve grande y difícil, desproporcionado a como lo es objetivamente

Es muy importante que se realice correctamente el diagnóstico de esta enfermedad, pues, como señalan J. Vallejo y R. Bataller, la depresión con crisis agudas de ansiedad (crisis de angustia) es un subtipo de depresión con mayor

tendencia a la cronicidad y peor respuesta terapéutica que los cuadros depresivos puros, y también tienen peor pronóstico que los trastornos de angustia aislados⁸¹. Por esto es importante concretar bien el diagnóstico de «depresión ansiosa» por su valor pronóstico, ya que, como también revela F. Alonso Fernández (1979), es una de las formas de depresión sobreaguda que implica un riesgo de suicidio elevado.

Evidentemente, diagnosticar bien va a suponer tener mejor perspectiva sobre el pronóstico y por supuesto realizar un tratamiento más adecuado de la enfermedad real que padece el paciente. Realizar diagnósticos rápidos y «cómodos» también puede suponer, desgraciadamente, mantener al paciente con su «incómoda» enfermedad de forma más duradera.

El médico, es un ser-ahí ante otro ser-ahí, que ha de tener tiempo para poder saber y conocer la patología distintiva de cada paciente y así plantear un tratamiento que siempre será, asimismo, personal.

El tratamiento peculiar del hombre con ansiedad y/o depresión no estará sólo en dar medicación —fácilmente con antidepresivos y/o ansiolíticos—, sino que ha de surgir desde el diagnóstico acertado de la enfermedad individual, histórica, insustituible.

NOTAS

⁷⁸ Tenemos que admitir que en algún sistema sanitario el tiempo de que dispone el médico de cabecera para atender a los pacientes es tan corto que ya es un verdadero milagro y un ejemplo magnífico del arte y sabiduría médica el que consigan detectar estos síndromes, que a veces el paciente expresa de forma muy difusa y no tan concretamente como puede ser el caso de un dolor de tobillo. Aun así, la falta de tiempo, aunque sea real, es un problema del sistema sanitario en cuestión, pero no debe ser una excusa para no ejercer adecuadamente nuestra profesión. El médico es siempre «médico» y no «médico de...» tal o cual institución o empresa. Estas instituciones o empresas nos contratan para que ejerzamos nuestra profesión (con nuestras responsabilidades); no para que nos transformemos en una nueva clase de asistente de la salud, identificado con directrices más o menos burocráticas o estructurales.

⁷⁹ Aunque, como indica S. A. Montgomery, en psiquiatría una de las áreas en las que ha habido menos acuerdo es entre los «agrupadores» —que son partidarios de un continuo de enfermedad ansiedad/depresión— y los «separadores» —que separan ambas enfermedades—. Este autor apoya la idea de que hay un «desorden subyacente» común a ambas enfermedades, y por esto señala que «en algunos casos la ansiedad es una forma de depresión o es una característica prodromal (es decir, malestar previo) de un desorden depresivo en desarrollo». Esto nos recuerda a la timopatía ansiosa (ver capítulo 3) de la que ya habla López Ibor cuando dice: «Reconocer que las neurosis son, en cierto sentido, enfermedades del ánimo» (timosis); las neurosis son estados de ánimo patológicos (*Las neurosis como enfermedades del ánimo*).

⁸⁰ Extraído de forma resumida del libro de J. J. López Ibor *La angustia vital*.

⁸¹ Incluso Oswald Bumke, en la edición española de 1946 de su *Nuevo tratado de enfermedades mentales*, ya señalaba el mal pronóstico de estas depresiones en la edad senil: «La enfermedad deja tras sí —y éste es el caso más frecuente— un estado de debilidad depresivo, con desaliento y un temple angustioso-hipocondríaco».

8. LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS EN LA SOCIEDAD ACTUAL. ANSIEDAD Y TRABAJO

«No hay más que trabajo, trabajo y trabajo. Si un individuo fue arrojado siendo niño desde la ventana de un tren y quedó lisiado para toda la vida, se lamentará principalmente porque quedó incapacitado para trabajar.»

E. FROMM.

No solemos darnos cuenta cuando hablamos de ansiedad y estrés en la sociedad actual o en la vida industrial moderna que, generalmente, estamos excluyendo la mayor parte del mundo en donde lo normal es la inanición o la lucha por la subsistencia básica, con o sin trabajo.

Pero cuando nos referimos a los países desarrollados o en vía de desarrollo «competitivos» (bendita y a la vez inicua palabra) podemos decir, entonces, que generalmente trabajamos «como locos», y malo es si no trabajamos o trabajamos poco. Hay un refrán que dice: «la inteligencia está muy bien repartida porque todo el mundo está contento con la que tiene», y algo parecido podemos aplicar al trabajo; trabajaremos bien o mal pero cada uno considera que, a su modo, mucho es lo que trabaja. No conozco a nadie que, en edad laboral ejerciendo un trabajo, me haya dicho que él trabaja poco.

El problema no va a ser cuánto trabajamos, sino más bien si la repercusión del trabajo —esa actividad a la que le dedicamos seguramente más de ocho horas diarias— nos origina por su exceso o por sus condiciones o circunstancias una enfermedad.

Como dice López Ibor (1966), «la idea que en cada época se va cuajando depende de su clima histórico». Si el hombre del Renacimiento se medía por la «virtud» y el de la época caballerescas por el honor, el hombre moderno se mide por la eficacia. He aquí unas palabras mágicas para nuestro tiempo: eficacia, trabajo, rendimiento. El hombre actualmente vive sometido a las leyes penosas del esfuerzo continuado y, sigue comentando este autor, a Ford le preguntaron una vez por qué seguía ampliando su negocio y lanzando nuevos tipos, y contestó que era porque no podía parar. Y éste es el tormento moderno. El hombre tecnificado tendrá una actividad externa mayor, pero la intrínseca es evidentemente menor. Por eso no encuentra satisfacción en su trabajo o en su quehacer cotidiano que le aburre o hastía.

En este sentido, Karen Horney señala una serie de factores importantes para que aparezca una enfermedad ansiosa: carácter competitivo de la sociedad, creación de necesidades siempre nuevas (cada vez queremos tener más cosas), limitación en las posibilidades de tener todas las cosas que queremos y al mismo tiempo se nos enfatiza la libertad individual que, en teoría, disfrutamos para poder elegir. A esta

lista añade Van der Verg el conformismo psíquico de las personas en nuestro tiempo.

Asimismo, Rojo Sierra (1962, 1975) indica cómo todo se ha hecho artificioso en esta sociedad patológica; la charla insignificante ha sustituido al lenguaje comunicativo, la sonrisa afectada ha reemplazado a la verdadera risa y la angustia se oculta en el disfrute de cosas materiales. Una ola de perplejidad atosiga a nuestro mundo, y como la perplejidad es angustiosa y la angustia provoca inquietud, esta inquietud interior te hace vagar buscando infructuosamente algo que no encuentras: el hombre está perdido por fuera y por dentro; cuando mira al mundo, a la sociedad, a la política, todo esto le parece absurdo; cuando se mira a sí mismo se siente incomunicado, vacío, impotente, perplejo.

Soledad, ansiedad e incertidumbre son las características de nuestro tiempo crítico. Por esto, no es de extrañar que para evitar esta ansiedad, esta angustia y perplejidad, el ser humano busque a veces en la sabiduría oriental, en la magia, en el ocultismo e incluso en sectas un sentido existencial. En otras ocasiones su postura es de protesta o rebeldía contra la estructura cultural y social existente, contra los convencionalismos, y muy a menudo se impregna de la esperanza de la técnica como soporte de las tremendas tensiones a las que se halla sometido y entonces se hace funcionario del trabajo mecanizado, y se identifica con el ritmo productivo máximo: estar siempre ocupado haciendo y haciendo cosas o actividades laborales continuas y medibles.

Cuántas y cuántas personas arrastradas por la vorágine del día a día, por el estrés del trabajo y de la vida cotidiana, no tienen «tiempo» para dedicarse a evolucionar en su *autenticidad*, sino que están preferentemente preocupadas por lo que pueden aparentar a los ojos ajenos, vivenciando que el hombre afortunado es el que ostenta un considerable lujo y posición social. Entonces prevalece el individualismo, las metas individuales de tener cosas, propiedades y posiciones propias y palidece el interés nostral (es decir, el interés por el conjunto de los «otros», de los demás)⁸².

La técnica ha sido un poder mágico que si bien al principio estaba al servicio del hombre, ahora se ha apoderado de éste. Le ha creado nuevas exigencias y necesidades de las que depende tanto que ya sin ellas no puede vivir y además está deformando su existencia misma. Como señala J. J. Groen, los animales que realizan trabajos «técnicos» como es el caso de las arañas, las hormigas o las abejas, al ser movidos por impulsos de nutrición y generación, reciben, al final, su compensación porque pueden materializar esos impulsos (alimentarse, reproducirse). Pero no es así en el hombre moderno, ya que carece de ese incentivo. No trabaja para cumplir necesidades biológicas, sino para un mercado y para unos clientes del mercado que le son ajenos. El hombre moderno ha sido definitivamente alejado de su trabajo y éste no le aporta el aspecto comunicativo que debería tener. La realización del trabajo en la vida actual está fundamentalmente condicionada por el dinero o por la sanción (si uno no cumple con el trabajo).

La lucha continua contra la monotonía, contra el peligro de ser disuelto en el anonimato (somos un número en la empresa, uno más muchas veces desconocido por los altos cargos de la misma), origina un sobreesfuerzo continuo, tanto a nivel psíquico como biológico, un estrés continuo que nos conducen a lo que Rof Carballo

denominó «el cansancio de la vida».

Cansado, desorientado e insatisfecho de la vida, con rivalidad laboral, competición con tareas monótonas, repetidas y anónimas, el trabajador insatisfecho y angustiado percibe su labor como injusta o desprovista de sentido personal, y debido a esta alienación⁸³, se transforma en una «cosa entre las cosas», en una pieza de engranaje.

Desgraciadamente, el desarrollo económico no se ha planteado pensando en las posibilidades humanas, sino sólo desde el punto de vista de conseguir un mayor bienestar material. Si bien la clásica definición de economía de Lionel Robbins (1932), «economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos», ya señalaba de forma directa que lo que se estudia era la conducta humana, no obstante, como indicó el economista M. Sigüenza, la política económica —y laboral— ha estado abierta a oír fundamentalmente a políticos (en sus distintas modalidades) y a hombres de negocios, perpetuando formas de sociedad que actúan patológicamente sobre sus miembros y apenas ha reparado, de forma efectiva, en las poderosas fuentes de carácter no racional de la conducta humana. Para no ser víctimas del desarrollo económico es necesario incluir el factor humano participante de la dinámica social.

El trabajo es una conducta humana, insiste también M. Yela (1977), y como conducta humana consiste en una actividad en la que alguien produce algo con otros. El trabajo productivo lo hace alguien, una persona, y será eficaz si permite y facilita la expresión de su personalidad. La ausencia o deterioro del valor personal del trabajo conduce al quebranto de la productividad y al enfrentamiento de los grupos.

Por esto, E. Fromm (1955) considera que una sociedad sana es aquella que responde a las necesidades objetivas humanas y se pregunta «¿[...] cuál sería la estructura de una sociedad sana?». En primer lugar, en ésta ningún hombre sería un medio para los fines de otro hombre, sino siempre y sin excepción un fin en sí mismo, y por lo tanto nadie sería usado ni se usaría a sí mismo con propósitos que no fueran los del desenvolvimiento de sus propias potencias humanas; en donde el hombre sea el centro de todas las actividades económicas y políticas... una sociedad que promueva la actividad productiva de cada uno en su trabajo.

Pero Rof Carballo (1977) insiste en que los diversos métodos que se han realizado para convertir el trabajo-servidumbre en trabajo-misión o trabajo-creación no suponen, las mayoría de las veces, otra cosa que disimulados esfuerzos para hacer que el rendimiento del trabajo aumente y por lo tanto el beneficio de la empresa. «Nuestros clientes serán mejor servidos si los trabajadores son felices, y esto dará mas dólares y centavos a la dirección», decía un experto a mil quinientos directivos de supermercados; el trabajador rinde más, y da más beneficio si es feliz⁸⁴. Realmente, sigue diciendo Rof, el estrés del trabajo sólo desaparece plenamente cuando el hombre siente que éste «aumenta» su condición humana y que le sirve para que en él se desplieguen posibilidades de crecimiento y creación.

Todo esto está muy bien, pero ¿qué vemos en la clínica psiquiátrica actual? Cada vez más y más enfermos que tienen de fondo un gran estrés y una fuerte presión laboral, y que muy a menudo no han conseguido mantener su salud psíquica al no ser

capaces de insensibilizarse a la imposición emocional existente en su trabajo (¿es necesario ser insensibles para poder sobrevivir con salud en el trabajo?), al no haber conseguido ser entes autómatas laborales o velocistas productivos de primera magnitud. Como ocurre con la anécdota atribuida a Henry Ford cuando un día gritaba furioso: «¡Cuando lo que necesito son dos buenos brazos para apretar tuercas, me mandan una persona! ¿Y para qué necesito una persona?».

Recuerdo que allá por los años ochenta nos llamaba la atención, ya que era muy poco frecuente, cuando un paciente venía expresando una situación laboral tan angustiante que le había originado una enfermedad, generalmente ansiosa. Esto hoy en día, por desgracia, lo podemos constatar en la clínica diaria varias veces cada mes, cuando no, aún peor, resulta que además nos encontremos con un problema de acoso laboral.

Ya comentábamos al principio de este capítulo que al decir de López Ibor, «la idea que en cada época se va cuajando depende de su clima histórico», y de forma muy parecida, en lo que nos atañe a los médicos, apunta Rof Carballo cómo la medicina arrastrada por el espíritu de la época y en cierto modo engañada por el inmenso poder de la ciencia natural se ha convertido cada vez más en una «tecnomedicina» que no percibe que de manera sutil se está produciendo un fenómeno singular gravísimo: tanto el trabajo humano como la enfermedad del hombre, como lo que el médico llama «curación», cada vez más se institucionalizan. La costosísima medicina del seguro de enfermedad, sigue diciendo Rof, se contenta con aliviar —en forma laudabilísima y maravillosa— la situación catastrófica o el síntoma... y los estudios médicos actuales deshabitúan cada vez más al estudiante del interés por el hombre como tal hombre y le concentran en «su papel de mecánico del cuerpo».

Cuántas y cuántas veces hemos tenido que tranquilizar a los pacientes porque tras ser visitados por «el control» que de su baja laboral realizan las mutuas u otros sistemas de inspección, lo primero que le han dicho es que «ya estaban para trabajar» o que «no era para tanto» o les culpabilizaban «de estar mucho tiempo de baja». En más de una ocasión el paciente deprimido o ansioso me ha llegado con un estado de gran alteración y sin haber dormido varios días tras su «entrevista con el médico» de control de bajas. Recuerdo en una ocasión una paciente, con grave depresión, que tras esa entrevista «médica de control», y después con una psicóloga del mismo equipo, la angustia era tan elevada y los sentimientos de culpa tan altos «por estar de baja» que le habían aparecido graves ideas de suicidio. Tan acusado empeoramiento me obligó a tener que escribir a los responsables de los «controles de la baja», indicándoles que estaban poniendo en peligro la vida de la paciente.

La burocratización de la medicina es un reflejo de la burocratización de la sociedad y, como señala E. Fromm, los burócratas son especialistas en la administración de cosas y de hombres. Debido a la grandeza del aparato que hay que administrar y de que es necesario hacer una abstracción, la relación de los burócratas con las personas es de enajenación total. Evidentemente, si no fuera por los burócratas, todo se haría pedazos, pero, como dijo Max, «el burócrata se relaciona con el mundo como con un mero *objeto* de su actividad».

Mas, necesariamente, tenemos que preguntarnos: ¿queremos simplemente que el paciente «mejore» para que sea capaz de volver a trabajar y estrictamente cumpla su tarea como un «robot», o queremos que la cumpla digna y humanamente de forma creadora, integrada en su historicidad?

Si el trabajo no se integra de forma creadora en la historicidad del sujeto, ¿cómo se van a soportar las situaciones laborales de significativo estrés? Así por ejemplo, en el caso de los trabajos con turnos, señalan Campbell y Singer, que los ritmos corporales tardan un largo tiempo en adaptarse a un nuevo ciclo-horario. En estos casos debido a la existencia de días intermedios de descanso nunca se ajusta al nuevo ciclo y está el trabajador en un estado de permanente desfase. Ha de realizar tareas que exigen atención cuando la hormona activadora adrenalina es baja y entonces la capacidad de concentración del trabajador está reducida. Cuando el estrés del trabajador con turnos se suma al producido por la automatización, entonces la atención y la capacidad de tomar decisiones son mínimas y el coste fisiológico aumenta. El incremento crónico de los costes fisiológicos originará efectos nocivos en la calidad de vida y en la salud.

En estas circunstancias el apoyo familiar y la vivencia del trabajo como un activo productivo en el proyecto vital y de individuación, minimizarán los efectos perjudiciales. Así se comprobó en un estudio comparativo de tres grupos de japoneses: el primer grupo vivía en Japón, otro en Estados Unidos y otro en Hawai. El estudio demostró una mayor incidencia de enfermedades coronarias (cardiopatías) entre los japoneses residentes en el continente americano respecto al grupo que vivía en Japón, situándose en un punto intermedio el grupo de Hawai. Ni la dieta ni las presiones laborales influyeron, sino que fundamentalmente la mayor unidad de la cultura japonesa manifiesta en el hogar y en la estructura familiar típica que se da incluso en las grandes empresas, originó una vivencia de «apoyo» que fue el factor compensador del estrés laboral.

La propuesta sueca, citada por Spillane, da prioridad a la valoración del *ambiente laboral* para evitar la enfermedad:

1. El trabajo debe ser dispuesto de manera que permita a cada trabajador individual incidir en su propia situación laboral, sus métodos y sus ritmos de trabajo.
2. El trabajo debe ser dispuesto de manera que permita una visión completa y una comprensión de los procesos de producción en su conjunto.
3. El trabajo debe ser dispuesto de manera que permita a cada trabajador usar y desarrollar todos sus recursos humanos.
4. El trabajo debe ser dispuesto de manera que permita a cada trabajador los contactos humanos y la cooperación en el curso del trabajo.

Y no nos olvidemos de una última especialmente importante:

5. El trabajo debe ser dispuesto de manera que permita a cada trabajador cumplir satisfactoriamente sus compromisos y obligaciones ajenos al trabajo, como

pueden ser la familia, los objetivos sociales, actividades lúdicas, relaciones satisfactorias interpersonales, etc.

Cuántas veces y veces nos encontramos con pacientes que llegan a casa y su capacidad en el hogar es «sólo para poder descansar del trabajo» y estar en condiciones de poder volver a trabajar. A más de un paciente cuando le hemos preguntado qué hace los fines de semana, nos indica que sólo descansar para poder seguir trabajando el lunes siguiente. Recuerdo un paciente joven, de 26 años, soltero, que recién entrado en una empresa para llevar la dirección de una de las secciones vino a la visita psiquiátrica porque el problema que tenía era que no podía levantarse los sábados por las mañanas para quedar con sus amigos habituales tal como había tenido por costumbre. Pensaba que podría ser una enfermedad. Cuando analizamos lo que le ocurría, detectamos que se levantaba a las 6 am, para empezar a trabajar en la empresa a las 7 de la mañana y que terminaba su trabajo —del que se sentía muy responsabilizado, más en cuanto que consideraba una gran oportunidad haber tenido ese puesto de dirección en una empresa siendo él tan joven— hacia las 9 de la noche y a veces hasta las 10 pm. Por esto apenas tenía tiempo para cenar y dormir. Lo que le ocurría era que llegaba tan cansado al fin de semana que le era imposible levantarse el sábado y hacer sus actividades relacionales ese día por el agotamiento que padecía. Lógicamente descansando todo el fin de semana, el lunes ya estaba recuperado para trabajar perfectamente de nuevo.

Podemos decir en este caso que el paciente no tenía una grave enfermedad psiquiátrica, pero sí estaba «enfermo», al padecer lo que podríamos llamar una sofropatía⁸⁵, al estar aherrojado (oprimido, subyugado) por su destino amenazante.

Y por esto el psiquiatra cuando cura una enfermedad está actuando como transformador humano, es decir, no sólo le va a interesar que desaparezcan los síntomas, sino que asimismo promueve un salto cualitativo humanizador. Ayuda en la individuación del paciente. En el caso precedente la misión psiquiátrica no sólo sería mejorar el cansancio y el sueño, sino que en este paciente, al igual que en las personas estresadas por el trabajo, además de hacer desaparecer la ansiedad y los otros síntomas que pueda sufrir, hemos de ayudarlo en el planteamiento de un nuevo estilo de vida que le acerque al equilibrio familiar y social; en definitiva, a la estabilidad de la frónesis que nos referíamos anteriormente.

* * *

Veamos a continuación dos situaciones especiales que son necesarias comentar: una en relación con los altos ejecutivos y otra en relación con el acoso laboral o *mobbing*.

a) *En primer lugar* hay también un tipo especial de estrés y ansiedad laboral que ha sido tradicionalmente muy poco reconocido en el alto ejecutivo. Y no voy a referirme a la vida estresante de estos altos y cualificados puestos laborales, hiperactivos en la consecución de las metas y objetivos que la empresa o la estructura

económica exige⁸⁶; no, me refiero a que se ha creado un nuevo tipo de hombre que podíamos denominar «homo eutímico». La palabra eutimia proviene del griego *eu* y *tymós*, y significa equilibrado, mente estable, y estos profesionales que ocupan altos cargos «tienen la obligación» de mantenerse equilibrados, con su «mente estable», ya que en caso contrario son apartados y ya no se confía en ellos. En muchas ocasiones estas personas han acudido con un trastorno ansioso o depresivo y han pedido que se les mejore lo antes posible, pues o bien no pueden faltar al trabajo o, si no les era posible disimular su estado, han tenido que darse de baja laboral con un diagnóstico de enfermedad física, corporal, ya sea una gripe, un lumbago o algo parecido, «pero nunca», insisten, se les ponga en la baja ansiedad o depresión. «Ya me ha fastidiado», me comentaba una mujer ejecutiva cuando al pedirle la baja a su médico de cabecera éste le puso «trastorno ansioso-depresivo». Este alto ejecutivo, este homo eutímico, padece una doble ansiedad: por una parte, la propia del trabajo, y por otra, además, la de no poderse poner enfermo «de la psique» y ha de mantener una constante ansiedad, angustia y tensión por la necesidad de aparentar su «mente estable y pura» de toda contaminación por una posible «locura» que le apartaría de su nivel laboral.

Como señala J. Guimó en su libro sobre los prejuicios contra la psiquiatría, el prejuicio deriva del temor a que el otro ser humano «diferente» psíquicamente actúe de forma descontrolada.

Aunque parezca increíble, tenemos que hablar de un derecho a poder padecer una enfermedad mental al igual que cualquier otra enfermedad humana.

Quienes provienen de una clase social más alta o han tenido mayor educación desarrollan, generalmente, mejor aceptación de la enfermedad mental. Pero en el caso de los altos ejecutivos, sus jefes, personas a las que se les supone bien formadas y capacitadas, son las primeras en discriminar y apartar a un compañero enfermo psíquico. Quizá, como señala Guimó, el problema para modificar estos prejuicios que originan una «distancia social» sea que no conseguimos cambiar el fondo afectivo que muy frecuentemente es inconsistente con el componente cognoscitivo. En otras palabras, personas que desarrollan altos niveles ejecutivos en las organizaciones laborales, si bien «saben» que no se debe discriminar a compañeros por una alteración mental (que puede también sea padecida por algún familiar de ellos mismos), no obstante aún mantienen un estado afectivo, un valor, de considerarlos «sin control» en su capacidad y decisiones. La estigmatización de los pacientes, sigue comentando Guimó, estará estrechamente relacionada con la utilización metafórica de la enfermedad, considerada como vergonzante y extraña. Vergüenza y extrañeza son metáforas que estigmatizan y violan la identidad de aquellos que la padecen. Y una vez etiquetada la persona, es discriminada al intentar volver a su antiguo estatus.

b) En segundo lugar tenemos que hablar del acoso laboral, también llamado *mobbing*⁸⁷.

En el contexto laboral fue utilizado por primera vez por el psicólogo y psiquiatra alemán, nacionalizado sueco, Heinz Leymann (1990) durante un congreso sobre higiene y seguridad en el trabajo: el *mobbing* o terror psicológico en el ámbito

laboral, dice Leymann, consiste en la comunicación hostil y sin ética, dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra otro, que es así arrastrado a una posición de indefensión. Estas actividades tienen lugar de manera frecuente (al menos una vez a la semana) y durante largo tiempo (por lo menos seis meses). A causa de esta conducta hostil, este maltrato origina una considerable miseria mental, psicosomática y social en el trabajador.

Por lo tanto, el *mobbing* supone, tal como resume D. Huertas:

- Una estrategia premeditada de maltrato psicológico para derrumbar psicológicamente a la víctima y lograr que abandone la empresa o se someta a los agresores.
- Se ejecuta sistemáticamente (al menos una vez por semana) y de forma sostenida en el tiempo (más de seis meses) por uno o más acusadores (*gang* o grupo instigador).
- El asedio es sutil, evita la agresión manifiesta, se ejerce de forma lenta y taimada y utiliza los métodos más corrosivos que posee el ser humano: la humillación, la descalificación del trabajo realizado, la asignación de tareas inalcanzables o ínfimas, la burla sobre la vida personal o las convicciones propias y la exclusión del grupo.
- Habitualmente, los compañeros de la víctima callan y se convierten en cómplices por el miedo a sufrir el mismo destino.
- La técnica de acoso es muy similar a la empleada en la caza o la lidia taurina: asediar a la presa hasta agotar sus fuerzas y finalmente darle muerte. Los instigadores utilizan mecanismos similares, sólo que el objetivo es la caída mental del agredido⁸⁸.
- Los factores que ponen en marcha la caza son variables: negarse a participar en actuaciones ilícitas, justificar un despido improcedente, colocar en el puesto del acosado a otro trabajador más afín, forzar una jubilación anticipada, conseguir que se vaya por las «buenas» y la empresa se pueda ahorrar el coste del despido, y en el caso de mujeres ante la negativa a propuestas de tipo sexual.
- El acoso laboral lo dirige un líder, al que sigue el *gang* de instigadores que se sienten amparados por el primero. Puede ser de tipo horizontal (entre puestos de categoría similar), ascendente (inferiores acosan a un superior) y descendente (superiores sobre un inferior), siendo esto último lo más frecuente.
- Son especialmente vulnerables los empleados jóvenes, las mujeres y los emigrantes

El acosador típico suele tener un rango humano caracterizado por el narcisismo, pocos valores nostrales (valores éticos hacia los demás) y con poco sentido de culpabilidad tras sus actos.

El acosado suele ser brillante, honrado, poco corruptible o manipulable, cumplidor en su trabajo, con iniciativa y dotado de un alto sentido ético (valores positivos).

En la Unión Europea, la tercera encuesta sobre las condiciones de trabajo, publicada por la OIT en el año 2000, encontró que un promedio de 13 millones de

trabajadores (9%) eran víctimas de hostigamiento sistemático, acoso sexual o alguna forma de violencia laboral.

Pero tengamos claro que el acoso laboral, per se, no es una enfermedad psiquiátrica sino una situación legal o judicial; si se produce la denuncia, el nivel institucional o judicial ha de dirimir la responsabilidad que el acosador tiene y, en su caso, si es incluso una responsabilidad penal. Pero aunque el *mobbing* no sea una enfermedad psiquiátrica, sí que lo son sus consecuencias.

El problema psiquiátrico, pues, no viene porque nosotros tengamos que diagnosticar si existe o no ese acoso laboral, sino por las consecuencias que esa mayor o menor injuria directa sobre el trabajador está originando en su estado psíquico.

El paciente nos cuenta una situación de acoso laboral, sin violencia física, que generalmente parece copiada de un libro. Es como si los que han de realizar un acoso laboral mirasen un manual o una página web para realizar siempre el mismo según unos patrones muy establecidos. Una paciente, tras una fusión laboral es apartada en un despacho, con un ordenador y un teléfono sin dejarla tener contacto con sus compañeros, ni hacer prácticamente ninguna actividad, pero tampoco puede pasar el tiempo leyendo una novela o escuchando música o la radio, pues entonces no estaría «atenta» a su trabajo. La intención de dañar psicológicamente a esta persona es por lo que en este caso estamos ante una conducta de acoso y no sólo ante una situación de malas condiciones laborales. Lo que se espera es que se vaya espontáneamente y deje la empresa sin coste alguno para ésta. Otro paciente que ha estado trabajando en contacto directo con el público en una farmacia durante más de 25 años, al traspasarse ésta, sólo le permiten estar ordenando los medicamentos en la trastienda, durante las ocho horas laborales (los maltratos premeditados, mantenidos en el tiempo, sistemáticos y por motivos ocultos, son conductas de acoso); en otro caso, la que era una jefa de sección ahora ve bloqueados sus correos electrónicos y que no le dan trabajo alguno y es apartada de toda decisión laboral, etc. Muy a menudo el elemento o núcleo acusador se encarga de desprestigiar al trabajador en cuestión, controlar sus comunicaciones y en definitiva producirle un aislamiento laboral, una situación de angustia, y si es posible descrédito tal que le haga «abandonar» gratuitamente la plaza que ocupa o dejándola vacante sin coste para la empresa o institución. (En la tabla 8.1 podemos ver el cuestionario de Leymann para el acoso laboral.)

TABLA 8.1

Las 60 preguntas de Heinz Leymann Leymann Inventory of Psychological Terrorization, LIPT ([Descargar o imprimir](#))

A continuación hay una lista de distintas situaciones o conductas de acoso que usted puede haber sufrido en su trabajo. Marque en cada una de ellas el grado en que la ha experimentado. Anote un cero («0») si no ha experimentado esa conducta en absoluto; un uno («1») si la ha experimentado un poco; un dos («2») si la ha experimentado moderadamente; un tres («3») si la ha experimentado mucho, y un cuatro («4») si la ha

experimentado de manera extremada. (Valorar la posibilidad de *mobbing* cuando una o varias de las 45 actitudes hostiles se repiten al menos una vez a la semana durante al menos 6 meses.)

0 = Nada en absoluto.

1 = Un poco.

2 = Moderadamente.

3 = Mucho.

4 = Extremadamente.

A) Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio acosador:

1. El jefe o acosador no permite a la víctima expresarse o decir lo que tiene que decir.
2. Se interrumpe continuamente a la víctima cuando habla.
3. Los compañeros le impiden expresarse.
4. Los compañeros le gritan, le chillan o injurian en voz alta.
5. Se producen ataques verbales criticando trabajos realizados.
6. Se producen críticas hacia su vida privada.
7. Recibe llamadas telefónicas amenazantes, insultantes acusadoras.
8. Se le amenaza verbalmente.
9. Se le amenaza por escrito.
10. Se rechaza el contacto con la víctima (evitando el contacto visual, mediante gestos de rechazo, desdén o menosprecio, etc.).
11. Se ignora su presencia, por ejemplo dirigiéndose exclusivamente a terceros (como si no le vieran o no existiera, no responden a sus preguntas).

B) Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener contactos sociales:

12. Los compañeros han dejado o están dejando de hablar con la víctima.
13. No se les deja que se dirijan a uno, le evitan.
14. Se le asigna a un puesto de trabajo que le aísla de sus compañeros.
15. Se prohíbe a sus compañeros hablar con él.
16. Se niega la presencia física de la víctima. En general se le ignora y se le trata como si fuera invisible.

C) Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su reputación personal o laboral:

17. Se maldice o se calumnia a la víctima.
18. Se hacen correr cotilleos y rumores falsos o infundados, orquestados por el acosador o el *gang* de acoso sobre la víctima.

19. Se ridiculiza a la víctima.
20. Le tratan como si fuera un enfermo/a mental o lo dan a entender.
21. Intentan obligarle a que se haga un examen o diagnóstico psiquiátrico.
22. Se fabula o inventa una supuesta enfermedad de la víctima.
23. Se imitan sus gestos, su postura, su voz y su talante con vistas a poder ridiculizarlos.
24. Se atacan o se burlan sus creencias políticas o religiosas.
25. Se hace burla de su vida privada.
26. Se hace burla de sus orígenes o de su nacionalidad.
27. Se le asigna un trabajo humillante.
28. Se evalúa su trabajo de manera parcial, injusta y malintencionada.
29. Las decisiones tomadas por la víctima son siempre cuestionadas o contrariadas.
30. Se le injuria o se le hacen insultos o comentarios en términos obscenos o degradantes.
31. Se acosa sexualmente a la víctima con gestos o proposiciones.

D) Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante la desacreditación profesional:

32. No se asigna a la víctima trabajo alguno.
33. Se le priva de cualquier ocupación, y se vela para que no pueda encontrar ninguna tarea por sí misma. Le cortan sus iniciativas, no le permiten desarrollar sus ideas.
34. Se le asignan tareas totalmente inútiles o absurdas
35. Se le asignan tareas muy inferiores a su capacidad o competencias profesionales.
36. Se le asignan sin cesar tareas nuevas y diferentes.
37. Se le hace ejecutar trabajos humillantes.
38. Se le asignan tareas que exigen una experiencia superior a sus competencias profesionales, esperando que fracase.

E) Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica de la víctima:

39. Se le obliga a realizar trabajos peligrosos o especialmente nocivos para la salud.
40. Se le amenaza físicamente.
41. Se agrede físicamente a la víctima, pero sin gravedad, a título de advertencia.

- 42. Se le agrede físicamente sin ninguna consideración.
- 43. Se le ocasionan voluntariamente gastos con intención de perjudicarla.
- 44. Se ocasionan desperfectos en su puesto de trabajo o en su domicilio.
- 45. Recibe agresiones sexuales o físicas directas.

F) Estrategias de la versión española agregadas al LIPT (modificada y adaptada al español por José Luis González de Rivera).

- 46. Le ocasionan daños en sus pertenencias o su vehículo.
- 47. Manipulan sus herramientas de trabajo (por ejemplo, borran archivos de su computadora).
- 48. Le sustraen algunas de sus pertenencias, documentos o herramientas de trabajo.
- 49. Se realizan informes confidenciales sobre usted sin notificarle ni darle oportunidad de defenderse.
- 50. Las personas que le apoyan reciben amenazas o presiones para que se aparten de usted.
- 51. Devuelven, abren o interceptan su correspondencia.
- 52. No le pasan las llamadas o dicen que usted no está.
- 53. Pierden u olvidan sus encargos.
- 54. Callan o minimizan sus esfuerzos, logros y aciertos.
- 55. Ocultan sus habilidades y competencias especiales.
- 56. Exageran sus fallos y errores.
- 57. Informan mal sobre su permanencia y dedicación.
- 58. Controlan de manera muy estricta su horario.
- 59. Cuando solicita un permiso, curso o actividad a la que tiene derecho se lo niegan o se le ponen obstáculos o dificultades.
- 60. Se le provoca para obligarle a reaccionar emocionalmente.

Cuando el paciente nos cuenta todo esto, normalmente, si el psiquiatra tiene cierta experiencia, con las sucesivas entrevistas que se realizan y conociendo los detalles, motivos y evolución de su reacciones afectivas, viendo ya que no es una situación de maltrato de la dirección por un motivo concreto, ni son agresiones esporádicas, ni malas condiciones laborales, ni conflictos laborales, sino que existe la voluntad de dañar la dignidad del trabajador, nos damos cuenta, sin necesidad de pasarlo por la «máquina de la verdad», que el paciente no miente y puede encontrarse en una de las tres circunstancias siguientes:

1. Padecer una depresión reactiva o de las que se han llamado situativas o de trasfondo⁸⁹.
2. Que se haya desencadenado una enfermedad ansiosa, un trastorno de ansiedad, ya bien delimitada.
3. Muy frecuentemente lo que tenemos es lo que podríamos denominar una *reacción vivencial ansioso-depresiva, inducida por la presión o situación laboral*. Éste es el caso más frecuente. La reacción emocional ante la vivencia de acoso laboral origina muy a menudo fuerte mentismo (pensamientos recurrentes acerca del problema, rumiaciones), insomnio y, junto a fuerte ansiedad, síntomas también depresivos por la impotencia ante la que se encuentra la persona en esa situación, culpabilizándose muy a menudo de haber hecho algo para que le traten ahora de esa manera. A veces el psiquiatra le diagnóstica de trastorno adaptativo. Yo no puedo más que estar en desacuerdo con ese diagnóstico: encima que le acosan en el trabajo ahora resulta que él es el trastornado y además «porque no se adapta». Si a mí me ocurriera, lo mínimo que diría es que «tiene narices»: encima que me siento acosado laboralmente ahora resulta que yo soy el que he de adaptarme a los insultos, vejaciones y demás crueldades que sobre mí se están realizando. Hay que tener en cuenta que el trastorno adaptativo, tal como es definido por el DSM-IV-TR, supone que «la reacción consiste en un acusado malestar, *superior al esperable* dada la naturaleza del estresante [...]». ¿Superior al esperable? Si me siento acosado en el trabajo, ¿no es esperable que tenga un acusado malestar y un deterioro significativo de la actividad social o profesional? Evidentemente, si estoy acosado en el trabajo y no «cumpló criterios» para que el profesional me diagnostique una enfermedad depresiva o ansiosa, sí que los tengo para relacionar mi estado ansioso-depresivo con la situación laboral, y por eso mi *reacción vivencial* puedo decir que está originada por la presión o situación profesional.

En el caso clínico de J. R. T.:

J. R. T. es un varón de 33 años de edad. Si estudiamos su psicobiografía (su vida), no encontramos ningún problema de adaptación, ni en su infancia ni en el trabajo, hasta que aparece la problemática laboral actual. Ocupa el segundo lugar en la fratría, teniendo una hermana mayor que él (38 años) y un hermano menor que él (27 años). Padre y madre son considerados cariñosos y la escolaridad fue normal, al igual que sus estudios de empresariales. Desde los 26 años tiene novia y convive junto con ella desde los 30 sin ningún problema especial. Con 27 años empieza a trabajar en la empresa actual teniendo muy buen rendimiento y adaptación, ascendiendo rápidamente y considerándose él «muy responsable» y que siempre le ha dado «muchas vueltas» a los problemas hasta encontrar soluciones. Desde hace cuatro años ya ocupa un nivel de alta cualificación en su empresa. Desde hace un año y medio tiene excesivo trabajo, ya que un directivo se va de la empresa y él tiene que realizar también parte del trabajo de éste, además del propio. Cuando pasan unos meses desde

que se fue el compañero directivo, deja la empresa, asimismo, otro directivo y por eso aumentó aún más su exigencia laboral. Aunque tenía exceso de trabajo y dormía poco, no obstante, dada su marcada responsabilidad, refiere que lo llevó bastante bien sin que se le manifestaran alteraciones significativas de salud, excepto el insomnio. El problema aparece cuando hace nueve meses, coincidiendo con que llega un nuevo director-jefe de su sección, padece una crisis convulsiva por lo que estuvo mes y medio de baja laboral, y al incorporarse se encuentra que no puede realizar su trabajo, pues le ocultan la información y no le dan explicaciones. Su nuevo jefe no quiere hablar con él ni le responde a los correos electrónicos que él le manda y además le controla todos sus *e-mails*. Como cada vez puede hacer menos trabajo al no tener información y nadie le da ninguna explicación, tampoco puede organizar a su equipo, del que él es responsable, y entonces el nuevo jefe asume las tareas de su equipo, sin contar con él. En esta situación, cada vez el insomnio es mayor y piensa que es culpable de haber hecho algo malo, quizá el haber cogido la baja laboral, teniendo cada vez más ansiedad y estando cada vez más deprimido. El cuestionario de acoso laboral LIPT mostró un índice global de acoso psicológico de 65, indicando sobre todo alteración importante en «desprestigio laboral, incomunicación o bloqueo de la comunicación, intimidación encubierta e intimidación manifiesta». Tuvo que coger de nuevo la baja laboral.

Comentario

La sintomatología que padecía antes de coger la última baja laboral era suficientemente significativa a nivel ansioso y depresivo como para que pudiéramos vincular fácilmente este estado a una *reacción vivencial inducida por la situación laboral*. Es más, una vez que está de baja laboral y se aparta del entorno profesional, en pocos meses conseguimos que desaparezca la sintomatología anímica y asimismo la ansiedad y el insomnio. El problema aparece a la hora de volver a incorporarse a su trabajo, ya que si se mantienen las mismas condiciones —que es lo esperable—, la sintomatología volvería rápidamente y su capacidad laboral sería prácticamente nula. Médicamente, sólo podemos hacer desaparecer la sintomatología estando de baja laboral y ayudarle a que tome una decisión respecto a su postura vital ante la situación. Una vez que ha avanzado en su curación estará en condiciones de afrontar su decisión, ya sea dejar la empresa, actuar legalmente contra ella, incorporarse al trabajo, etc., y en cada caso el médico prestará el apoyo para conservar su estabilidad psíquica, su eutimia (su ánimo estable y normal); ésta es nuestra única y posible misión, el apoyo al ser humano que está enfermo o que puede enfermar, mas no a la decisión en sí, pero sí médicamente a la persona que toma la decisión.

No nos confundamos: nuestro compromiso es médico, es un compromiso con su salud, pero no con la decisión que siempre ha de ser tomada libremente por el paciente, con ayuda, pero por él mismo.

* * *

Para terminar este capítulo hagámonos unas reflexiones:

1. Si, como pensamos, es cierto que la mayor parte de la gente se encuentra casi continuamente angustiada en sus vidas personales y en la constante lucha por subir o mantener su escala social, con persistente miedo a fracasar.
2. Si sabemos todo esto, ¿por qué seguimos trabajando de esta manera y manteniendo este estilo de vida que hace que la persona común no tenga tiempo para reflexionar que le es necesario un salto humano a una nueva escala de valores en la que, el humanismo, los valores trascendentales, el propio hombre sea un fin en sí mismo?

Quizá la respuesta esté en que a pesar de los grandes avances técnicos, no obstante, a nivel del desarrollo de nuestra concepción del mundo seguimos siendo unos neuróticos acomodados: nos acomodamos a esta realidad inauténtica y aunque sean absurdas las explicaciones o justificaciones que nos hagamos acerca de lo bueno que es este estilo de vida, aun así nos aferramos a nuestras ideas aprendidas. Las múltiples facetas de la vida quedan reducidas y fijadas en un esquema mecánico y repetitivo del que no escapamos⁹⁰. Como señala Watzlawick en su libro *¿Es real la realidad?*, es muy difícil cambiar una actitud mental aunque nos digan lógicamente que no es buena.

Tenemos que favorecer lo que Sartre denominó «el instante» (*«l'instant»*). El «instante» no es sino una decisión íntima de trascender a los errores vitales, y en una nueva y súbita cristalización existencial cambiar rotundamente el antiguo estilo creencial. No es suficiente con conocer la inautenticidad de nuestro estilo de vida, sino que tenemos que cambiar los valores de nuestra concepción del mundo.

NOTAS

⁸² F. Künkel habla de actitud «nosista» cuando recae la importancia de la relación del sujeto con los demás más en el «nosotros» que en el «yo» del individuo. Entonces exigirá de sí y de los otros que el bien común se anteponga al bien propio. Por el contrario, habla de actitud «yoísta» cuando predomina en el sujeto que «el nosotros» no existe más que para amparar al individuo y servir a sus necesidades privadas; intentará, entonces, consciente o inconscientemente, exaltarse a sí mismo y rebajar a la comunidad a la función de medio o camino para conseguir sus fines individuales.

⁸³ La palabra «alienación» (según Trilling) procede de un famoso cuento de Denis Diderot, *El sobrino de Rameau*, que Hegel, entusiasmado, envió a Engel para que lo leyera.

⁸⁴ La primera definición de sociología fue propuesta por el filósofo francés Auguste Comte, quien, en 1838, acuñó el término «sociología» y llamó a su nueva disciplina *física social*. Como la palabra física sólo considera lo que es medible, cuantificable, cuando los sociólogos actúan como «físicos sociales» sólo les interesa medir, en el caso del trabajo, los rendimientos aunque se eclipse el factor humano. Si el trabajador es feliz, esto habrá que medirlo «porque nos dará rendimiento» que a su vez es también medible. Cuando este tipo de sociólogos entran a regular la producción, en una fábrica o como «gestores» en la asistencia médica, pueden aumentar el ritmo de fabricación y en medicina el número de altas médicas que se dan, por ejemplo, en un hospital, pero casi siempre a costa de un detrimento del factor humano en el ámbito laboral, cuyas consecuencias no siempre interesan o no se «miden» a medio y largo plazo.

⁸⁵ Heráclito fue el primero en utilizar el concepto de frónesis. Es un estado de pensar unido a la sofía (sabiduría) como expresión de escuchar a la naturaleza

En el estado de frónesis el hombre se unifica en la tranquila forma de existir y alcanza la «paz» en la que es

posible el sí mismo y la vida a partir de un yo estable. En este estado se manifiesta el puro-ser-en-algo de la persona, que en el caso del trabajo diríamos que el sujeto tiene un equilibrio de su puro-ser, en-el trabajo. En lo que hemos llamado sofropatía se desequilibra el proyecto del sí mismo y la vida.

[86](#) Esto ya no es propio del «alto ejecutivo», sino que en nuestro mundo competitivo se ha ido infiltrando en casi todos los niveles de la organización laboral.

[87](#) *Mobbing*, etimológicamente procede de verbo inglés *to mob*, que significa atacar, asediar; el sustantivo de *mob* significa muchedumbre, jauría. El término fue acuñado por Konrad Lorenz para designar la hostigación de varios animales contra un animal solitario mayor, con el fin de alejarlo.

[88](#) En un artículo, J. L. González de Rivera titula al *mobbing* como «el asesinato psicológico en el lugar de trabajo».

[89](#) En el libro *La enfermedad depresiva: conocer y entender la depresión en lenguaje para todos* (Editorial Albatros, 2008) abordé las diferentes clases de depresiones. Como resumen, en estas depresiones denominadas de trasfondo, la situación que se mantiene «detrás», ya sea paro laboral, acoso o una problemática familiar determinada importante, actúa como desencadenante de la enfermedad y posible factor encronizante y de riesgo.

[90](#) Mario Berta habla de neurosis epistemológica cuando el pensar persiste basado en un solo polo de la realidad que es vivenciado como si fuera la totalidad absoluta. El pensamiento cree captar o utilizar la totalidad, cuando en realidad no es más que un fragmento o una perspectiva parcial.

9. LA ANSIEDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PSICOLOGÍA: MODELOS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO

Dra. Marisa García-Merita

Profesora titular de Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos
Universidad de Valencia

«Si no tenemos creencias con las que la mente se haya identificado, entonces la mente, sin identificación alguna, es capaz de mirarse y verse tal como es, eso constituye el principio de la comprensión de uno mismo.»

KRISHNAMURTI, *El libro de la vida*

9.1. INTRODUCCIÓN

En el campo de la psicología el estudio de la ansiedad se realiza desde distintos enfoques y aproximaciones, pues el vocablo ansiedad sufre, lamentablemente, de la ambigüedad que es relativamente frecuente en muchos términos psicológicos. Por un lado, nos encontramos con el acercamiento que tiene lugar desde la psicología clínica, que se centra en el estudio de aquellos trastornos que tienen en común el que su principal sintomatología es la ansiedad (patológica). Sin embargo, incluso desde este enfoque clínico, existen diferentes interpretaciones sobre el concepto de ansiedad.

Algunos autores la interpretan como un exceso de activación. Otros la conceptualizan como la repercusión afectiva de la incertidumbre, considerándola muy asociada al miedo anticipado a que el resultado del refuerzo que obtenga el sujeto sea de privación. Incluso hay autores que han defendido que la ansiedad es un factor de personalidad.

Tanto desde la psicología aplicada como desde la psicología de la personalidad, se ha intentado desentrañar muchos de los equívocos a los que lleva este término. Uno de los aspectos centrales que han ocupado a los teóricos de la psicología ha sido el intento de diferenciar claramente entre activación, ansiedad y estrés, términos que, en muchas ocasiones, se utilizan como sinónimos, llevando a la confusión.

Hay algo respecto a lo que todo el mundo está de acuerdo, y es que un cierto grado de activación es absolutamente necesario para realizar cualquier actividad de la vida cotidiana. Por ejemplo, los deportistas atribuyen frecuentemente el éxito o el fracaso en una competición a la intensidad de la activación general (Pons y García-Merita, 1994).

En realidad, las consecuencias negativas del exceso de activación o de la falta de ella no son ignoradas por nadie. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que alguien estaba demasiado nervioso o, por el contrario, demasiado tranquilo y confiado, y que por eso no se había producido el resultado esperado en un examen, en una conferencia, en una competición deportiva, etc.?

Es bastante común escuchar frases como las siguientes: «estaba muy tenso y no supo qué contestar», «fue porque se puso nervioso», «la situación era demasiado estresante», «en el último momento se puso muy ansioso», «estaba como dormido y no reaccionó». En resumen, lo que queremos señalar es que todo el mundo sabe que una elevada activación puede suponer una ventaja en ciertos contextos o situaciones, pero que existen ocasiones en que esto puede ser contraproducente.

Ahora bien, es importante que tengamos claro que los conceptos de activación y de ansiedad no pueden identificarse. Esto no quiere decir que la ansiedad sea independiente de la activación; muy al contrario, ambas están íntimamente relacionadas. De hecho, la ansiedad siempre va acompañada de un elevado nivel de activación. Incluso, algunos autores han señalado que la ansiedad puede considerarse como el impacto emocional de la activación.

Veamos a continuación un breve resumen de los aspectos más importantes respecto a los tres vocablos mencionados: activación, ansiedad y estrés.

9.2. ACTIVACIÓN O AROUSAL

Es indiscutible que siempre que se produce una conducta manifiesta ésta va acompañada de un determinado nivel de activación.

La activación o arousal es un constructo hipotético que refleja el aumento o disminución de la excitabilidad, reactividad o tendencia a responder del sistema nervioso central y del sistema nervioso vegetativo, y cuyos mecanismos neurofisiológicos están bien especificados, como más adelante describiremos.

La activación presenta las siguientes características:

1. Se refiere sólo al aspecto de intensidad de la conducta.
2. Es un continuo desde los estados de máxima alerta hasta los estados de coma.
3. Es producto de la interacción entre las condiciones ambientales (externas) y las condiciones internas del organismo.
4. Es tanto específica como inespecífica.

Puesto que las situaciones varían, el patrón de activación debe ajustarse a las demandas del momento. Así, si una acción concreta requiere la puesta en marcha de determinados sistemas (p.ej., muscular, visceral), la reactividad de estos sistemas se modificará y, por tanto, su nivel de activación aumentará.

Respecto a los factores que determinan el nivel de activación, se ha visto que influyen tanto las características de la situación como la sensibilidad de los diferentes sistemas sensoriales (Duffy, 1972). Algunos autores defienden que la incertidumbre,

la novedad y el conflicto son los mayores estimuladores de la activación (Hennessy y Levine, 1979).

Las relaciones entre ansiedad y activación no están del todo claras. La teoría clásica de la activación considera que la ansiedad es un punto en el continuo de la activación. Es decir, que llegaría un momento de intensidad de la activación en el que ya podríamos decir que ésta puede denominarse ansiedad. Sin embargo, otros autores consideran que el concepto de ansiedad es más amplio que el de activación. Así, la activación está manifestando actividad puramente fisiológica y se refiere sólo a la dimensión de intensidad de la conducta, mientras que la ansiedad es un patrón de conductas complejo con sentimientos subjetivos de tensión, que va acompañado de actividad fisiológica (Anderson, 1990; García-Merita, Miquel y Fuentes, 1991) y que se refiere tanto a la intensidad como a la dirección de la conducta. Martens (1991) llegó a decir que la ansiedad es la activación producida por la percepción de peligro.

9.2.1. Mecanismos neurofisiológicos de la activación

Desde un punto de vista estructural, el sistema nervioso de los organismos superiores se divide en dos partes: el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). El SNP se divide a su vez en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo o vegetativo. Desde un punto de vista funcional, el sistema nervioso actúa de forma integrada existiendo numerosas vías de conexión entre el SNC y el SNP.

El sistema nervioso somático incluye los nervios aferentes y los órganos sensoriales y motores. Su función primordial es la de ser activador de la musculatura voluntaria.

El sistema nervioso autónomo (SNA) incluye los nervios de los órganos internos, vísceras y glándulas. Este sistema es el más directamente involucrado en la mediación de los aspectos emocionales y motivacionales de la conducta. El SNA consta de dos divisiones, la simpática y la parasimpática. La división simpática actúa como mecanismo de excitación de todo el cuerpo y lo prepara para la acción vigorosa. Así, la estimulación del simpático produce un aumento del ritmo cardíaco y de la profundidad de la respiración, detiene la actividad gastrointestinal, libera la glucosa almacenada, desvía la sangre de las vísceras y de la piel hacia los músculos, y pone a funcionar las glándulas sudoríparas. En resumen, la difusión de los impulsos nerviosos del simpático hace elevar el *nivel general de activación*, preparando al organismo para «luchar o huir» cuando éste percibe un peligro.

Por su parte, la división parasimpática se ocupa de las funciones de recuperación, restauración y nutrición del cuerpo cuando éste se halla en reposo (ralentiza el ritmo cardíaco, activa la función gastrointestinal para favorecer la digestión, etc.). En líneas generales tiene la función opuesta a la división simpática. Además, el sistema parasimpático tiene una acción más específica y es capaz de modular la función alterada de cualquier órgano por parte del simpático.

La mayoría de los órganos tienen una inervación antagonista dual, es decir, que

están provistos tanto de nervios simpáticos como parasimpáticos. El SNA mantiene típicamente un nivel tónico de salida en ambas divisiones denominado tono. El tono será mayor o menor según el incremento o decremento de una u otra división, pero es la suma algebraica de ambas entradas la que determina la respuesta de los órganos. Así por ejemplo, el ritmo cardíaco puede aumentar, bien por un incremento en la entrada simpática, bien por una disminución en la entrada parasimpática.

El SNA está bajo el control directo de diversos núcleos del tallo cerebral, los cuales, a su vez, reciben el influjo del hipotálamo y de algunas estructuras límbicas del prosencéfalo (es decir, del SNC).

El sistema nervioso central incluye: el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal. Su función principal es recibir y procesar la información procedente del SNP. Las estructuras del SNC más importantes relacionadas con la activación y la ansiedad son: el córtex cerebral, el hipotálamo, la formación reticular y ciertas estructuras límbicas como el hipocampo, el núcleo amigdalino y los cuerpos mamilares.

Además del SNC y del SNA existen una serie de glándulas endocrinas relacionadas también con las situaciones emocionales (sistema endocrino). Éstas son: las cápsulas suprarrenales, la tiroides, y la glándula rectora de todas ellas, la hipófisis. Esta última está, a su vez, regulada por el hipotálamo. Estas glándulas segregan unas sustancias, denominadas hormonas, que se vierten en la sangre y actúan a distancia sobre los diferentes órganos o tejidos para provocar las modificaciones necesarias. Es decir, son facilitadoras de ciertos comportamientos que se dan en respuesta a determinadas situaciones.

El SNC reacciona ante una situación de tensión mediante respuestas de adaptación que, a través del hipotálamo, estimulan la capsula suprarrenal, bien directamente por vía del simpático, bien indirectamente a través de la hipófisis. Cuando la respuesta que se requiere es inmediata, el SNC actúa directamente estimulando, a través del simpático, la médula suprarrenal que liberará bruscamente grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina. Éstas actúan para liberar energía almacenada y así aumentar el metabolismo, suministrando un mecanismo eficaz para distribuir el efecto energético de la actividad simpática por todo el cuerpo.

Existe otra forma de respuesta más tardía, más lenta y continua. En este caso, el hipotálamo actúa indirectamente, enviando el mensaje recibido a la hipófisis, que va a segregar una hormona llamada ACTH (hormona adrenocorticotrópica). Esta última estimula la corteza suprarrenal que segregará los corticoides. Estos corticoides actúan, a su vez, sobre el hipotálamo mediante un *feedback* negativo que hace que se detenga la liberación de ACTH.

La ansiedad

La teoría clásica de la activación, como ya hemos dicho, considera a la ansiedad simplemente como un punto en el continuo de la activación. Por ejemplo, Duffy (1972) afirma que la ansiedad es una tendencia general hacia una activación elevada.

Pero tengamos en cuenta que este tipo de definición sólo se fija en una parte de la ansiedad, concretamente en la responsividad fisiológica.

Debemos tener en cuenta que la ansiedad implica, además del componente de activación, un componente cognitivo. En este sentido, algunos autores han señalado que cuando la activación se interpreta como algo negativo que impide la adaptación, entonces los índices de activación pueden ser considerados como índices de ansiedad (Dienstbier, 1989).

Otros autores sugieren que la ansiedad puede ser definida como la reacción emocional displacentera que acompaña a la activación del sistema nervioso autónomo, y que es una condición emocional desadaptativa (Landers, 1980), o que es un estado de ánimo negativo caracterizado por síntomas corporales de tensión física y aprensión respecto al futuro (Barlow y Durand, 2003). Por tanto, la consideran una emoción, y por ello, más compleja y cualitativamente distinta a la actividad fisiológica que la acompaña.

Es cierto que todas las conductas emocionales, sean negativas o positivas, se caracterizan por ir acompañadas de una elevación en la activación general del sistema nervioso, pero el factor fisiológico no es el único que caracteriza a las emociones y por tanto no debemos identificarlas con él.

Las emociones comprenden, al menos, tres aspectos bien diferenciados: la experiencia subjetiva de la misma, la conducta motora que la caracteriza y la conducta neurofisiología de la misma. Sería bastante sencillo el estudio de las emociones si estos tres aspectos pudiesen diferenciarse claramente para cada una de ellas. Pero desgraciadamente esto no es así. En ciertas situaciones, la experiencia, la conducta y la fisiología no guardan una consistencia mutua. Así por ejemplo, desde el punto de vista de la experiencia y de la conducta, es fácil distinguir entre un estado emocional de ansiedad y uno de ira, pero no es tan fácil encontrar diferencias claras en la actividad visceral que se relaciona con ambos estados. En otras ocasiones, puede resultarnos difícil diferenciar entre la experiencia subjetiva de un estado emocional de miedo y uno de ansiedad, y más difícil todavía resulta diferenciar las respuestas fisiológicas de dichas emociones. Ahora bien, el hecho de que los mecanismos neurofisiológicos sean los mismos no debe inducirnos a realizar un reduccionismo biológico e identificar emoción con actividad fisiológica, es decir, ansiedad con activación.

9.2.2. Ansiedad rasgo y ansiedad estado

En ocasiones, se ha intentado aclarar la confusión que se produce al utilizar el término de ansiedad, tanto para referirse a una tendencia general (predisposición) del individuo para reaccionar ante las situaciones con sentimientos de tensión y nerviosismo como para referirse a la propia reacción emocional.

En este sentido, Spielberger (1966) señaló que para que una definición de ansiedad fuera adecuada tendría que considerar la diferenciación entre la ansiedad como un estado emocional y la ansiedad como un rasgo de personalidad. Así, propuso la teoría

de la ansiedad estado-rasgo, distinción que más tarde casi todos los autores mantendrían.

La *ansiedad estado*, según Spielberger (1970), es una combinación única de sentimientos de tensión, aprensión y nerviosismo, pensamientos molestos y preocupaciones, asociado todo ello con una elevada activación del organismo.

La ansiedad estado es una emoción negativa que varía a lo largo de un continuo, donde la ausencia de la misma se traduciría en calma y serenidad, su elevación moderada en sentimientos de tensión, aprensión nerviosismo y preocupación, y que en su extremo superior se manifestaría por intensos sentimientos de miedo, pensamientos catastróficos y comportamientos desorganizados de pánico.

Los cambios fisiológicos asociados al incremento de ansiedad estado incluyen: elevación de la tasa cardíaca y de la presión sanguínea, respiración intensa, rápida y superficial, sequedad de boca, dilatación de las pupilas, erección capilar y aumento de la transpiración. Además se puede producir la contracción de algunos músculos, preparando al cuerpo del sujeto para una acción rápida y vigorosa.

Según Spielberger (1972), cuando un estímulo o situación es valorado como amenazante se producirá un estado de ansiedad. La intensidad de esta reacción será proporcional a la cantidad de amenaza que la situación suponga (según la percepción subjetiva) para el individuo. El estado de ansiedad se mantendrá elevado hasta que la valoración de la situación como amenazante sea alterada por un afrontamiento eficaz o por operaciones defensivas.

Por otra parte, denominó *ansiedad rasgo* a una disposición de la personalidad a percibir ciertas situaciones como amenazantes y a responder a ellas con niveles elevados de ansiedad estado. A diferencia de la ansiedad estado, la ansiedad rasgo no puede manifestarse directamente en el comportamiento, sino que debe ser inferida por la frecuencia con la que un individuo experimenta elevaciones en su ansiedad estado.

Spielberger considera que aquellas personas que poseen un alto grado de ansiedad rasgo perciben un mayor rango de situaciones como amenazantes, y están más predispuestas a sufrir ansiedad estado.

Como los niveles altos de ansiedad estado son experimentados como intensamente molestos, si una persona no puede evitar el estímulo que los produce, pondrá en marcha las habilidades de afrontamiento necesarias para enfrentarse a la situación amenazante, iniciando un proceso defensivo para reducir el estado emocional displacentero. De esta forma, y en la medida en que los mecanismos de defensa tengan éxito, las circunstancias se interpretarán como menos amenazantes y se producirá una reducción del estado de ansiedad, ya que los mecanismos de defensa influyen en el proceso psicofisiológico de tal manera que se modifica la percepción o valoración de la situación.

Un hecho importante es que las personas con alta ansiedad rasgo perciben las situaciones, donde su adecuación personal ha de ser evaluada, como más amenazantes que las personas que tienen menor ansiedad rasgo.

Desde el campo de la psiquiatría, Rojo Sierra (manuscrito no publicado) opina de forma bastante similar a Spielberger. Defiende que existe un factor disposicional del

individuo a reaccionar con ansiedad, al que llama *ansiabilidad*.

En cuanto a lo que Spielberger llama ansiedad estado, Rojo considera que la ansiedad es una vivencia de *alarma psíquica*. Alarma que, si bien aparece ante un posible acontecimiento, siempre requiere de una desmesurada reacción de aprestamiento (activación), sin posibilidad de concretizar el objeto alarmante. Así pues, es una alarma desencadenada abierta a todo horizonte. No como el miedo, que siempre cuenta con la inminencia de algo determinado.

En la taxonomía de este autor (Rojo, 1989), la ansiedad es una modalidad de la angustia. La angustia es un estado afectivo opuesto al de la dicha, que aparece en la persona cuando falla la consonancia integrativa entre los estamentos afectivos y sus recíprocas interacciones.

Rojo considera que la angustia puede tener tres modalidades: la ansiedad, la culpa y la perplejidad (ver Rojo, 1989, y Rojo y García-Merita, 2002, para una ampliación sobre este tema). La ansiedad se produce por la disonancia entre la expectativa que tiene el sujeto y la posibilidad fáctica. Su manifestación puede afectar de forma general y difusa a la persona o, por el contrario, predominar específicamente en el plano psíquico o en el somático.

Cuando la manifestación es global y difusa se produce como «un temor sin saber a qué», como un temor sin objeto. Pero, a diferencia del *trema* o humor delirante⁹¹, este temor no afecta a todo, como una atmósfera siniestra e incierta, sino que queda cernido sobre el mismo sujeto y sobre valores muy unidos a él. Por eso no puede ser definida la ansiedad simplemente como amenaza.

Por otra parte, pero siempre teniendo en cuenta la conceptualización de la ansiedad como alarma psíquica ante una disonancia de expectativa-facticidad, cuando las manifestaciones no son generales y difusas, sino que predominan en el plano psíquico, podemos distinguir:

- a) *Disonancia entre la expectativa y la realidad en el sentir pasar el tiempo*. Con dos variedades, 1) *el desasosiego* (ansiedad de espera), que es cuando la expectativa formuló un tiempo más corto del intervalo cronológico (p.ej., cuando estamos esperando que termine la intervención quirúrgica de un ser querido), y 2) *el atosigamiento*, sucede en el caso contrario. La expectativa del intervalo cronológico se queda corta por imposibilidad fáctica de hacer todo lo exigido (p.ej., una secretaria tiene que realizar demasiadas tareas para un solo día).
- b) *Disonancia en el sentir el espacio propio y sus posibilidades motoras, con la concreción en el espacio geométrico que le toca*. Existen dos posibilidades: 1) Percepción del espacio vital empequeñecido. Es la *acatisia*, la «intranquilidad» de no poder sentarse, de tener que ir de un sitio a otro, el necesitar gran espacio para desenvolverse. 2) Espacio vital magnificado. Es la *agorafobia*, miedo a los lugares amplios y llenos de gente.
- c) *Disonancia en la expectativa de conseguir una solución unificada de una cualificación cognitiva* (hacer tareas, proyectos, tener recursos para salir de un

apuro, etc.). Es la ansiedad de *zozobra*, de quien no encuentra salida a una situación.

Existen también manifestaciones en el cuerpo que vivimos (eidosoma). Éstas pueden ser: 1) Torácicas: opresión torácica, nudo en la garganta, dificultad de respiración (por parecer que no entra aire en los pulmones), dolor precordial y dolor pectoral izquierdo. 2) Abdominales: plenitud, náuseas y vómitos, movimientos viscerales. 3) En los miembros y percepción muscular, como sensación de tensión interna, de no caber en el propio cuerpo, tirantez de cuello. Sensación de bloqueo de la coordinación motora, de temblor interno, de claudicación de fuerzas (especialmente en las piernas), y cefaleas temporo-parieto-frontales opresivas.

Por último, Rojo señala los efectos fisio-anatómicos de la ansiedad de forma muy similar a los descritos por Spielberger para la ansiedad estado: taquicardia, hipertensión, palidez, midriasis, sequedad de boca, sensaciones de malestar visceral, sudoración intensa, etc.

9.3. ESTRÉS

El término estrés es uno de los constructos psicológicos más ambiguos, y la conceptualización sobre el mismo es muy variada, dependiendo del campo de la psicología en que nos movamos (psicología clínica, psicología de las organizaciones, psicología de la personalidad, etc.).

Desde el campo de la psicología clínica, el estrés ha sido definido, frecuentemente, como si fuese un estímulo. Este tipo de definiciones hacen hincapié en los acontecimientos del entorno, como puede ser un desastre natural, una enfermedad, la muerte de un ser querido o un despido laboral. Acontecimientos más o menos universales que suelen hallarse fuera del control del individuo, y a los que se denominará estresores.

También puede ocurrir que esos estímulos estresores sí que estén influidos por el individuo, como, por ejemplo, un examen que puedes elegir realizar o no, un viaje en avión que podrías suspender, etc. Incluso, como señala Lazarus, los «ajetresos diarios», es decir, pequeñas cosas que pueden afectarnos en un momento dado, pueden llegar a ser estresores tan importantes como la muerte de un ser querido o de una grave enfermedad. Existen teóricos que defienden que cualquier cambio que exija la adaptación del individuo, sea positivo o negativo, puede tener un efecto estresante (Colmes y Masuda, 1974).

Una de las conceptualizaciones del estrés, considerado como estímulo, más utilizadas es la realizada por Spielberger (1972). Propone que el término estrés debe sólo utilizarse para denotar las condiciones (estímulos) ambientales o circunstancias que se caracterizan por poseer algún grado de peligro físico o psíquico (figura 9.1).

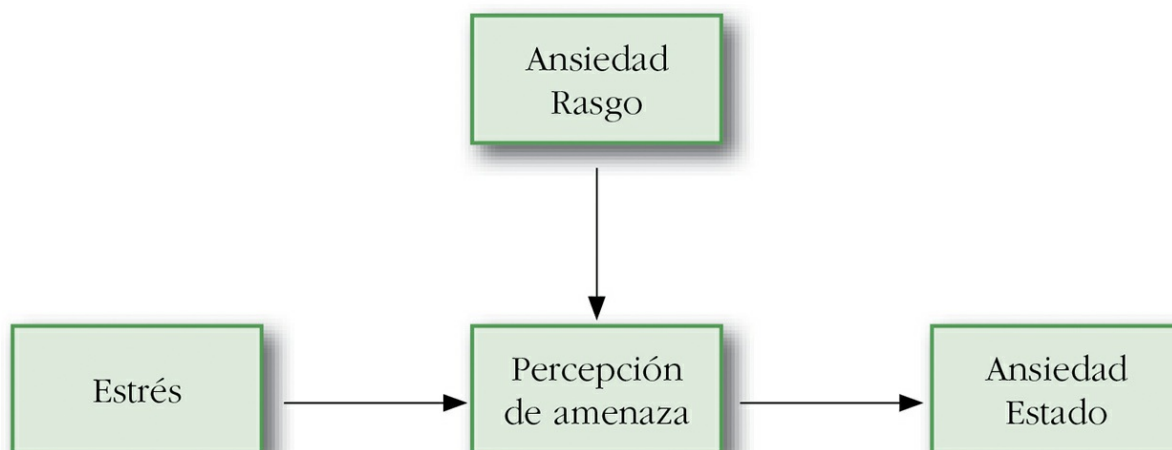


Figura 9.1. *Modelo de ansiedad como proceso de Spielberger donde el Estrés se define como estímulo* ([Descargar o imprimir](#))

En otras ocasiones, el estrés ha sido definido como una respuesta, considerando que cuando la activación (respuesta) del individuo aumenta su intensidad, podemos hablar de un organismo que se halla en situación de estrés. Esta conceptualización (figura 9.2) es frecuente en el campo de la medicina y de la biología y, en cierta medida, hace al estrés sinónimo de ansiedad. Pero tengamos en cuenta que al definir al estrés a través de la respuesta que origina, no disponemos de un modo sistemático con el que podamos identificar prospectivamente aquello que resulta estresante de lo que no lo es, pues obligadamente tenemos que esperar a la respuesta. Además, la respuesta no puede juzgarse como reacción psicológica al estrés sin hacer referencia al estímulo que la ha provocado.

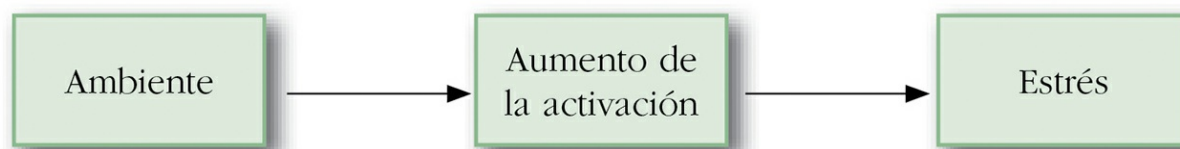


Figura 9.2. *Modelo del Estrés como respuesta* ([Descargar o imprimir](#))

Estas definiciones del estrés, como estímulo o como respuesta, son limitadas en su utilidad. Se hace necesario conseguir determinar de forma específica las condiciones bajo las que ciertos estímulos resultan estresantes. En este sentido, Lazarus insiste en que hay que tener en cuenta las características del sujeto, por un lado, y la naturaleza del medio por otro. Por ello define el estrés como «el resultado de una relación entre el sujeto y el entorno, que es evaluado por este como amenazante o desbordante de sus recursos, y que pone en peligro su bienestar» (Lazarus y Folkman, 1986). Hace, por lo tanto, una ampliación a los modelos anteriores al incluir en el suyo, por un lado, las características personales del individuo y factores situacionales, y por otro, la relación entre el individuo y el entorno (figura 9.3). Debemos de tener en cuenta que Lazarus no utiliza el vocablo ansiedad y, si nos damos cuenta, su concepto de estrés psicológico es bastante similar al concepto de ansiedad estado de Spielberger.

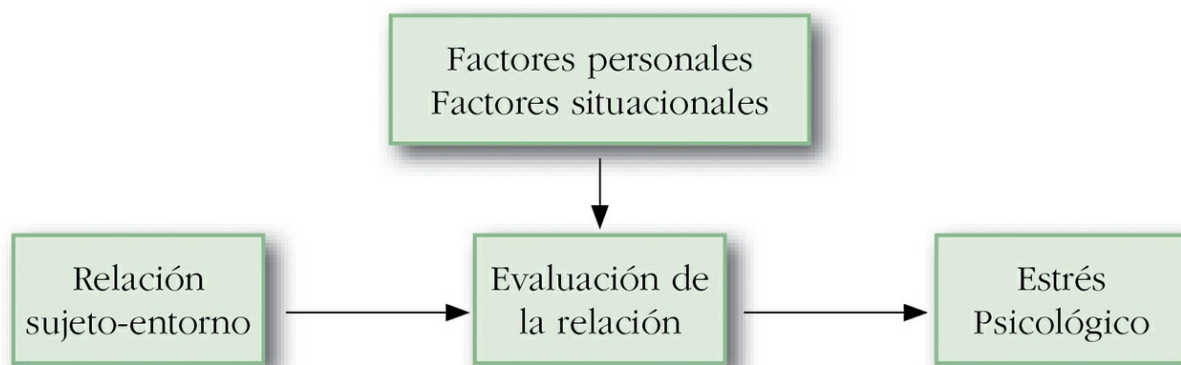


Figura 9.3. Modelo de Lazarus sobre el Estrés Psicológico. ([Descargar](#) o [imprimir](#))

En otras ocasiones, el estrés ha sido definido como un proceso. Éste es el caso de Martens (1970), que define el estrés como «el proceso que comprende la percepción de un desequilibrio sustancial entre las demandas objetivas del ambiente y la capacidad de respuesta, bajo condiciones donde el fracaso se percibe como algo que tendrá importantes consecuencias y a lo que se responde con un incremento de los niveles de ansiedad estado». Justifica esta elección con los siguientes argumentos: a) la ansiedad se ha asociado a menudo con rasgos de personalidad; b) sólo una parte del proceso de ansiedad es descrito por Spielberger, y c) el estrés es a menudo considerado como algo más que un estímulo ambiental.

Por todo ello, Martens se refiere al estrés como a un proceso completo que está asociado con la ocurrencia de un estado de ansiedad, y no sólo al estímulo ambiental que provoca la percepción de amenaza (véase figura 9.4).

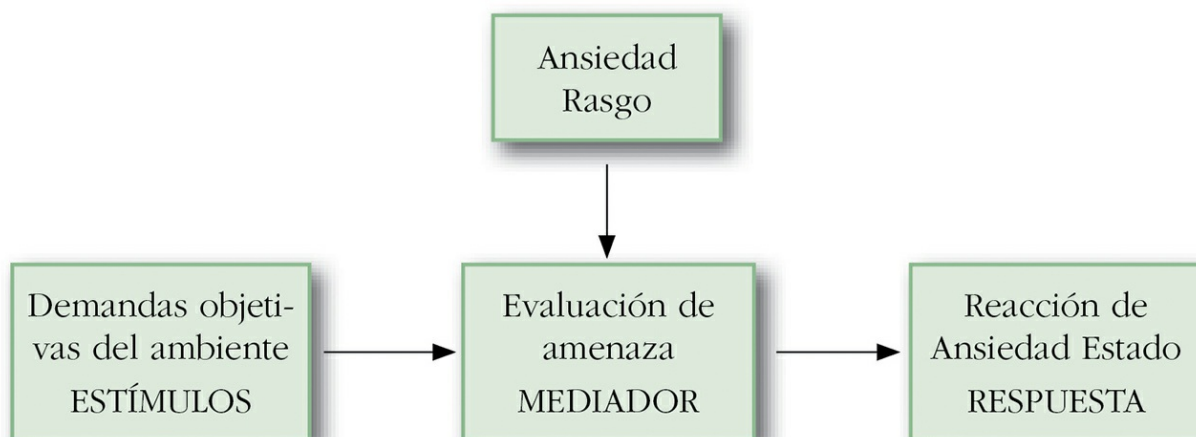


Figura 9.4. Modelo del Estrés propuesto por Martens donde el estrés hace referencia a todo el proceso ([Descargar](#) o [imprimir](#))

Observamos que desde el punto de vista de la psicología no existe un acuerdo unánime sobre cómo conceptualizar el estrés y la ansiedad. Incluso algunos autores llaman ansiedad lo que otros denominan estrés. Todo esto lleva, en ocasiones, a confusiones a la hora de interpretar resultados de investigaciones que no señalen claramente con qué modelo se están manejando. Por ello es muy aconsejable que, al utilizar estos vocablos, digamos en el sentido de quién los estamos utilizando o bien

definamos lo que nosotros vamos a entender por los mismos.

9.4. EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD

Las formas de evaluar la ansiedad más comúnmente utilizadas son los autoinformes, los indicadores conductuales y los indicadores fisiológicos.

1. Evaluación de la ansiedad a través de autoinformes

La medida más comúnmente utilizada para la evaluación de la ansiedad son los autoinformes. Éstos suponen un mensaje verbal que el sujeto emite sobre cualquier tipo de manifestación propia. Los autoinformes son producto de la introspección del individuo que los complementa, y por tanto son informaciones subjetivas. Por este motivo han recibido numerosas críticas al considerarse que pueden ser poco fiables debido a la subjetividad de la situación. También se considera criticable el hecho de que el sujeto puede contestar lo que considere que será mejor visto por los demás. Es decir, los sesgos de respuesta que produce la deseabilidad social. A pesar de todo siguen siendo la medida más popular para la evaluación de la ansiedad, especialmente en la práctica clínica, situación en la que se presupone que el problema de la deseabilidad social será menor, ya que el paciente debe estar más interesado en que se le solucionen sus problemas que en dar una buena imagen.

Además, algunos autores consideran que este tipo de medidas de ansiedad nos pueden proporcionar más información sobre el estado general del sujeto que ninguno de los índices o conjunto de índices de las medidas fisiológicas.

Los autoinformes que evalúan la ansiedad pueden ser «generales», es decir, cuestionarios que preguntan sobre la intensidad o la frecuencia de los síntomas de la ansiedad sin especificar el contexto donde ésta se produce, y cuestionarios «específicos» en los cuales se halla detallada la situación donde se produce la ansiedad.

El autoinforme (general) más comúnmente utilizado es la escala de ansiedad estado-rasgo (STAI) de Spielberger. El STAI es una escala tipo Likert, con dos escalas de 20 ítems cada una, que mide la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. Las respuestas a los ítems se hacen en una escala de 4 pasos que se puntúa de 0 a 3. Por tanto, las puntuaciones de la escala de ansiedad estado y de ansiedad rasgo pueden variar de un mínimo de 0 puntos hasta un máximo de 60.

Existe una diferencia fundamental en la forma de contestar a estas dos escalas. En el caso de la ansiedad estado lo que se evalúa es la intensidad de los síntomas de ansiedad en un momento determinado. Está compuesta por frases con las que el sujeto puede describir cómo se siente con ítems como «me siento calmado», «estoy tenso», «estoy preocupado». Cada ítem se puntúa de la siguiente manera: 0 = nada, 1 = algo, 2 = bastante, y 3 = mucho. En cambio en la escala de ansiedad rasgo lo que se evalúa es la frecuencia general de los síntomas de ansiedad, sin referirse a ninguna

situación concreta. Ejemplos de ítems son: «soy una persona estable», «siento ganas de llorar», «me siento bien». Los ítems se puntúan de la siguiente forma: 0 = casi nunca, 1 = a veces, 2 = a menudo, y 3 = casi siempre.

Siguiendo las instrucciones del manual se obtiene la puntuación directa de las escalas. Posteriormente, utilizando los baremos pertinentes, se transforman estas puntuaciones en centiles, teniendo en cuenta el sexo y la edad del sujeto.

En principio, el STAI fue diseñado para su autoaplicación, por lo que puede ser administrado tanto individual como colectivamente. Este cuestionario puede utilizarse en adolescentes y adultos, con un nivel cultural mínimo para comprender las instrucciones y enunciados del mismo. El STAI ha mostrado una gran validez de constructo (grado en que el test mide una elaboración teórica, es decir, si mide lo que queremos medir) y capacidad para distinguir entre los componentes estado y rasgo.

Ahora bien, no sería aconsejable utilizarlo si nos estamos moviendo con una conceptualización de la ansiedad diferente a la de Spielberger. Existe una gran variedad de autoinformes, desde todas las teorías, pero no vamos a detenernos en su explicación, ya que haría interminable este capítulo.

2. Indicadores conductuales de la ansiedad

La observación de aquellas conductas que vamos a considerar indicadores de la ansiedad puede llevarse a cabo en la situación natural o en situaciones artificiales, ambas tienen ventajas e inconvenientes, y dependiendo del propósito deberían elegirse unas u otras. En la situación natural se puede conseguir una descripción más real, pues estarán presentes todos los estímulos que pueden estar influyendo en la conducta. Sin embargo presenta el problema de que requieren más tiempo, de que sea imposible estar en la situación natural o, incluso, pueden existir problemas éticos. Por su parte, la observación en situaciones artificiales, de laboratorio, son situaciones más controladas en las que resulta más sencillo manipular algunas variables, pero el sujeto percibe la situación como artificial y sabe que nada inesperado puede ocurrir; por tanto, sus conductas no son exactamente las que tendría en una situación real.

Dentro de las mediciones conductuales se pueden distinguir dos tipos: las estrategias directas, en las que se observa la conducta de ansiedad en sí misma (p.ej., si un sujeto tiene miedo a hablar en público, se le hace dar una charla frente a un número reducido de personas y se observan las manifestaciones de ansiedad, como temblor de manos o de voz), y las indirectas, en las que lo que se observa son las conductas de evitación que desarrolla el sujeto ante los estímulos ansiógenos. Se asume que las respuestas de evitación son reforzadas por una reducción de la ansiedad; por tanto, su intensidad debe reflejar la intensidad de la ansiedad que la ha provocado. Así por ejemplo, si un sujeto tiene fobia a las ratas, en un lugar controlado se le pide que se aproxime lentamente a una jaula donde tenemos encerrada una, observando qué conductas utiliza el sujeto para evitar la ansiedad que le provoca la rata y cuál es la intensidad de las mismas.

Este tipo de medidas presentan una cierta ambigüedad en los datos recogidos. Incluso aunque la ansiedad sea considerada como un constructo que está relacionado con ciertos tipos de comportamientos, particularmente con los expresivos y de evitación, es cuestionable pretender que la ansiedad pueda ser identificada por ellos.

Para que la conducta pueda ser considerada como un indicador de la ansiedad se debe tener en cuenta el contexto donde se produce. Por ejemplo, si un sujeto tiembla al entrar en nuestra consulta, esto puede deberse a la ansiedad o simplemente a que hace frío en la calle. La razón de su conducta llegará a ser clara cuando obtengamos información adicional como, por ejemplo, que no hace frío o que no acaba de llegar de la calle.

La conducta observada tiene, además, otro problema, ya que no distingue entre comportamiento ansioso y comportamiento de afrontamiento. Por ello, la situación nos debe proveer de un contexto interpretativo, de forma que los datos conductuales puedan ser adecuadamente evaluados. Por esta razón, el análisis de los datos conductuales no puede concentrarse exclusivamente en la ejecución de un movimiento, sino que se debe tener en cuenta la situación particular que rodea al individuo. Por tanto, si se eligen unos determinados movimientos como objeto de análisis y tratamos de deducir la ansiedad desde estos movimientos reguladores, es esencial que también se registren las verbalizaciones que realiza la persona observada.

3. Indicadores fisiológicos de la ansiedad

Los indicadores fisiológicos pueden ser clasificados como: a) respiratorios y cardiovasculares, b) bioquímicos, y c) electrofisiológicos. Los parámetros que más frecuentemente se han estudiado con respecto a la ansiedad incluyen: pulso, presión sanguínea, tasa respiratoria, indicadores bioquímicos (p. ej., adrenalina y noradrenalina) y medidas electrofisiológicas, como la actividad electrodérmica, los potenciales evocados y la actividad electroencefalográfica.

Las ventajas más destacadas que proporciona el uso de este tipo de evaluaciones son las siguientes: son independientes de las verbalizaciones del sujeto, no exigen autoobservación, permiten una valoración continuada a lo largo de todo el proceso y no distraen la ejecución motora, ya que hay aparatos telemétricos que permiten su medida a distancia.

Sin embargo, también presentan desventajas. Incluso los análisis que están basados en medidas fisiológicas son dependientes del método. Por ejemplo, dos indicadores fisiológicos diferentes, como son la tasa cardíaca y los potenciales de acción del electromiograma, son índices de activación general y sin embargo muestran sólo pequeñas correlaciones (Hackfort y Shwenkmezger, 1989).

Por otra parte, aunque existe acuerdo sobre los efectos fisiológicos de los procesos emocionales, sólo se han encontrado, hasta ahora, unas pocas reacciones específicas para emociones diferentes. Esto significa, por ejemplo, que un incremento en la tasa

cardíaca puede ocurrir tanto en emociones de cólera como de placer.

Otra consideración importante es que los principales indicadores del sistema circulatorio, así como bioquímicos, no pueden ser legítimamente utilizados cuando el organismo está físicamente activado. Estos parámetros cambian mucho más como resultado, por ejemplo, de la actividad física que como resultado de situaciones que induzcan ansiedad.

9.5. TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE LA ANSIEDAD

Intentar combatir la ansiedad es algo muy antiguo. Desde tiempos remotos se han utilizado técnicas que intentaban remediar esa desagradable tensión que sufre el organismo en determinadas situaciones. Aunque aún no existiesen estudios científicos y teorías explicativas de la misma, ni tan siquiera se hubiese acuñado el término, el alivio de la ansiedad ha interesado a todo el mundo. Algunas de las técnicas utilizadas son milenarias, como el yoga o la meditación trascendental.

A mediados del siglo xx empiezan a aparecer terapéuticas modernas, científicamente probadas y generalmente farmacológicas, que suponen un importantísimo avance a la hora de aliviar el sufrimiento de los seres humanos frente a la ansiedad patológica que conllevan numerosos trastornos psiquiátricos. Pero la ansiedad no es sólo un trastorno psiquiátrico, también es uno de los problemas por el que los psicólogos reciben más demandas de ayuda. Así pues, desde hace décadas empieza a ponerse un especial énfasis en lo psicológico a la hora de luchar contra la ansiedad.

Desde la psicología ha existido bastante polémica sobre si es conveniente el uso combinado de fármacos con terapia psicológica, o si esta combinación puede restar efectos a algunas técnicas psicológicas. En el sentido contrario, existen defensores de la utilización exclusiva de la farmacoterapia, especialmente por su rapidez de acción y por el ahorro de tiempo que supone frente a la terapia psicológica. Pese a ello, en la actualidad, la gran mayoría de profesionales suelen ser partidarios de combinar ambos sistemas terapéuticos.

En lo que se refiere a los tratamientos psicológicos, un objetivo fundamental es dotar a los pacientes de recursos que no hagan necesaria una presencia demasiado continuada del terapeuta. Éste es el caso que cumplen adecuadamente las técnicas de relajación y otras técnicas menores, como por ejemplo la biorretroalimentación. Suelen dedicarse una serie de sesiones a su enseñanza por parte del terapeuta, para posteriormente dejar que sea el propio paciente el que las realice solo.

En general, este tipo de técnicas menores se fundamentan en la idea de que es imposible que coexistan la sensación de bienestar corporal y la de ansiedad. Tengamos en cuenta que las respuestas del organismo a la ansiedad provocan pensamientos y actos que comportan tensión muscular, y que esta tensión fisiológica aumenta, a su vez, la sensación subjetiva de ansiedad. Se establece, por tanto, «un círculo vicioso». Del tipo de: «Me parece que me estoy mareando, sería horrible que

me desmayase ahora» —se acelera el ritmo cardíaco—, «¡Cielo santo, a ver si me va a dar un infarto!» —sudoración, sensación de ahogo, tensión muscular—, «Esto es horrible, me voy a morir».

En la línea que defiende que la relajación es incompatible con la ansiedad resultó de vital importancia el libro de Jacobson (1938) titulado *Relajación progresiva*. En él se describe su técnica de relajación muscular profunda (posteriormente la explicaremos), la cual, según su autor, no requiere ni imaginación, ni fuerza de voluntad, ni sugestión.

9.5.1. Principales técnicas para el control de la ansiedad

Las estrategias de intervención psicológica que pueden llevarse a cabo para conseguir el control de la ansiedad son diversas y proceden de diferentes teorías y escuelas psicológicas.

La mayor parte de los programas psicológicos para el control de la ansiedad están constituidos por un conjunto de técnicas elementales: las técnicas de relajación, las técnicas de activación y la biorretroalimentación, que se suelen combinar con otras técnicas psicológicas de corte cognitivo o conductual.

A continuación detallaremos brevemente lo más destacado de las técnicas más utilizadas desde el campo de la psicología.

9.5.1.1. La relajación

Vamos a dedicarle una especial atención a las técnicas de relajación, ya que en casi todos los programas terapéuticos se incluye alguna de ellas.

Entendemos por relajación, o disminución de la tensión, el estado muscular opuesto a la contracción. Si existe una finalidad, por ejemplo vamos a huir del ataque de un perro, es normal y positivo que los músculos se hallen tensos, contraídos, que estén en acción. Pero si no existe finalidad para esa tensión, entonces es negativo y molesto para el que lo sufre.

Como es bien sabido, los músculos voluntarios funcionan en parejas, unos son flexores y otros extensores, pero ambos tipos funcionan igual: acortándose y alargándose. Cuando, por ejemplo, cierro mi mano se contraen los músculos flexores de la misma y los extensores se distienden, se estiran, mientras que cuando la abro se produce el efecto contrario, se tensan los extensores y se distienden los flexores. Así pues, cuando un músculo voluntario de nuestro cuerpo se tensa, su opuesto en el par desarrolla una tensión contraria para mantener la parte implicada en la posición oportuna. Esto puede llegar a producir unos niveles de tensión muscular muy elevados. Lo que generalmente ocurre es que nos pasa inadvertida hasta que el nivel de tensión es tan grande que se produce dolor. Esto es muy frecuente en ciertas zonas del cuerpo, como por ejemplo el cuello o la zona lumbar de la espalda, cuando

trabajamos en posturas forzadas y continuadas.

La tensión se manifiesta a tres niveles: fisiológico, conductual y subjetivo. El nivel fisiológico incluye los cambios viscerales, somáticos y corticales. Por su parte, el nivel conductual se refiere a los actos externos directamente observables del organismo (hiperactividad, huida, expresiones corporales y faciales de tensión, etc.). Por último, el nivel subjetivo hace referencia a la experiencia interna consciente del propio estado emocional o afectivo (sensación de malestar, de desasosiego, de inquietud, etc.).

Es evidente que es necesario que siempre exista un cierto grado de tensión muscular, pues de lo contrario no podríamos ni siquiera mantenernos de pie. Asimismo, una fuerte activación es necesaria si lo que vamos a realizar (huir de un peligro corriendo, jugar un partido de tenis, etc.) lo requiere. Pero es frecuente que algunos de nuestros músculos trabajen innecesariamente o en exceso.

En lo que se refiere a la relación que existe entre exceso de tensión muscular y ansiedad, Jacobson (1938) señaló que las tensiones psicológicas, los pensamientos indeseados, la sobrecarga nerviosa u otros aspectos mentales pueden provocar un exceso de tensión muscular. También comprobó que si enseñaba a los sujetos a relajar su musculatura, se reducía su ansiedad. Es decir, era prácticamente imposible que existiese ansiedad sin hipertonía, y por lo tanto, eliminando ese exceso de tensión podríamos rebajar, o incluso eliminar, la ansiedad.

Debemos tener en cuenta que la mayoría de las personas desconocen los músculos que están tensos de una forma crónica en su cuerpo o los que trabajan innecesariamente y por tanto deben ser entrenados para tomar conciencia de ello.

Como señalan Harris y Harris (1987), la relajación significa no desarrollar ninguna actividad muscular o llegar lo más cerca posible de la actividad cero. Las técnicas de relajación pretenden conseguir que el sujeto controle su tensión muscular, reduciendo al máximo la tensión de su musculatura voluntaria, acompañado esto de una reducción de la actividad de la musculatura involuntaria.

El entrenamiento en relajación puede utilizarse como un fin en sí mismo, considerándose un método para reducir la tensión o activación innecesaria y secundariamente la ansiedad, o como un componente de programas más completos, ya que al estar relajado se facilita, por ejemplo, la imaginación, por lo que es adecuado en aquellos programas en los que se utilice esta última.

Así pues, las técnicas de relajación siempre pretenden lo mismo: conseguir un grado saludable de distensión muscular y ausencia de ansiedad y tensión psicológica. Aunque algunas ponen más énfasis en lo somático, mientras que otras lo hacen en lo mental.

A continuación presentaremos algunas de las principales técnicas de relajación. En todos los casos es aconsejable que la iniciación o aprendizaje de las mismas se realice por un profesional.

1. La relajación muscular progresiva

La relajación progresiva es un método desarrollado por Jacobson en 1934. Este autor fue pionero en el entrenamiento en relajación, desarrollando un método fisiológico para combatir la tensión y la ansiedad. Ya en sus primeras investigaciones se había dado cuenta de que la tensión que se presentaba cuando una persona manifestaba «ansiedad» implicaba un esfuerzo que se traducía en el acortamiento de las fibras musculares, y que dicha ansiedad podía ser eliminada haciendo desaparecer la tensión. Jacobson descubrió que tensando y relajando sistemáticamente varios grupos de músculos, y aprendiendo a atender y a discriminar las sensaciones resultantes de la tensión y la relajación, una persona puede eliminar, casi completamente, las contracciones musculares y experimentar una sensación de relajación profunda. La culminación de estos estudios fue la técnica de relajación progresiva.

Este tipo de relajación se llama progresiva porque se avanza de un grupo de músculos a otro a medida que se va dominando la técnica. Se pretende proporcionar el modo de identificar los músculos o grupos de músculos que están en tensión y distinguir entre la sensación de tensión y relajación.

Los supuestos de la relajación progresiva son los siguientes:

- a) Pretende ser una técnica fisiológica centrada en la relajación de la musculatura esquelético-motora.
- b) El programa de entrenamiento se basa en la discriminación de las señales de tensión en los distintos músculos a través de ejercicios sistemáticos de tensión-relajación.
- c) La relajación de la musculatura esquelético-motora conlleva automáticamente la relajación del sistema autonómico-vegetativo y la relajación del sistema nervioso central.
- d) La relajación fisiológica produce efectos paralelos en la relajación emocional (a través del sistema nervioso autónomo) y en la relajación cognitiva (a través del sistema nervioso central).

En algunas situaciones especiales el uso impropio del entrenamiento en relajación progresiva puede tener efectos negativos; por tanto, no se debe emplear la técnica sin explorar primero ciertas áreas, como por ejemplo que existan bases orgánicas que puedan estar causando las molestias que tratamos de eliminar.

a) El entorno y la postura corporal

Cuando se está aprendiendo esta relajación es importante cuidar el entorno físico que rodea a la persona, ya que éste puede facilitar o dificultar el aprendizaje. En general debe buscarse una habitación silenciosa y cómoda. Las ventanas y las puertas deben estar cerradas para eliminar la visión y los ruidos del exterior, también es importante cuidar la iluminación que debe ser tenue de tal forma que no moleste al sujeto que se está relajando pero que permita al entrenador cierta luz para observar

los signos de relajación. Cuando la persona haya aprendido a relajarse en estas condiciones se puede ir generalizando poco a poco a otras situaciones más cotidianas hasta conseguir que el sujeto sea capaz de relajarse en cualquier situación.

Dependiendo del tipo de relajación progresiva que se esté entrenando, es decir, tumbado o sentado, se debe contar con un sofá amplio, o con una cama, una colchoneta, un sillón o una silla, donde el sujeto pueda estar con los brazos y las piernas extendidos y apoyados.

También se debe sugerir que la persona lleve ropa cómoda y suelta para las sesiones, así como que se desprenda de todo aquello que pueda interferir en su libertad de movimientos, como las gafas, reloj, zapatos, etc.

b) Instrucciones iniciales

Se dedica una sesión preliminar a explicar en qué consiste el procedimiento que se va a seguir. Debe enfatizarse que se trata de un entrenamiento en la discriminación de las sensaciones de tensión y relajación de sus músculos. Por otra parte, es importante insistir en que para conseguirlo deberá practicar, de la misma manera que practicaría otras habilidades. Para ello, en algunos casos, es interesante pedir colaboración a la familia de tal manera que respeten los momentos en que la persona está practicando sin que se le interrumpa o moleste.

Por otra parte es aconsejable que el sujeto se comprometa a un programa regular de práctica, de tal forma que se detalle el número de sesiones por día, los días que debe practicarla, la duración de las sesiones y el lugar en que se va a realizar. Si es necesario, se puede ayudar a través de grabaciones realizadas por el terapeuta, que le vayan indicando el orden en que debe ir tensando y relajando los músculos de manera adecuada, así como que le proporcione instrucciones sobre dónde debe focalizar su atención en cada momento. Por último se le informa de que puede ayudarse de la imaginación.

Se le debe explicar que va a aprender una técnica de autocontrol que le puede ser útil en cualquier momento de su vida y que puede utilizar antes de una situación que le produzca ansiedad, durante la misma y después de ella, si se sigue sintiendo ansioso. Además, si practica relajación regularmente, podrá mantener un nivel bajo de ansiedad en su vida cotidiana.

c) El programa de relajación progresiva

La mayoría de las modificaciones, sobre el programa establecido por Jacobson, que se utilizan actualmente, requieren menos tiempo que el recomendado por él. No obstante, en lo sustancial se mantiene lo mismo: el entrenamiento es progresivo, se avanza de un grupo de músculos a otro a medida que se ha adquirido práctica en el precedente.

La relajación puede realizarse en diferentes posturas: tumbado, sentado, de pie e incluso andando. Nosotros vamos a explicar el método, propuesto por Cautela y Grogen en 1978, que se realiza en posición sentada y actúa sobre 16 grupos de músculos. Este método tiene la ventaja de mantener las características básicas de la técnica original de Jacobson, pero introduciendo algunos elementos importantes que proceden de la psicología del aprendizaje y de las aplicaciones de la técnica en terapia y modificación de conducta.

Una vez que el sujeto domine el procedimiento de 16 grupos musculares, podrá pasar a entrenarse a través del procedimiento de 7 paquetes musculares. En este procedimiento se realiza una agrupación de los 16 músculos en 7, con el objeto de reducir el tiempo necesario para alcanzar el estado de relajación.

A su vez, cuando ya domine el procedimiento de relajación de 7 paquetes musculares, podrá pasar a relajarse a través del procedimiento reducido de 4 paquetes musculares. La finalidad es conseguir la relajación con el menor tiempo posible.

Pasos del programa

Primero se explica en qué consiste la técnica. A continuación se pasa a enseñar cómo debe realizar los ejercicios. Para ello se le indica el orden muscular que va seguirse y la forma en que se debe realizar la tensión y la relajación de los mismos.

En algunas ocasiones al sujeto le puede ocasionar vergüenza el tener que realizar ciertas muecas o posturas. Para reducir este tipo de conductas el psicólogo puede mostrar cómo se realizan los ejercicios haciéndolos primero él mismo e invitando al sujeto a que le imite. Por otra parte, ante las risas o comentarios irónicos, bien de familiares o de compañeros que estén presentes (p.ej., si se hace en grupo), lo mejor es no hacerles caso, es decir, practicar la extinción ante ese tipo de conductas (García-Merita, Pons y Atienza, 1994).

Para comenzar la relajación el sujeto debe estar sentado, con la cabeza firme, la espalda apoyada en el respaldo, los pies apoyados en el suelo, sin cruzar las piernas y con las manos sobre los muslos, adoptando la posición más cómoda posible. También puede realizarse la relajación estando tumbado en el suelo o en una colchoneta.

Comenzamos explicando que debe realizar siempre lo mismo, pero en cada ocasión con un grupo de músculos distinto, esto es:

1. Tensar los músculos todo lo que pueda, sin llegar a hacerse daño, durante unos 5 segundos.
2. Fijar su atención en lo que siente y dónde lo siente, mientras tiene el músculo tensado.
3. Relajar los músculos poco a poco sintiendo cómo desaparece la tensión.
4. Disfrutar de la sensación agradable que produce el tener los músculos relajados durante 20 o 30 segundos.

Hay que advertirle que debe intentar mantener relajado el resto del cuerpo y que

aunque esto puede parecerle difícil, se consigue con la práctica.

A continuación se empiezan los ejercicios según el orden muscular que se le ha indicado. La primera vez puede mantener los ojos abiertos y el psicólogo le va ayudando a realizar los ejercicios. En sesiones posteriores se le sugiere que los cierre.

Una vez que ya sabe realizar los ejercicios de tensión-relajación y los de respiración, llevamos a cabo una relajación completa.

El sujeto se coloca en la posición inicial y realiza una respiración profunda quedando con los ojos cerrados al final de la misma. Entonces empezamos los ejercicios de tensión-relajación tal y como se ha indicado anteriormente.

Al finalizar los mismos se le pregunta si tiene todos sus músculos relajados a lo cual la persona nos debe responder con una señal previamente establecida para decir que sí o que no, como por ejemplo levantar un dedo de la mano derecha o izquierda según lo haya conseguido o no. En el caso de que nos responda que no, el psicólogo irá mencionando los grupos de músculos hasta que la persona nos indique que ha conseguido relajarlos. Esto se repetirá cuantas veces sea necesario.

Una vez se ha logrado la relajación en todos los grupos de músculos se puede profundizar más en ella repitiendo la lista lentamente y dándole instrucciones de mayor relajación, esta vez sin tensión previa. Por ejemplo: «los músculos de su frente están más y más relajados, siente como están laxos, sueltos», «nota cómo sus párpados pesan, y se relajan cada vez más», «la nariz y las mejillas están cada vez más relajadas», etc.

Cuando se ha terminado de repetir la lista de músculos se realizan cinco respiraciones profundas sintiendo cómo todo el cuerpo queda totalmente relajado. Al finalizar las respiraciones profundas puede dedicarse unos minutos a disfrutar del estado de relajación y realizar ejercicios de imaginación o salir de la misma.

El psicólogo debe estar muy atento a lo que le está ocurriendo al sujeto y reforzarlo constantemente cuando lo esté haciendo correctamente. El tono de voz en general es bajo, pero cuando le estamos dando las instrucciones de tensión puede ser un poco más enérgico, y sin embargo cuando le estamos indicando que debe relajar los músculos nuestra voz debe ser suave y más lenta, utilizando frases como: «libero la tensión de mi cuerpo», «me siento calmado», «libero mis músculos», etc.

En algunos casos, la persona puede quedar un poco desorientada o con somnolencia; cuando esto ocurre se le debe explicar que es totalmente normal y que se le pasará pronto. En raros casos puede presentar cierta dificultad en pasar a la actividad, habiéndose quedado como dormido o traspuesto; en estos casos debe dársele la orden de abrir los ojos, con energía y acompañada de una fuerte palmada o chasquido de los dedos cerca de los oídos.

Cuando se ha terminado la relajación se evalúa cómo ha ido todo el proceso preguntándole si se ha relajado totalmente, si ha sido una experiencia agradable, si ha tenido problemas de cualquier tipo, etc.

Una vez que el paciente, ha aprendido a relajarse se le indica que la relajación es una habilidad como otra cualquiera; por lo tanto, se adquiere practicándola, y que cuanto más la practique conseguirá una relajación más profunda.

Normalmente el tiempo de entrenamiento que se requiere es de una a dos semanas, a razón de 15 minutos al día y si es posible de dos sesiones diarias.

Para facilitar la práctica es conveniente que la persona se comprometa a un programa regular y se fije el número de sesiones que se van a realizar, la duración de las mismas, el momento del día y el lugar más conveniente.

Como señalábamos anteriormente, cuando la persona ya ha aprendido a relajarse mediante los ejercicios de tensión-relajación de los 16 grupos musculares, y discrimina estas sensaciones, se puede pasar a trabajar la relajación sobre 7 grupos musculares principales.

Los siete grupos principales de músculos son:

1. Músculos del brazo dominante, mano, antebrazo y bíceps.
2. Músculos del brazo no dominante, mano, antebrazo y bíceps.
3. Frente, parte superior de las mejillas y nariz, parte inferior de las mejillas y mandíbulas.
4. Cuello y garganta.
5. Músculos del tórax, hombros, espalda y abdomen.
6. Músculos del muslo, pantorrilla y pie dominante.
7. Músculos del muslo, pantorrilla y pie no dominante.

Del mismo modo, una vez dominado este procedimiento, el sujeto podrá pasar al practicar el procedimiento de cuatro grupos musculares.

Los cuatro grupos principales de músculos son:

1. Músculos de la mano, antebrazo y bíceps.
2. Músculos de la cabeza, cara, cuello, hombros; también la frente, mejillas, nariz, ojos, mandíbula, labios y lengua.
3. Músculos del tórax, de la región del estómago y de la región lumbar.
4. Músculos de los muslos, nalgas, pantorrillas y pies.

2. La relajación dinámica

La relajación dinámica es una técnica sofrológica que fue ideada por Caycedo. Está inspirada en técnicas orientales, pero no las imita ni pretende seguir sus fines culturales o religiosos (Espinosa, 1986).

El término sofrología etimológicamente proviene del griego *sos* (armonía, serenidad), *phren* (mente) y *logos* (estudio o tratado). La sofrología es una escuela creada por Caycedo en 1960, cuando estaba en Madrid de médico interno en el servicio de Psiquiatría del profesor López Ibor.

Caycedo (1971) defendía que el objeto de la sofrología era el estudio de la conciencia y su patología. Sin embargo, Rojo Sierra considera que lo que hace esta técnica es conseguir que el sujeto se sitúe en un estado especial de conciencia al que llama Caycedo «sofroliminal», similar al que Rojo llama nivel beta (ver Rojo Sierra,

En torno a la conciencia humana). Conseguido esto, ejercitando la vivencia de la imagen corporal (eidosoma) dirigiendo la autoconciencia voluntariamente hacia ella, se alcanza la *Sofronikos* (etimológicamente: «ser de inteligencia elevada, templado de carácter y con sentimientos elevados»).

Caycedo recupera algunos términos de la antigua filosofía griega. Así por ejemplo, toma de Platón, en su diálogo *Cármides*, la idea de que la auténtica curación supone una armonía entre el cuerpo y el espíritu, que no se puede curar la parte sin atender al todo, y que para ello son muy importantes las palabras o discursos. Para ello, Caycedo acuñó otro término: el *terpnos-logos* (*terpnos* = agradable, sugerente, y *logos* = habla, palabra). Este *terpnos-logos* son palabras persuasivas que actúan sobre aquella parte de la mente, el timos, donde el cuerpo y el espíritu se unen, para producir un estado de bienestar, de armonía cuerpo-espíritu. Caycedo crea, pues, el término *terpnos logos* para designar la forma de hablar del terapeuta sofrológico cuando se dirige a sus pacientes. Por otra parte, como el propio Caycedo (1971) señala, la relajación dinámica respeta las estructuras fundamentales del yoga, del budismo tradicional y del zen. Estas técnicas las aprendió el autor en profundidad aprovechando su larga estancia en India y en Japón.

Puede resultar a primera vista paradójico hablar de relajación y de dinamismo ya que, como decíamos al principio, generalmente se entiende por relajación no realizar ninguna actividad muscular. Sin embargo, Caycedo ha demostrado que la sofronización puede ser dinámica e, incluso, puede practicarse de pie, sin que se altere el equilibrio. Los diferentes ejercicios intercalados piden un cierto grado de tensión muscular, pero permiten que durante la fase de recuperación se profundice en la distensión mental. La alternancia tensión-distensión, hacen que cada vez sea menor el tono muscular, aumentando la relajación mental, por desactivación de la formación reticular (Davrou, 1985). Esto se consigue cuando el sujeto, bien entrenado, lleva tiempo practicando.

No debemos confundir la ausencia de movimiento de nuestros órganos corporales con la relajación muscular de los mismos. Podemos tener un brazo quieto y apoyado en un sofá, pero que sus músculos estén tensos, contraídos, y tengan un tono muscular demasiado elevado para la actividad que están realizando. El descenso del tono muscular es lo que debe conseguir una buena técnica de relajación, para que nuestros músculos gasten la menor energía posible cuando esto no sea necesario.

Además, la relajación dinámica de Caycedo tiene otra ventaja añadida: su práctica se hace en condiciones tan parecidas a las que nos son habituales (no es necesario que haya poca luz, ni que no haya ruidos, ni que estemos tumbados...) en la vida cotidiana que su generalización es muy sencilla. Esto es especialmente importante para aquellas personas que no pueden permitirse ni lugares ni condiciones especiales para conseguir una buena relajación.

La relajación dinámica es tanto un método de sofronización individual como de grupo. Se divide en tres grados distintos que pretenden conseguir la integración de tres funciones esenciales: la función sensorial, el primer grado; la función afectiva, el segundo grado, y la función intuitiva, el tercer grado.

Estos tres grados constituyen un método perfectamente estructurado y ordenado cronológicamente que debe observarse escrupulosamente. Efectivamente no puede practicarse el tercer grado sin tener perfectamente integrados los grados I y II.

Cada uno de los grados se entrena habitualmente durante nueve días, distribuidos generalmente a tres días por semana con una hora de duración por día. Así el entrenamiento completo se suele llevar a cabo en tres ciclos de nueve días cada uno.

Por medio del entrenamiento sofrológico y de las técnicas de relajación dinámica, la persona enriquece su conciencia en el sentido de integrar, equilibrar y activar la vivenciación de su personalidad y de su esquema corporal.

No pretendemos presentar cómo se lleva a cabo la preparación integral mediante técnicas sofrológicas, ya que éstas suponen una filosofía del ser humano que pretende conseguir la «integración de la personalidad». Pero queremos presentar aquí la relajación dinámica de Caycedo por dos razones: porque nos permite aproximarnos al conocimiento de lo que son las técnicas sofrológicas y porque, pensamos, que esta técnica puede utilizarse como una técnica de relajación aisladamente aunque no se participe totalmente de la filosofía sofrológica o no se realice el programa sofrológico completo. Incluso es suficiente utilizar sólo el primer grado de la misma, si lo que buscamos es una técnica de relajación. No obstante, aunque sea de modo abreviado expondremos los grados segundo y tercero.

a) La relajación dinámica: el primer grado

En líneas generales, y muy resumidamente, diremos que el primer grado es una aproximación sofrológica de técnicas del raja yoga hindú.

El raja yoga es practicado por los grandes yoguis del Himalaya, los cuales utilizan ejercicios físicos y meditación para realizar una serie de autoanálisis que les permitan conseguir una hiperclaridad de conciencia.

Se denomina también relajación dinámica concentrativa, ya que va a poner énfasis en el aprendizaje de la concentración que permita la toma de conciencia de la corporalidad (función sensorial) en tanto que realidad vivida.

El entrenamiento en este primer grado permite, poco a poco, pasar de la sensación a la percepción y dirigirse hacia la emoción. Es como si el profundizamiento sensorial, gracias a la repetición de las sensaciones, pudiese permitir llegar a la percepción necesaria para la emoción. Para este proceso es absolutamente esencial la integración del esquema corporal.

El entrenamiento en el primer grado permite progresar en el aprendizaje de la toma de conciencia de tensiones persistentes, ya que son ellas las que hay que captar e identificar después de los ejercicios, durante la fase de recuperación.

Las señales informativas pueden no ser más que sensaciones vagas, indeterminadas, que no son bien identificadas. Cuando estas sensaciones son identificadas y evaluadas podemos hablar de percepciones discriminativas. Como sabemos, la percepción y la emoción están íntimamente ligadas, de forma que cuando

la percepción disminuye, la emoción disminuye también.

Este grado conlleva una serie de ejercicios que pretenden amplificar las sensaciones corporales, a fin de que puedan ser percibidas lo más finamente posible después del período de recuperación que sucede a cada ejercicio. Se alternan ejercicios con períodos de reposo o recuperación. Se puede realizar de pie, sentados o tumbados (esta última posición es cada vez menos utilizada). Precisamente uno de los más importantes descubrimientos que nos aporta el primer grado es que podemos relajarnos en cualquier posición.

Esquema general de aplicación

1. Explicación del método, del fundamento de la técnica y de los ejercicios que van a hacerse ese día.
2. Ponerse en posición de pie, manteniendo bien el equilibrio (las piernas ligeramente abiertas, los brazos colgando a lo largo del cuerpo).
3. Calentamiento mediante algunos movimientos de estiramiento y ensayo de la respiración abdominal.
4. Sofronización simple. Ésta es la técnica de base. Comprende dos partes: el proceso de relajación muscular y la distensión mental. Viene a durar unos cinco minutos. Sus fases están perfectamente estereotipadas:
 - a) Relajación del rostro y de la cabeza.
 - b) Relajación de los hombros y de los miembros superiores que favorece al mismo tiempo la relajación del cuello y la nuca.
 - c) Relajación de la espalda, del pecho y del vientre, con la liberación de la respiración.
 - d) Relajación de la parte inferior del cuerpo: pelvis, periné y miembros inferiores.
 - e) La distensión mental, profundizando el nivel de conciencia hasta llegar al borde mismo del sueño (nivel sofroliminal) pero sin perder la autoconciencia.
5. Primer ejercicio de activación, relajación recuperativa, segundo ejercicio de activación, relajación recuperativa, tercer ejercicio de activación.
6. Relajación recuperativa en posición sentado con profundización del «nivel sofroliminal».
7. Concentración mental sobre un objeto neutro.
8. Desofronización o activación general.

A continuación vamos a presentar detenidamente estos ocho pasos, según lo enseña uno de los principales discípulos de Caycedo: el doctor Mariano Espinosa.

Aunque cualquier persona puede probar a autoaplicársela, es importante señalar que es muy conveniente que la explicación de la técnica y las primeras sesiones

corran a cargo de un especialista.

Explicación pormenorizada de los pasos del primer grado

1. *Explicación del método*

Una vez explicado en qué consiste el método y cuáles son los fundamentos científicos, se le pide al practicante que se ponga ropa cómoda cada vez que vaya a realizar la relajación (aunque esto no es imprescindible una vez que se domina la técnica) y que se quite los zapatos.

2. *Postura y equilibrio*

En posición de pie, se le explica la postura más adecuada y se insiste en que es importante que note que mantiene el equilibrio.

3. *Calentamiento y respiración*

A continuación, estando de pie, se realizan algunos ejercicios de estiramiento (un minuto o dos). Luego se ensaya la respiración abdominal, diciéndole:

Vamos a ensayar ahora unas respiraciones abdominales. De pie y con los ojos abiertos (apoyando al principio sus manos en el abdomen y la espalda para captar la sensación de fuelle) espire contrayendo el abdomen (tire todo el aire que tenga) e inspire relajándolo, de tal forma que su abdomen se hinche cuando inspire y se vacíe cuando tire el aire, como un fuelle (esto se repite tres veces).

Ahora cierre los ojos (a partir de ese momento toda la técnica se realizará con los ojos cerrados). Si en algún momento se siente incómodo o se marea puede abrirlos y volverlos a cerrar y así cuantas veces lo considere. Mantener los ojos cerrados es sólo para facilitar la atención.

4. *Técnica de sofronización simple (TSS)*

A continuación tome conciencia de la forma de la cara y trate de aflojar los músculos de la misma... la frente... los párpados... las mejillas... las mandíbulas... el labio superior... el labio inferior... la lengua. Tome conciencia de la forma de los hombros y trate de aflojarlos, sin esfuerzo, sin pretender hacerlo bien, sólo tiene que hacerlo.

La relajación del cuello y la nuca se conseguirá conforme vaya logrando relajar la cara y los hombros. Tome conciencia del cuello y la nuca y trate de aflojar sus músculos.

Se encuentra bien... tranquilo... con energía...

Ponga la atención sobre los brazos aflojándolos, sin intentar hacerlo bien y sin esfuerzo, lentamente... ponga la atención en los codos... intente aflojarlos... ponga su atención en los antebrazos... intente aflojarlos... en las muñecas... en las manos...

incluso en los dedos de las manos. Ponga atención sobre el tronco... relaje la espalda... la tripa. Ahora su respiración se torna más tranquila, es una respiración muy agradable... suave... profunda... en calma.

De momento, como está de pie, no va a relajar las piernas, pero tome conciencia de cómo le sostienen, dese cuenta de la sensación de equilibrio. Ésta es una sensación muy agradable.

A partir de este momento intente mantenerse en este nivel de conciencia, a ras del sueño, en que se encuentra. Mientras, realizaremos una serie de ejercicios y relajaciones (TSS) intercaladas que le van a permitir tomar conciencia de sus propias sensaciones vitales.

5. Activación, relajación recuperativa

5.1. Activación: estimulación de cuello y nuca

Ahora inicie unos movimientos de cuello, muy lentos y suaves, primero hacia adelante como si quisiese tocarse el pecho con la barbilla, luego hacia atrás como si quisiese tocar la espalda con la nuca, luego hacia la derecha... ahora hacia la izquierda. Ahora deje que su cabeza gire describiendo un círculo alrededor de sus hombros, muy suavemente, muy lentamente, esto suele resultar muy agradable, como un masaje... Ponga atención en la sensación de los músculos de cuello y nuca, y observe que guarda el equilibrio.

5.2. Relajación (TSS) recuperativa intercalada

Ahora vuelva a la relajación nuevamente. Afloje más si puede los músculos de la cara... de los hombros... de los brazos... del tronco (TSS), poniendo especial atención en las sensaciones de recuperación.

5.3. Activación: Estimulación de la cintura escapular

A continuación realice el ejercicio de hombros (que consiste en elevarlos y bajarlos rápidamente como si con ellos dijese que «no sabe» muy deprisa y enérgicamente). Para ello, primero expulse bien todo el aire, ahora inspire profundamente, mantenga dentro el aire y mueva los hombros arriba y abajo, enérgicamente (diez veces)... ¡expulse el aire! de golpe como si quisiese apagar un montón de velas (repita esto tres veces intercalando relajación recuperativa entre cada uno de los ejercicios).

Relajación... Ahora, otra vez, tire el aire... respire profundamente... aguante el aire... mueva los hombros enérgicamente... ¡tire el aire!... Relajación... Una vez más... expulse el aire del todo... tome el aire... aguántelo... mueva los hombros enérgicamente... ¡tire el aire!

5.4. Relajación (TSS) recuperativa

Intente soltar los músculos de la cara, de los hombros, el cuello, la nuca, los brazos, el tórax... el vientre... note las sensaciones de recuperación.

5.5. Estimulación global del cuerpo

Después de la última relajación vamos a realizar un ejercicio de brazos. Espire el aire como en el ejercicio anterior, inspire profundamente, retenga el aire y levante los brazos hacia arriba como si quisiera tocar el techo, expulse el aire al mismo tiempo que baja los brazos, así tres veces con relajación (TSS) intercalada.

6. *Relajación recuperativa en posición sentado (TSS)*

Después de la tercera vez siéntese en una silla (que previamente tendrá detrás) o tumbese en el suelo, con la cabeza apoyada sobre el occipucio, los brazos semiflexionados apoyados en el suelo y las piernas entreabiertas dejando caer los pies hacia fuera.

Ahora relájese (TSS) (en este caso se incluye la pelvis, el periné y las piernas).

7. *Concentración sobre objeto neutro*

En este paso intente imaginar durante la relajación un objeto neutro, a ser posible natural, cualquier cosa... se trata sólo de mantener el recuerdo del objeto libremente elegido, sin esfuerzo y sin que importe que le vengan a la mente otros objetos (esto es un comienzo de ensayo para el segundo grado).

8. *Técnica de desofronización o activación general*

Por último vamos a pasar al estado activo, sin prisas, notando bien las sensaciones de movimiento, de energía. Realice unas cuantas respiraciones profundas y vaya estimulando progresivamente todo el cuerpo. Empiece por apretar los puños y extender luego las manos, cierre fuertemente la boca, contraiga todos los músculos de la cara, desperécese y estire los brazos... ahora las piernas, mueva los pies... contraiga los dedos de los pies. Ponga atención y note las sensaciones musculares de activación. Ahora, cuando lo considere oportuno, puede abrir los ojos, permaneciendo unos momentos sin incorporarse. A continuación puede levantarse pero sin brusquedad.

b) La relajación dinámica: el segundo grado

El segundo grado es una aproximación sofrológica de técnicas budistas tibetanas. También se denomina relajación dinámica contemplativa, ya que pone énfasis en la contemplación del esquema corporal (función afectiva o emocional). El entrenamiento en el segundo grado permite la toma de conciencia de la función emocional.

La emoción es una respuesta del sistema neurovegetativo y endocrino que se manifiesta a través de la musculatura lisa y estriada. La contracción del esófago, con dificultades para respirar, los espasmos de la vesícula biliar, son por ejemplo respuestas de la musculatura lisa a la emoción, mientras que las respuestas de la musculatura estriada se manifiestan por la tensión persistente de la misma. Así pues, percepción, emoción y respuesta neuromuscular tienen una estrecha relación. Precisamente es gracias a las tensiones musculares persistentes como se realiza la percepción de las emociones.

La relajación dinámica da una importancia capital a la toma de conciencia de las manifestaciones de la emoción para conseguir una auténtica autonomía. De otro modo nos arriesgamos a que la mayor parte de nuestras acciones estén determinadas por las tensiones persistentes de nuestras experiencias precedentes.

Esta noción es importantísima en sofrología, ya que permite comprender por qué una experiencia negativa, con sus manifestaciones «dolorosas» adicionales, puede influir en la siguiente experiencia, y así sucesivamente en un verdadero círculo vicioso.

De la misma manera ocurre con las manifestaciones emocionales positivas y sus experiencias consecuentes. Esto es precisamente lo que puede conseguirse a través de la sofronización.

La toma de conciencia de las manifestaciones de la emoción es tanto más importante si las tensiones persistentes se acompañan de imágenes visuales, auditivas y de monólogos interiores que pueden persistir e influir en las experiencias futuras.

Los ejercicios de este grado pretenden forzar la toma de conciencia de la corporalidad, en el presente, por su evaluación en el espacio, por la integración de su participación en el mundo, gracias a la capacidad de autovisualización.

Se aconseja siempre empezar el segundo grado con la práctica de algún ejercicio del primer grado. Se inicia de pie delante de una silla, tomando conciencia en esta posición de la sensación de equilibrio.

Los contenidos, abreviados, los presentamos a continuación:

1. En posición de pie se realizan algunos ejercicios de calentamiento

Se le sugiere al practicante que cierre los ojos, manteniéndose así durante todo el tiempo. Se dirige una técnica de sofronización simple, igual que hemos comentado en el grado uno, pero haciendo énfasis en la percepción del equilibrio.

2. Estimulación de la toma de conciencia de la verticalidad

Es la única estimulación que se realiza de pie. Se entrecruzan los dedos de las manos. Se realiza una inspiración prolongada y profunda, reteniendo el aire. Se elevan rápidamente las manos cruzadas por delante de la frente (con las palmas hacia la cara), sin tocarla. Se está un momento así tomando conciencia de la altura del cuerpo. Luego se hacen descender lentamente las manos cruzadas, coordinando el tiempo de descenso con la espiración prolongada. Esto se repite tres veces y luego se

sienta en la silla que tenía detrás.

3. Relajación recuperativa intercalada (TSS)

Igual que en el primer grado, pero se le pide que cambie el objeto neutro que había aprendido a visualizar, por sí mismo, siendo ahora él el único objeto de concentración. Se le sugiere que intente verse como si se mirase desde fuera, de frente, de perfil, por detrás...

4. Estimulación de la toma de conciencia de la longitud, forma y sensación de espacio ocupado por todo el cuerpo

Se entrecruzan los dedos de las manos, éstas se llevan detrás del occipucio como si se apoyase la cabeza sobre una almohada. Se realiza una inspiración suavemente profunda y prolongada, reteniendo el aire al final. Se tensa suavemente todo el cuerpo, presionando con la cabeza sobre las manos cruzadas. Al mismo tiempo se despegan las piernas del suelo extendidas juntas hacia adelante. Se permanece así unos instantes. Luego se espira el aire prolongada y suavemente, sincronizándolo con la distensión progresiva de todo el cuerpo y el descenso lento de las piernas hasta que toquen el suelo. Esto también se repite tres veces.

5. Relajación recuperativa intercalada (TSS). Con autovisualización

Estimulación de la toma de conciencia de las áreas corporales donde radican los sentidos. Olfato (percepción fosas nasal es a través del roce del aire), gusto (percepción con la lengua de las estructuras de la boca), vista (con las manos ahuecadas se tapan ambas zonas oculares), oído (con las manos ahuecadas se tapan los pabellones auriculares) y tacto (se elige una zona del cuerpo y muy lentamente y sólo rozándola se explora con los dedos).

6. Relajación recuperativa final (TSS)

Con activación de la autovisualización. Luego se le pide que abandone la visualización y se pasa al último paso.

7. Desofronización (Igual que en el primer grado.)

c) La relajación dinámica: el tercer grado

El tercer grado es una aproximación sofrológica de técnicas zen japonesas. Se denomina relajación dinámica reflexiva. Su motivación fundamental es acostumbrar al sujeto a incluir en sus pensamientos al cuerpo (función intuitiva).

Se pretende llegar a percibir intensamente la sensación equilibrada de la corporalidad como si pensásemos o sintiésemos con el cuerpo. Éste es integrado

plenamente en el área de nuestros pensamientos

La forma de activación corporal se realiza por medio de la postura, que se hace en posición de sentados, y de la marcha, que se practica poniéndose de pie, alternando pasos sincronizados con respiraciones rápidas y profundas, intercalándose relajaciones.

En este grado las pausas de silencio, por parte del que dirige, suelen ser mayores para facilitar la vivencia y la reflexión sobre la naturaleza, vida y energía del cuerpo.

Finalizadas las posturas y marchas sucesivas, se practica el ejercicio mental de proyectar hacia el futuro situaciones o deseos que de alguna forma guarden relación con la realidad, activando de esta forma las capacidades prospectivas o de futurización de la mente. Se defiende que de esta manera se establece un circuito de retroalimentación que permite la traslación de las sensaciones presentes de vitalidad y de energía a la situación deseada.

Las fases abreviadas (tomadas esta vez de la técnica enseñada por el doctor I. Davrou) las presentamos a continuación:

1. Técnica de sofronización simple

Estando de pie. Alcanzado el nivel sofroliminal, el sujeto se concentra en la respiración abdominal.

2. Concentración en la respiración

Se sienta cómodamente y continúa la concentración. El objeto de concentración es ahora la respiración.

3. La experiencia de la postura

Se deja de poner atención en la respiración, para realizar el ejercicio de la postura. La postura de sentados es ahora sobre el borde de la silla, con el busto bien erguido, el mentón ligeramente elevado, los párpados entreabiertos. El practicante debe aprender a sentir que la postura le confiere poco a poco la comunicación consigo mismo.

4. Relajación recuperativa (TSS)

Sentados. Igual que en los grados anteriores.

5. La marcha

Los períodos de meditación son variables, a gusto de cada uno, y están entremezclados con períodos de marcha, lenta, con respiración sincrónica (la marcha está basada en la marcha zen).

El practicante se pone de pie, los ojos entreabiertos y las manos sobre el bajo vientre, se avanza un paso al mismo tiempo que se inspira, se retiene el aire y se lleva

suavemente todo el cuerpo sobre el pie avanzado, después durante la espiración, se lleva el otro pie a la misma altura, etc.

6. Desofronización

Igual que en el primer grado, aunque puede durar menos tiempo, ya que el tercer grado se realiza a un nivel de menor profundización.

Terminaremos este apartado citando textualmente unas frases de Caycedo:

«[...] cualquiera que sea su explicación, existía un hecho real: mediante ciertos métodos psicofísicos los yoguis pueden influir sobre su conciencia, obteniendo modificaciones especiales de la misma. Dichas modificaciones son necesarias para el extraordinario control que obtienen sobre su actividad física y mental» (Alfonso Caycedo. *La India de los yoghis*, pp. 45).

9.5.1.2. La biorretroalimentación

Esta técnica puede ser útil para conseguir tanto la relajación como la activación. Como ya hemos señalado, en ocasiones, es importante que una persona consiga un nivel de activación mayor que sea el óptimo para la tarea que está realizando. Esto es muy conocido en ciertos deportes, como el tenis, donde podemos ver a los jugadores realizando ejercicios (saltar, moverse, etc.) entre puntos, para conseguir un nivel de activación adecuado, incluso cuando ya llevan más de dos horas de partido y parecería más lógico que aprovecharan esos momentos para descansar.

El principio de la retroalimentación y elemento esencial de la misma hace referencia a la información que recibe el organismo de sus propios procesos biológicos, normalmente difíciles de someter a un control voluntario.

Para la biorretroalimentación son necesarios tres elementos (Zaichkowsky y Fuchs, 1989):

1. Algún tipo de instrumentación (normalmente electrónica) que permite medir las funciones biológicas de forma inmediata, a partir de transductores que recogen las señales del organismo y las convierten en datos analógicos.
2. Un sistema para amplificar esta información y enviarla de forma inteligible y más o menos inmediata al mismo sujeto en el que se está midiendo. Normalmente se transforman los datos biológicos en señales analógicas, en tonos auditivos o estímulos visuales, que recoge un polígrafo.
3. La intención de utilizar la retroalimentación con el propósito de ayudar a la persona a conseguir un control voluntario sobre un proceso biológico en particular. Frecuentemente se utilizan paralelamente, instrucciones verbales del experimentador para enseñar al sujeto a utilizar estrategias cognitivas, instrucciones verbales para que consiga cambiar los parámetros biológicos en la dirección deseada siendo consciente de esos cambios. Todo ello se combina también con la presentación o retirada de refuerzos contingentes a los cambios

observados.

Normalmente, las variables fisiológicas que se evalúan son la frecuencia cardíaca y los potenciales musculares.

Además de las técnicas elementales descritas, los psicólogos suelen utilizar otros métodos para la reducción de la ansiedad. Veamos los más importantes.

9.5.1.3. *Las técnicas de afrontamiento*

Existen numerosas técnicas psicológicas para el control de la ansiedad que pueden introducirse bajo este epígrafe. La idea general de todas ellas es conseguir que el paciente pueda relajar su ansiedad frente a ciertas situaciones frente a las que así reacciona, y proporcionarle una mayor capacidad de autocontrol en aquellas situaciones concretas que habitualmente le producen ansiedad. En esta línea está el procedimiento de *desensibilización sistemática* de Wolpe (1978) y los trabajos de Meichenbaum sobre *inoculación del estrés* (Stress Inoculation Training, SIT, 1977).

Vamos a describir este último programa, ya que muchas de las técnicas de afrontamiento lo utilizan en alguna medida.

El entrenamiento en SIT consiste globalmente en aprender a relajarse utilizando combinadamente la respiración profunda y la relajación muscular progresiva, de forma que cada vez que se experimenta ansiedad se puede relajar la tensión.

El programa de inoculación al estrés incluye las siguientes fases (el número de sesiones que aparece entre paréntesis es aproximado, depende de las necesidades de cada persona a la hora de desarrollar las distintas habilidades que se necesitan):

1. Fase de educación (10 sesiones)

En esta fase lo primero que debe llevarse a cabo es una conversación con la persona explicándole los efectos que poseen la ansiedad y la falta de concentración sobre su conducta. Por ejemplo, a través de la conversación, podemos hacerle recordar alguna situación en la que estaba consiguiendo buenos resultados y, debido a la tensión que le producía la misma, lo ha hecho muy por debajo de sus posibilidades.

En segundo lugar, es necesario que el sujeto domine la relajación progresiva totalmente, incluida la respiración, de forma que sea capaz de relajarse en cualquier circunstancia, en muy poco tiempo y de forma casi automática.

2. Fase de adiestramiento (10 sesiones)

Esta fase la podemos subdividir, a su vez, en tres apartados que describimos a continuación.

a) *Realización de una jerarquía de situaciones generadoras de ansiedad*

El sujeto, ayudado por el psicólogo, debe realizar una lista de las principales

situaciones que le producen ansiedad. Debe tener en cuenta para su construcción las situaciones previas y posteriores a las que le provocan la ansiedad. También deben incluirse en la lista hechos provocadores de ansiedad que puedan presentarse en un futuro inmediato. Para la realización de la jerarquía, se tendrán en cuenta todas las áreas de su vida: el trabajo, la relación familiar, la relación con los compañeros, las relaciones sociales, etc. Asimismo deben tenerse en cuenta los lugares y personas específicas implicadas en situaciones que se asocian típicamente con momentos desagradables. Se debe intentar obtener una lista de 20 elementos que recorra toda la gama, desde la molestia ligera hasta las experiencias más espantosas.

Después se debe ordenar esta lista desde los elementos menos perturbadores hasta los más desagradables, de forma que cada uno de los elementos de la lista sea un poco más ansiógeno que el precedente.

Wolpe (1958) diseñó un sistema para ordenar las situaciones provocadoras de ansiedad, que está basado en una medida a la que llamó «unidades subjetivas de ansiedad» (usas). El estado de relajación completa se valoraría con 0 usas, y el hecho más ansiógeno con un valor de 100 usas. El resto de los elementos se valorará entre estos dos extremos (0-100), dependiendo de la impresión subjetiva que produce cada situación comparada con ellos. Es decir, en primer lugar, se le pregunta al sujeto cuál es la situación más desagradable, la que valoraría con 100 usas. Luego se le pide que elija una situación donde se encuentre totalmente relajado y se valora con 0 usas. A continuación se le va pidiendo que vaya situando el resto de situaciones teniendo en cuenta lo alejadas o cercanas que estén a las valoradas con 100 y con 0 usas, respectivamente.

Es aconsejable, en una lista de 20 elementos, separar cada uno de ellos por incrementos de 5 usas. De esta forma, se podrá ir avanzando en los elementos de la jerarquía en pasos relativamente iguales.

Si a una persona le es difícil encontrar 20 situaciones estresantes, puede reducirse un poco la lista pero siempre manteniendo la jerarquía entre ellas.

b) Aplicación de las técnicas de relajación a la jerarquía de situaciones estresantes

Cuando ya se ha realizado la jerarquía, ésta se utiliza para aprender a relajarse. Se debe empezar por la situación que menos ansiedad produce (la que el sujeto ha valorado con menos usas, normalmente con 5). Hay que conseguir que el paciente se la imagine lo más nítidamente posible. Esta imagen debe incluir con claridad dónde se está, con quién, los sonidos, los olores, la temperatura, y todo lo que sea importante para hacer realista la escena. Se debe mantener la imagen provocadora de ansiedad durante 30 o 40 segundos y observar cómo se reacciona ante ella. Hay que prestar especial atención a los cambios en el ritmo cardíaco, en la respiración, el grado y calidad de la tensión muscular y los pensamientos asociados a ella. Estas sensaciones o pensamientos se deben utilizar como señales para efectuar la relajación y la respiración profunda. Hay que conseguir mantener la escena con toda claridad en la mente mientras se relaja. Se pueden utilizar las palabras «calma, relax, serenidad,

tranquilo», como indicadores verbales de alivio de la tensión.

Cuando se ha logrado imaginar la escena dos veces, sin experimentar ansiedad durante 30 segundos cada vez, se puede pasar al siguiente elemento de la jerarquía (el valorado con 10 usas). Se utiliza el mismo método con todos los elementos hasta llegar al más difícil, al valorado con 100 usas.

Un aspecto importante es que a medida que el sujeto se consigue relajar ante los elementos valorados con más usas, aumenta la confianza en sus posibilidades de reducción de la ansiedad, incluso en las situaciones más amenazantes.

El primer día que se empieza a trabajar no se debe imaginar más de tres o cuatro escenas. Es aconsejable parar antes de sentirse cansado o aburrido.

c) Entrenamiento en reevaluación cognitiva

En el proceso antes descrito, podemos observar que muchas veces, cuando se está intentando hacer frente a una situación difícil, aparece un flujo continuo de pensamientos automáticos negativos, como: «no voy a conseguirlo», «estoy mal preparado», «me estoy poniendo nervioso y no voy a tener suficiente capacidad», «lo he hecho fatal y no quiero volver a intentarlo», «todos piensan que he hecho el ridículo».

Para superar estos pensamientos automáticos se necesita elaborar una lista personal de pensamientos de afrontamiento. Estos pensamientos de afrontamiento actúan como interruptor del circuito de las emociones negativas. Se le explica al paciente que sus pensamientos no deben aumentar su ansiedad, sino que, por el contrario, pueden ayudar a disminuirla. Los pensamientos de afrontamiento pueden informar a su organismo de que no hay motivo para alarmarse, de que puede permanecer relajado. Por tanto, se le pide que haga su propia lista de pensamientos de afrontamiento y se la aprenda de memoria.

Meichenbaum sugirió cuatro categorías para formular las frases de afrontamiento:

- *Preparación.* Con frases como las siguientes: «no tengo por qué preocuparme», «lo haré bien», «ya lo he hecho bien otras veces».
- *Confrontación con la situación estresante.* Con frases como: «puedo hacerlo, lo estoy haciendo», «hazlo paso por paso, sin correr», «si no pienso en el miedo, no lo sentiré».
- *Afrontamiento del miedo.* Con frases del tipo: «¡relájate!», «respira profundamente», «antes o después esto se acabará», «puedo controlarlo».
- *Reforzamiento del éxito.* Con frases como: «¡lo he conseguido!», «lo he hecho perfectamente», «lo he superado, la próxima vez será todavía mejor».

No hay que olvidar que para que sea efectivo, debe ser cada sujeto el que elabore su propia lista de pensamientos de afrontamiento a la ansiedad; el psicólogo puede ponerle algún ejemplo, como los aquí mencionados, pero es más efectivo que sea el paciente el que elabore su lista.

3. Fase de aplicación (1 sesión)

El último paso de este programa es la aplicación de las habilidades aprendidas a situaciones reales. Para ello se elegirá un elemento de la jerarquía que no sea demasiado ansiógeno (valorado con pocos usos) y que sea fácil que ocurra *in vivo*.

Cuando el sujeto se sienta preparado, se coloca realmente en esta situación. Al empezar el afrontamiento se utilizará la tensión corporal como señal para relajarse. Al mismo tiempo, los pensamientos de afrontamiento a la ansiedad deberán ir fluyendo de forma continua y tranquilizadora.

Es previsible que el afrontamiento de situaciones reales sea más difícil de conseguir que eliminar la ansiedad ante escenas imaginadas, ya que en las situaciones reales siempre pueden surgir imprevistos que no sucederían con escenas imaginadas, pero la práctica continuada de la relajación y los pensamientos de afrontamiento harán que tanto una como los otros sean tan naturales que se pongan en acción ante el menor signo de tensión.

Debemos tener muy en cuenta, como muy acertadamente señalan Lazarus y Folkman (1986), que los pensamientos, emociones y conductas de una persona no son entidades separadas que se puedan modificar sencillamente con palabras reconfortantes. No debemos olvidar que están relacionados con todos los demás aspectos de la vida del individuo. Por tanto hay que conseguir comprender al sujeto en su globalidad y ser conscientes de que, en ocasiones, un programa de este tipo puede resultar ineficaz para ciertas personas o para ciertas situaciones.

9.5.1.4. La reestructuración cognitiva

Los pensamientos y cogniciones pueden influir en la manera de afrontar determinadas situaciones favoreciendo o dificultando la aparición de la ansiedad.

Todos hemos experimentado alguna vez la sensación de que estamos en conversación con nosotros mismos, es decir, que existe un lenguaje interno del pensamiento que da lugar a las frases con las que interpretamos el mundo. Si este lenguaje interno es preciso y se ajusta a la realidad, no es fuente de problemas pero en ocasiones es absurdo o poco ajustado a lo real, en ese caso puede ser una fuente importante de ansiedad y de otros trastornos emocionales.

Albert Ellis, el fundador de la terapia racional emotiva, basó esta terapia precisamente sobre la teoría de que las personas controlan en gran medida sus propios destinos creyendo y actuando según los valores y creencias que tienen (Ellis, 1981). Su teoría mantiene que las personas directamente no reaccionan de forma emocional ante los acontecimientos de su vida, sino que causan sus propias reacciones según la forma en que interpretan los acontecimientos que experimentan.

Este autor desarrolló su famosa teoría A-B-C de la perturbación emocional (A = experiencia activadora; B = creencia sobre A; C = consecuencia emocional).

Defendía que el hecho de que la consecuencia emocional (C), al seguir directa y casi inmediatamente a la experiencia activadora (A), hace que pensemos que A es

causa de C. Pero esto no es así, pues C no proviene directamente de A, sino de B. Es decir, de la creencia que el sujeto tenga sobre A.

Por ejemplo, supongamos que a un joven lo deja su novia y piensa: «Mi novia me abandonó y esto tan terrible me ha deprimido y evita que salga de casa a buscar un nuevo amor». La teoría de Ellis afirma que esta conclusión no se sigue necesariamente, por lo que representa un paso en falso. Puesto que lo que realmente ha ocurrido incluía: A (la pérdida de la novia) y C (la consecuencia de esa pérdida o privación o frustración), pero C no provenía directamente de A, sino de B, es decir, de la creencia que tenía el joven sobre el hecho de tener novia: «Mi novia era todo lo que tenía en el mundo, no puedo vivir sin ella, es horrible lo que me ha ocurrido y no tiene solución. ¡Debo recuperarla!».

Es probable que a este pensamiento le siga un sentimiento de desesperación, de depresión. Sin embargo, si el sujeto lo que se dice a sí mismo es, por ejemplo: «Es triste que mi novia me haya abandonado, sería mejor que esto no hubiese pasado, supongo que esto pasará y que encontraré otras personas. Tengo que esforzarme. No es el fin del mundo». En ese caso, el joven tenderá solamente a sentirse triste, contrariado y desafortunado por el abandono de la novia.

Así pues, la teoría defiende que las experiencias activadoras en A, como la pérdida de la novia, no hacen que el sujeto tenga consecuencias emocionales en C, tales como los sentimientos de desesperación, de depresión o de ansiedad, y no le llevan a las consecuencias conductuales, tales como la inactividad y el enclaustramiento. Más bien él es el factor principal que produce sus propias consecuencias, en C, al creer firmemente ciertas cosas en B, su sistema de creencias.

De esta forma, la teoría central de la terapia racional emotiva afirma que las cosas que ocurren no son las que te perturban, sino la opinión que tienes de ellas.

Ellis también elaboró una perspectiva de las creencias irracionales básicas que constituyen la mayor parte de los trastornos emocionales, entre los que se incluye la ansiedad.

Las diez ideas irracionales básicas propuestas por Ellis son las siguientes:

1. Para un adulto, existe una necesidad absoluta de cariño y aprobación de sus semejantes, familia y amigos.
2. Hay que ser indefectiblemente competente y casi perfecto en todo lo que se emprende.
3. Ciertas personas son malas, viles y perversas y deberían ser castigadas.
4. Es horrible cuando las personas y las cosas no son como uno quisiera que fueran.
5. Los acontecimientos externos son la causa de la mayoría de las desgracias de la humanidad; la gente simplemente reacciona según como los acontecimientos inciden sobre sus emociones.
6. Hay que sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa desconocida, incierta o potencialmente peligrosa.
7. Es más fácil evitar los problemas y responsabilidades de la vida que hacerles

frente.

8. Se necesita contar con algo más grande y fuerte que uno mismo.
9. El pasado tiene mucho que ver en la determinación del presente.
10. La felicidad aumenta con la inactividad, la pasividad y el ocio indefinido.

Algunos autores han añadido otras ideas irracionales a la lista de Ellis. Se aconseja que la lista se pueda ampliar individualmente enseñando al paciente a descubrir en qué situaciones experimenta ansiedad, mal humor, depresión, sentimientos de minusvalía, etc. Detrás de cada una de estas emociones, especialmente si las siente de forma crónica, hay un diálogo irracional consigo mismo. Ahora bien, en ocasiones resulta difícil descubrir ese diálogo y ésa es una tarea en la que debe intervenir el terapeuta.

El tiempo de entrenamiento varía mucho de un paciente a otro, pero se aconseja que el sujeto dedique unos 20 minutos al día durante dos semanas, para conseguir detectar sus pensamientos irracionales y conseguir rechazar alguno de ellos. Para ayudar en esta tarea existen registros de opiniones, listados de ideas irracionales, reglas para suscitar el pensamiento racional, sistemas de rechazo de ideas irracionales y una serie de instrumentos que pueden resultar de gran utilidad (véase, p. ej., Davis, McKay y Eshelman, 1988).

Delimitando el concepto, podemos entender por técnicas de reestructuración cognitiva aquel conjunto de técnicas que pretenden cambiar directamente las cogniciones y los pensamientos de las personas. Todo este tipo de pensamientos permiten desplazar los pensamientos amenazantes activadores de la ansiedad y combatir los síntomas cognitivos de la misma, como las preocupaciones o imágenes molestas que perjudican la autoestima del sujeto.

9.5.1.5. Programas basados en el condicionamiento clásico

Este tipo de programas se apoyan en el supuesto defendido por el condicionamiento clásico de que cuando a un sujeto se le presentan repetidamente dos estímulos juntos, éstos se acabarán asociando. De tal manera que la reacción que provoca uno de ellos se producirá ante la presentación del otro. De esta forma se consigue que un estímulo neutro se convierta en un estímulo condicionado.

Pongamos por caso que lo que pretendemos es una reacción de relajación; en primer lugar tendremos que investigar qué estímulos provocan en ese sujeto reacciones de calma. Por ejemplo puede ser una música con un ritmo determinado. Esta música actuará de estímulo incondicionado, ya que por sí misma produce reacciones de relajación. Como es difícil que el sujeto pueda escuchar dicha música en los contextos donde necesitaría relajarse, por ejemplo antes de dar una conferencia, se intenta asociar dicha música con otro estímulo que pueda estar presente en la situación, aunque en principio este segundo estímulo no produzca ningún tipo de reacción (estímulo neutro), por ejemplo un colgante. Tras presentaciones repetidas de ambos estímulos juntos (la música y el colgante), cuando

al sujeto se le presente el colgante éste conseguirá evocar las mismas reacciones que se producían ante la música. Es decir, el sujeto llegará a asociar la música y el colgante de tal manera que éste se convierte en un estímulo condicionado de reacciones de relajación.

El entrenamiento en el programa de condicionamiento clásico debe luego aplicarse en las situaciones reales. Por ejemplo, se puede escoger un suceso cercano a una situación importante en el que el sujeto se sienta demasiado ansioso, y hacerle que intente conseguir el control de su ansiedad tocando el colgante y reproduciendo las sensaciones de relajación asociadas con él.

Las ventajas de este entrenamiento para el control de la ansiedad son, por un lado, que el entrenamiento en el programa es bastante corto, ya que normalmente no se necesita excesivo número de sesiones para que se produzca el condicionamiento. Y por otro lado, que las exigencias y esfuerzo que se le piden al sujeto durante el entrenamiento son mínimos, por lo que es fácilmente aplicable.

Ahora bien, es evidente que este tipo de técnicas no pueden ser efectivas cuando la ansiedad se produzca por situaciones existenciales del paciente o por conflictos individuales que deberían ser resueltos.

9.5.1.6. La terapia cognitivo-conductual

Más recientemente, este conjunto de procedimientos terapéuticos conductuales se han enriquecido con el desarrollo de las técnicas cognitivas. Hoy en día se les conoce como técnicas cognitivo-conductuales.

En general, este tipo de tratamiento va destinado a cambiar los patrones de pensamiento del sujeto, compartiendo con el paciente una conceptualización del trastorno, de forma que entienda y conozca con la mayor amplitud posible en qué consiste la ansiedad.

Luego debe justificarse el tratamiento que se va a seguir, así como informarle sobre la fisiología y psicología de la ansiedad, sobre cuál es su función adaptativa y cuándo se transforma en patológica.

Debe insistirse en la diferencia entre pensamientos realistas e irrealistas, y en la diferencia entre lo posible y lo probable (Capafons, 2001).

También es importante que el paciente aprenda a identificar las señales que preceden a sus episodios de ansiedad. Lo que se pretende es que los pacientes accedan al estímulo ansiógeno con la menor ansiedad anticipatoria posible, y con atribuciones adaptativas frente a sus reacciones fisiológicas.

Luego se añaden al tratamiento técnicas de relajación o de control de la respiración, o técnicas conductuales.

Es fundamental que al mismo tiempo se les prepare en técnicas de reestructuración cognitiva, para que puedan identificar sus pensamientos negativos, como el miedo a volverse loco, a desmayarse, a perder el control, etc. De forma que puedan cuestionárselos y cambiarlos por interpretaciones más realistas y racionales.

En resumen, lo que se pretende es añadir el componente cognitivo al simple

control de la ansiedad.

Se parte del supuesto de que es la interpretación del suceso, más que el propio suceso, el que determina la aparición de estados emocionales que producen pensamientos desadaptativos, lo que a su vez lleva a la respuesta de ansiedad. Por tanto, si no conseguimos un cambio en la forma de interpretar la realidad, no conseguiremos una solución definitiva, la eliminación duradera de la ansiedad patológica.

Los tratamientos psicológicos parten de un planteamiento que podríamos resumir con las consiguientes consideraciones.

En primer lugar, el primer objetivo de la psicoterapia es conseguir que el paciente sea «libre», incluso de su terapeuta. Es decir, el paciente ha de hallar por sí mismo su propio camino, madurar independientemente y desarrollar su propia personalidad. El terapeuta se limitará a prestarle la ayuda, la guía, que precisa para aclarar su situación real, utilizando técnicas y procedimientos experimentalmente verificados. Este proceso suele significar una reestructuración del sistema cognitivo del paciente, reestructuración que es la que realmente liberará al paciente.

Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un paciente que responde con un cuadro de ansiedad cada vez que tiene que enfrentarse a situaciones sociales como hablar en público, o incluso dirigirse a un dependiente para solicitar un artículo o a un camarero para pedir un refresco.

Si le enseñamos una técnica de relajación en nuestra consulta, con la intención de que la practique él solo diariamente, de forma que sea capaz de controlar su ansiedad, es posible que consigamos reducir o incluso eliminar estas respuestas ansiosas. No obstante sería mucho más eficaz y lo haría independiente de nosotros si consiguiésemos averiguar cuáles son sus creencias sobre lo que supone el hablar en público, cuáles las posibles ideas absurdas o irracionales («se debe sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa desconocida o incierta», «es más fácil evitar los problemas y responsabilidades de la vida que hacerles frente») que le llevan a evitar la situación. O bien qué deberes y obligaciones se ha impuesto de forma radical («debo ser competente y casi perfecto en todo lo que haga»).

La terapia, fundamentalmente, debe dirigirse a la resolución de problemas emocionales relacionados con las creencias que la persona ha desarrollado durante su vida, antes de la aparición del cuadro ansioso. Si conseguimos eliminar esas ideas irracionales, de forma que el paciente sustituya su lenguaje interior por otro más racional, estaremos eliminando las consecuencias de estas ideas irracionales, la ansiedad, de una manera más duradera y efectiva.

Así pues, es muy importante que descubramos el diálogo interior del individuo, detectar lo que hay de irracional en el mismo y enseñarle a cambiarlo. El diálogo irracional puede cambiarse y junto a él cambiarán las emociones provocadoras de ansiedad.

No obstante, para poder ser más eficaces en la reestructuración cognitiva, incluso para poder comenzarla, es preciso que el nivel de ansiedad del sujeto haya disminuido lo suficiente como para que puede entablarse una discusión productiva que nos

permita detectarlas y sustituirlas por pensamientos alternativos. Para ello es fundamental el tratamiento farmacológico y las técnicas de relajación u otras técnicas conductuales.

En segundo lugar, pero no menos importante, es fundamental para conseguir el desarrollo autorresponsable de las potencialidades de un ser humano, sean cuales sean las técnicas o programas utilizados, que todo ello se realice a través de una comunicación existencial auténtica entre terapeuta y paciente.

9.6. BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, K. J. (1990). Arousal and the inverted-U hypothesis: A critique of Neiss Reconceptualizing Arousal. *Psychological Bulletin*, 107, 96-100.
- Barlow, D. H y Durand, V. M. (2003). Psicopatología. Madrid. Thomson Editores.
- Benson, H. (1975). *The relaxation response*. NY: Williams Morrow.
- Berstein, D. S. y Borkovec, T. C. (1973). *Progesive ralaxation trining*. Champaing, IL: Research Press Co.
- Borkovec, T. D. (1976). Psychological and cognitive processes in the regulation of anxiety. En G. Schwartz y D. Shapiro (eds.). *Consciousness and selfregulation: Advances in research*. Vol. 1, pp. 261-312.
- Capafons, J. I. (2001). Tratamientos psicológicos eficaces par las fobias específicas. *Psicothema*, volumen 13, pp. 447-452.
- Cautela, J. R. y Groden, K. (1978). *Técnicas de relajación*. Barcelona: Ed. Martínez Roca.
- Caycedo, A. (1971). *La India de los Yoguis*. Barcelona: Ed. Scentia.
- Davidson, R. J. y Schwartz, G. E. (1976). The psychobiology of relaxation and realted states; A multi-process theory. En D. I. Mosto. fosky (ed.), *Behavior control and modification of pychological activity*. Englewood Cliffs. Nj: Prentice Hall, 339-442.
- Davis, M., McKay, M. y Eshelman, E. R. (1988). *Técnicas de autocontrol emocional*. Barcelona: Ed. Martínez Roca.
- Davrou, I. (1985). *Manuel de Sophrologie*. Le Moustier. Mirambeau
- Dienstbier, R. A. (1989). Arousal and physiological toughness: Implications for mental and physical health. *Psychological Review*, 96, 84-100.
- Duffy, E. (1972). Activation. En N. S. Green. field y R. A. Sternbach. *Handbook of Psychology*. NY: Holt, Rinehart y Winston.
- Ellis, A. (1981). La teoría básica clínica de la terapia racional-emotiva. En A. Ellis y R. Grieger. *Manual de Terapia Racional Emotiva*. EDB. Bilbao
- Espinosa, M. (1986). *Realidad de una ciencia sofrológica: Pasado y presente*. Madrid: Egraf.
- García-Merita, M. L., Miquel, M. y Fuentes, L. (1991). *Psicofisiología clínica: depresión y esquizofrenia*. Valencia: Promolibro.
- García-Merita, M., Pons, D. y Atienza, F. (1994). Técnicas de Relajación. En I. Balaguer (dir.). *Entrenamiento psicológico en el deporte*. Valencia: Ed. Albatros
- Hackfort, D. y Schwenkmezger, P. (1989). Measuring anxiety in sport: Perspectives

- and problems. En D. Hacfort y C. D. Spielberger (eds.). *Anxiety in Sport: An Internacional Perspective*, NY: Hemisfere.
- Landers, D. M. (1980). The arousal performance relationship revisited. *Research Quaterly*, misphere.
- Harris, D. V. (1986). Relaxation and energizing techniques for regulation of arousal. En J. M. Williams (ed.). *Applied Sport Psychology* Palo Alto, California: Mayfield, 185-207.
- Hennessy, J. W. y Levine, S. (1979). Stress, arousal and pituitary-adrenal system: A psychoendocrine Hypothesis. En J. M. Spagre y A. N. Epstein (eds.). *Progress in Psychophysiology and Psychology*. New York: John Wiley.
- Jacobson, E. (1938). *Progresive relaxation*. Chicago: University of Chicago Press 51, 77-90.
- Lazarus, R. S. (1966). *Psychological stress and coping process*. NY: McGraw-Hill.
- Lazarus, R. S., y Averill, J. R (1972). Emotion and cognition: With special reference to anxiety. En C. D. Spielberger (ed.). *Anxiety: Current trends in theory and research*, NY: Academic Press.
- Lazarus, R. S. y Folkman, S. (1986). *Estrés y procesos cognitivos*. Barcelona: Ed. Martínez Roca.
- Malmo, R. B. (1959). Activation: A neuropsychological dimension. *Psychological Review*, 66: 367-386.
- Malmo, R. B. (1971). Anxiety and motor behavior: A review. *Journal o/Motor Behavior*, 2, 2: 151-179.
- Martens, R. y Landers, D. M. (1970). Motor performance under stress: A test of the in verted-U hypothesis. *Journal o/ Persona lit y and Social Psychology*, 16: 29-37.
- Martens, R., Vealey, R S. y Burton, D. (1991). *Competitive anxiety in sport*. Champaign, Human Kinetics Books. Illinois.
- McKay, M., Davis, M. y Fanning, P. (1985). *Técnicas cognitivas para el tratamiento del estrés*. Barcelona: Martínez Roca.
- Meichenbaum, D. (1977). *Cognitive-behavior modi/ication: An integrative approach*. NY: Plenum.
- Meichenbaum, D. (1984). Selectes psychology factors limiting performance: A mental health model. En D. H. Clarke y H. M. Eckert (eds.). *Limits of Human Performance*. Champaign: Human Kinetics, 70-80.
- Pons, D., Balaguer, I. y García-Merita, M. L. (1991). Evaluación de la ansiedad en los deportes de competición a través de autoinformes. III Congreso de Evaluación Psicológica. Barcelona.
- Pons, D. y García-Merita, M. (1994). La ansiedad en el deporte. En I. Balaguer (dir.). *Entrenamiento psicológico en el deporte*. Valencia: Ed. Albatros.
- Rojo Sierra, M. (1988). *Psicología y psicopatología del bloque informativo (percepción, memoria y fantasía)*. Valencia: Ed. Promolibro
- Rojo Sierra, M. (1995). *En torno a la conciencia humana*. Valencia: Ed. Promolibro.
- Rojo Sierra, M. y García-Merita, M. (2002). *Psicopatología de la afectividad y de la actividad motora*. Valencia: Promolibro
- Schachter, S. y Singer, J. E. (1962). Cognitive, social and psychological determinant of emotional state. *Psychological Review*, 69, 379-399.

- Spielberger, C. D. (1966). Theory and research on anxiety. En C. D. Spielberger (ed.). *Anxiety and Behavior*, New York: Academic Press. 3-20.
- Spielberger, C. D. (1972). Conceptual and methodological issues in anxiety research. En C. D. Spielberger (ed.). *Anxiety: Current trends in theory and research* (volumen 2, pp. 23-49). New York: Academic Press.
- Spielberger, C. D. (1978). Theory and measurement of anxiety states. En R. B. Cattell y R. M. Dreger (eds.). *Handbook o/ modern personality theory*. NY: John Wiley.
- Spielberger, C. D. (1989). *Anxiety in sports and international perspective*. New York: Hemisphere Publishing Corporation.
- Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L. y Lushene, R. E. (1970). *STAI Manual/or the State-Trait AnxietyInventory (Self Evaluation Questionnaire)*. Palo Alto, California: Consulting Psychologist Press.
- Wolpe, J. (1958). *Psychotherapy by reciprocal inhibition*. Stanford: Stanford University Press.
- Zaichkowsky, L. D. y Fusch, E. (1989). Biofeedback-assisted self regulation for stress management in sport. En D. Haecfort y E. D. Spielberger (eds.). *Anxiety in Sports: An International Perspective*. NY: Hemisphere, pp., 235-245.

NOTAS

[91](#) Primera etapa de presentación de las ideas delirantes. El individuo de pronto cree que el ambiente se ha hecho distinto sin ningún cambio sensorial. Detecta una alteración sutil que abarca todo. Sobre el ambiente flota algo, preternatural, nefasto, indefinible. Jaspers lo llamó temple delirante, y Conrad, trema.

10. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ANSIOSA. TRATAMIENTO PSICOFARMACOTERÁPICO

«La conclusión es que sabemos muy poco y sin embargo es asombroso lo mucho que conocemos.»

BERTRAND RUSSELL (1872-1970), filósofo y matemático inglés.

He aquí cómo satirizó Paul Dubois la conducta del médico de su época. «Entonces saca su agenda y prescribe: “bromuro potásico”. En la consulta siguiente pone: “bromuro sódico” o cambia de jarabe. Finalmente —¡válgame dios!— recurre desesperado a la constelación de sales brómicas combinadas. El paciente que no ha curado se dirige entonces, en su desaliento, a otro médico; éste extremando su probado celo prolonga aún más el interrogatorio, realiza con mayor minuciosidad la exploración y, con la frente apoyada en la mano, reflexiona seriamente: ¿apostamos algo a que acaba por rescribir bromo o cacodilato sódico?».

Actualmente si no dedicamos tiempo a estudiar al enfermo ansioso, diríamos algo parecido: tiene ansiedad, entonces le damos un ansiolítico y/o un antidepresivo⁹². Si no mejora, le cambiaremos uno u otro, y si sigue sin mejorar, lo mandaremos también al psicólogo, y si aún así no mejora, ante su desesperación, seguro que le volvemos a cambiar el ansiolítico, el antidepresivo o ambos.

¿En qué momento de estos pasos nos hemos planteado que el paciente ha de saber lo fundamental de su vida que ha influido en su enfermedad ansiosa, y le hemos dado una explicación adecuada para que conozca la enfermedad, no sólo como unos síntomas que padece, sino como un acontecimiento vital encarnado en su historicidad? Si hacemos esto último, el enfermo podrá realizar entonces una autocomprensión de su patología y le podremos explicar el sentido y el objetivo del fármaco. Evidentemente esto necesita algo muy importante: tiempo.

El ejercicio de la medicina me ha constatado, diariamente, que un «antiguo medicamento» sigue teniendo en el siglo XXI máxima eficacia: este medicamento es el «tiempo que le dedicamos al paciente». Nos permite mejorar el diagnóstico individualizado y hacer además una buena valoración situacional, todo lo cual hará más efectivo cualquier otro tipo de tratamiento que le administremos. Más de una vez me ha sorprendido el paciente cuando ya llevábamos largo tiempo de entrevista que, entonces, me revela algo fundamental para conocer los motivos internos que han sido fundamentales para entender cómo y por qué se desencadenó su enfermedad. Como decía el humanista y filósofo español Juan Luis Vives (1492-1540), «La diligencia en

escuchar es el más breve camino hacia la ciencia».

Es curioso que en 1965 decía Hofling, en su *Tratado de psiquiatría*, cómo muchos médicos se sentían intranquilos cuando trataban a sus pacientes si no les prescribían alguna medicación, y cómo muchos de ellos sentían que no habían recibido el cuidado adecuado a menos que se les hubiera prescrito algún medicamento. Ahora ya en el siglo XXI la situación se ha invertido completamente y en esta medicina «contra reloj», que M. Rojo Moreno la denominó «medicina industrial» en la que prácticamente siempre prescribimos medicamentos, los médicos nos encontramos intranquilos y muchas veces incómodos en el ejercicio de nuestra profesión, y al mismo tiempo los pacientes, a menudo, vivencian que no han recibido el cuidado adecuado, no por la falta de fármacos, sino por la falta de tiempo dedicado a escucharles, a conocerles, a ocuparnos de su persona singular enferma, pues todo ello es «el paciente».

Podríamos hablar en este capítulo de los diferentes ansiolíticos, fundamentalmente benzodiacepínicos (diazepam, clobazam, alprazolam...), que se usan en la enfermedad ansiosa, y asimismo de los diferentes antidepresivos que ya tienen oficialmente dada, por la comunidad científica internacional y por las autoridades sanitarias, la «indicación» para su uso en el trastorno de ansiedad, en las fobias, en el trastorno por estrés postraumático, etc., pero eso no creo que fuera demasiado interesante, pues no sería más que hacer un listado de medicamentos que, de todas formas, podemos ver resumido en la tabla 10.1.

TABLA 10.1
Psicofármacos más utilizados en el tratamiento de la enfermedad ansiosa

FÁRMACO	AÑO	CLASE	COMENTARIO
Morfina	1804	Opiáceo	Aislada en 1804 por Derasne, se sintetizó en 1952 por Gates.
Placebo	1807	-----	T. Jefferson dice: «Uno de los médicos más eficaces que yo haya conocido jamás me aseguraba que utilizaba más píldoras de pan, gotas de agua coloreadas y polvos de ceniza de nogal que todas las demás medicinas juntas».
Ac metilbarbitúrico y otros	1922	Inducir sueño	Kläsi hace tratamientos de 5-7 días de sueño ininterrumpido.
Amital sódico	1932	Barbitúrico	Linndermann promueve su uso en psicoterapia, creándose así la técnica de narcoanálisis.
Meprobamato	1950	Meprobamato	Sintetizado en 1950 y comercializado en 1953. En 1955, F. Berger demuestra la capacidad tranquilizante no hipnótica de esta sustancia.
Clordiacepóxido	1960	BZD	(Sintetizado en 1957) L. Stembach, poco miorrelajante.
Diazepam	1963	BZD	(Sintetizado en 1959). Bastante miorrelajante.
Imipramina	1960	ATC	Klein y Fink demuestran que este ATC bloquea las crisis de angustia.
Trimeprimina	1961	ATC	Sedativo, buen regulador del sueño.

Clorimipramina	1964	ATC	En 1967, Fernández-Córdoba y López Ibor demostraron su efectos en el TOC.
Fluoxetina	1972	ISRS	Se comercializó en 1989.
Alprazolam	1981	BZD	Fue la primera BZD aprobada por la Administración de Estados Unidos (FDA) para el tratamiento del trastorno de angustia.
Lorazepam		BZD	No se metaboliza hígado.
Oxazepam		BZD	Fue la tercera benzodiacepina comercializada en Estados Unidos.
Flurazepam		BZD	Usado como hipnótico.
Trazodone	1982	AD	Muy sedativo, se utiliza muy a menudo en el insomnio y por no tener efectos anticolinérgicos, también se usa mucho en ancianos. Puede originar priapismo.
Fluvoxamina	1983	ISRS	Es el más sedativo de los ISRS. Tiene muy buena acción sobre el TOC y ha sido aprobado para el TOC infantil.
Citalopram	1989	ISRS	
Paroxetina	1991	ISRS	Fue el primer ISRS aprobado por la FDA para el control del trastorno por angustia.
Sertralina	1992	ISRS	
Gabapentina	1994	GABA	Interactúa con el transportador GABA.
Venlafaxina retard	1999	IRSN	Dual, inhibidor de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. Primer fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento crónico del trastorno ansiedad generalizada.
Escitalopram	2002	ISRS	Además de antidepresivo, indicado para el tratamiento del trastorno de angustia con y sin agorafobia y en la fobia social.
Zolpidem		Pro-BZD	Usado como hipnótico. No es benzodiacepínico pero ocupa los receptores BZD tipo I.
Pregabalina	2004	GABA	Indicado en el trastorno de ansiedad generalizada, fibromialgia y dolor neuropático.
Duloxetina	2005	IRSN	Antidepresivo dual que también tiene la indicación oficial en el trastorno por ansiedad generalizada.
Agomelatina	2007	Agonista de melatonina	Antidepresivo, mejora el insomnio. Hasta 2009 sólo comercializado en Ucrania. En 2009 se comercializa en la UE.

AD = antidepresivo; GABA = gamma-amino-butírico; ISRS = antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina; IRSN = antidepresivo selectivo Inhibidor de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina (dual); BZD = ansiolítico benzodiacepínico; ATC = antidepresivo tricíclico.

Las propiedades farmacológicas típicas de los ansiolíticos benzodiacepínicos — cuyos receptores en el sistema nervioso central ya fueron descubiertos en 1977— son:

- Acción ansiolítica o tranquilizante.
- Acción relajante muscular.
- Acción antiagresiva.
- Acción anticonvulsiones.
- Acción potenciadora del alcohol y de los barbitúricos.

A pesar de que a veces han tenido publicidad adversa, las benzodiacepinas, son los compuestos psiquiátricos más recetados en el mundo. Sólo una de ellas, el alprazolam, tuvo 31 millones de recetas en Estados Unidos en 2001. El consumo de benzodiacepinas aumenta con la edad, de forma que las personas mayores de 65 años reciben el 27% de todas las recetas de benzodiacepinas y el 38% de todas las recetas de hipnóticos. Aunque cada vez más están siendo desplazadas en el tratamiento de la ansiedad por los ISRS (antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina), por los IRSN (antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina) o por análogos del GABA (como la pregabalina), no obstante, como indican Raj y Sheehan, es práctica común iniciar el tratamiento con la administración simultánea de más de un tipo de fármacos a la vez.

Un problema frecuentemente planteado cuando usamos ansiolíticos se refiere al abuso de los mismos o, como lo denomina Barcia (1977), el *misuse* o mala utilización, que puede ocurrir, bien porque se prescriban de forma insuficiente, o bien porque se realice un mal uso por ignorancia. También se abusa del fármaco cuando el paciente lo toma para animarse, o bien lo consume en dosis mayores de las prescritas, o por su cuenta.

Es evidente que un tratamiento bien controlado y correctamente recetado por el médico nos va a proporcionar más beneficio que perjuicio, y el potencial de abuso es mínimo; pero si usamos los ansiolíticos automedicándonos para rápidamente tranquilizarnos «por los disgustos» o por las situaciones «normales estresantes de la vida», entonces psicológicamente cada vez la persona va a tolerar menos la tensión y ansiedad del transcurrir diario y de los problemas cotidianos, usando inadecuadamente estos medicamentos para que le alivie y le haga más cómoda la vida. Pero ¿cuándo la vida va a serle lo suficientemente cómoda y calmada?

Realmente el abuso, como comprueban Raj y Sheehan en la revisión que realizan, es bajo en la práctica clínica: la incidencia de dependencia de las benzodiacepinas (ansiolíticos) entre los pacientes a los que se les había prescrito correctamente el fármaco se estimó en sólo 1 caso por cada 50 millones de meses de tratamiento. Y en otro estudio que revisa el cuadro de «dependencia de benzodiacepinas», se diagnosticó sólo en 150 casos (0,5%) de las 33.000 hospitalizaciones consecutivas que tuvieron lugar en un hospital psiquiátrico alemán.

Por lo tanto, la realidad es que el abuso o dependencia a las benzodiacepinas es baja en términos generales, aunque hay que señalar que esto no ocurre así cuando los enfermos realizan al mismo tiempo abuso de alcohol o de otras drogas o tienen trastornos de personalidad.

Otra pregunta frecuente es cómo se pueden retirar los ansiolíticos.

Se denomina «ansiedad de rebote» a la reaparición de los síntomas de ansiedad tras la retirada de una benzodiacepina. Pero si retiramos lentamente el ansiolítico como, entre otros muchos autores, demostraron Fontaine y cols., no se produce normalmente incremento de la ansiedad, a diferencia de un 10% de pacientes que sí la padecieron cuando se les suprimió de forma brusca.

Como señala J. Massana:

1. Las benzodiazepinas no son fármacos de abuso para los pacientes que las necesitan médicamente.
2. Es conveniente explicar a los pacientes que podrían experimentar algún problema al retirar las benzodiazepinas, pero que esto no significa que hayan desarrollado un cuadro de adicción, sino que se trata de un cuadro muy frecuente producido por muchos y diversos fármacos (antidepresivos tricíclicos, ISRS, IMAOS, esteroides...). Además, muchos de los trastornos de ansiedad son cuadros crónicos, por lo que el empeoramiento se puede deber a la propia enfermedad y no a la retirada del fármaco.
3. Cuando se realiza una reducción gradual y conservadora el riesgo de abstinencia desaparece o se minimiza.
4. La confusión respecto a dependencia, tolerancia y adicción ha conducido a muchos clínicos a renunciar al uso de benzodiazepinas. Esta decisión es especialmente desafortunada, puesto que cuando se prescriben de forma apropiada constituyen uno de los psicofármacos más seguros y efectivos.
5. Son fármacos fundamentales en la medicina actual por su capacidad para aliviar la miseria humana a bajo precio. El objetivo fundamental de la práctica médica es el de aliviar el sufrimiento humano, y la idea de que la dependencia a las benzodiazepinas es similar a la de la heroína o a la del alcohol se debe simplemente a la falta de información.

El tratamiento con estos medicamentos durante el embarazo también ha sido una cuestión polémica, frecuentemente planteada hasta el punto que como no están permitidos los estudios controlados (comparando a mujeres embarazadas a las que se les daría un medicamento, frente a otras a las que, a propósito, se les recetaría un placebo), no hay aprobado «oficialmente» ningún psicofármaco para el embarazo⁹³. Pero tengamos en cuenta que del total de nacimientos, sin tomar medicación alguna, «normalmente» alrededor de un 3% presentan malformaciones que alteran alguna función del niño o que requieren una corrección quirúrgica, y hasta un 12% muestran malformaciones de menor grado. Es muy importante tener en cuenta que una enferma ansiosa puede fácilmente sufrir una depresión y, en los trabajos que revisan Schatztzberg, Nemeroff, Newport, Fisher y cols., se ha comprobado que los hijos recién nacidos de mujeres con depresión muestran un riesgo desproporcionadamente mayor de presentar menor perímetro craneal al nacer, bajo peso tras el nacimiento, parto prematuro, tamaño corporal pequeño respecto a la edad gestacional e incluso precipitar la aparición de cambios comportamentales duraderos en el niño. Además, las mujeres con depresión muestran tasas mayores de consumo de cigarrillos y de alcohol, y tienen un mayor abandono de los cuidados prenatales y realizan una nutrición insuficiente, que son, en sí mismos, factores de riesgo para el embarazo. La depresión materna durante el embarazo se asocia, además, a alteraciones biológicas del niño, como son la elevación de las concentraciones en sangre de cortisol y catecolaminas. Aunque se han estudiado más los efectos en el niño de la depresión de la madre gestante que en el caso que ésta padezca sólo un trastorno de ansiedad, no

obstante en un estudio realizado sobre ocho mujeres que padecieron grave trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) durante el embarazo, se pudo observar que dos desarrollaron preeclampsia, tres tuvieron un parto prematuro y cinco dieron a luz mediante cesárea (Maina et al., 1999). Además, la depresión grave de la madre durante el embarazo puede afectar a las capacidades cognitivas y de regulación emocional del niño durante toda su infancia (es lo que se llama teratogénesis neurocomportamental).

Podríamos seguir dando datos y más datos, pero lo que parece evidente es que, a mi parecer, con lo dicho anteriormente, si soy una madre y padezco una enfermedad ansiosa o una depresión, yo personalmente preferiría que me trataran, y lo más pronto posible, antes que dejar que esa enfermedad, por una inculta y tópica concepción de lo «natural», afecte a mi hijo por no tomar, por ejemplo, medicación que «no es natural».

Por supuesto que es deseable, en general, no tomar medicación durante el embarazo, como igualmente sería deseable no tomar ningún fármaco con 85 años de edad, pero no hagamos de esta cuestión el «mito de Tarzán», «de lo natural», a costa de nuestra salud real o de la salud de nuestros hijos⁹⁴.

No se ha detectado en miles y miles de embarazadas con una enfermedad ansiosa y/o depresiva que han tomado medicaciones ya bien conocidas y evaluadas —al utilizarse generalmente los fármacos más clásicos (benzodiazepinas, tricíclicos, ISRS)—, alteraciones en los niños al nacer, ni posteriormente en todo su desarrollo psicomotor o de neurocognición. Así por ejemplo, en un estudio de Kulin (1998) comparando tasas de malformaciones congénitas en 237 mujeres embarazadas que tomaron ISRS durante el embarazo, no encontraron diferencias significativas entre sus hijos y los que habían nacido de otras mujeres sanas controles (sin haber tomado medicación). Incluso se ha comprobado que los ISRS pueden mejorar, durante el embarazo, el control de la glucemia. Otros autores estudiaron a 2.220 mujeres que habían tomado ISRS durante el embarazo y no había un número mayor de malformaciones congénitas comparándolas con las que no habían tomado medicamento alguno. Igualmente ocurre con los clásicos antidepresivos tricíclicos; valga como ejemplo la revisión de Altshuler (1996) sobre más de 300.000 mujeres que habían tomado estos medicamentos durante la gestación y la incidencia de malformaciones era de 3,1%, la misma que la que tienen las mujeres que no se medican. Y para terminar de dar datos, igualmente con la administración de benzodiazepinas tampoco se han encontrado malformaciones neonatales: en los primeros estudios se señaló una posible relación entre la toma de estas sustancias durante el embarazo y un posible incremento de hendidura oral (palatina) en los niños recién nacidos, pero muchos trabajos posteriores sobre miles y miles de niños no lo han encontrado, como por ejemplo Barry y St. Clair sobre 1.300 embarazadas que tomaron alprazolam, no detectaron exceso de hendiduras palatinas en los recién nacidos. Aunque ciertamente, por otro lado, Eros (2002) encontró que por cada 10.000 niños nacidos que hubieran tomado sus madres benzodiazepinas podría haber 1 (uno) más con hendidura oral que si no las hubieran tomado⁹⁵.

Es importante señalar que la naturaleza de la mejoría producida por los ansiolíticos puede ir más allá de la mera acción de tranquilizar. Ya comprobaron Lipman y cols. cómo tras administrar a pacientes un ansiolítico (clordiacepóxido), éstos refirieron mayor número de acontecimientos positivos y menor número de acontecimientos vitales negativos mientras lo tomaban en comparación con otros pacientes semejantes ansiosos que tomaron placebo. Por lo tanto, los pacientes que tomaban el medicamento tenían una visión de la realidad más positiva y al aliviarles la ansiedad estos enfermos podían «digerir» las situaciones de la vida de forma más constructiva.

Es fundamental diferenciar entre tratamiento psicofarmacológico y tratamiento psicofarmacoterápico de la ansiedad. La farmacología es la ciencia que estudia los medicamentos; la farmacoterapia es la ciencia que estudia la forma como estos medicamentos realmente curan o no las enfermedades⁹⁶.

¿Pero realmente los ansiolíticos y antidepresivos curan la ansiedad?

Comentan Cole y Davis cómo un problema clínico, no siempre resuelto, es cuándo deberíamos prescribir ansiolíticos: ¿Sólo en casos agudos y graves de ansiedad? ¿A una madre inquieta por el matrimonio de su hija? ¿A los viudos recientes durante el período de duelo? ¿A divorciados moderada y crónicamente turbados? ¿Para mejorar el bienestar o sólo para prevenir la disfunción social? ¿Es mejor, a la larga, hacer vivir a la gente sus ansiedades y resolver sus problemas sin ayuda química?

Probablemente nadie tiene la respuesta absoluta a estas y otras muchas y parecidas preguntas, pero siempre tendremos que tener en cuenta que el médico deberá hacer una valoración global e individualizada del paciente si queremos responder en cada caso a cómo tratar la enfermedad en el enfermo concreto que la padece en una situación concreta.

En los casos leves reactivos a un acontecimiento, evidentemente que sí vamos a encontrar rápidamente una respuesta satisfactoria al disminuir la sintomatología ansiosa o angustiosa que padecen, permitiendo a la persona superar esa situación concreta y así poder utilizar mucho mejor sus recursos psicológicos para enfrentarse a la misma. Pero cuando la enfermedad es ya de cierta importancia tenemos que tener en cuenta, como señala L. Binswanger (1973), que la psicopatología nunca es un fenómeno aislado, sino que refleja el fondo de un yo, de una persona; la persona se manifiesta en los síntomas y a la vez nosotros captamos el interior de la persona a través de los síntomas.

Realmente como, en esta misma línea, señala J. Wyrsh (1949), «la persona va a ser transformada por su enfermedad». Y siendo esto así, si sólo nos quedamos en el tratamiento de los síntomas y no hacemos un análisis biográfico y «entendemos» la enfermedad como parte de la historia personal, es posible que a corto plazo mejoremos la sintomatología del paciente, pero pronto resurgirá de nuevo la alteración ansiosa «superando» la medicación, o como suelen decir algunos «ya no me hace efecto».

No tratamos síntomas, tratamos personas, y por esto tenemos que saber para qué y con qué objetivo estamos dando la medicación dentro del conjunto personal, y

asimismo el paciente también ha de saber qué finalidad y cuáles son las metas reales que se buscan con el tratamiento psicofarmacoterápico (ya sea al dar una benzodiacepina, un tricíclico, o un antidepresivo dual que tenga la indicación sobre la ansiedad patológica, como la duloxetina, la venlafaxina, etc.).

La curación de la enfermedad ansiosa necesitará que hagamos un tratamiento basado en la comprensión total del paciente, es decir, necesitará de una holoterapia⁹⁷. Por estas características tan especiales de los tratamientos psiquiátricos, siempre basados en la totalidad de la persona, es por lo que tendríamos que hablar realmente de una farmacopsiquiatría⁹⁸ —específica de nuestra especialidad—, en la que no sólo nos interesa el síntoma, sino también cómo es vivenciado el mismo, qué repercusión afectiva tiene sobre la persona y cuál es el impacto que el propio síntoma y la enfermedad ansiosa está produciendo en la totalidad individual. La efectividad del fármaco va a depender no sólo de que lo demos contra los síntomas, sino de que además podamos focalizar objetivos más concretos en el tratamiento superando el estricto esquema: *síntoma que se padece* o *fármaco que se administra*. Es decir, ya no recetaremos simplemente un medicamento para los síntomas psíquicos, sino que será un medicamento para una psique individual que padece síntomas individuales, afectando a un ser humano concreto. Por esto hablamos de farmacopsiquiatría, que no sólo se ocupa de la terapia de lo psíquico (psicofarmacoterapia o psicofarmacología), sino que intencionalmente focaliza el aspecto médico (iatría) del ser humano individual sufriente con síntomas psíquicos que tienen un impacto vivencial importante en su historicidad.

NOTAS

⁹² Se utilizan también para tratar la ansiedad los antidepresivos tricíclicos, los ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina) y los duales o IRSN (inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina).

⁹³ Los placebos son sustancias sin actividad, sin acción farmacológica. Se administran como medicamentos aunque se sabe que no tienen actividad. Hasta 1811 no se incluyó el término placebo en los diccionarios médicos indicando que era una sustancia «para complacer o para estimular la imaginación del enfermo en su beneficio». En 1894 ya se definió como sustancia inerte.

⁹⁴ El mito de Tarzán consiste en que en estas películas el héroe que vive en la selva siempre aparece bien peinado, sin parásitos, sin un rasguño en la piel, sin caries dentales..., es decir, «perfecto» en esas condiciones de vida «naturales». Es un mito pensar que si viviéramos en la selva, sin más medios que la plena naturaleza, nos mantendríamos así de bien. Realmente, los aborígenes de las selvas padecen muchas enfermedades, parasitosis, caries y una esperanza de vida de 35 años de edad.

⁹⁵ Por esto es por lo que la FDA, que es la administración para el control de los medicamentos, ya que están prohibidos los estudios controlados (dando a unas embarazadas medicación y a otras placebo), es por lo que clasifican a algunas benzodiacepinas dentro del grupo C = no hay estudios clínicos adecuados en mujeres embarazadas, y puede ser útil a pesar de sus riesgos potenciales, y otras dentro del grupo D = aunque hay evidencias de riesgo, los beneficios potenciales del uso en mujeres embarazadas pueden ser aceptables a pesar de los riesgos potenciales.

⁹⁶ Diferenciamos entre «droga» y «fármaco». La palabra droga, de procedencia céltica, que significa «cosa mala o de mala calidad», se habría aplicado a las sustancias químicas y a las mercancías ultramarinas por el mal gusto de aquéllas y por la desconfianza que el pueblo mira toda clase de drogas, y de ahí deriva el nombre de los comercios denominados droguerías. No todas las drogas son curativas y por eso en las droguerías se venden sustancias que realmente no lo son. La palabra fármaco deriva del griego *phármakon* = medicamento,

y de ahí el nombre de los establecimientos dispensadores o farmacias, en donde sí que se facilitan estas sustancias curativas. Por esto tenemos que hablar en el tratamiento de la ansiedad de «farmaco-terapia». El problema de la confusión con estas palabras está que en inglés sólo existe la palabra *drug* = droga, tanto para los medicamentos como para las sustancias de la droguería, y de ahí que muchas personas, incluso profesionales de la salud, salgan en medios de comunicación haciendo una traducción literal y hablando de las «drogas para la depresión, para la ansiedad, etc.», dando lugar a confusión y que pueda hacer pensar, asimismo, que estas sustancias tengan alguna semejanza con otras como la heroína, cocaína..., que también son denominadas «drogas». Por esto el miedo de muchos pacientes a ser «drogados» cuando les damos un tratamiento con psicofármacos.

[97](#) La palabra *holon*, en contraposición con la expresión «pan», significa no la generalidad de todo, sino, como es el caso de Aristóteles «la totalidad como tal»; por eso hablamos de una holo-terapia.

[98](#) El término «farmacopsiquiatría» fue acuñado por Kraepelin en 1892.

11. LA PSICOBIOGRAFÍA: VALOR HIGIOGÉNICO Y PATOGÉNICO. VALORACIÓN DE ACONTECIMIENTOS DE LAS EDADES PREESCOLARES

M. Rojo Sierra (Resumen)

11.1. PREFACIO O PRÓLOGO A ESTE CAPÍTULO

En 1988, el profesor Miguel Rojo Sierra publicó en la editorial Nau Llibres un pequeño librito con el título que lleva este capítulo. Tanto se ha hablado y escrito sobre si los acontecimientos que nos han ocurrido en la primera infancia tienen una especial importancia para que luego padezcamos enfermedades psíquicas, que en esa pequeña obra hizo una exposición magistral de su pensamiento al respecto.

El pasado infantil ya es lejano en una persona adulta, pero situaciones que acontecieron ¿pudieron ser beneficiosas para nuestra salud psíquica posterior? (es decir, tener un valor higiogénico) o ¿pudieron ser perjudiciales haciéndonos más vulnerables a enfermedades psíquicas ulteriores? (es decir, tener un valor patogénico). Ésta es la cuestión fundamental que se plantea. Se ha escrito mucho sobre la importancia de la infancia en general, ¿pero y de la edad preescolar, es decir, anterior a los 6 años?

El título significa exactamente lo antedicho: «la psicobiografía» hace referencia a que se quiere valorar la vida del paciente; «valor higiogénico» está haciendo referencia a la higiene mental, es decir, a la prevención de la enfermedad mental⁹⁹, y «valor patogénico» hace referencia a la capacidad efectiva que puede tener la psicobiografía, la vida preescolar, para facilitar la enfermedad mental (la patogenia es la parte de la medicina que estudia cómo se genera la enfermedad).

Quizá la obra del profesor Miguel Rojo Sierra, en algunos apartados, esté más bien escrita y dirigida exclusivamente al profesional de la salud, y por esto he querido en este libro que estamos leyendo sobre la ansiedad «en lenguaje para todos» hacer un resumen de ella, mas siempre cuidando que el lenguaje sea comprensible y pueda ser asequible no sólo a psiquiatras, médicos en general, psicólogos o profesionales de la salud, sino también a cualquier persona que realmente esté interesada vivamente por la enfermedad psíquica y por el hombre que padece esa enfermedad.

En la edición de esa obra de Rojo Sierra colaboré yo mismo, junto con las profesoras M. García Merita e I. Balaguer, pertenecientes al área de Psicología, y con los profesores L. Rojo Moreno, L. Livianos Aldana y M. Rojo Moreno, pertenecientes al área de la Psiquiatría.

A continuación, y sin más dilación, empezamos ya con el resumen de la obra.

11.2. INTRODUCCIÓN

Todas las historias clínicas que hago, o hacen mis colaboradores, son biografiadas, por lo que tenemos que considerar siempre el valor que para el enfermo que ahora es ya adulto tuvo lo que le ocurrió en su infancia, en su adolescencia y —si es anciano— también lo que le pasó en sus mejores tiempos de apogeo.

Pero muchas veces nos hemos preguntado: ¿acaso los acontecimientos penosos, las frustraciones y conflictos que le ocurrieron en el lejano pasado tienen de verdad interés en la entrevista que ahora le hacemos al adulto, con circunstancias totalmente distintas?, porque aquellas edades tan tempranas de su vida —y que a veces ni siquiera recuerda ya bien— no son hoy sino historia.

Pero ¿qué validez tiene la historia con lo que acontece actualmente?

11.3. SOBRE LA HISTORIA DEL INDIVIDUO, QUE ES SU VIDA

Es importante entender el concepto de «bios» que utilizó K. Jaspers.

El hombre tiene siempre un pasado tras él. Todo cuanto aconteció en este pasado, de algún modo, deja restos, incluso lo olvidado. El bios es todo este pasado desplegado hasta el presente; pasado que ahora sólo es una imagen de la memoria, pero que permanece en cada uno de nosotros. Y además toda persona sabe que lo que es ahora está de alguna manera realizado por los actos que él hizo a lo largo de la historia de su vida.

Cuando analizamos el bios de una persona, también tenemos que tener en cuenta que a lo largo del mismo la persona va «formando su mundo». Esto quiere decir que cada ser humano sabe que no está en el mundo sólo para vegetar, sino que quiere existir para algo, quiere experimentar un sentido de su vida. Pero como la vida no le muestra por sí sola su sentido, él tiene que dárselo, ha de formar su propio sentido vital. Dicho de otro modo, de forma ineludible cada persona tiene una «tarea de formación» que hacer durante su vida.

Y además tenemos que tener en cuenta que al igual que los cimientos son decisivos en cualquier edificio, también, dice K. Jaspers, lo son las primeras vivencias, porque «toda vivencia que por primera vez origina un efecto importante en una persona, orienta su capacidad afectiva para toda la vida».

11.4. ETAPAS Y CURSO DEL BIOS

La infancia, dice textualmente K. Jaspers, echa los cimientos. Lo que fue malogrado, faltó o fue destruido en esta etapa apenas puede ser curado jamás.

La vejez es la última etapa que se caracteriza porque ya, para ese bios aquí llegado, deja de serle posible nada especialmente nuevo. La vejez está inspirada por la veracidad de la larga experiencia de la vida. El bios puede adquirir en esta etapa una imperturbabilidad y una holgura de sentimientos que son extrañas en las etapas de la niñez, de la juventud e incluso en la del adulto.

Desde la infancia a la vejez el curso de cada bios humano no es homogéneo ni uniforme. Está lleno de accidentes, muescas y torceduras. Como a lo largo de la vida el ser humano está obligado a adaptarse a las distintas circunstancias y situaciones, por esto aparecen quebrantamientos y crisis del bios.

Suceden *quebrantamientos*, ya que la capacidad psicobiológica para adaptarse al mundo circundante es limitada, y entonces pueden aparecer pérdidas de esta adaptación en un momento determinado. La situación que hasta el momento era estable ha cambiado y el sistema de adaptación hasta ahora útil ya no sirve. Así ocurre, por ejemplo, por la pérdida de alguien importante como la madre para el niño o la mujer para un hombre inválido. El quebrantamiento dura hasta que la adaptación vuelve a recuperarse. Algunas naturalezas dan la impresión como si resistieran todas las tormentas como rocas inmutables: son naturalezas firmes y tengamos en cuenta que en este caso la firmeza es salud. Constituyen bios en los que las situaciones patogénicas apenas influyen: son poco vulnerables.

Pero otras naturalezas parecen no tener firmeza alguna porque son como «ecos de lo que ocurre en el ambiente»: son naturalezas infirmes, y como la infirmeza es enfermedad¹⁰⁰, desarrollan bios enfermizos para los que lo higiénico (los acontecimientos positivos y estabilizadores) apenas cuenta y lo patogénico los hiere enseguida.

Aparecen *las crisis* cuando en un momento del desarrollo del bios, éste sufre una transmutación o transformación del mismo. Se diferencian las crisis de los quebrantamientos porque no se trata de una simple recuperación del sistema adaptativo ante un cambio en su mundo vivido, sino de una verdadera metamorfosis que exige una nueva adaptación radical al mundo aunque la situación de éste hubiera continuado estable, como antes.

Son crisis importantes (como ya vimos en otro capítulo) las que describió K. Conrad:

- La primera, entre los 6-8 años.
- La segunda, entre los 13-16 años.
- La tercera, alrededor de los 36-50 años.

En estas crisis no sólo hay irrupciones psíquicas, apareciendo nuevas necesidades e impulsos, sino importantes modificaciones biosomáticas de modo que se cambia frecuentemente la constitución corporal y hay una gran vulnerabilidad a enfermedades. Después de cada una de estas metamorfosis puede aparecer una buena armonización del sujeto, resurgiendo con más horizontes que antes, o puede, por el contrario, no armonizarse cayendo en decadencia.

Hay también otras crisis imprevistas como pueden ser de tipo religioso, social o político, que fundamentan una manera de entender la vida de forma completamente nueva.

11.5. VARIEDADES DE «FORMAS» DEL BIOS

Observó Jaspers que había desarrollos del bios prematuros y tardíos.

En los prematuros hay un «senilismo» muy precoz, manifestándose porque esa persona pronto se enquistaba en su rutinario modo de ser y saber, bien haciéndose muy reduccionista (todo no es más que esto y ya sé de la vida lo que tengo que saber) o bien dedicándose pronto a filosofar sobre la vida, pero no a vivirla. Todos conocemos a algún joven o persona de mediana edad que realmente es ya un «anciano» en su modo rígido y reductivo de pensar.

En los bios tardíos se acusa un infantilismo prolongado. Pero hablar de infantilismo no es algo peyorativo, ya que hay infantilismos negativos y también infantilismos positivos.

El bios es retardado por infantilismo negativo cuando permanece en las primeras etapas del desarrollo quedando la persona inmadura. Por el contrario, un bios es retardado por infantilismo positivo cuando en medio de sus avanzadas etapas conserva el «germen primigenio» de la admiración y creatividad; la productividad no deja de ser persistente al igual que la plasticidad de su espíritu y «alma abierta».

* * *

La teoría general del bios que nos ha mostrado Jaspers permitió a dos autores, Charlotte Buhler y Van der Horst, hacer un esquema más particular que ya nos conduce directamente a la ubicación de nuestro tema: las edades preescolares, dentro del marco del desarrollo histórico del ser humano.

Charlotte Buhler (1956), profesora de la Universidad de Viena, observa que toda existencia humana recorre una «curva vital fusiforme», pues la primera parte de la existencia es expansiva y la segunda es restrictiva, terminando con la muerte.

Esta curva vital la divide en 5 etapas o fases:

1. Etapa de aprendizaje: el ser depende del medio familiar y está construyendo los cimientos del conocer.
2. Etapa de ensayo: el ser hace tanteos de actividad inespecífica, para hallar su auténtica expresión y autoidentificación.
3. Etapa de madurez: el ser mantiene estacionario el crecimiento, llegando su existencia al apogeo en el que alcanza el punto culminante de su obra y plenitud.
4. Etapa de restricción subjetiva: el individuo se distancia de sus pasiones y entra en actividad objetiva, dirigida por el deber pero no por el sentimiento como antes.
5. Etapa de restricción objetiva: el rendimiento baja; el interés se vuelve hacia atrás. Se va retirando primero el futuro y al final hasta el presente.

Finalmente llega la muerte.

Pero lo más interesante del trabajo de Buhler es señalar que estas etapas se dan tanto en personas que tienen vidas largas como en personas que las tienen más cortas.

Expone como ejemplos ilustrativos las vidas de Napoleón y Shelley.

Napoleón alcanza el «apogeo» de su bios desde el comienzo del consulado hasta la paz de Tilsit. Después ocurre un cambio de destino: se aleja de su mundo pasional divorciándose de Josefina —la mujer con la que se había casado por amor—, se hace «objetivista» y contrae un matrimonio político al que se sentía «obligado».

Su quinta etapa, la de la «restricción objetiva», sucede en Santa Elena, donde Napoleón empieza a redactar sus *Memorias*; mira al pasado. A lo largo de esta vida se ve que la edad de apogeo acabó a los 38 años y la muerte le sobrevino a los 52 años, cuando su vida ya estaba enteramente cumplida.

No menos interesante es el caso del poeta inglés Percy Shelley, cuya muerte ocurre en 1822, poco antes de cumplir los 30 años, al desaparecer en medio de una tormenta.

Su primera etapa de aprendizaje se extiende hasta los 14 años. La etapa de ensayo se extiende hasta los 20 años, en los que intenta actuar en Irlanda, siguiendo sus ideales. En la etapa de apogeo —desde los 22 hasta los 24 años— recibe una herencia, madura su gran amor con Mary Godwin y su existencia se consolida.

Pero desde los 24 a 28 años ya aparece la etapa de restricción subjetiva: muere su mujer, el Estado le niega los hijos y Shelley se siente lleno de obligaciones y deberes.

Desde los 29 a 30 años su vida está interpretada; vuelve sus ojos al pasado, escribe su biografía y encuentra la muerte en un naufragio.

Un hombre que no viva mucho cumple las cinco etapas pero contraídas. El hombre longevo tiene igualmente las cinco etapas pero dilatadas y extendidas.

Van der Horst (1942), de forma parecida, observó que las personas de especial y elevada inteligencia (genios) jóvenes tienen un pronto período de florecimiento que coincide con el momento en que se inicia el descenso de la vida, presentándose, entonces, la muerte muy precozmente. Pero los genios longevos tienen retrasado su punto culminante, como fue el caso de Shakespeare, que escribió sus mejores obras después de los 50 años. Igualmente ocurrió con Pasteur, que hizo su descubrimiento con 64 años de edad, y Miguel Ángel, que terminó con 70 años la cúpula de San Pedro.

Vidas cortas o vidas largas, pero siempre las mismas etapas en todo bios.

11.6. LOS SUCESOS Y ACONTECIMIENTOS EN LAS EDADES PREESCOLARES

Distinguimos, por las necesidades y presiones completamente distintas, por una parte, el primer año de vida, y por otra, la edad preescolar (de 1 a 6 años).

11.6.1. En el primer año de vida

En este primer año se da en el bios humano un ineluctable suceso: ha de cambiar su nivel vivencial; de encontrarse, antes de nacer, en el útero, con la placenta que le aportaba todas sus necesidades, ahora ha de anidar en este mundo circundante que a

veces no sólo le es inhóspito y que no satisface generosamente sus necesidades, sino que, además, ahora la persona nacida ha de aprender a satisfacerlas.

En el primer año de vida, el ser humano ha de echar sus raíces e implantarse en el espacio y en el tiempo.

Como señala Rabindranath Tagore en su obra *Ofrenda lírica*:

«Pasé sin darme cuenta el umbral de esta vida, ¿qué poder fue el que me hizo abrir en este inmenso misterio, como un capullo, a media noche en el bosque?

Cuando a la mañana vi la luz sentí al punto que yo era un extraño en este mundo; que lo desconocido sin nombre ni forma ya me tenía en brazos, en la forma de mi madre».

Y, en efecto, esta relación madre-hijo es vitalmente importante. El ser humano no nace como los demás animales. Portmann ya demostró que la evolución y madurez que ha de realizar el hombre en el primer año de vida la efectúan los demás mamíferos dentro del útero materno.

Los estudios bioquímicos del sistema nervioso demuestran que sólo al cabo de un año el vástago humano alcanza, proporcionalmente, la madurez que tiene ya al nacer un mamífero de su jerarquía. Para llegar, pues, a esta madurez biológica que tiene cualquier mamífero al ser parido, habría precisado el ser humano que el embarazo se hubiera prolongado un año más de lo que ocurre normalmente.

Nace, por tanto, el hombre como feto inmaduro y en el primer año ha de madurar a «niño» precisando de una manera especialmente significativa del cuidado y cariño de su madre ¹⁰¹.

Por lo tanto, la comunicación que tenga con la madre durante el primer año de vida va a ser esencial. Si ésta no se cumple, aparecerá un grave acontecimiento patogénico: *el abandono*.

Hay cuatro vías importantes de comunicación madre-hijo; tres dedicadas a la compenetración con el espacio y la cuarta con el tiempo.

Las vías de comunicación y enraizamiento espacial son:

1. La táctil, que proporcionará lo que Max Scheler llamó «el espacio propio», es decir, el espacio que biológicamente llenamos con nuestra presencia: la vivencia del espacio corporal.
2. La óptica, que proporcionará la captación familiar del espacio ajeno y circundante al cuerpo.
3. La olfatoria, que rellenará entre lo «propio» y circundante la separación que obligadamente queda.

El aprendizaje, enraizamiento o penetraje de la experiencia del tiempo se hará fundamentalmente mediante la boca: es la vía oral.

Vamos a comentar, a continuación, algo sobre estas vías:

1. La vía táctil

La insustituible importancia de esta vía hace mucho tiempo que ha sido descubierta y estudiada. La relación táctil es una necesidad biológica. Cuando a diferentes especies de mamíferos y aves se les priva de esa serie de tratos de caricias como el lamido, el picoteo y la limpieza, al compararlos con los animales pequeños que sí han tenido estos cuidados se hace patente:

- Un defectuoso valor biológico: su aspecto es paupérrimo.
- Una mayor susceptibilidad a las enfermedades por falta de defensas.
- Y la mayoría tienen una muerte prematura.

Igualmente, son muy conocidos los estudios de Seiz, que comparó gatitos que eran separados pronto de las madres con aquellos que eran separados mucho más tarde. Cuando ambos grupos se hicieron adultos, los que apenas habían tenido contacto con la madre eran enormemente suspicaces y miedosos, atacaban sin previo aviso, robaban la comida y jamás la compartían. Por otra parte, los que había tenido un buen contacto con la madre eran amistosos y confiados, eran pacíficos en el grupo y bufaban para, en lo posible, no atacar físicamente.

En resumidas cuentas, ya en el animal se ha podido comprobar que el contacto táctil es higiénico para una firmeza biológico-social ulterior y su privación es patogénica, tanto en infirmeza biológica (facilidad de enfermedades y muerte precoz) como para su ajustamiento social.

Igualmente ha ocurrido con las experiencias en humanos. Rene Spitz estudió niños institucionalizados en orfanatos. Los 91 niños que estudió, atendidos en instituciones con higiene irreprochable —al igual que los niños que han tenido que sufrir largas hospitalizaciones sin que las madres los tocan durante días y días—, presentaron retraso global de la personalidad, dificultad de lenguaje y conductas disociales, entre las que sobresale la incapacidad de lograr una relación amorosa normal, no valorando adecuadamente el afecto que reciben. Rof Carballo (1961) habló de la «huella del desamor» cuando está disociada la urdimbre madre-hijo. Huella que hace para siempre al sujeto ser insaciable al amor y cariño que luego le dan.

Esto nos hace pensar que si en el primer año de vida falta la comunicación táctil y el acogimiento, aunque no sea una falta extrema, se pueden producir tres formas de cimentación patogénica:

- Un mínimo grado de falta de contacto cimentará una conducta de «llamar insaciablemente la atención ajena».
- Un grado intermedio podría facilitar una mediocridad de rendimientos intelectuales.
- Un grado mayor, cimentaría patogénicamente los precoces fundamentos de un autismo, de una gran dificultad de relación con los demás, o de un negativismo.

Por el contrario, si el contacto ha sido grande, y máximo el acogimiento, esto es radicalmente higiénico (favorable) para que el desarrollo del bios manifieste luego

una buena fortaleza biológica, una conducta generosa y capaz de amar, y una buena disposición para construir ese «sentimiento nostral» básico y necesario para que haya una auténtica comunicación social.

Pero es importante recalcar que hay que ser muy cauto para no culpar a la madre, así sin más, cuando se sospeche una falta de contacto o comunicación en el primer año de vida. Como bien dice A. Seva (1979), en la díada madre-hijo hay un círculo dinámico transaccional; es decir, el recién nacido no sólo recibe el afecto de la madre, sino que el propio niño también lo debe activar. Por esto, la díada de una madre muy poco expresiva y un niño también pobre en expresión puede ser funesta.

2. La vía óptica

Va a suponer el cimiento de la vivencia de la proximidad o distancia, tanto geográfica como afectiva.

La vieja expresión de que «los ojos son las ventanas del alma» tiene mucho de verdad porque de la mirada emana gran fuerza informativa. La mirada de la madre al hijo y de éste a ella fue comparada por Campbell a la mirada fascinosa, a la mirada hipnótica. Es mirada fija mientras que el gesto sonríe; mirada de pupila a pupila largos ratos mantenida. Ortega y Gasset, en su ensayo sobre el amor, comparando también el enamoramiento con un *rapport* hipnótico, decía que la mirada de los amantes —que quietos en silencio, sus ojos penetran en sus ojos— recordaba a la mirada interocular de madre e hijo.

El gesto de la mirada, al decir de Charlotte Wolf, es difícil de definir: pues no es mirada arrebatada, ni maravillada ni deseosa ni admirativa; es mirada de ternura, esa mirada que el adulto siempre recuerda de su madre cuando era niño.

Por eso, la comunicación por la mirada, precisamente por estar tan saturada de «mirarse alma a alma» (el tacto era acogerse cuerpo y cuerpo), si bien cimienta higiénicamente la seguridad en la distancia, su ausencia y su cambio de sentido puede cimentar disposiciones prematuras patogénicas.

Miradas desviadas y miradas anónimas de madres enfermas o incapaces de empatizar con sus hijos, incapaces de crear esa díada madre-hijo, van a ser especialmente perjudiciales cuando esté la progenitora nutriendo al niño en esa alimentación oral en la que la mirada de ojos a ojos debería comunicar algo esencial pese a que un espacio vacío se interpone entre él y la madre.

3. La vía olfatoria

Es una vía muy positiva de comunicación, aunque poco estudiada.

Muchos olores informan y provocan conductas a través de las feromonas¹⁰². Puede que el niño identifique mediante feromonas diádicas y grupales su entorno y le sea traumático, especialmente durante el primer año de vida, la separación de su

madre y de su ambiente a otro ambiente oloroso distinto. Es más, cabe preguntarse que si una madre *desde sus adentros* rechaza al hijo, aunque aparentemente lo acoja, no obstante, el niño puede que sienta y vivencie el abandono, a pesar del acogimiento formal.

4. La vía oral

Por la comunicación oral, el niño aprende que el nuevo ambiente extrauterino no es tan hostil como le pareció tras el parto, sino que también le produce satisfacciones en lo visceral de su cuerpo interno, satisfaciéndole necesidades que intermitentemente tiene.

Cuando el niño experimenta su primera experiencia de hambre nota un estado interno muy desagradable: nosotros lo llamamos «necesidad vital de comer», pero el niño no puede ni siquiera llamarlo nada. Mas he aquí que algo se solidariza con él, la boca, la faringe y el estómago (que para el niño es todo lo mismo) y se siente maravillosamente satisfecho y con placer cuando le llega por primera vez la leche.

Pero pasado cierto tiempo vuelve a sentir esa espantosa necesidad, mas al punto llega la satisfacción. Por lo tanto, se establece un ritmo compuesto por tres fases: tensión, satisfacción e intervalo.

Como es bien sabido, el ritmo es un fenómeno básico para vivenciar el tiempo¹⁰³. Gracias a los contactos táctiles, ópticos y olfativos se empezó a implantar el ser del niño en el espacio; ahora, con el ritmo de las «tetadas» ha de lograrse o malograrse el primer cimiento de implantación en la temporalidad.

Si todo marcha bien, en el niño empezará a forjarse un importante elemento higiénico para el futuro despliegue de su personalidad. Propongo llamarle «el sentido providencial», es decir, el sentido de estar sosegado, tranquilo en espera; y con ello el niño va haciendo los cimientos de la esperanza. Poco a poco su cerebro va asociando que cuando tiene hambre su madre aparece, que cuando está tranquilo y dormido nada le altera. Y cuando otra vez siente el desasosiego alimentario, va descubriendo que siempre y providencialmente la madre está allí.

Gracias a esto:

- Sabrá esperar cada vez mejor, sin tensión.
- Empieza a germinar la vivencia del estar protegido.

Y si esto ocurre, cada vez más en el niño coincidirán los ritmos (comidas, descansos) por él esperados con los acontecimientos. O dicho de otro modo, «el tiempo interno» se encaja con el «tiempo externo» (Carrel), produciéndose en el niño la ataraxia, la vivencia de calma, en la temporalidad.

Si no se malogra este fundamento, en las etapas ulteriores irá descubriendo que la madre preveía, y que los demás también pueden prever. Y entonces el niño empezará a contar o a tener en cuenta a «los otros»... y si se conserva este aprendizaje hasta la

madurez, podrá adaptarse con cierto sosiego, en los momentos de vacío que hay en toda crisis o quebranto de su propia vida o realización personal.

La higienía oral basa, fundamenta, la serenidad y la firmeza que hay que tener en los tiempos de tribulación, tan frecuentes en todo bios.

Pero, por desgracia, no siempre sucede así, y en muchos niños este ritmo de tensión-incorporación está anormalizado, apareciendo disturbios patogénicos que recaerán fundamentalmente en la esperanza en los demás y en la previsión.

Hay dos tipos de anormalizaciones:

- a) Uno recae en el intervalo.
- b) Otro recae en la satisfacción oral.

a) Recae en el intervalo cuando la madre quiere criar al niño rígidamente según el promedio científico. Nos explicaremos: el niño normalmente tiene la tensión de comer cada tres horas. Pero esto el recién nacido tiene que irlo aprendiendo. El niño al principio pedirá la comida unas veces antes y otras veces después, hasta que encuentre su ritmo alrededor de las tres horas. Pero si la madre prescinde de sus propios sentimientos y de su propia espontaneidad en relación con su bebé, querrá educarlo desde el principio a un ritmo impuesto.

Como el niño no lo ha aprendido y exige lactar antes de tiempo, la madre férrea dejará que el niño llore hasta que por cansancio se canse y así ella gana la batalla. Precisamente cuando ya está el niño exhausto y dormido, la madre observa que ha llegado la hora teórica de darle la leche, pero ahora el bebé no responde, no tiene hambre sino extenuación y la leche no le produce la misma satisfacción.

Repitiéndose la experiencia veces y veces se creará el cimiento disrítmico siguiente:

- Cuando el bebé quiere alimento no se le da.
- Cuando no quiere, entonces se le da.

Así queda rota la vinculación *motivación* ò *satisfacción*, ya que la relación se invierte.

Si tal fundamento patogénico no se corrige en el ulterior desplegamiento del bios, podrá aparecer después —de joven o adulto o viejo— lo que llamamos deseo paradójico; es decir, por un lado, el deseo vehemente de aquello que no se tiene, y por otro lado, indiferencia absoluta cuando se consigue lo deseado, o indiferencia ante muchas de las cosas que ya se tienen.

b) Decíamos que el segundo tipo de anormalización recaía en la *satisfacción oral*.

El deseo de ingerir lo siente el niño como una especie de torturante escozor labial y gingival. El reflejo de succión exige esto, y esta desazón local también hay que satisfacerla para que la saciedad sea subsanada.

Esta anomalía sucede frecuentemente, bien por tener poco tiempo el pezón en la

boca del bebé, o bien cuando se hace un agujero grueso en la tetina del biberón que hará que el niño replete pronto su estómago, pero el escozor labio-gingival seguirá existiendo.

Lo hemos observado, en nuestros días, en madres que por el trabajo van siempre con prisas ansiosas y no tienen ayuda.

El resultado es que cuando ya está calmándose la saciedad (pero aún no está calmada) le retiran el pecho o el biberón. A pesar de regurgitar, luego, aunque el estómago del bebé esté lleno de leche, no obstante el niño se ha quedado tenso y ansioso.

La «tetada» esperada normalmente en este caso llegó a punto, pero también casi a punto de satisfacerse con ella es retirada.

Al repetirse veces y veces se crea un cimiento patológico: el bebé acabará condicionándose a tender a lo que le hace feliz, pero, al mismo tiempo, «temer que se acabe cuando empieza a serlo».

Lo hemos denominado angustia paradójica. Esta angustia, si no se compensa en las etapas siguientes puede construir, sobre su cimentación, las neurosis del éxito y también aparece en caracteres psicopatóides: los hombres que ilusionados pretenden una finalidad y al tenerla no se atreven a disfrutarla. Un último extremo cimentaría un abstencionismo a no desear nada, pues la satisfacción de todo también nada dura.

* * *

Pero si de una manera global contemplamos el abandono o rechazo, tenemos obligatoriamente que hacernos dos preguntas:

- a) ¿Cómo podemos sospechar que hay o ha habido realmente una privación afectiva?
- b) ¿Cómo puede demostrarse que estos sucesos son patógenos de verdad?

a) Podemos sospechar una privación precoz de afectividad si aparece una de estas circunstancias:

1. El niño ha sido criado separado de la madre (ya sea por enfermedad de la madre, divorcio, etc.) sin que haya una persona sustituta del maternaje.
2. El hijo rechazado:
 - Por aborrecer la madre al padre y no querer hijos de él.
 - Por rechazo tajante del embarazo y no poder abortar.
 - Por ser hijo de madre soltera muy joven.
 - Por ser hijo de viuda muy joven: como puede suceder en el primer hijo póstumo, teniendo la madre conflictos con la familia y teniendo que rehacer su vida.
 - Algunas veces cuando ha muerto la madre en el parto del niño y de forma latente culpabilizan a él de su muerte (especialmente si la madre era hija

única o la única mujer entre todos los hermanos varones).

Tengamos en cuenta que éstos son detectores, y también que muy raramente el rechazo va a ser reconocido directa y explícitamente por la madre.

b) ¿Cómo podemos demostrar que estos sucesos son patógenos de verdad?

La acción patógena de la privación queda demostrada por los múltiples estudios epidemiológicos que se han realizado. Como ejemplo, en el estudio de Vicente Rubio (1980), que abarcó a hijos de inclusas de cinco provincias, pudo comprobar que:

- El 85% de los niños se asustaban de las visitas.
- El 91% no hablaban aún a los 30 meses de edad.
- El 89% tenían importantes problemas en el reconocimiento de su cuerpo.
- Y el 90% tenían retraso motor e intelectual.

La edad más sensible para los efectos del abandono parece situarse entre el séptimo y el decimoquinto mes de vida, y coincide, según Seva Díaz, con ese período en el que, al decir de Erickson, se desarrolla el sentido básico de la esperanza.

Pero antes de terminar esta precocísima etapa hay que señalar que aunque en el primer año de vida es cuando la privación afectiva tiene más efectos patogénicos, no obstante va a ser asimismo muy importante esta privación afectiva en toda la etapa del aprendizaje, pues para el bios aún sigue siendo indispensable la dependencia con la familia. Y por esto, Pilar González, en su tesis doctoral (1978), demuestra cómo la edad media en la que la privación afectiva es vivenciada como muy traumática se sitúa en los 5,85 años de edad.

Tanto en la edad preescolar como en la escolar la privación de cualquiera de los padres (por muerte o separación) va a tener consecuencias patogénicas cualitativas importantes. La privación materna puede acrecentar especialmente el riesgo depresivo desde un 9% en los pacientes que no habían sufrido privación, hasta un 22% en los que sí la habían sufrido (Seva y Vázquez). En algunos casos la privación paterna puede aumentar el riesgo paranoide (Swanson) al quedar con menos protección la madre y volcar en el hijo el miedo al mundo.

11.6.2. Edad preescolar: la etapa del aprendizaje

Nos vamos a atener sólo a lo que se denomina la primera infancia, normalmente comprendida entre los 1 y 6 años.

¿Qué propensiones, en general, van a surgir en esta época en el niño?

Podemos resumirlas en tres:

- a) La curiosidad y el aprendizaje de la belleza.
- b) La fantasía creadora.
- c) La imitación.

Y estas propensiones cursan con una canalización común: el juego.

a) La curiosidad y el aprendizaje de la belleza

La curiosidad se deriva del mismo afán exploratorio que el niño tiene en estas edades. No es nada raro que en esta época el niño saque de los estantes bajos de las librerías los libros que están a su alcance, haga una pila con ellos, los abra, los cierre y arranque sus hojas. Naturalmente, la misma curiosidad le hace meter los dedos en los agujeros de un enchufe o destripar un juguete. El problema es cuando su curiosidad alcanza un jarrón, un ánfora o algo frágil. Ha tocado lo bello. Aunque obviamente los mayores deben poner ciertos objetos valiosos a buen recaudo de modo que al niño le sea posible admirarlos pero no tocarlos, es inevitable que pida que le den alguno de ellos.

Patogénicamente se actúa muy negativamente si los mayores le riñen. No sólo porque se les da a entender que es malo seguir los impulsos de su propia naturaleza, sino porque, como ha indicado Erikson, ya empieza el niño a tener sentido para distinguir la estética. Si al niño riñéndole se le repite que esas cosas no las puede tocar y se le dan objetos viejos o más feos para que lo haga, se está haciendo una asociación entre jugar espontáneamente con lo desechable y estar tenso si juega con lo bello, pues puede recibir una regañina. Con los refuerzos negativos de las riñas se fortalece el sentirse cómodo con lo antiestético e incluso gozar con ello y desestimar lo artístico. Recuerdo un paciente nuestro así educado que sufría de impotencia sexual con su esposa —extraordinariamente hermosa— sintiéndose en cambio feliz y sin inhibición alguna con las prostitutas, mejor cuanto más sucias fueran, aprovechando para decir todas las palabras soeces que en ninguna otra situación pronunciaba.

F. Kunkel (1950) propone, por estas razones, enseñar al niño a venerar las cosas bellas en vez de eludirlas por miedo al castigo. La destrucción de una valiosa pieza —dice Kunkel— es una pérdida afectiva, pero si se le atemoriza al niño, se rompe algo más bello todavía: la confianza que el niño tenía de sentirse partícipe del goce que la belleza del mundo produce.

Higiogénicamente, si se le enseña al niño con ademanes suaves y delicados a tocar reverencialmente cualquier objeto frágil, se le está cimentando la capacidad de apercibir la belleza inmanente que lleva en sí la vida.

b) La fantasía creadora

En la fantasía creadora se realizan ensayos para la identificación de su propia vida, y por eso el niño pinta, dibuja, le encanta hacer formas con la plastilina, etc. Es pernicioso toda comparación, tanto exaltante como rebajante, de su trabajo, dibujo u obra. Tan nefasto e inhibidor es decir al niño que lo ha pintado, modelado o jugado mejor que sus otros hermanos o amigos, como humillarle diciéndole que uno de sus amigos sí que lo ha hecho bien.

Lo preciso es estimularle la fantasía para que, como diría C. G. Jung, extienda sus

ocurrencias. Por ejemplo, si ha pintado una locomotora se puede aprobar simplemente su obra diciendo: «sí, parece en efecto una locomotora, ¿pero por qué no le has pintado las ruedas más pequeñas? ¿Es divertido dibujar máquinas, verdad? ¿Dónde vimos una locomotora parecida? ¿No la vimos en la estación?». Así al niño se le estimula a que prosiga: «Sí, además vimos una grúa, un vagón, etc.». Desviando la atención de la vanidad egocéntrica despertamos el destello de la creatividad.

c) La imitación

La imitación deriva del hecho de que el niño en sus exploraciones del mundo circundante descubre otro misterio: «los demás».

Los «demás» tienen un cuerpo como él, y lo que es más raro: unas normas. El niño se explora y explora su propio cuerpo y lo compara, pero no tiene patrón alguno para las normas o preceptos. Al principio le parece al niño la cosa muy simple: «Hay acciones y personas buenas y hay acciones y personas malas». Bueno es lo que cuando lo hago me aprueban, malo cuando me riñen.

Pero ¿cómo aprender que ha de hacer cosas buenas y evitar ser malo? Pues precisamente con la imitación, identificándose con unos patrones de aprobación o desaprobación. Busca patrones claros y perfilados, ya que mediante ellos aprende a orientar su conducta.

Evidentemente, los primeros patrones a imitar provendrán de los padres. Si éstos no son claros, el niño se desorientará en su estilo imitativo.

Esto ocurre cuando los padres realizan, por ejemplo, una hiperprotección ejecutiva o de tipo gratificante no dejándole hacer nada o le dan todo cuanto pide.

Si se produce una hiperprotección ejecutiva, el niño no aprende a valerse por sí solo, no tendrá un adiestramiento adecuado y se hará muy dependiente de los demás.

Si se da una hiperprotección gratificante, que realmente es un «falso amor» o pseudoamor hacia el niño, ya que se le da todo sin que tenga casi tiempo a pedirlo, entonces no aprenderá a apreciar las dádivas, ni se le ocurrirá que no pueda conseguir lo que se proponga; no estará preparado para las frustraciones que obligatoriamente le han de venir en la vida. No podrá resistir la más mínima frustración y, patogénicamente, se cimentaran grandes posibilidades de ser de adulto neurótico.

Quizá sea aún peor la desorientación que causa la hiperprotección ansiosa de los padres, ya que el patrón que ofrecen es de ser unos padres extremadamente solícitos, pero vigilan tanto al hijo «por su bien» que lo desautoestiman amándole. Están tan encima de él que le inculcan la duda y la desorientación. Hemos visto hipocondríacos en los que en su infancia la madre tenía un fuerte amor ansioso a que fueran a caer enfermos, alarmándose ante el más leve estornudo, cuidando de su abrigo, del enfriamiento o pulmonía que por estar sudando y beber agua fría podría sobrevenirle. Hemos visto obsesivos por padres ansiosos que hacían que el vástago repasase sus rendimientos y sus acciones en un perpetuo examen de conciencia, para que de mayores «fueran unos auténticos modelos».

11.6.2.1. El juego

Todas estas propensiones, la curiosidad, la fantasía y la imitación son canalizadas en el niño mediante el juego. En esta época de la vida el juego es imprescindible. Durante el primer año de vida el niño jugaba con movimientos casi automáticos y así empezaba a construir el primer esbozo sensoriomotor de su esquema corporal. Pero luego hasta el 6.º año de vida el juego asumirá el papel de ser la única práctica del aprendizaje de él en el mundo, el único experimento posible que va realizando a partir de sus observaciones.

En principio se pensó que la naturaleza del juego era derrochar energía; energía que podría ser encauzada más positivamente, pues en el juego se desperdiciaba. Pero luego se comprobó que el juego no es simple actividad que se derrocha: su esencia no recae en la energía gastada sino en el *modo de jugar*.

El hombre adulto ha de trabajar y por lo tanto actuar, y su trabajo y acciones siempre tienen consecuencias. No sucede así con el juego, ya que sus consecuencias y efectos no van a ser trascendentes, por lo que va a servir como preparatorio para el futuro y serio «juego» de decisiones del adulto en la vida.

Precisamente, como todo juego, tiene un componente de riesgo y aventura, es por lo que mediante el juego el niño ya se entrena en el fracaso y en la frustración, como vacuna contra los quebrantos que luego, ya de adulto, va a encontrar en su bios.

Por este motivo para el niño debe quedar claro y bien definido qué es trabajar y qué es jugar. Debe vivenciar que trabajo se llama a lo que es obligado, impuesto para su futura formación y adaptación a la sociedad: «Trabajo cuando debo hacer esto aunque no quiera; me pueden obligar a estudiar, pero juego si yo quiero» (Seva).

Hurlók (1976) insistía en que el niño debe conseguir un equilibrio entre sus «deberes y el juego». Normalmente, dice el autor, si un niño lleva mucho tiempo jugando se aburre y tiende a dejar el juego y acomodarse a un trabajo de estructura obligada; y esto sucede también al revés: cuando el niño se cansa de su labor obligada, su imaginación fantástica le invita a jugar al menos con ella.

El juego realiza una acción higiénica (positiva) por su apoyo a la fantasía creadora, a la curiosidad y a la imitación de normas, ya que a la vez es permisivo y no comprometido seriamente con los resultados. También enseña a resolver éxitos y frustraciones en situaciones pasajeras que no van a marcar definitivamente a la personalidad. Y, por último, el juego —cosa importantísima— troquela en esta época al niño para que en lo sucesivo pueda mantener una comunión perfecta con los grupos. Si durante la primera infancia el juego va realizando adecuadamente el contacto social, tendremos ya un buen cimiento para preservar en el futuro a ese ser humano de la mala o nula sociabilización.

Pero el juego también puede tener acciones patogénicas graves. Esto sucede, bien porque el juguete o el juego produzcan una deformación de la personalidad, o bien porque simplemente haya una privación del juego en estas edades.

El primer caso ocurre cuando el niño utiliza juguetes agresivos o realiza juegos violentos (por desgracia aún existen juegos «asesinos»). El juguete agresivo o

violento hace que en esta época tan importante de modelado cerebral se favorezcan pulsiones violentas, cimentando más el odio que el amor (Seva), y desensibilizando al niño de las supuestas heridas o de la muerte del otro (ya que en su fantasía cuando un niño habla a su muñeca o al conductor por radio de su tanque lo vive como real; igualmente cuando mata soldados o realiza juegos violentos también lo vive como real).

La privación del juego es gravemente patogénica. Un niño que no juega es un niño enfermo siempre; y un adulto que no ha jugado apenas en su infancia es un adulto desequilibrado con graves problemas de comunicación interpersonal.

Desgraciadamente, en nuestra cultura competitiva hay, muy a menudo, una tendencia abusiva a sobrecargar de deberes y estudios al niño, con el correspondiente estrangulamiento de la espontaneidad lúdica del juego. Y no sólo con deberes y estudios; cuántas y cuántas veces nos hemos encontrado con estos «pequeños ejecutivos extraescolares» que nada más terminar el tiempo escolar han de ir «obligatoriamente» a hacer judo + danza + refuerzo de idioma + tocar un instrumento musical + algún deporte de equipo, etc. Recuerdo con qué orgullo me comentaba un abuelo la lista de actividades programadas para todas las tardes, pues tenía que llevar a su nieto cada día de la semana a múltiples «extraescolares», necesitando una agenda para poder acordarse. No lo olvidemos, el «juego» como obligación podrá ser aprendizaje, pero no es juego.

11.7. APRENDIZAJE PREESCOLAR Y ESTRUCTURA SOCIAL

Hasta mitad del siglo pasado, aproximadamente hasta 1960, la etapa preescolar tenía unas características comunes:

- De 1 a 6 años, el niño vivía todo el día en el ambiente familiar jugando en el entorno casero o en todo caso se reunía con amigos cuyos padres eran siempre conocidos por la familia: el marco familiar, por lo tanto, no se perdía.
- El niño se sentía siempre respaldado por la presencia de sus padres, por lo que podía dedicarse complacientemente a conocer las cosas del mundo sin temor a arriesgarse, ya que cuando se alejaba de su casa lo hacía «en recorridos en espiral», pues siempre las distancias tenían como centro el hogar, y si se perdía, tenía la certidumbre de que iba a ser siempre hallado. Era, pues, la época de las exploraciones vigiladas y respaldadas.

Pero actualmente el marco de referencia del niño ha cambiado:

- Ha desaparecido el centro familiar y de hogar que antes unía al niño y se estiraba con él como un invisible cordón psíquico incluso cuando se alejaba en sus exploraciones y aventuras.
- Actualmente, en plena industrialización, casi siempre han de trabajar ambos padres. Los padres no pueden estar con ellos y la sociedad ha de modificar y

adaptar una nueva educación y enseñanza para esos pequeños seres. ¿Cuál? Hacer, amparándose en la pedagogía, lo más pronto posible instituciones que con la más mínima edad acojan a los niños: es decir, crear los centros preescolares, ya sean las guarderías hasta los 3 años o los jardines de infancia desde los 3 hasta los 6 años¹⁰⁴.

La situación resultante para los niños de estas últimas generaciones es que contactan muy pronto con niños de otras familias y al mismo tiempo se han difuminado o desaparecido las figuras paternas, no siendo estos centros ni su hogar ni su escuela.

¿Qué consecuencias higiénicas o patológicas tiene esta nueva situación?

Aún es pronto para verificarlas, pero extraigamos algunas consideraciones:

1. Los niños abandonan mucho antes el medio familiar, luego la figura de los padres sufre depreciación.
2. Al adaptarse el niño, haciendo la comida también con los otros y siendo cada vez menor el contacto pleno con la familia, se vincula más con sus coetáneos favoreciéndose los cimientos de los *gags* infantiles.
3. Si el centro tiene como filosofía el ser la preparación para la escuela haciendo penetrar exigencias escolares en mentes aún no preparadas, en detrimento de la espontaneidad, entonces empezará inadecuada y prematuramente la «exigencia» en estos niños. Por el contrario, si en el otro extremo, la filosofía del centro es de una práctica pseudoliberal de los niños en la autonomía e independencia, se estará preparando los cimientos de la anomia (no aprender las normas) y por lo tanto de una desviación psicopática posterior al carecer de sistema. Sólo si la institución es coordinada y apta y la dirige una experta de verdad, tendrá no sólo la ventaja de favorecer la rapidez del reconocimiento del medio y de desarrollar y reconocer los movimientos básicos y concienciar mejor al niño sobre su esquema corporal y la orientación temporo-espacial, sino sobre todo que el niño aprenda el respeto de las cosas, la estética de la relación interpersonal y el civismo con sus compañeros. Si esto último se da, entonces la precocidad escolar puede suponer una precocidad creativa estética y cívica.

11.8. ¿ES VÁLIDO TODO LO ANTERIORMENTE DICHO COMO INFLUENCIA POSITIVA (HIGIÉNICA) O NEGATIVA (PATOLÓGICA)?

Intentemos una valoración desde la física.

Lo comentado hasta ahora nos podría hacer pensar que somos algo catastrofistas. Puede ser, pero no lo somos. ¿Por qué? Porque tendríamos que suponer que el pasado ineluctablemente es causa de lo que sucede después, y que lo que sucede ahora ineludiblemente influirá decisivamente en el futuro. Pero la influencia y causa de la historia en el presente no es sino un simple supuesto, una simple especulación.

¿Cómo puede lo que ha pasado interferir y menos producir el presente?

Es necesario que hagamos una crítica básica de la posible veracidad de cuanto aquí hemos dicho.

La realidad es que cuanto hemos dicho acerca del bios y de los acontecimientos higiogénicos o patogénicos que en sus primeras épocas se dieran, lo hemos dicho tomando como sistema referencial el paradigma (el modelo) de la física newtoniana.

Me explicaré mejor:

Según la física de Newton, el tiempo es algo continuo, ilimitado y homogéneo y que se diferencia radicalmente del espacio por dos características: una, la de tener una sola dirección (esto se llama an-iso-trópico), por lo que jamás puede irse «tiempo atrás» en la actividad, sino sólo en la imaginación y en la memoria; otra segunda característica es la de ser «fluente», es decir, que pasa y transcurre uniformemente, sin relación con nada externo. Por lo tanto, las cosas suceden, pero el tiempo ni las produce ni las conserva, pues pasa por encima de nuestros haceres y nuestros sentires.

El espacio es lo que cuenta en la física de Newton, ya que por su tridimensionalidad constituye la esencia de todas las cosas en que se manifiesta. En el espacio, al ser iso-trópico (es decir, que no tiene una dirección determinada), podemos movernos hacia atrás, adelante, a los lados, etc. Podemos, pues, en el espacio volver atrás sobre lo recorrido que no ha cambiado, pero no, según Newton, en el tiempo.

Pero el bios es continuo cambio, y jamás, según esta concepción, contaría en un presente del hombre adulto lo que ocurrió «cuando fue niño», pues ahora, se encuentre donde se encuentre, es otro, sus sentimientos son otros y sus conflictos también son otros.

¿Entonces, de lo dicho, nada?

Realmente no podemos poner punto final aquí. ¿Por qué? Porque si bien tendríamos que ponerlo y afirmar que al psiquiatra de adultos no le interesa la psicología infantil, sino sólo por sus presuntas huellas, esto sólo es cierto según el paradigma o modelo newtoniano de la física clásica.

Pero la realidad actual es que la física clásica newtoniana antigua ha sido sustituida por una física nueva: la física einsteniana.

¿Servirá la física de Einstein para darnos un nuevo modelo que nos haga inteligible una conexión del presente con el pasado y que justificará nuestro trabajo psicobiográfico (estudio de la vida pasada) para curar a nuestros pacientes?

Con Einstein, la física sufrió una auténtica revolución paradigmática. Y esta revolución también se basa en una nueva concepción del tiempo. Einstein postuló que la velocidad de la luz es fija y constante en el vacío e independiente de que se mueva la fuente luminosa. Y el tiempo no es ilimitado, sino que tiene «un tope»: el de la velocidad de la luz¹⁰⁵.

Tan fija es la velocidad de la luz que si alguien intentara pasar de esa velocidad, no lo conseguiría, sino que entonces lo que ocurriría es que se invertiría la dirección del tiempo.

Por lo tanto, según el modelo einsteniano, el tiempo no va sólo en una dirección

(no es anisotrópico como con Newton), sino que puede ir «hacia delante y hacia atrás».

Además considera Einstein que el tiempo está en las cosas como una dimensión más, y por lo tanto no hay un espacio como algo distinto al tiempo, sino que está unido formando el espacio-tiempo.

Por lo tanto, el orden de los acontecimientos o sucesos no estará obligado a ir siempre del pasado al futuro, sino que es susceptible de cambios.

El bios (los acontecimientos de nuestra vida) quedará establecido en el espacio-tiempo; ubicado siempre en este espacio-tiempo no cabe decir «que existió o dejó de existir», pues va a persistir encajado en sus referencias espacio-temporales.

Según este modelo einsteniano, como el bios dejado atrás no desaparece sino que permanece enclavado es su espacio-tiempo, podría darse el caso —desde el punto de vista teórico— que al igual que echando el tren marcha atrás en el espacio newtoniano reencontrara los lugares pasados, así también según el concepto espacio-tiempo de Einstein podríamos volver atrás en el bios, a la vida ya transcurrida y terminada anteriormente. El bios dejado atrás, según este modelo, no desaparece, sino que está como enclavado en sus momentos espacio-temporales.

En base a todo esto, si consideramos lo que ha ocurrido en la vida del paciente desde el nacimiento hasta el momento de la entrevista con el médico, vamos a poder distinguir una serie de modos de articulación de los sucesos:

a) Un modo está constituido por los sucesos que hemos denominado «canalizados». Son los aparecidos muy tempranamente, y como si fueran a modo de barreras perforantes llegan hasta el mismo presente de la entrevista atravesando sin modificación todas las estructuras anteriores. Un ejemplo son los acontecimientos psicoambientales que han ocurrido y permanecido indelebles hasta el momento.

Pongamos un ejemplo: Antonio es un adulto de 56 años. Motivo de la consulta: tiene fobia a cohetes, petardos y «mascletás». Acontecimientos más tempranos: a los 5-6 años, durante la guerra civil española, bombardearon varias veces su ciudad costera. Los estampidos le horrorizaron, y una bomba le dejó entre escombros. Desde entonces, ininterrumpidamente, tiene miedo a las tormentas, a los explosivos de las ferias y a los petardos. Al ser trasladado a Valencia encuentra con dificultad piso amplio (tiene 5 hijos) hasta que por fin halla uno. Pero este piso está junto a un hogar fallero cuyos socios imprevistamente hacen estallar tracas y castillos de fuegos artificiales. Desde entonces aparecen graves crisis de ansiedad temiendo obsesivamente las explosiones. Se ha mudado a vivir a una urbanización, pero tener que venir diariamente a la ciudad a trabajar en la oficina se le hace ya imposible por la angustia.

b) Otro modo de articulación de sucesos proponemos llamarle *articulación por sucesos «asentados»*. Son acontecimientos ocurridos en circunstancias psicoambientales distintas, pero que teniendo un tema común se han apoyado unos sobre otros a lo largo del bios hasta el momento de la consulta, apilándose hasta la actualidad. Constituyen las llamadas «biografías muy cargadas».

Como ejemplo, proponemos un caso. Vicenta, que tiene en el momento de la consulta 43 años, había pasado una niñez horrible. El padre, que era alcohólico y celotípico (son celos patológicos), no sólo no atendía a la familia, sino que además golpeaba frecuentemente a la madre. Ante esta espantosa situación, ella y su hermano se unieron mucho. En su adolescencia muere el padre pero la madre se casa con un hombre que ya tenía un hijo y entonces ella y su hermano quedaron marginados. En el tiempo de la juventud el hermano se fue de casa al encontrar una beca de estudio. Vicenta se casa, no enamorada, para probar suerte con otro hogar. Tras tener un hijo, que muere al nacer, ella se hace tan celosa y tanto increpa al marido que sus relaciones se hacen muy violentas. Cuando ella tiene 36 años el marido fallece en accidente de tráfico. Queda sola, no quiere volver a la casa materna y como el hermano estaba colocado en una embajada americana le invita a que marche con él. Entonces empieza para Vicenta la única buena época de su vida en la que con su hermano viaja a muchas ciudades de Estados Unidos y Sudamérica. Mas sólo unos años. El hermano es diagnosticado de un tumor cerebral y muere teniendo ella que regresar. Se siente sola, como con una vida de mala estrella. Hace un intento de suicidio del que se salva de milagro, y es traída a la entrevista psiquiátrica por unas amigas, diagnosticándosele una depresión existencial de Häfner.

Vemos cómo se han apilado adversidades sobre adversidades, todas alrededor de las figuras masculinas de su vida.

c) El tercer modo está constituido por lo que proponemos llamarles *sucesos conmocionantes*. Suceden próximos al horizonte en que se da la entrevista, y en este plano se descubren ser muy perturbadores.

d) Por último, al cuarto modo proponemos llamarle *sucesos enquistados*. Representan todos aquellos sucesos que si bien ocurrieron en un espacio-tiempo pasado fueron elaborados y, aunque pudieron ser muy trepidantes en el curso de varias etapas del bios, ya no son en el momento de la entrevista más que cicatrices del bios absolutamente inoperantes en el espacio-tiempo de este presente, a no ser porque una doctrinología del psiquiatra suponga que «inconscientemente» operan.

Así pues, utilizando el paradigma (modelo) einsteniano sobre el concepto del bios podemos concluir:

1. Que de todos los sucesos y acontecimientos biográficos pasados, sólo unos pocos de ellos son eficientes, tanto higiénicamente como patológicamente en el presente. Luego ya no basta con detectarlos en una minuciosa biografía, sino que hay que demostrar la fuerza eficaz de esas vivencias en esa persona en concreto.
2. Que sí es posible que lleguen influencias al presente del lejano pasado, puesto que en el marco einsteniano con «el paso del tiempo» no desaparecen las causas ni motivos, sino que permanece en una entidad en el universo físico todo el trozo de bios desde el nacimiento hasta el momento de nuestra exploración en la entrevista psiquiátrica. Forma el paciente *cuerpo con su pasado*: sólo vemos en la entrevista una sección transversal del paciente, pero

en esa sección transversal late y permanece el auténtico fondo de su ser.

Para terminar, permítansenos estas consideraciones:

No soy catastrofista al contemplar la gran patogenia que los acontecimientos preescolares pueden cimentar, ya que aunque sólo podemos indagar y conocer lo que ya se ha manifestado, no obstante no podemos en modo alguno adivinar el «futuro revelado». Cuando vemos las biografías de personas ya fallecidas las contemplamos como largas carreteras que si bien tienen rectas que parecen dirigirse definitivamente al norte, también tienen recodos que tuercen al este o al oeste pareciendo que eran asimismo direcciones concluyentes, para luego, otra vez, cambiar de dirección imprevisiblemente; así continuamente hasta la muerte.

Hay dos grandes misterios, a mi entender, de hechos que si bien percibimos y vivenciamos no obstante se nos esconde su cómo y su porqué. El primer misterio es por qué tenemos conciencia. Nuestro cerebro, que funciona como un supercomputador, puede hacer todas nuestras conductas y reconocimientos sin que «nos enteremos», pues lo que sirven son los procesamientos cibernéticos; «la conciencia», el «darse cuenta» es un lujo.

El segundo misterio es el porqué existe la transcendencia, es decir, la vivencia de que pasa el tiempo, que transcurre.

Y es que estos dos grandes misterios, el de la conciencia y el del tiempo cronológico, posiblemente son los que encierran, tras impenetrables velos, las tremendas incógnitas del ser humano: la de tener conciencia, la de vivir cómo pasa el tiempo, la de tener que morir... y no saber el porqué de todo ello.

11.9. EPÍLOGO

Por el profesor Omar Lazarte¹⁰⁶

La psicobiografía del catedrático profesor doctor Miguel Rojo Sierra

Dentro del gran campo de la medicina biográfica desarrollado desde el comienzo del siglo XX el distinguido catedrático señala la importancia de los primeros años de vida en la formación normal o patológica del ser humano. Esto vale, tanto para el aspecto formativo que educa para la salud (en especial la salud mental) como para evitar el desarrollo de aspectos patológicos (medicina preventiva). En mi opinión, desde el ángulo médico hemos estudiado sobre todo los aspectos patológicos exigidos por nuestro quehacer profesional específico, aunque ahora va apareciendo una «psicología positiva» que en parte puede complementar la visión patológica y que es fundamental que tengamos en cuenta, sobre todo los que tenemos una función también de psicólogos y educadores.

El trabajo de mi gran amigo Miguel sirve tanto para unos como para otros, y es el resultado, tanto de su profundo conocimiento científico-antropológico como de su

experiencia profesional y de sus propias reflexiones teóricas que abren nuevas perspectivas para la investigación científica.

Desde el punto de vista de la promoción de la salud mental, la psicobiografía ofrece una visión global de la problemática a considerar en el campo preventivo y también ofrece un marco teórico de síntesis que incluso podríamos ampliar con el término psicosociobiografía, englobando así el campo de la microsociología de cada etapa evolutiva.

Desde el punto de vista de la logoterapia se agrega sistemáticamente el estudio de los valores y sus predominios en cada etapa de la vida. Esto puede ser completado con los aportes que realiza Erik Erikson en su libro *Infancia y sociedad*. Respecto al aporte que hace Miguel acerca de la edad preescolar entiendo que es la gran etapa psicoevolutiva donde se fundamenta el adulto futuro. Por ello no basta ver algunos aportes parciales que han dado diversos autores en forma analítica, porque la evolución de cada individuo no depende de un solo factor, sino de complementaciones y compensaciones que hacen a la persona total, como ser-en-el-mundo. Es en esa etapa donde el niño forma parte del grupo familiar en forma dominante, por lo cual el trabajo psicopedagógico debe realizarse sobre el conjunto. Interviene allí mucho la imitación espontánea, y como bien se señala en la psicobiografía, el niño participa y absorbe naturalmente los valores y las conductas de su ambiente en su proceso de socialización. Hay que destacar aquí el aporte que hizo Alfred Adler al destacar la educación del niño en el «sentimiento de comunidad» armonizando con el afán de superación como individuo. Para ello hay que lograr ámbitos educativos sanos, sea la familia, el jardín de infantes, etc. Señalo como muy importante lo que aporta este trabajo en lo que se refiere al primer año de vida y las posibles distorsiones de esa delicada «urdimbre afectiva» entre madre e hijo señalada por Rof Carballo. Pueden producirse reacciones primarias de abandono difíciles de detectar si no hay un adecuado asesoramiento a la madre. En esto los obstetras y los pediatras tendrían que estar preparados para hacerlo. No olvidemos que la medicina, por encima de las distintas formas en que se aplica en las diversas especialidades, tiene que ser vista desde un punto de vista psico-somático-social y también histórico, como insiste Miguel. E incluso llegar a su perspectiva temporo-espacial que nos lleva al tiempo trascendente.

Se trata de un libro para estudiar y trabajar en equipo multidisciplinario con una finalidad de aplicación práctica en el ámbito de cada disciplina.

NOTAS

⁹⁹ La palabra higiénico deriva del griego *hygiés* = sano, y *génesis* del latín = origen, es decir, que origina o produce salud. La higiene mental tiene su origen en Beers (1908), que fue un ex psicótico que tras haber sufrido varias permanencias en hospitales psiquiátricos escribió un libro en el que describía la situación deplorable en que se encontraba la asistencia intrahospitalaria, y por esto lo primero sobre lo que se ocupó la higiene mental fue en mejorar esta asistencia. En 1920 se crearon las ligas psiquiátricas en Francia y Canadá; en 1922, en Inglaterra; 1924, Italia y Dinamarca, y en 1926, en Suiza y España, y así sucesivamente en los diferentes países. Pero lo importante es que a partir de la Segunda Guerra Mundial cambian los fines de la higiene mental, pasando a segundo plano la importancia de la asistencia hospitalaria, y toma importancia decisiva la prevención de las enfermedades mentales.

[100](#) La palabra enfermo descende del latín *infirmus*, que significa débil, que no es firme (firme = *firmus*).

[101](#). La palabra «madre» no está especificando si es biológica, adoptiva, etc.

[102](#) Las feromonas son sustancias químicas secretadas por un individuo con el fin de provocar un comportamiento determinado en otro individuo de la misma u otra especie. Son, por tanto, señales cuyas principales ventajas son el gran alcance y la evitación de obstáculos, puesto que son arrastradas por el aire. Proviene de las palabras griegas *phera* y *hormōn*, que significan «portadora de excitación». Algunas mariposas, como la *Saturnia pyri*, son capaces de detectar el olor de la hembra a 20 km de distancia. Muchas especies de plantas y animales han utilizado diferentes aromas o mensajes químicos como medio de comunicación y casi todas utilizan uno o varios códigos por este medio, tanto para atraerse sexualmente como para otros fines. Estas sustancias tienen además la particularidad de inducir cambios en el comportamiento de los individuos que tienen contacto con ellas. Se conocen dos vías olfativas separadas: olores normales y feromonas. La vía de olores normales proyecta en el sistema nervioso, sistema límbico y amígdala. La vía de las feromonas proyecta en el órgano vomeronasal, bulbo olfatorio secundario, amígdala e hipotálamo. Uno de los casos más estudiados y explicados es el de sincronización del ciclo menstrual de mujeres que conviven en un mismo ambiente. En el antiguo Egipto se ha reconocido el uso de feromonas para la fabricación de perfumes. Éste era fabricado a base del sudor de hombres seleccionados para este trabajo y depositado en tinajas para luego ser mezclado con fragancias. Al parecer, los egipcios habían descubierto que el sudor contenía sustancias afrodisíacas para el ser humano, sobre todo el sudor de personas vigorosas y sanas físicamente (<http://es.wikipedia.org/wiki/feromona>).

[103](#) Aunque Rojo Sierra ya había hablado de esto anteriormente, luego en el año 2000 publicó, junto con la profesora M. L. García-Merita, un libro titulado *Psicología y psicopatología de la captación del tiempo y del espacio*. Editorial Promolibro.

[104](#) El nombre jardín de infancia *kindergarten* se debe al pedagogo alemán Froebel, que llamó así a estas instituciones preescolares porque asemejó estos niños, aún tan pequeños, con plantas de viveros que necesitaban un cuidado muy especial. Por eso era obligatorio tener jardín en estas instituciones.

[105](#) La velocidad exacta de la luz en el vacío es 299.792.458 metros por segundo (m/s), aunque se suele redondear a 300.000 kilómetros por segundo (km/s).

[106](#) Omar Lazarte, profesor de la Universidad de Cuyo (Mendoza), Argentina, es médico y profesor de Psicología Médica, ha sido secretario científico y presidente de la Sociedad Argentina de Salud Mental y es presidente honorario de la Sociedad Argentina de Logoterapia.

12. ¿DESAPARECERÁ LA ENFERMEDAD ANSIOSA Y EL ESTRÉS? LA PSIQUIATRÍA IRREDENTA. ANTROPOLOGÍA BIOGENÉTICA

«Puede decirse que el verdadero problema de la vida mental no es por qué enferman algunas personas, sino más bien por qué no enloquece la mayor parte.»

E. FROMM

BREVE INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ESTE CAPÍTULO

Obligatoriamente he de justificar este capítulo. El espíritu que me ha movido a escribir este libro está basado, como el propio título lo indica, en hacerlo «en lenguaje para todos», y es cierto que este capítulo final puede ser algo más complicado para muchas personas que no estén adentradas en el pensamiento existencial o antropológico. Pero al intentar explicar mi idea de «cómo puede desaparecer en la humanidad la enfermedad ansiosa» no puedo concebirla sin un proceso de evolución humana, y este proceso no creo que venga únicamente por un aumento del intelecto. ¿Cuántos nuevos genios tenemos cada año en el mundo? Seguramente cientos que puede que sean capaces de multiplicar y dividir a los 4 años de edad y acabar una licenciatura superior a los 13 años (como un caso del que tengo referencia), pero ¿cuántos de estos talentos han sido, últimamente, catalizadores de una nueva revolución humanista? Por desgracia, yo no conozco personalmente ninguno, y posiblemente el lector tampoco conozca alguno (aunque es posible que exista). Por esto, pienso que la evolución humana ha de avanzar apoyada en nuevas cualidades, también humanas, pero no sólo del intelecto, sino de superación de opuestos. Y explicar esto es lo que me ha sido difícil hacerlo con un lenguaje siempre accesible, aunque espero y deseo que sí que sea, al menos, comprensible. A todo aquel que entienda fácilmente este capítulo agradecerle, por adelantado, haberlo leído, y para el que lo intente y desespere o no lo entienda, también mi mayor agradecimiento, porque creo que siempre la evolución fraguará gracias al esfuerzo humano, y seguro que el problema no ha estado en su entendimiento, sino en mi capacidad de poder expresar lo que deseo con más claridad.

* * *

Vivimos en un mundo cada vez más tecnificado y del que esperamos que la ciencia y los avances de la civilización nos solucionen nuestros problemas y nos den la felicidad. Como indica Mario Berta, cada vez se puede constatar un avance más y

más profundo en disciplinas como la psicología, sociología y, podemos añadir, la biología; pero por otro lado, a pesar del aumento del poder humano sobre la naturaleza y sobre sí mismo, siguen las guerras de exterminio, la pobreza y el desamparo, la existencia de la esclavitud y del abuso sobre otros seres humanos, la pornografía infantil, la falta de trabajo para ganarse la vida, la falta de ideales religiosos, la discriminación racial y la falta de una auténtica integración científica, política y social, etc.

La ansiedad y el estrés no es sólo un problema de la vida acelerada, es, en gran parte, un problema de falta de síntesis de opuestos. Me explicaré mejor.

El hombre actual no ha asimilado una concepción del mundo centrada en buscar un equilibrio entre el polo externo, materializado, científico y cosificado (por una parte), y el polo interno vivencial ético-práctico basado en valores humanos (por otra parte). Dicho con otras palabras, el hombre actual¹⁰⁷ realmente está invadido, arrastrado por el mundo exterior, trabajo, deseos de relevancia, mejoras adquisitivas, posición social, etc., pero aunque «sabe» o, como diría T. de Chardin, «ve» que realmente lo más importante es su vida interior, no obstante ésta se despliega siempre sumisa al ritmo de las exigencias externas.

Cuando en la época presente nos preguntamos sobre el sentido de la persona individual y del género humano, señala W. Dilthey, precisamente hoy, envueltos en un rápido progreso de las ciencias, nos encontramos perplejos, pues: 1) las ciencias han disuelto las creencias religiosas y filosóficas de los siglos anteriores; 2) el conocimiento del espacio, el tiempo, la causalidad e incluso la realidad misma ha sido sometida a duda; 3) la comparación histórica muestra la relatividad de todas las convicciones históricas. Hay una inseguridad acerca de los valores y fines de la vida; la zozobra y la impresión de vacío dominan al hombre en medio de la multitud de conocimientos.

¿Y qué ocurre con la ansiedad?

Pues ocurre que los avances técnicos nos hablan de receptores celulares del sistema GABA, de los neurotransmisores, de estadísticas que nos indican qué personas tienen más frecuentemente un estrés postraumático o trastornos fóbicos y, asimismo, constantemente, hay sofisticados estudios genéticos que nos orientan hacia posibilidades de herencia de una enfermedad ansiosa, pero que siempre están en relación con las circunstancias ambientales, ¿mas dónde está el proceso evolutivo del ser humano para superar con una concepción más elevada del mundo, de la vida y de su existencia, la ansiedad cotidiana, el estrés o el impacto de un trauma?

Dice Ortega y Gasset que la fe en la ciencia no es ya una opinión individual, sino una opinión colectiva, y por lo tanto, una realidad independiente de los individuos es un «dogma social».

La ciencia, los estudios de TAC, resonancia magnética, los estudios sobre las neuronas y sobre las partes más íntimas de éstas, tienen actualmente, como diría Ortega, vigencia histórica. Es decir, actúan como disciplinas objetivas, como un cauce supraindividual que sincera o ficticiamente todo el mundo lo acata y procura ajustarse a él. Todo el mundo cree en la ciencia y en que ésta nos resolverá el futuro

humano.

¿Pero no estaremos mirando con microscopio las células de los árboles de un bosque habiendo perdido la visión global del bosque? Al final de todo qué estamos estudiando del paciente ansioso, ¿sus receptores benzodiacepínicos, serotoninérgicos y la acción de los neurotransmisores —lo cual está muy bien— y también al hombre enfermo y su historia personal?, o sólo los receptores y la biología para así poder darle y justificar una medicación.

Pero ahora volvamos a lo que decíamos al principio de este capítulo.

Este polo material, externo proporcionador de nuestra seguridad y felicidad, que es la ciencia, las cosas... ya lo tenemos asimilado, y quizá tan asimilado que hasta demasiado identificado con la totalidad de nuestra cosmovisión. Como señala K. Jaspers, la mayoría de los hombres están frente al mundo técnico sin comprenderlo. Es para ellos una segunda naturaleza, pero un mundo que no dominan, sino al que están sometidos. Este mundo se convierte en un lastre y finalmente adquiere para los hombres una vida propia: la máquina vive, todo este mundo es un poder, una fuerza. O como bien señala J. Rubio, el mito del progreso en su versión actual exalta unilateralmente el intelecto y el progreso técnico. Progreso se identifica con avance técnico-económico. Lo humano personal se sacrifica a lo técnico-exterior, habiendo un distanciamiento real del hombre respecto a sí mismo. En lugar de realizar el ser humano una actividad prospectiva del futuro centrada en su evolución personal, éste es sustituido por una fe en un progreso exterior de manera que sus temores, deseos, esperanzas y frustraciones son proyectadas y satisfechas en un ilusorio paraíso futuro.

¿Pero y el otro polo?

El polo de los valores aún no ha sido asimilado como vigencia histórica individual. Por supuesto que sabemos que socialmente es incorrecto reírnos de los discapacitados o decir palabras malsonantes, gritar, insultar, etc.; todo esto está aprendido en las sociedades mínimamente desarrolladas; aprendido sí, pero no incorporado, no está asimilado por los individuos, con vigencia histórica actuante interiorizada; no es un dogma ético individual perenne.

Por esto, la oposición de estos dos opuestos (sentido de la vida desde la ciencia y lo exterior o sentido de la vida desde la ética y valores) no es, para el hombre de la sociedad actual, una oposición real sino ficticia, y su síntesis sólo una idealización social.

El postulado básico del humanismo evolucionista estará sustentado por una nueva incorporación de valores que sea operante y por lo tanto práctica en la configuración del sentido del mundo. Utilizando conceptos de Julián Huxley, podríamos decir que necesitamos nuevos «integradores noéticos», es decir, nuevos creadores de estructuras simbólicas o conceptuales prácticas y operativas que interpreten grandes sistemas de la realidad.

Mientras esto no ocurra, no es de extrañar, entonces, que existan muchos más pacientes ansiosos y enfermos psíquicos, en general, de los que vemos los psiquiatras, los médicos y en conjunto los profesionales de la salud, pues ese modo existencial descompensado tiene muchas repercusiones psíquicas. Quizá por esto hablaba J. J.

López Ibor Sr. de una «psiquiatría irredenta», refiriéndose a un número amplio de personas que serían consideradas por un especialista como enfermas, pero que no acuden a él, sino a otros profesionales o a otras personas, o simplemente viven o mueren con su enfermedad¹⁰⁸.

Y si el ser humano evolucionase en esta asimilación de opuestos, ¿se encontraría en un nuevo estado de conciencia o con una nueva concepción del mundo, en definitiva, en un estado de frónesis que le libraría de la ansiedad y el estrés?

Heráclito fue el primero en utilizar el concepto de frónesis. En el estado de frónesis, el hombre, saliendo de la tumultuosa diversidad de la vida, se unifica en la tranquila forma de existir y alcanza la «paz» en la que es posible el sí mismo y la vida a partir de un yo estable. Este modo de ser, cuya posibilidad está en toda existencia, como señala Binswanger, sólo por pocos es buscado y elegido; la mayoría lo descuida y sigue con el modo de ser disperso ante su vida cotidiana.

Pero para llegar a este estado de frónesis, creo que es necesario un paso más. Este paso consiste en que la persona que asimila los opuestos, tras conseguir esto, vivencie un nuevo estado de conciencia de «unidad de los opuestos».

Es muy interesante y nos ayudara a entender esto que acabo de decir, siguiendo a Mónica Cavallé cuando se refiere a Heráclito, que fue el primero en la historia de la humanidad que dijo «me he buscado a mi mismo».

Dice esta autora que Heráclito recriminaba con ironía la confianza que muchos de sus coetáneos, «nuevos ricos» del pensamiento, tenían en el gusto desorbitado por la especulación y la confianza ciega en la razón individual. Heráclito se aferraba a la filosofía imperecedera o perenne y advirtió que todo es dual y que todo obedece a una dinámica rítmica o bipolar. Así, todo lo que asciende, tarde o temprano desciende o decae; todo lo que nace, muere; no hay luz sin oscuridad y sabemos de la oscuridad porque sabemos de la luz; la vigilia se alterna con el sueño y el sueño con la vigilia; sólo podemos concebir el bien por referencia al mal, y viceversa, etc. Heráclito sabía que nada escapaba a esa dinámica de alternancia dual. Ahora bien, y esto es importante de remarcar, sabía que entre esos polos o términos duales (bien-mal, luz-oscuridad, ascenso-descenso, mundo material-mundo de los valores, etc.), entre esos aparentes contrarios, *latía una unidad secreta*. Adivinaba esa unidad secreta, entre otras cosas, en el hecho de que dichos polos sólo pueden comprenderse en su referencia mutua, de tal modo que es imposible separarlos. La observación de la realidad le desvelaba que todo tiene su par de opuestos; pero le desvelaba también que los opuestos, lejos de ser contrarios mutuamente excluyentes, son interdependientes, y que por lo tanto hay *una unidad secreta que los enlaza*.

«Es siempre uno y lo mismo, lo vivo y lo muerto, despierto y dormido, joven y viejo» (Heráclito, fragmento 88).

En otras palabras, sigue Cavallé, todo se manifiesta de modo dual y a su vez en su más profunda intimidad, todo es uno. La sabiduría nos enseña que es posible percibir a la vez la dualidad y la unidad. Ahora bien, con nuestra mente occidental moderna nos cuesta conocer esa *unidad latente* y admitir que todo tiene dentro de sí el germen de su opuesto. Estamos convencidos de que lo que es A, es A, y no puede ser B. ¿Por

qué? Porque hemos hecho de nuestra razón, del pensamiento lógico y conceptual, el eje y la medida de la realidad. En otras palabras, porque hemos olvidado a Heráclito y hemos entronizado a Aristóteles, que reduce la «realidad» a la lógica, al *logos* aristotélico¹⁰⁹.

Esta explicación de Cavallé nos ayuda mucho a culminar lo que hemos dicho hasta aquí.

1. Es fundamental que se asimilen los opuestos: por una parte, el mundo físico, material, científico, y por otra, el ético o axiológico, el de los valores humanos¹¹⁰; pero los dos con igualdad de «valor» o categoría, no siendo mejor ni superior uno u otro.
2. Es necesario que evolucione el ser humano a una nueva concepción del mundo o nivel de conciencia, en la que ya emerja como una «unidad» la síntesis de los opuestos. Esta unidad ordenadora del mundo nos prepara para un nuevo saber, un saber para el que Heráclito utiliza la palabra *cosmos*, y por esto a este estado de la evolución humana M. Rojo Sierra lo denomina «hombre cósmico».

¿Entonces ya desaparecerá el riesgo de padecer ansiedad?

Pienso que entonces disminuirá mucho el riesgo de padecer ansiedad y estrés — puede que desapareciera—, pero no sólo porque el hombre realizase esa evolución de conciencia hacia la unidad «de los opuestos», sino porque entonces emergerán nuevos valores humanos, una nueva concepción del mundo que, ahora *como unidad* (en la que los opuestos no han desaparecido), podrá entrar en la dinámica o dialéctica con otros seres humanos que han llegado al mismo estadio, al mismo nivel evolutivo humano; y, ¡ahora sí!, creo que ése será el germen de otro nuevo nivel de conciencia, un nuevo saber concomitante (esto significa conciencia) que hará desaparecer la enfermedad ansiosa¹¹¹.

Y por esto, una psiquiatría desarrollada¹¹² ha de ser aquella que considere a la enfermedad como una alteración que afecta a todas las potencialidades humanas; la enfermedad bloquea el desarrollo de la fuerza relacional, accional y espiritual, así como la capacidad de unificar opuestos, y el psiquiatra no sólo ha de buscar la desaparición del síntoma, sino que además ha de comprobar que esa recuperación sintomática vaya aparejada con una recuperación de las fuerzas evolutivas humanas que le permita a la persona nuevas realizaciones y nuevas posibilidades.

La repercusión que la enfermedad psíquica tiene en el paciente, como individuo histórico, nos permite entender la psiquiatría como impulsadora de una antropología biogenética, puesto que la evolución del hombre ha de seguir la línea de la codificación genética, y por lo tanto biológica, de los valores¹¹³. La esencia del ser unitivo (con conciencia unitiva de ambos polos) que entra en dialéctica con otras personas que han alcanzado el mismo nivel, ha de ser biológica y genética para que los valores queden codificados en nuestra prospección evolutiva.

La ansiedad y el estrés son, en gran parte, una expresión del desequilibrio humano psicosocial que se nos manifiesta desde múltiples ámbitos: disfunciones familiares,

valores educativos, emigraciones... y sólo mediante una unificación de opuestos, y un salto gen-ético, es posible superar (abarcándolo) el sentido psicosocial mediante la emergencia de un sentido cósmico. El hombre unitivo, que es también bipolar, no está estancado en la dinámica de sus polos, pues, en constante dialéctica con otras personas de igual nivel evolutivo, va constantemente haciendo prospección de nuevos modos de conciencia¹¹⁴.

Miguel Rojo Sierra, en su libro titulado *El hombre cósmico*, señala cómo ya Oupensky habló de un grado de nivel humano que llamó «hombre IV» y cómo los físicos David Bohm y David Peat afirman que la evolución progresiva cósmica ahora recae en el ser humano, y por tanto ya es hora de que se mire a sí mismo y prosiga en su ser la evolución del cosmos al cual pertenece. Quien empieza a transhumanizarse empieza también a captarse a-sí-en-el-cosmos, señala M. Rojo. El hombre cósmico futuro vivenciará aspectos sorprendentemente positivos cuando consiga dinamizar y dirigir su autoconciencia de manera plena: podrá actuar mentalmente sobre el cuerpo; primero en la bioquímica cerebral, por lo que no padecerá enfermedades psíquicas; después sobre el resto del cuerpo, en sus sistemas de inmunidad y en la corrección de las divisiones celulares anormales (displasia, discariosis), por lo que no tendrá enfermedades corporales. Cuando el ser humano llegue a adquirir este nuevo estado de ultraconciencia, sobrevendrá una mutación que transformará a este hombre actual que está todavía haciéndose, no en un superhombre como creyó Nietzsche, sino en un hombre «del todo hecho» que por su «conciencia nueva» formará un «cosmos nuevo».

¿Puede que todo esto sea una utopía?

Es posible, pero, como decía Ortega, «un utopista, a menos que sea un ingenuo hasta la saciedad, siempre es un realista inexorable», e igualmente lo afirmaba Teilhard de Chardin: en el fondo son los utopistas (no los «realistas») los que científicamente tienen razón; ellos al menos, aun cuando sus anticipaciones nos hagan sonreír, tienen sentido de las dimensiones auténticas del fenómeno humano.

NOTAS

¹⁰⁷ Cuando escribo «hombre» me refiero al *ánthrôpos* (griego), al *homo* (latín), término que significa «humano» y que por lo tanto abarca a los dos sexos, tanto masculino como femenino. Como señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, bajo esta acepción se comprende a todo el género humano

¹⁰⁸ Citado por J. J. López Ibor Aliño en *La psiquiatría de hoy*.

¹⁰⁹ Aunque Heráclito fue el primero que introdujo las expresiones *logos* y *philósphos*, su concepto de *logos* no tiene nada que ver con el aristotélico, que es el más comúnmente conocido y relacionado con el pensar lógico para el conocimiento.

¹¹⁰ Podríamos decir ética-axiológica, ya que la **ética** (del latín *ethicus* y éste del griego clásico *thikós*, «moral, relativo al carácter»), tiene como objeto de estudio la moral y la acción humana, y la **axiología** (del griego *axios*, «lo que es valioso o estimable», y *logos*, «ciencia») es la teoría del valor o de lo que se considera valioso. Puede hablarse de una «ética axiológica», que fue desarrollada, principalmente, por Max Scheler y Nicolai Hartmann. El estudio axiológico culmina con el desarrollo de un sistema de valores.

¹¹¹ Como dice Omar Lazarte (comunicación personal, 2008), se habrá entrado a un estado de presencia

participante. Será un salto cualitativo. Estamos ya hablando de sintonización de esencias similares. Esta conciencia cuántica está más allá de toda separatividad, porque surge de un estado unitivo.

[112](#) Utilizo la palabra «desarrollada» en el sentido que le dio Julian Huxley como que «favorece las facultades humanas».

[113](#) La concepción de la incorporación gen-ética es afirmada con intensidad por Ramón P. Muñoz cuando escribe, en su obra *Reversibilidad de valores*, que comprendió que los valores no eran solamente virtudes sino sustancia, una química supraevolutiva proveniente de la activación de la nueva gen-ética humana. La nueva historia comienza cuando se configura un nuevo código gen-ético. Para Ramón Muñoz, el problema reside en que entre el hombre que ha realizado la unidad bipolar y el hombre que no ha llegado a ese nivel de conciencia «hay una brecha generacional», un «hiato-gen-ético».

[114](#) Se desarrollaría así una evolución gen-ética social.

BIBLIOGRAFÍA

- Adler, A. (1963). Cit. por E. Mira y López en *Doctrinas psicoanalíticas*. Ed. Kapelusz, Bs.
- Adler, A. (1978). *El carácter neurótico*. Buenos Aires: Ed. Paidós.
- Adler, A. (1965). *La psicología individual y la escuela*. Buenos Aires: Ed. Losada.
- Alonso Fernández, F. (1979). *Fundamentos de la psiquiatría actual*, tomos I y II. Ed. Paz Montalvo, 4.^a edición.
- Alonso Fernández, F. (1989). *Psicología médica y social*. Barcelona: Salvat.
- Alsobrook, P. J. y Pauls D. L. (2001). Genética del trastorno obsesivo-compulsivo. En Jenike, Baer, Minichiello (dirs.). *Trastornos obsesivo-compulsivos*. Ed. Harcourt.
- Andrews, G. y Stewart, G. (1990). The genetics of six neurotics disorders: a twin study. *J. Affect Disord*, 19: 23-29.
- Angst, J. et al. (1982). A panel study of anxiety states, panic attacks and phobia among young adults. Research Conference on Anxiety Disorders, Panik Attacks and Phobia. Key Biscayne, Florida.
- Atshuler. L. L. y Cohen, L. S. (1996). Pharmacologic management of psychiatric illness in pregnancy: dilemmas and guidelines. *Am J. Psychiatry*, 153: 592-606.
- Ayuso Gutiérrez, J. L. (2005). Trastornos de ansiedad: crisis de angustia. *Tratado de psiquiatría*, volumen II (Vallejo y Leal, dirs.). Ars Médica.
- Baca, E., Cervera, S., Giner, J., Leal, C., Roca, M. y Vallejo, J. (2002). La neurosis en la actualidad. En *Trastornos neuróticos*, M. Roca Bennasar (coord.). Ars Médica.
- Baca, E. (2002). Trastornos por estrés postraumático. En *Trastornos neuróticos*, M. Roca Bennasar (coord.). Ars Médica.
- Ballenger, J. C. (2003). Trastorno de pánico y agorafobia. En *Tratado de psiquiatría*, tomo II (Gelder, M. G., López Ibor, J. J. y Andreasen, N., dirs.). Ed. Ars Médica.
- Ballesteros Alcalde, C. y Conde López, V. (2000). Trastornos por ansiedad social de inicio en la infancia y la adolescencia. En *Abordaje actual del trastorno por ansiedad social*, J. Bobes, M. P. González, P. A. Saiz y M. Bousoño. Masson.
- Barcia, D. (1982). Cit. Barcia, D. y Galiana, M. *Tranquilizantes menores en psiquiatría* (dirs. López Ibor, Ruiz Ogara y Barcia Salorio), tomo II. Ed. Toray.
- Barcia, D. (1982). Ritmos biológicos. En *Psiquiatría* (C. Ruiz Ogara, D. Barcia Salorio y J. J. López Ibor Aliño, dirs.), tomo I. Editorial Toray.
- Barcia, D. (1988). *Historia de la psicofarmacología*. Editor Demetrio Barcia.
- Barry, W. S. y St. Clair, S. M. (1987). Exposure to benzodiazepines in utero. *Lancet* 1: 1436-1437.
- Beidel, D. C. y Turner, S. M. (1998). *Shy children, phobic adults: nature and treatment of social phobia*. Washington: American Psychological Association, 6. Cit. Luis Jiménez Treviño y cols. Manifestaciones clínicas y diagnóstico diferencial del trastorno por ansiedad social. En *Abordaje actual del trastorno por*

- ansiedad social*, J. Bobes, M. P. González, P. A. Saiz y M. Bousoño. Masson, 2000.
- Bernardo, M. (2000). Epidemiología. En *Trastornos afectivos: ansiedad y depresión* (J. Vallejo y C. Gastó, eds.). Masson.
- Berta, M. (2007). *El dios vivo y la neurosis epistemológica de nuestro tiempo*. Colección Psicoterapia Abierta. Montevideo.
- Binswanger, L. (1966). Cit. Rojo Sierra, M. Perspectiva filosófico-existencial en la nueva psiquiatría. *Folia Neuropsiquiátrica* 1(2): 2-32.
- Binswanger, L. (1973). *Artículos y conferencias escogidas*. Editorial Gredos.
- Bobes, J., García Calvo, C., Prieto, R., García García, M., Rico Villademorros, F. y Grupo Español de Trabajo para la validación de la versión española de la Escala de Detección del Trastorno de Ansiedad Generalizada según DSM-IV. (2006). Propiedades Psicométricas de la versión española de la escala de detección del trastorno de ansiedad generalizada según DSM-IV de Carroll y Davison. *Actas Esp. psiquiatr.* 34(2): 83-93.
- Brachfeld, O. (1970). *Sentimientos de inferioridad*. Biblioteca Universal Miracle.
- Brissaud, E. (1890). Cit. M. H. Stone (2004). *Historia de los trastornos de ansiedad. Tratado de los trastornos de ansiedad*. D. J. Stein y E. Hollander (dirs.). Ars Médica.
- Brouette, T. H. y Goddard, A. W. (2004). *Patogenia del trastorno de ansiedad generalizada. Tratado de los trastornos de ansiedad*, Stein y Hollander (dirs.). Ars Médica 2004.
- Buhler, Ch. (1956). El curso de la vida humana. *Arch. neurobiología y psiquiatría*, XIV, 1, 14-21.
- Bumke, O. (1946). Nuevo tratado de enfermedades mentales. F. Seix (ed.).
- Caballero Martínez, L. (1999). Trastorno mixto ansioso-depresivo. En *Trastornos del humor*, capítulo 28. M. Roca Bennasar (coord.). Ars Médica.
- Cavallé, M. (2002). *La sabiduría recobrada. Filosofía como terapia*. Ed. Oberon. Grupo Anaya.
- Campbell, F. y Singer, G. (1983). *Estrés, drogas y salud*. Edición en español, Ed. Ariel, 1987.
- Cameron, R. B. y Schatzberg, A. F. (2002). Trastorno mixto ansioso-depresivo. En *Tratado de los trastornos de ansiedad* (D. J. Stein y E. Hollander, dirs.). Primera edición en Estados Unidos. Edición española, Ars Médica, 2004.
- Chang, S. C. (1997). Social anxiety (phobia) and East Asian culture. *Depression and anxiety*, 5: 115-120.
- Charney, D. S. (2007). Mecanismos psicobiológicos de la capacidad de adaptación y la vulnerabilidad: repercusiones para la adaptación satisfactoria al estrés extremo. Clinical Psychiatry. Self-Assessment Program. Trastornos de ansiedad. Traducción al español editado por Médica Trendt, S. L.
- Cole, J. O. y Davis, J. M. (1982). Tranquilizantes menores, sedantes e hipnóticos. En Freedman, Kaplan y Sadock. *Tratado de psiquiatría*, tomo II, Ed. Salvat.
- Conde López, V. (2005). La psiquiatría en el nuevo milenio. Lección inaugural del curso académico 2005-2006, Valladolid.
- Conrad, K. (1941). *Der Konstitutions typus als genetisches Problem*. Berlín: Ed.

Espringer.

- Derogatis, L., Lipman, R., Covi, L. y Rickels, K. (1972). Factorial invariance of symptom dimensions in anxious and depressive neurosis. *Arch Gen Psychiatry*, 27: 659-665, 1972.
- Díez, C. y Sánchez Planell, L. (2000). Etiopatogenia. En *Trastornos afectivos: ansiedad y depresión*. J. Vallejo, G. Gaasto (dirs.). Ed. Masson.
- Dilthey, W. (1988). *Teoría de las concepciones del mundo*. Alianza Editorial.
- DSM-IV-TR. *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*. Ed. Masson, 2002.
- Dubois, P. (1964). Cit. por Kolle, K. *Psiquiatría. Manual para médicos y estudiantes*. Ed. Alhambra.
- Ehlers, A. (2003). Trastorno de estrés postraumático. En *Tratado de psiquiatría*, tomo II (Gelder, M. G., López Ibor, J. J. y Andreasen, N., dirs.). Ed. Ars Médica.
- Eley, T. C. y Gregory, A. M. (2004). Behavioral Genetics. En Morris, T. L. y March, J. S. (eds.). *Anxiety disorders in children and adolescents*. 2.^a ed. New York: Guilford Press, 71-97.
- Eley, T. C. (2006). Bases genéticas de los trastornos de ansiedad. En *Las fases iniciales de las enfermedades mentales. Trastornos de ansiedad*, J. L. Vázquez-Barquero, Andrés Herrán Gómez (eds.). Masson.
- Elrod (1964). Cit. por Bräutigam, W. *La psicoterapia en su aspecto antropológico*. Madrid: Gredos.
- Epstein, S. A. y Hicks, D. (2005). Trastornos de ansiedad. En *Tratado de medicina psicosomática* (James L. Levenson), tomo I, Ars Médica.
- Eros, F. y Cziezel, A. (2002). A population-based case-control teratologic study of nitrazepam, medazepam, nofisopam, alprazolam and clonazepam treatment during pregnancy. *Eur J. Obstet gynecol Reprod Biol* 101: 147-154.
- Fontaine, R., Chouinard, G. y Annable, L. (1984). Rebound anxiety in anxious patients after abrupt withdrawal of benzodiazepine treatment. *Am. J. Psychiatry*, 141: 848-852.
- Freud, S. (1975). *Obras completas*. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.
- Fromm, E. (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. Ed. Fondo de Cultura Económica.
- Galton y Cattell (1984). Cit. M. Rojo Sierra. *Lecciones de psiquiatría*, tomo I. Edita Promolibro.
- García Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Saiz, P. A., Bousoño, M. y Bobes, J. (2006). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica*, 4.^a edición. Ars Médica.
- Gastó Ferrer, C. y Massana Montejó, G. (2005). Neurosis. Aspectos conceptuales y críticos. En *Tratado de psiquiatría*, volumen II. Julio Vallejo y Carmen Leal (coords.). Ars Médica.
- Gelenter, J., Page, G. P. y Bonvicini, K. (2003). Chromosome 14 risk locus for simple phobia: results from a genomewide linkage scan. *Mol Psychiatry*, 8: 71-82.
- Gersh, F. y Fowles, D. (1979). Neurotic depression: the concept of anxious depression. En Depue, R. (ed.). *The psychobiology of the depressive disorders*. New York Academic Press.

- Giner, J., Cervera, S. y Ortuño, F. (1998). Manifestaciones clínicas, subtipos y diagnóstico diferencial. En S. Cervera, M. Roca y J. Bobes (eds.). *Fobia social*. Masson.
- Giner Ubago, J., Baca, E., Cervera, S., Leal, C., Roca, M. y Vallejo, J. (2002). Nosología y neurosis. En *Trastornos neuróticos*, M. Roca Bennasar (coord.). Ars Médica.
- Glauser, G. (1968). *Manual de análisis biográfico*. Editorial Gredos.
- González de Rivera, J. L. y Morera, A. (1983). La valoración de sucesos vitales. Adaptación española de la escala de Holmes y Rahe. *Psiquis*, 1: 20-25.
- Goodwin, D. W., Guze, S. B. y Robins, E. (1969). Follow up studies in obsessional neurosis, *Arch Gen Psychiatry*, 20: 182-87, 1969
- Goodwin, D. W. (1990). *Ansiedad etiología y manifestaciones clínicas*. Ediciones Temis, S. A.
- Guimón, J. (2001). *Los prejuicios contra la psiquiatría*. Core Academic.
- Gregory (1984). Cit. Rojo Sierra, M. y cols. *Lecciones de Psiquiatría*, tomo I. Valencia: Ediciones Promolibro.
- Grinker, R. R. (1975). De la alienación a la adaptación. En *El cansancio de la vida*, J. Rof Carballo (dir.). Editorial Karpos.
- Groen, J. J. (1977). Trabajo, estrés y enfermedad. En *Trabajo y estrés*. Ed Karpos.
- Hettema, J. M. (2007). Genética de los trastornos de ansiedad. En *Clinical psychiatry. Trastornos de ansiedad*. Ed. Medical Trene, S. L.
- Heymans (1984). Cit. M. Rojo Sierra. *Lecciones de psiquiatría*, tomo I. Ed. Promolibro.
- Hofling, C. H. (1974). *Tratado de psiquiatría*. Ed. Interamericana.
- Hofstätter, P. (1957). *Psychologie*. Frankfurt.
- Holmes, T. y Rahe, R. (1967). The social readjustment rating scale. *Journal of Psychosomatic Research*, 11, 213-218.
- Huertas, D. (2007). *Violencia. La gran amenaza*. Alianza Editorial.
- Hurler, E. B. (1979). *Desarrollo psicológico del niño*. Madrid: Ed. McGraw-Hill.
- Huxley, J. (1959). *Nuevos odres para vino nuevo*. Editorial Hermes.
- Issakidis, C. y Andrews, G. (2002). Service utilisation for anxiety in an Australia Community Simple. *Soc Psychiatry Epidemiol*, 37: 153-63.
- Janet, P. (1909). *Les névroses*. París: Flammarion.
- Jaspers, K. (1953). *La fe filosófica*. Buenos Aires: Ed. Losada.
- Jaspers, K. (1967). *Psicología de las concepciones del mundo* (edición original, Berlín 1960). Edición española, Editorial Gredos.
- Jaspers, K. (1913). *Psicopatología general*. Traducción de la quinta edición alemana en español, Buenos Aires: Editorial Beta, 1975.
- Jaspers, K. (1958). *Filosofía* (dos tomos) (1932, 1.ª ed. alemana). Edición en español: Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, Revista de Occidente.
- Kalinowsky, L. B. (1982). *Coma insulínico. Tratado de psiquiatría* (Freedman, Kaplan y Sadock, dirs.), tomo II, Salvat.
- Kendell, R. E. (1974). The stability of psychiatric diagnosis. *Br. J. Psychiatry*, 124: 352-356, 1974.
- Kendler, K. S., Walters, E. E. y Neale, M. C. (1995). The structure of genetic and

- environmental risk factors for six major psychiatric disorders in women: phobia, generalized anxiety disorder, panic disorder, bulimia, major depression, and alcoholism. *Arch Gen Psychiatry*, 52: 374-383.
- Kendler, K. S. y Jacobson, K. C. (2002). Sex differences in genetic and environmental risk factors for irrational fears and phobias. *Psychol Med*, 32: 209-217.
- Kolle, K. (1964). *Psiquiatría. Manual para médicos y estudiantes*. Primera edición española, Editorial Alhambra.
- Kretschmer, E. (1967). *Constitución y carácter* (primera edición española, 1947). Editorial Labor.
- Kulin, N. A. y Pastuszak, A. (1998). Pregnancy outcome following maternal use of the new selective serotonin reuptake inhibitors. *Jama*, 279: 609-610, 1998.
- Künkel, F. (1972). *Del yo al nosotros*. Editorial Luis Miracle.
- Liddell y Bauvelt (1984). Cit. M. Rojo Sierra, *Lecciones de psiquiatría*, tomo I. Edita Promolibro.
- Lipman, R. S. y cols. (1965, 1971). Cit. Cole, J. O. y Davis, J. M. Tranquilizantes menores, sedantes e hipnóticos. En Freedman, Kaplan y Sadock. *Tratado de psiquiatría*, tomo II, Ed. Salvat, 1982.
- López Galán, S. (2004). *Fobias y manías*. Editorial Rey Ali.
- López Ibor, J. J. (1969). *La angustia vital*. Ed. Paz Montalvo (primera edición, 1950).
- López Ibor, J. J. (1966). *Las neurosis como enfermedades del ánimo*. Madrid: Ed. Gredos.
- López Ibor Aliño, J. J. (1975). *La psiquiatría de hoy*. Editorial Toray.
- López Ibor, J. J. (1979). *Neurosis*. Editorial Gredos.
- Luxemburger, H. Cit. Hofstätter.
- McEwen y Stellar. Cit. Charney, D. S.
- Maina, G., Albert, U. y Bogetto, F. (1999). Recent life events and obsessive-compulsive disorder (OCD): the role of pregnancy/delivery. *Psychiatry Res*, 89: 49-58.
- Manuzza, S. y Schneier, F. R. et al. (1995). Generalized social phobia. Reliability and validity. *Arch. Gen Psychiatry*, 52:230-37. Cit. Luis Jiménez Treviño y cols. (2000). Manifestaciones clínicas y diagnóstico diferencial del trastorno por ansiedad social. En J. Bobes, M. P. González, P. A. Saiz y M. Bousoño. *Abordaje actual del trastorno por ansiedad social*, Masson.
- Marañón, G. (1943). *Manual de diagnóstico etiológico*. Decimocuarta edición, Espasa Calpe, 1991.
- Marcel, G. (1955). *Los hombres contra lo humano*. Buenos Aires: Edita Librería Hachette.
- Marías, J. (1988). Introducción y comentarios en su traducción del libro *Wilhem Dilthey. Teoría de las concepciones del mundo*. Alianza Editorial.
- Mauz (1967). Cit. E. Kretschmer, *Constitución y carácter*. Ed. Labor.
- Marikangas, K. R. y Weissman, M. M. (1985). Epidemiology of anxiety disorders in adulthood. En Michels, R. y Cavenar, J. O. (eds.). *Psychiatry: Social, Epidemiologic and Legal Psychiatry*. Philadelphia: JB Lippincott.
- Martín Santos, L. y Dilthey (1955). *Jaspers y la comprensión del enfermo mental*. Ed.

- Paz Montalvo.
- Masten Ann (2007). Cit. Charney, D. S.
- Massana, J. (2005). Ansiolíticos e hipnóticos. En *Tratado de psiquiatría*, volumen II (Vallejo y Leal, dirs.). Ars Médica.
- Melick, M. E., Longue, J. N. y Fredrick, C. J. (1982). *Stress and disaster*. In *Handbook of Stress*, Edited by Melick M. New York: Free Press, 613-630.
- Menchón, J. M. y Vallejo, J. (2009). Trastorno obsesivo-compulsivo. En T. Palomo y M. A. Jiménez-Arriero (dirs.). *Manual de psiquiatría*. Ene Life Publicidad. S. A., y Editores. Edición patrocinada por GlaxoSmithKline.
- Mingote Adán, J. C. y Pérez Corral, F. (1999). *El estrés del médico. Manual de autoayuda*. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
- Mira y López, E. Prólogo al libro «Clínica psicosomática» (1945) de Lelio Zeno y Emilio Pizarro Crespo. Ed. Ateneo. Bs.
- Montgomery, S. A. (1992). *Ansiedad y depresión*. Wrightson Biomedical Publishing Ltd.
- Moreno, F. A., Wiegand, C. B. y Taitano, E. K. (2006). Safety, tolerability, and efficacy of Psilocybin in 9 patients with ObsessiveCompulsive disorder. *J. Clin Psyciatry*, 67: 1735-140.
- Muñoz Soler, R. P. (2006). *Reversibilidad de valores*. Arcana Ediciones.
- Nemiah, J. C. (1982). Neurosis fóbica. En Freedman, Kaplan y Sadock. *Tratado de psiquiatría*, tomo I. Salvat Editores.
- Neuman, E. (1996). Lo creador como fenómeno fundamental de la psicoterapia. Cit. Rojo Sierra, M. *Perspectiva filosófico-existencial en la nueva psiquiatría. Folia Neuropsiquiátrica*, volumen I (2): 1-32.
- Newport, D. J. K., Fisher, A., Grbal, S. y Stowe, Z. N. (2006). Psicofarmacología durante el embarazo y la lactancia. En Schatzberg, A. F. y Nemeroff, C. H. (dirs.). *Tratado de psicofarmacología*. Masson.
- Notestein, F. (2005). Cit. Conde López, V. La psiquiatría en el nuevo milenio. Lección inaugural del curso académico 2005-2006, Valladolid.
- Noyes, R. y Clarkson, C. (1987). A family study of generalized anxiety disorder. *Am J. Psychiatry*, 144: 1019-1024.
- Oral, V. A. (1951). Cit. Kolle, K. *Psiquiatría. Manual para médicos y estudiantes*. Primera edición española, Editorial Alhambra, 1964.
- Ortega-Monasterio, L. (1993). *Lecciones de psicología médica*. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU).
- Ortega y Gasset, J. (1981). *Historia como sistema y otros ensayos de filosofía*. Revista de Occidente, en Alianza Editorial (primera edición en 1941).
- Pasau, R. O. (1987). *Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de ansiedad*. Edifarma.
- Pérez Sales, P. (2009). Trastornos adaptativos reacciones de estrés. En T. Palomo y M. A. Jiménez-Arriero (dirs.). *Manual de psiquiatría*. Ene Life Publicidad, S. A., y Editores. Edición patrocinada por GlaxoSmithKline.
- Pinel, Ph. (1978). *Nosographie philosophique*, Paris: Bailliére (cit. Baca, 2002).
- Prusoff, B. y Klerman, G. (1974). Differentiating depressed from anxious neurotic outpatients. *Arch Gen Psychiatry*, 39: 302-309.

- Raj, A. y Sheehan, D. (2006). Benzodiacepinas. En Schatzberg, A. F. y Nemeroff, C. H. (dirs.). *Tratado de psicofarmacología*. Masson.
- Rasmussen, S. A. y Eisen, J. L. (2001). Epidemiología y rasgos clínicos del trastorno obsesivo-compulsivo. En M. A. Jenike, L. Baer, W. E. Minichiello (dirs.). *Trastornos obsesivo-compulsivos, manejo práctico*, 3.^a edición. Harcour (edición español).
- Rauch, S. L., Corá-Locatelli, G. y Greenberg, B. D. (2004). Patogenia del trastorno obsesivo-compulsivo. En D. J. Stein y E. Hollander (dirs.). *Tratado de los trastornos de ansiedad*. Ars Médica.
- Rey Ardid, R. (1974). *Psicología médica*. Espaxs.
- Ridruejo Alonso, P., Medina León, A. y Rubio Sánchez, J. L. (1996). *Psicología médica*. McGraw-Hill-Interamericana.
- Robbins, L. (1935). *An essay on the nature and significance of economic science*. Segunda edición, London: Macmillan.
- Rof Carballo, J. (1961). *Urdimbre afectiva y enfermedad: introducción a una psiquiatría dialógica*. Barcelona: Ed. Labor.
- Rof Carballo, J. (1976). *El cansancio de la vida*. Ed. Karpos.
- Rof Carballo, J. (1977). El trabajo y nuestra responsabilidad. En *Trabajo y estrés*. Ed. Karpos.
- Rojo Moreno, J. (2008). *La enfermedad depresiva. Conocer y entender la depresión en lenguaje para todos*. Ed. Albatros.
- Rojo Sierra, M. (1954). Tratamiento de la neurosis obsesiva por los derivados del tropano. Consecuencias psicológicas. *Rev. Psiquiatría y Psicología Médica de Europa y America Latinas*, año II, tomo I, número 5: 365-373.
- Rojo Sierra, M. (1958). Influencia del cine y las lecturas en las menores. *Actualidad Médica*, septiembre, 642-659.
- Rojo Sierra, M. (1959). Terapéutica lisérgica en ciertos síndromes obsesivos y neurosis sexuales. *Actas Luso-Españolas de Neurología y Psiquiatría*, volumen XVIII, 2: 108-113.
- Rojo Sierra, M. (1961). El dilema «educación o instrucción» en la higiene mental del niño. *Archivos de Neurobiología* XXIV (3): 276-287.
- Rojo Sierra, M. (1961). El dolor en su utilización terapéutica. *Psiquiatría y Psicol. Med. de Eur. y América Latina*, 5 (2): 162-165.
- Rojo Sierra, M. (1961). Lo psicógeno. *Actas Luso-Esp. Neurol. Psiquiatr.* 20(4): 1-71, y volumen 21 (1), 1962.
- Rojo Sierra, M. (1962). Psicopatología de la sociedad. Granada. *Actualidad Médica*, julio-agosto.
- Rojo Sierra, M. (1965). Aspectos somatógenos de las llamadas neurosis obsesivas. *Archivo de Neurobiología*, tomo 28, 1: 27-41.
- Rojo Sierra, M. (1975). La psiquiatría ante la crisis actual. *Folia clínica internacional*, tomo XXV (11), 3-16.
- Rojo Sierra, M. (1978). *Fundamentos doctrinales para una psicología Médica*. Barcelona: Ediciones Toray.
- Rojo Sierra, M. (1983). La vida de hoy y los trastornos psíquicos. *Actas Luso-Esp. Neurol. Psiquiatr.*, 11, 6: 333-441.

- Rojo Sierra, M. (1984). *Lecciones de psiquiatría*, tomos I, II, III y IV. Valencia: Ediciones Promolibro.
- Rojo Sierra, M. (1988). *La psicobiografía: valor higiénico o patológico. Valoración de acontecimientos preescolares*. Ed. Nau Llibres.
- Rojo Sierra, M. (1999). *El hombre cósmico. Aportación al transhumanismo de Julian Huxley*. Ed. Promolibro.
- Rojo Sierra, M. y García-Merita, M. L. (2000). *Psicología y psicopatología de la captación del tiempo y del espacio*. Valencia: Ed. Promolibro.
- Rollo May (1990). Cit. Goodwin, D. W. *Ansiedad. Etiología y manifestaciones clínicas* (prólogo). Barcelona: Ed. Temis, S. A.
- Ross, J. (1993). Social phobia: the consumer's perspective. *J. Clin. Psychiatry*, 54: 12 (supl.).
- Roth, (1982). Cit. Vallejo Ruiloba, J. y Bataller, R. (2000). Relación entre los estados de ansiedad y los trastornos depresivos. En *Trastornos afectivos: ansiedad y depresión* (Ruiloba, J. y Gastó, C., coords.), capítulo 38. Masson.
- Rubio Cariacedo, J. (1973). *Antropología prospectiva*. Studium ediciones.
- Saiz Ruiz, J., Braquehais Conesa, D. e Ibáñez Cuadrado, A. (2005). *Trastorno de ansiedad generalizada. Tratado de psiquiatría*, volumen II (Vallejo y Leal, dirs.). Ars Médica.
- Schlatter, J. y Cervera, S. (2005). *Trastornos fóbicos. Tratado de psiquiatría*, volumen II (Vallejo y Leal, dirs.). Ars Médica.
- Sarró, R. (1984). Cit. Rojo Sierra, M. *Lecciones de psiquiatría*, tomo III. Valencia: Ediciones Promolibro.
- Schatzberg, A. F. y Nemeroff, C. H. (2006). *Tratado de psicofarmacología*. Masson.
- Schneider, K. Cit. López Ibor, J. J. (197). *Neurosis*. Ed. Gredos.
- Schwarz, O. (1932). *Psicogénesis y psicoterapia de los síntomas corporales*. Editorial Labor, S. A.
- Seva Díaz, A. (1964). Investigaciones en torno al fenómeno obsesivo. Tesis doctoral. *Actas Luso-Esp. de Neurol. y Psiquiatr.* (23), 4.
- Seva Díaz, A. (1979). *Psiquiatría clínica*. Ed. Espax.
- Seva Díaz, A. (1980). Los problemas derivados de las carencias y privaciones afectivas en la infancia. *Comunic. Psiquiatr.*, 79, 359-372.
- Seva Díaz, A. (1983). *Salud mental evolutiva*. Zaragoza: Ed. Libros Pórtico.
- Seiz, F. S. (1984). Cit. M. Rojo Sierra. *Lecciones de psiquiatría*, tomo I. Edita Promolibro.
- Selye, H. (1954). «Stress» (sufrimiento). *Tratado sobre el S-G-A y las enfermedades de adaptación*. Editorial Científico Médica, primera edición española.
- Sigüenza, M. (1977). El desarrollo económico como problema. En *Trabajo y estrés*, Ed. Karpos.
- Sims, A. (1983). *Neurosis in Society*. London: McMillan Press. Cit. Vallejo Ruiloba, J. y Baca Baldomero, E. et al. (2002). *Trastornos neuróticos. Historia natural de las neurosis. Síndrome neurótico general*. Ars Médica.
- Spiegel, D. A. y Barlow, D. H. (2003). Trastornos de ansiedad. En *Tratado de psiquiatría*, tomo II (Gelder, M. G., López Ibor, J. J. y Andreasen, N., dirs.). Ed. Ars Médica.

- Spillane (1983). Cit. Campbell. F. y Singer, G. *Estrés, drogas y salud*. Edición en español, Ed. Ariel, 1987.
- Spitz, R. (1946). Anaclitic depression. *Psychoanal Study Child*, 2: 313.
- Srole, L. (1980). The Midtown Manhattan Longitudinal Study vs. «the mental Paradise lost» doctrine. *Arch General Psychiatry*, 37, 29-221.
- Stein, M. B., Kirk, P. y Prabhu, V. (1995). Mixed anxiety-depression in a primary-care clinic. *J. Affect Disord*, 34: 79-84.
- Swanson, D. y Bonert, Ph. (1974). *El mundo paranoico*. Barcelona: Ed. Labor.
- Tancer, M. E. y Uhde, T. W. (2004). Patogenia de la fobia social. En D. J. Stein y E. Hollander (dirs.). *Tratado de los trastornos de ansiedad*. Ars Médica.
- Tagore, R. (1955). *Obra escogida*. Traducción de Z. Camprubi de Jiménez. Madrid: Ed. Aguilar.
- Teilhard de Chardin, P. (1963). *El fenómeno humano*. Taurus.
- Tellenbach, H. (1976). *La melancolía*. Madrid: Ed Morata.
- Tyrer, P. (1985). ¿Neurosis divisible? *Lancet*, 1(8430): 685-688. Cit. Vallejo Ruiloba, J. y Baca Baldomero, E. et al. (2002). *Trastornos neuróticos. Historia natural de las neurosis. Síndrome neurótico general*. Ars Médica.
- Vallejo Ruiloba, J. (2000). Trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos (III). Trastornos obsesivos. En Demetrio Barcia (dir.). *Tratado de psiquiatría*, tomo I, Aran Ediciones.
- Vallejo Ruiloba, J. y Bataller, R. (2000). Relación entre los estados de ansiedad y los trastornos depresivos. En Ruiloba, J. y Gastó, C. (coords.). *Trastornos afectivos: ansiedad y depresión*, capítulo 38. Masson.
- Vallejo Ruiloba, J., Menchón Magriñá, J. M. y Alonso Ortega, M. P. (2005). Trastorno obsesivo-compulsivo. En J. Vallejo Ruiloba y C. Leal Cercós (dirs.). *Tratado de psiquiatría*, volumen II. Ars Médica.
- Vallejo, J. (2006). Trastornos obsesivos. En Vallejo, J. (dir.). *Introducción a la psicopatología y la psiquiatría*. 6.ª ed. Barcelona: Masson. 419-433.
- Van der Horst, L. (1942). Psiquiatría y antropología. *Actas Luso-Esp. de Neurol. y Psiquiatr.*, 1 y 2. Cit. M. Rojo Sierra y cols. (1988). *La psicobiografía: valor higiénico o patogénico. Valoración de acontecimientos preescolares*. Ed. Nau Llibres.
- Vázquez Barquero, J. L. et al. (1987). A community mental health survey in Cantabria: a general description of morbidity. *Psychol Med.*, 17: 227-241.
- Vázquez Barquero, J. L. y Herrán Gómez, A. (2006). *Las fases iniciales de las enfermedades mentales. Trastornos de ansiedad*. Masson.
- Watzlawick, P. (1986). *¿Es real la realidad?* Editorial Herder.
- Weitbrecht, H. J. (1969). *Manual de psiquiatría*. Ed. Gredos.
- Wyrsh, J. (1949). Cit. Binswanger, L. (1973). *Artículos y conferencias escogidas*. Editorial Gredos.
- Wolf, Ch. (1951). *Psicología del gesto*. Barcelona: Ed. L. Miracle.
- Yela, M. (1975). Ocio y cansancio de la vida. En J. Rof Carballo (dir.). *El cansancio de la vida*. Editorial Karpos.
- Yela, M. (1977). Mando y trabajo eficaz. En *Trabajo y estrés*. Ed. Karpos.
- Zinbarg, R. E., Barlow, D. H. y Liebowitz, M. (1994). The DSM-IV field trial mixed

anxiety-depression. *Am J. Psychiatry*, 151: 1153-1162.

Edición en formato digital: 2017

© Juan Rojo Moreno (coord.)
© Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A.), 2017
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid
piramide@anaya.es

ISBN ebook: 978-84-368-3857-2

Está prohibida la reproducción total o parcial de este libro electrónico, su transmisión, su descarga, su descompilación, su tratamiento informático, su almacenamiento o introducción en cualquier sistema de repositorio y recuperación, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, conocido o por inventar, sin el permiso expreso escrito de los titulares del Copyright.

Conversión a formato digital: REGA

www.edicionespiramide.es

Índice

Prólogo	7
1. Casos clínicos	10
1.1. Primer caso clínico	10
1.2. Segundo caso clínico	11
1.3. Tercer caso clínico	13
2. Qué es la ansiedad y el estrés. La ansiedad como enfermedad que se «comprende» en la totalidad de la propia vida	15
2.1. La ansiedad	15
2.2. El estrés	20
2.2.1. La intensidad de la vivencia	31
2.2.2. El tiempo de duración de la vivencia	31
2.2.3. La edad crítica del sujeto	31
2.2.4. El significado que la vivencia tiene para él	32
2.3. La ansiedad como enfermedad que se «comprende» en la totalidad de la propia vida	34
3. Los sucesos de nuestra vida que pueden influir en la aparición de la ansiedad	41
3.1. Factores disposicionales	42
3.1.1. La herencia	42
3.1.2. Temperamento y carácter	47
3.1.3. La edad y el sexo	53
3.1.3.1. Edades más frecuentes de la primera aparición	53
3.1.3.2. Edades de cambio, vulnerabilidad o metamorfosis	54
3.2. Factores de sensibilización biográfica	58
3.2.1. Privación de comunicación adecuada	59
3.2.1.1. El hijo mal deseado	61
3.2.1.2. El exceso de castigos	61
3.2.1.3. El aislamiento social de la familia	62
3.2.2. Aprendizajes anómalos	64
3.2.2.1. Hiperprotección	65
3.2.2.2. Preferencias	67
3.2.2.3. Responsabilidad precoz	70
3.2.2.4. Falta de gratificación	71
3.2.3. Frustraciones	72
3.2.4. Conflictos	73

3.3. Factores desencadenantes	76
4. La neurosis de ansiedad y el trastorno de ansiedad	80
4.1. La neurosis de ansiedad	80
4.2. Trastorno de ansiedad	83
4.3. La enfermedad ansiosa endógena: la timopatía ansiosa	89
5. Fobias, obsesiones, compulsiones	93
5.1. Las fobias simples	94
5.2. Agorafobia	98
5.3. Fobia social (ansiedad social)	102
5.4. Síndrome obsesivo-compulsivo (Trastorno obsesivo-compulsivo, TOC)	106
6. Trastorno por estrés traumático (TEPT)	115
7. Ansiedad y depresión	121
7.1. Cuando la enfermedad es realmente ansiosa y deriva con el tiempo hacia una depresión	122
7.2. Cuando hay una enfermedad ansiosa y síntomas depresiformes, pero no una depresión real	124
7.3. Cuando ocurre que tenemos un síndrome ansioso-depresivo	125
8. La ansiedad y el estrés en la sociedad actual. Ansiedad y trabajo	131
9. La ansiedad desde el punto de vista de la psicología: modelos, evaluación y tratamiento	147
9.1. Introducción	147
9.2. Activación o arousal	148
9.2.1. Mecanismos neurofisiológicos de la activación	149
9.2.2. Ansiedad rasgo y ansiedad estado	151
9.3. Estrés	154
9.4. Evaluación de la ansiedad	157
9.5. tratamientos psicológicos para el control de la ansiedad	160
9.5.1. Principales técnicas para el control de la ansiedad	161
9.5.1.1. La relajación	161
9.5.1.2. La biorretroalimentación	177
9.5.1.3. Las técnicas de afrontamiento	178
9.5.1.4. La reestructuración cognitiva	181
9.5.1.5. Programas basados en el condicionamiento clásico	183
9.5.1.6. La terapia cognitivo-conductual	184
10. Conceptos fundamentales del tratamiento de la enfermedad ansiosa. tratamiento psicofarmacoterápico	189

11. La psicobiografía: valor higiénico y patológico. valoración de acontecimientos de las edades preescolares	198
11.1. Prefacio o prólogo a este capítulo	198
11.2. Introducción	199
11.3. Sobre la historia del individuo, que es su vida	199
11.4. Etapas y curso del bios	199
11.5. Variedades de «formas» del bios	200
11.6. Los sucesos y acontecimientos en las edades preescolares	202
11.6.1. En el primer año de vida	202
11.6.2. Edad preescolar: la etapa del aprendizaje	209
11.6.2.1. El juego	212
11.7. Aprendizaje preescolar y estructura social	213
11.8. ¿Es válido todo lo anteriormente dicho como influencia positiva (higiénica) o negativa (patológica)?	214
11.9. Epílogo	218
12. ¿Desaparecerá la enfermedad ansiosa y el estrés? La psiquiatría irredenta. Antropología biogenética	221
Bibliografía	228
Créditos	238